

Buku Ajar

Persalinan

Daris Yolanda Sari
Christina Pernatun Kismoyo
Debora Paninsari
Aprilita Br Sitepu
Imelda Diana Marsilia
Indra Yulianti
Firdaus Mubayyina
Fitria Prabandari
Rina Octavia
Septa Dwi Insani
Siti Rochimatul Lailiyah
Hutari Puji Astuti
Umu Qonitun
Veryudha Eka Prameswari
Yeti Yuwansyah

Editor: Zakkiyatus Zainiyah



Buku Ajar Persalinan

Daris Yolanda Sari, SST., Bdn., M.Keb.
Dr. Bdn. Christina Pernatun Kismoyo, S.SiT., MPH.
Dr. Debora Paninsari, SST., Bdn., M.Keb.
Bd. Aprilita Br Sitepu, SST., M.K.M.
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Indra Yulianti, SST., Bd., M.Kes.
Bdn. Firdaus Mubayyina, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bdn. Fitria Prabandari, SSiT., M.Keb.
Rina Octavia, S.ST., Bd., M.Kes.
Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.
Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.
Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.
Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.
Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



Buku Ajar Persalinan

Penulis: Daris Yolanda Sari, SST., Bdn., M.Keb.
Dr. Bdn. Christina Pernatun Kismoyo, S.SiT., MPH.
Dr. Debora Paninsari, SST., Bdn., M.Keb.
Bd. Aprilita Br Sitepu, SST., M.K.M.
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Indra Yulianti, SST., Bd., M.Kes.
Bdn. Firdaus Mubayyina, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bdn. Fitria Prabandari, SSiT., M.Keb.
Rina Octavia, S.ST., Bd., M.Kes.
Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.
Bdn. Siti Rochimatul Lailiyah, S.SiT., M.Kes.
Hutari Puji Astuti, S.SiT., M.Kes., M.Keb.
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.
Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.
Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN : 978-634-96049-1-8
Cetakan Pertama : Juni, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
*All Right Reserved***

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram: @bimbel.optimal
Tiktok: @maskokooo
www.optimaluntuknegeri.com
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya *Buku Ajar Persalinan*. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan referensi yang komprehensif sekaligus praktis bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta para pendidik yang secara aktif terlibat dalam asuhan dan pelayanan persalinan.

Persalinan merupakan momen kritis yang membutuhkan pemahaman mendalam serta keterampilan klinis yang memadai dari setiap tenaga kesehatan. Dengan perubahan paradigma dalam praktik kebidanan yang semakin menekankan pada keselamatan ibu dan bayi, pemahaman terhadap prinsip dasar persalinan, asuhan yang berkelanjutan, serta kemampuan dalam menghadapi komplikasi menjadi hal yang wajib dikuasai. Buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan teoritis yang didukung dengan aplikasi praktis yang relevan dan mudah dipahami.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada para penulis dan kontributor atas dedikasi tinggi serta kerja kerasnya. Harapan kami, buku ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dan tenaga kesehatan, serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pelayanan persalinan di Indonesia.

Mei 2025

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
---------------------	------------

Daftar Isi.....	iv
------------------------	-----------

Bab 1 Konsep Dasar Kebidanan Persalinan..... 1

A. Filosofi dan Paradigma Kebidanan	2
B. Konsep Dasar Persalinan dan Kelahiran.....	3
C. Outcome-Based Education (OBE) dalam Pendidikan Kebidanan	4
D. Implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 dalam Praktik Persalinan	5
Latihan Soal.....	8
Rangkuman Materi	11
Glosarium.....	12
Daftar Pustaka.....	14

Bab 2 Anatomi dan Fisiologi Persalinan..... 15

A. Anatomi Pelvis dan Jalan Lahir	16
B. Fisiologi Persalinan Normal	17
C. Mekanisme Persalinan Normal.....	20
D. Adaptasi Fisiologis Ibu dan Janin	22
Latihan Soal.....	23
Rangkuman Materi	26
Glosarium.....	27
Daftar Pustaka.....	30

Bab 3 Asuhan Antenatal Menuju Persalinan..... 31

A. Skrining Risiko Kehamilan	32
B. Konseling <i>Informed Choice</i> dan <i>Birth Plan</i>	33
C. Persiapan Lingkungan dan Tim Persalinan.....	34
D. Edukasi Tanda Awal Persalinan	35
Latihan Soal.....	37
Rangkuman Materi	40
Glosarium.....	41
Daftar Pustaka.....	42

Bab 4 Asuhan Persalinan Kala I, II, III, dan IV	43
A. Penilaian Tanda Persalinan.....	44
B. Manajemen Kala I (Fase Laten dan Aktif)	45
C. Pemantauan Partograf	47
D. Penatalaksanaan Kala II dan III	49
E. Kala IV: Observasi Awal Pascapersalinan	51
Latihan Soal.....	53
Rangkuman Materi	57
Glosarium.....	58
Daftar Pustaka.....	60
 Bab 5 Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai KEPMENKES 320/2020.....	61
A. Penilaian Awal Neonatus (APGAR Score)	63
B. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan <i>Skin to Skin Contact</i>	64
C. Profilaksis Neonatus.....	66
D. Pemantauan Awal Neonatus	68
Latihan Soal.....	70
Rangkuman Materi	74
Glosarium.....	75
Daftar Pustaka.....	77
 Bab 6 Komplikasi Persalinan dan Manajemen Rujukan	78
A. Deteksi Dini Komplikasi Persalinan	80
B. Manajemen Emergensi Obstetri	81
C. Prosedur Rujukan Sesuai Kepmenkes 320/2020	83
D. Peran Bidan dalam Tim Multidisiplin	85
Latihan Soal.....	86
Rangkuman Materi	88
Glosarium.....	89
Daftar Pustaka.....	91
 Bab 7 Asuhan Pascapersalinan (Postpartum)	92
A. Perawatan Ibu Pascapersalinan	93
B. Pencegahan dan Deteksi Komplikasi Postpartum	94
C. Edukasi Kesehatan Reproduksi Pascapersalinan	96
D. Dukungan Psikososial Masa Nifas.....	98
Latihan Soal.....	100
Rangkuman Materi	103
Glosarium.....	105

Daftar Pustaka.....	107
Bab 8 Dokumentasi dan Pencatatan Asuhan Persalinan	109
A. Pentingnya Dokumentasi Kebidanan.....	110
B. Catatan Medis dan Buku KIA.....	111
C. Aspek Hukum dan Etika Dokumentasi	113
D. Teknik Pendokumentasian Efektif	115
Latihan Soal.....	118
Rangkuman Materi	121
Glosarium.....	122
Daftar Pustaka.....	124
Bab 9 Pencegahan Infeksi Dalam Persalinan	126
A. Prinsip Pencegahan Infeksi	128
B. Teknik Asepsis dan Antisepsis	131
C. Pengendalian Infeksi di Ruang Bersalin	134
D. Edukasi Pencegahan Infeksi.....	136
Latihan Soal.....	139
Rangkuman Materi	142
Glosarium.....	144
Daftar Pustaka.....	146
Bab 10 Mutu dan Keselamatan Dalam Praktik Kebidanan Persalinan	147
A. Keselamatan Pasien dalam Praktik Kebidanan.....	148
B. Audit Klinis Persalinan.....	149
C. Manajemen Risiko Kebidanan.....	150
D. Continuous Quality Improvement (CQI)	150
Latihan Soal.....	151
Rangkuman Materi	155
Glosarium.....	156
Daftar Pustaka.....	158
Bab 11 Simulasi dan Praktik Klinik Berbasis <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>.....	159
A. Desain Simulasi (Skill Lab dan OSCE).....	161
B. Studi Kasus Persalinan Normal dan Komplikasi	162
C. Rubrik Penilaian Keterampilan Klinik	163

D. Refleksi dan <i>Feedback</i> Praktik Klinik	163
Latihan Soal.....	164
Rangkuman Materi	167
Glosarium.....	168
Daftar Pustaka.....	170
Bab 12 Tren dan Isu Terkini Dalam Persalinan	171
A. Tren Persalinan di Rumah (<i>Home Birth</i>)	172
B. <i>Water Birth</i> (Persalinan dalam Air)	172
C. <i>Gentle Birth</i> dan <i>Hypnobirthing</i>	173
D. Penggunaan Teknologi Digital dalam Persalinan (<i>Telemidwifery</i>)	175
E. Isu Etik dan Legal terkait Persalinan Kontemporer	176
F. Peran Media Sosial dalam Edukasi Persalinan	177
Latihan Soal.....	179
Rangkuman Materi	183
Glosarium.....	185
Daftar Pustaka.....	186

Bab 1

Konsep Dasar Kebidanan Persalinan

Persalinan merupakan salah satu proses fisiologis penting dalam kehidupan perempuan yang memerlukan pendekatan kebidanan berbasis bukti. Untuk itu, sangat penting bagi tenaga kebidanan untuk memahami filosofi, paradigma, serta konsep dasar persalinan dan kelahiran yang sesuai dengan standar profesi. Outcome-Based Education (OBE) memberikan kerangka pendidikan yang jelas dalam membentuk kompetensi bidan. Di samping itu, implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 menjamin pelayanan persalinan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan persalinan berbasis filosofi, paradigma, konsep dasar kebidanan, pendidikan berbasis OBE, serta menerapkan ketentuan Kepmenkes 320 Tahun 2020 secara profesional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kebidanan persalinan yang mencakup filosofi, paradigma, konsep persalinan, pendekatan Outcome-Based Education (OBE), dan implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 dalam pelayanan persalinan secara komprehensif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan filosofi dan paradigma kebidanan dalam konteks persalinan.
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar persalinan dan kelahiran.
3. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) dalam pendidikan kebidanan.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 dalam praktik persalinan.

A. Filosofi dan Paradigma Kebidanan

1. Filosofi Kebidanan

Filosofi kebidanan merupakan keyakinan mendasar bahwa proses persalinan adalah proses alami, fisiologis, dan pada dasarnya tidak memerlukan intervensi medis kecuali dalam situasi tertentu yang membahayakan keselamatan ibu atau bayi. Filosofi ini menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki hak penuh atas tubuhnya dan proses kelahirannya. Dalam kebidanan, filosofi ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui informasi, dukungan, dan pendekatan humanis sehingga mereka mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya dan bayinya.

2. Paradigma Kebidanan

Paradigma kebidanan mencerminkan nilai-nilai utama yang mendasari praktik kebidanan, terdiri dari tiga prinsip utama:

- **Normalitas**

Paradigma normalitas melihat persalinan sebagai proses alami yang umumnya berlangsung tanpa komplikasi. Tugas utama bidan adalah mendukung, memfasilitasi, serta memantau proses tersebut secara cermat. Intervensi medis hanya dilakukan jika ada tanda-tanda komplikasi yang mengancam keselamatan ibu atau bayi. Dengan paradigma ini, bidan menekankan pentingnya pendekatan minimal intervensi, memberi kesempatan bagi tubuh perempuan untuk menjalani proses persalinan secara alami.

- **Kemitraan**

Paradigma kemitraan dalam kebidanan berfokus pada penghargaan terhadap perempuan sebagai mitra yang aktif dan setara dalam proses persalinan. Dalam paradigma ini, ibu memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan terkait proses kelahirannya. Bidan memberikan informasi yang jelas, mendukung, dan membantu ibu merasa nyaman serta aman. Kemitraan ini juga melibatkan keluarga sebagai bagian integral dari tim dukungan yang penting untuk menciptakan lingkungan persalinan yang positif dan kolaboratif.

- **Kontinuitas Asuhan**

Kontinuitas asuhan berarti bahwa pelayanan kebidanan diberikan secara terintegrasi dan berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga masa nifas. Kontinuitas ini memastikan bahwa ibu dan keluarganya menerima perawatan yang konsisten dari tenaga kesehatan yang dikenal dan dipercaya sepanjang proses persalinan. Hal ini mampu menciptakan hubungan yang kuat antara ibu dan bidan, meningkatkan rasa percaya diri ibu, mengurangi stres, serta meningkatkan kualitas pengalaman persalinan. Selain itu, kontinuitas asuhan memungkinkan identifikasi dini masalah kesehatan, sehingga komplikasi bisa dicegah atau dikelola secara efektif.

B. Konsep Dasar Persalinan dan Kelahiran

Persalinan adalah rangkaian proses fisiologis alami yang memungkinkan bayi keluar dari rahim ibu melalui jalan lahir. Proses ini mencakup empat tahap utama yang penting untuk dipahami secara detail oleh tenaga kebidanan agar dapat memberikan asuhan yang optimal.

1. Kala Pembukaan (Kala I)

Kala pembukaan dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan semakin intensif, menyebabkan serviks menjadi lunak, menipis (effacement), dan terbuka hingga mencapai pembukaan penuh sekitar 10 cm. Tahap ini merupakan tahap yang paling lama dalam persalinan dan terbagi menjadi dua fase:

- **Fase Laten:** Dimulai dari kontraksi pertama hingga pembukaan serviks sekitar 4 cm. Kontraksi biasanya ringan hingga sedang, dan ibu umumnya masih dapat melakukan aktivitas ringan. Fase ini dapat berlangsung hingga beberapa jam atau bahkan hari, terutama pada ibu yang baru pertama kali melahirkan.
- **Fase Aktif:** Dimulai dari pembukaan 4 cm hingga pembukaan lengkap (10 cm). Kontraksi menjadi lebih intens, teratur, dan sering, biasanya berlangsung setiap 3 hingga 5 menit dengan durasi 40 hingga 60 detik. Pada fase ini, dukungan fisik dan emosional dari bidan serta keluarga sangat penting untuk membantu ibu tetap nyaman, rileks, dan percaya diri.

2. Kala Pengeluaran Bayi (Kala II)

Kala ini dimulai dari pembukaan serviks lengkap hingga kelahiran bayi. Selama kala ini, ibu akan merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mengejan karena bayi bergerak turun melalui panggul menuju jalan lahir. Bidan memiliki peran penting dalam:

- Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada ibu untuk mengejan secara efektif dan aman.
- Menyediakan posisi persalinan yang nyaman bagi ibu, seperti posisi jongkok, setengah duduk, atau miring, yang dapat membantu proses kelahiran bayi secara optimal.
- Melakukan manuver sederhana, seperti melindungi perineum untuk mencegah robekan, dan membantu bayi lahir secara lembut dan aman tanpa intervensi berlebihan.

3. Kala Pengeluaran Plasenta (Kala III)

Kala pengeluaran plasenta dimulai segera setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara utuh. Proses ini biasanya berlangsung antara 5 hingga 30 menit setelah kelahiran bayi. Pada tahap ini, bidan harus melakukan:

- Pemantauan tanda-tanda pelepasan plasenta, seperti kontraksi uterus lebih kuat dan pemanjangan tali pusat.

- Manajemen aktif dengan pemberian oksitosin untuk mencegah perdarahan postpartum.
- Pemeriksaan plasenta secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal, yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan atau infeksi.

4. Kala Observasi (Kala IV)

Kala observasi adalah masa kritis dalam dua jam pertama setelah lahirnya plasenta. Dalam periode ini, ibu dan bayi membutuhkan pengawasan ketat untuk mendeteksi komplikasi dini, seperti perdarahan postpartum atau gangguan lain. Aktivitas yang dilakukan oleh bidan selama kala ini meliputi:

- Pemantauan tanda vital ibu secara rutin (tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh).
- Memastikan uterus berkontraksi dengan baik (uterus keras dan terletak di bawah pusat).
- Pemeriksaan perdarahan dan kondisi umum ibu.
- Memberikan edukasi awal mengenai menyusui, teknik perawatan bayi baru lahir, dan kebersihan diri ibu untuk mencegah infeksi.

C. Outcome-Based Education (OBE) dalam Pendidikan Kebidanan

Outcome-Based Education (OBE) merupakan pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memastikan bahwa hasil atau capaian belajar mahasiswa jelas, spesifik, dan terukur. Dalam pendidikan kebidanan, penerapan OBE bertujuan agar lulusan memiliki kompetensi yang esensial dan terukur sesuai dengan kebutuhan praktik profesional kebidanan.

Dalam OBE, pendidikan kebidanan difokuskan untuk mengembangkan beberapa kompetensi esensial, antara lain:

1. **Kompetensi Klinis** Kompetensi klinis meliputi kemampuan teknis dalam memberikan asuhan persalinan yang aman dan efektif, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi komplikasi. Mahasiswa dilatih untuk menguasai keterampilan seperti pemeriksaan fisik ibu hamil, monitoring tanda vital, manajemen persalinan normal, deteksi dini komplikasi, dan tindakan intervensi yang tepat.
2. **Kompetensi Komunikasi** Kemampuan berkomunikasi efektif sangat penting bagi seorang bidan. Kompetensi ini mencakup keterampilan dalam memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga, konseling selama proses persalinan, serta menyampaikan informasi medis secara jelas dan mudah dipahami. Keterampilan ini memastikan hubungan terapeutik yang positif dan membantu meningkatkan kepuasan ibu terhadap pelayanan yang diterimanya.
3. **Kompetensi Pengambilan Keputusan Klinis** Dalam praktik kebidanan, pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat berdasarkan bukti ilmiah sangat penting. Mahasiswa diajarkan bagaimana menganalisis informasi klinis yang relevan,

mempertimbangkan risiko dan manfaat berbagai tindakan, serta membuat keputusan yang paling tepat untuk keselamatan ibu dan bayi.

4. **Kompetensi dalam Teknologi Kesehatan** Penguasaan teknologi kesehatan merupakan kompetensi penting lainnya yang harus dimiliki bidan. Mahasiswa dilatih dalam penggunaan alat-alat kesehatan yang relevan secara efisien, tepat, dan aman. Ini mencakup teknologi pemantauan janin, manajemen nyeri selama persalinan, serta penggunaan alat bantu persalinan yang sesuai.

Implementasi OBE dalam pendidikan kebidanan mencakup beberapa langkah strategis berikut:

- **Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi** Kurikulum pendidikan kebidanan disusun secara sistematis berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan, yang mencerminkan kebutuhan praktik kebidanan modern. Kurikulum ini memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran mengarah pada penguasaan kompetensi spesifik yang jelas dan terukur.
- **Penilaian Berbasis Kompetensi** Penilaian mahasiswa dalam sistem OBE dirancang untuk mengukur sejauh mana kompetensi telah tercapai. Metode penilaian mencakup simulasi klinis, Objective Structured Clinical Examination (OSCE), evaluasi kinerja di praktik klinik, serta ujian tertulis berbasis kasus. Penilaian ini memungkinkan evaluasi yang obyektif dan terukur atas pencapaian mahasiswa.
- **Umpan Balik Berkala** Umpan balik yang diberikan secara teratur merupakan **komponen** penting dalam OBE. Umpan balik ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai kemajuan mereka, identifikasi area yang membutuhkan perbaikan, serta rekomendasi untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi lebih lanjut.

D. Implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 dalam Praktik Persalinan

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 320 Tahun 2020 merupakan pedoman resmi yang mengatur standar profesi dan kompetensi bidan di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan kebidanan yang diberikan memenuhi standar kualitas tinggi, aman, dan efektif dalam menghadapi berbagai kondisi selama proses persalinan.

1. Standar Kompetensi Profesi

Standar kompetensi profesi adalah elemen kunci dalam Kepmenkes 320 Tahun 2020 yang memastikan setiap bidan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan persalinan yang optimal. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam:

- Mengelola persalinan normal secara mandiri, mulai dari kala pembukaan hingga observasi postpartum.

- Mengidentifikasi, merujuk, dan menangani komplikasi selama persalinan, termasuk situasi darurat seperti distosia, perdarahan postpartum, atau komplikasi lainnya.
- Menjamin keselamatan ibu dan bayi melalui intervensi yang sesuai berdasarkan bukti ilmiah terkini.

2. Pemantauan Ketat

Implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 menegaskan pentingnya pemantauan ketat kondisi ibu dan bayi selama proses persalinan. Pemantauan ini mencakup:

- Penilaian berkala terhadap tanda vital ibu, kontraksi uterus, serta kemajuan pembukaan serviks.
- Pemantauan kondisi janin melalui auskultasi detak jantung janin atau pemantauan elektronik jika diperlukan.
- Evaluasi respons ibu terhadap nyeri, serta pemberian dukungan fisik dan emosional untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan selama persalinan.

3. Penggunaan Pedoman Klinis Berbasis Bukti

Pedoman klinis berbasis bukti merupakan bagian integral dalam implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020. Pedoman ini memberikan arahan jelas bagi bidan mengenai intervensi klinis yang harus dilakukan, didasarkan pada penelitian dan bukti ilmiah terbaru. Bidan diwajibkan untuk:

- Menerapkan praktik klinis yang terbukti efektif dan aman dalam berbagai situasi persalinan.
- Meminimalisasi penggunaan intervensi yang tidak perlu dan memastikan bahwa setiap tindakan medis didasarkan pada pertimbangan klinis yang matang dan bukti yang kuat.
- Terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan berbasis bukti.

4. Dokumentasi yang Akurat dan Lengkap

Dokumentasi klinis yang akurat dan lengkap adalah kewajiban penting dalam praktik kebidanan sesuai Kepmenkes 320 Tahun 2020. Dokumentasi ini mencakup:

- Catatan lengkap mengenai proses persalinan, termasuk progres pembukaan, kondisi ibu dan bayi, serta tindakan yang dilakukan selama persalinan.
- Rekam medis yang jelas dan detail, yang berguna untuk memastikan kontinuitas asuhan dan memudahkan komunikasi antar profesional kesehatan.
- Informasi yang akurat dan terorganisir dengan baik untuk kepentingan audit klinis dan evaluasi kualitas pelayanan.

5. Pendidikan dan Konseling Kesehatan

Kepmenkes 320 Tahun 2020 menempatkan edukasi dan konseling kesehatan sebagai tanggung jawab utama bidan. Bidan harus mampu:

- Memberikan edukasi yang jelas dan informatif kepada ibu dan keluarganya mengenai berbagai aspek persalinan, mulai dari persiapan, proses persalinan, perawatan postpartum, hingga perawatan bayi baru lahir.
- Menawarkan konseling tentang menyusui, kebersihan pribadi, dan tanda-tanda komplikasi postpartum, untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam menjaga kesehatan dirinya dan bayinya.
- Membantu ibu dan keluarga membuat keputusan yang terinformasi tentang berbagai pilihan yang tersedia selama proses persalinan dan perawatan setelahnya.

6. Refleksi dan Feedback Praktik Klinik

Refleksi dan feedback sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keterampilan mahasiswa. Tahapan refleksi dan feedback yang efektif meliputi:

- Sesi Debriefing
 - Diskusi terbuka tentang pengalaman praktik.
 - Mahasiswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing.
 - Supervisor memberikan feedback konstruktif berdasarkan observasi langsung.
- Penulisan Jurnal Reflektif
 - Mahasiswa menuliskan pengalaman, perasaan, serta pelajaran yang didapat selama praktik klinik.
 - Dosen memberikan respon tertulis untuk mengarahkan perbaikan keterampilan dan sikap klinik.
- Evaluasi Berkala
 - Evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan mahasiswa.
 - Menyesuaikan kegiatan simulasi berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Esai Filosofi dan Paradigma Kebidanan

Tulislah esai singkat sebanyak 500-700 kata yang menjelaskan filosofi dan paradigma kebidanan. Dalam esai ini, jabarkan secara jelas konsep normalitas, kemitraan, dan kontinuitas asuhan, serta berikan contoh nyata penerapan paradigma tersebut dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Tugas 2: Studi Kasus Konsep Dasar Persalinan dan Kelahiran

Pilihlah salah satu tahapan persalinan (Kala I hingga Kala IV) dan buatlah studi kasus yang mencakup:

- Identifikasi gejala atau tanda pada tahap persalinan yang dipilih.
- Tindakan dan intervensi yang tepat dilakukan oleh bidan pada tahap tersebut.
- Penjelasan alasan mengapa tindakan tersebut dilakukan.

Tulislah dalam 400-600 kata.

Tugas 3: Role Play Kompetensi Komunikasi dalam OBE Kebidanan

Lakukanlah simulasi role play dengan teman atau kelompok kecil, di mana Anda bertindak sebagai bidan yang memberikan edukasi dan konseling kepada seorang ibu yang sedang menghadapi persalinan. Catatlah skenario percakapan Anda dan tulislah refleksi sebanyak 400-600 kata tentang apa yang telah Anda pelajari mengenai kompetensi komunikasi dari kegiatan ini.

Tugas 4: Analisis Implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020

Buatlah analisis kritis sebanyak 500-700 kata tentang pentingnya implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020 dalam praktik persalinan. Jabarkan manfaat penerapan standar kompetensi profesi, pemantauan ketat, penggunaan pedoman klinis berbasis bukti, dokumentasi klinis, serta pendidikan dan konseling kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan persalinan.

Tugas 5: Penyusunan Rencana Asuhan Persalinan

Susunlah sebuah rencana asuhan persalinan lengkap berdasarkan Kepmenkes 320 Tahun 2020 untuk seorang ibu primigravida yang mengalami persalinan normal. Rencana asuhan ini harus mencakup:

- Tahapan persalinan (Kala I hingga Kala IV).
- Tindakan pemantauan dan intervensi yang dilakukan.
- Rencana edukasi dan konseling kepada ibu dan keluarganya.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu primigravida usia 27 tahun datang ke klinik kebidanan dengan kontraksi teratur setiap 5 menit. Saat diperiksa, serviks sudah terbuka 5 cm, ibu terlihat cemas dan tidak nyaman.
Sebagai bidan, tindakan yang paling tepat sesuai dengan paradigma kebidanan adalah
 - A. Memberikan analgesik segera untuk mengurangi rasa nyeri.
 - B. Menyiapkan ibu untuk segera dipindahkan ke rumah sakit.
 - C. Menyarankan ibu untuk segera mengejan.
 - D. Memberikan dukungan emosional dan penjelasan tentang proses yang dialami ibu.
 - E. Melakukan intervensi medis tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada ibu.

2. Seorang ibu melahirkan bayi sehat secara spontan di klinik kebidanan. Setelah 10 menit, tanda pelepasan plasenta belum tampak jelas.
Tindakan yang tepat berdasarkan paradigma normalitas adalah
 - A. Segera melakukan manual plasenta.
 - B. Memberikan tambahan oksitosin dosis tinggi secara intravena.
 - C. Mengobservasi tanda pelepasan plasenta dan menunggu hingga 30 menit.
 - D. Meminta ibu untuk mengejan terus-menerus.
 - E. Langsung merujuk ibu ke rumah sakit.

3. Seorang ibu multipara usia 32 tahun berada dalam kala aktif persalinan dengan pembukaan serviks 8 cm. Ia mulai merasa sangat kelelahan dan nyeri hebat.
Sebagai bidan, langkah tepat sesuai dengan filosofi kebidanan adalah
 - A. Memberikan edukasi, dukungan emosional, dan bantuan teknik relaksasi.
 - B. Menyarankan segera operasi caesar.
 - C. Mengabaikan keluhan ibu dan meminta agar tetap tenang.
 - D. Melakukan episiotomi preventif.
 - E. Langsung melakukan intervensi analgesik.

4. Seorang ibu berada pada dua jam pertama setelah melahirkan (kala observasi). Ia mulai tampak pucat, denyut nadi meningkat, dan uterus terasa lunak.
Tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh bidan adalah
 - A. Memberikan informasi kepada keluarga tentang kondisi ibu.
 - B. Memberikan konseling menyusui.
 - C. Melakukan pemijatan uterus dan pemberian oksitosin.
 - D. Memindahkan ibu ke ruang rawat inap.
 - E. Menyarankan ibu untuk beristirahat saja.

5. Seorang bidan melakukan pemantauan pada seorang ibu yang sedang menjalani kala pembukaan aktif.
- Dalam implementasi Kepmenkes 320 Tahun 2020, tindakan yang paling tepat dalam dokumentasi adalah
- A. Hanya mencatat saat bayi sudah lahir.
 - B. Mencatat hanya kondisi ibu tanpa kondisi janin.
 - C. Mencatat sesekali apabila ada keluhan dari ibu.
 - D. Menyerahkan semua pencatatan kepada keluarga.
 - E. Melakukan pencatatan detail setiap perkembangan pembukaan serviks, kontraksi, dan kondisi ibu serta janin.

Kunci Jawaban

1. **Kunci Jawaban: D**

Pembahasan: Paradigma kebidanan berfokus pada kemitraan, di mana bidan harus memberikan dukungan emosional, penjelasan yang jelas, serta membantu ibu merasa nyaman dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan.

2. **Kunci Jawaban: C**

Pembahasan: Dalam paradigma normalitas, persalinan dianggap proses fisiologis alami, sehingga tindakan medis hanya dilakukan bila ada indikasi kuat. Menunggu hingga 30 menit untuk observasi tanda pelepasan plasenta merupakan tindakan yang sesuai standar.

3. **Kunci Jawaban: A**

Pembahasan: Filosofi kebidanan mendukung pemberdayaan perempuan melalui informasi, dukungan, dan pendekatan humanis. Memberikan edukasi dan dukungan emosional membantu ibu melewati tahap ini secara alami dengan nyaman dan aman.

4. **Kunci Jawaban: C**

Pembahasan: Kala observasi sangat penting untuk mendeteksi dini komplikasi seperti perdarahan postpartum. Tanda-tanda pucat, denyut nadi meningkat, dan uterus lunak mengindikasikan perdarahan postpartum. Tindakan prioritas adalah melakukan pemijatan uterus dan pemberian oksitosin.

5. **Kunci Jawaban: E**

Pembahasan: Sesuai Kepmenkes 320 Tahun 2020, dokumentasi klinis yang akurat dan lengkap adalah kewajiban penting dalam praktik kebidanan. Semua perkembangan selama persalinan harus dicatat secara detail untuk memastikan kualitas pelayanan dan kontinuitas asuhan.

Rangkuman Materi

Filosofi kebidanan memandang proses persalinan sebagai kejadian fisiologis yang alami dan normal, yang pada dasarnya tidak memerlukan intervensi medis kecuali dalam situasi tertentu yang mengancam keselamatan ibu atau bayi. Dalam filosofi ini, perempuan dihormati sebagai individu yang memiliki hak penuh atas tubuhnya dan keputusan mengenai proses kelahirannya. Pendekatan kebidanan secara humanis dan informatif bertujuan untuk memberdayakan perempuan sehingga mampu mengambil keputusan terbaik bagi dirinya dan bayinya.

Paradigma kebidanan mendukung filosofi tersebut dengan tiga prinsip utama, yakni normalitas, kemitraan, dan kontinuitas asuhan. Paradigma normalitas menegaskan bahwa persalinan biasanya berlangsung tanpa komplikasi sehingga intervensi medis minimal diutamakan, kecuali jika terjadi kondisi yang membahayakan. Paradigma kemitraan menempatkan ibu sebagai mitra aktif dalam proses persalinan, yang mana bidan memberikan informasi yang jelas, dukungan, dan menciptakan lingkungan persalinan yang positif bersama keluarga. Sementara itu, kontinuitas asuhan memastikan pelayanan kebidanan diberikan secara konsisten dari masa kehamilan hingga masa nifas, sehingga meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres, dan mencegah komplikasi dengan deteksi dini.

Persalinan sendiri adalah rangkaian proses alami yang terdiri dari empat tahap utama. Tahap pertama, atau kala pembukaan, dimulai dari kontraksi uterus hingga pembukaan serviks penuh sekitar 10 cm, terbagi menjadi fase laten dengan kontraksi ringan hingga sedang dan fase aktif dengan kontraksi intensif. Pada tahap kedua, kala pengeluaran bayi, ibu merasakan dorongan kuat untuk mengejan, dan tugas bidan adalah memberikan dukungan emosional serta membantu ibu dalam posisi persalinan yang optimal dan aman. Tahap ketiga, kala pengeluaran plasenta, melibatkan pengawasan pelepasan plasenta dan manajemen aktif untuk mencegah perdarahan postpartum. Tahap terakhir, kala observasi, merupakan periode penting setelah plasenta lahir, di mana pemantauan ketat terhadap kondisi ibu dan bayi dilakukan untuk mendeteksi dini komplikasi, serta memberikan edukasi awal tentang perawatan bayi dan kebersihan diri.

Dalam pendidikan kebidanan modern, Outcome-Based Education (OBE) menjadi pendekatan yang mengedepankan hasil pembelajaran yang spesifik dan terukur. OBE memastikan mahasiswa menguasai kompetensi klinis dalam menangani persalinan, komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, serta kompetensi penggunaan teknologi kesehatan secara efisien dan aman. Implementasi OBE melibatkan kurikulum berbasis kompetensi, metode evaluasi yang sistematis seperti simulasi klinis

dan OSCE, serta umpan balik berkala yang berorientasi pada peningkatan kemampuan mahasiswa.

Kepmenkes 320 Tahun 2020 merupakan pedoman resmi yang menentukan standar kompetensi profesi bidan di Indonesia, mencakup kemampuan mengelola persalinan secara mandiri, menangani komplikasi, dan menjamin keselamatan ibu serta bayi dengan intervensi berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Implementasi regulasi ini juga menekankan pentingnya pemantauan ketat kondisi ibu dan janin selama persalinan, penggunaan pedoman klinis berbasis bukti, dokumentasi medis yang akurat dan lengkap, serta kewajiban bidan untuk memberikan edukasi dan konseling kesehatan yang informatif kepada ibu dan keluarganya.

Glosarium

Auskultasi: Metode pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi tubuh, seperti detak jantung janin, menggunakan stetoskop atau alat khusus.

Distosia: Kesulitan atau hambatan yang terjadi selama proses persalinan yang menyebabkan bayi sulit lahir secara normal.

Effacement: Penipisan dan pemendekan serviks yang terjadi selama tahap awal persalinan.

Episiotomi: Prosedur bedah kecil untuk memperlebar jalan lahir dengan cara menggunting perineum.

Intervensi medis: Tindakan medis atau bedah yang dilakukan untuk menangani atau mencegah komplikasi selama proses persalinan.

Kala Pembukaan: Tahapan pertama persalinan, dimulai dengan kontraksi uterus teratur hingga pembukaan serviks penuh (10 cm).

Kala Pengeluaran Bayi: Tahapan kedua persalinan, dimulai dari pembukaan serviks penuh hingga bayi lahir.

Kala Pengeluaran Plasenta: Tahapan ketiga persalinan, dimulai setelah bayi lahir dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara utuh.

Kala Observasi: Tahapan keempat persalinan, masa kritis dua jam setelah plasenta lahir untuk pemantauan komplikasi postpartum.

Kepmenkes 320 Tahun 2020: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan standar kompetensi profesi bidan.

Kompetensi Klinis: Kemampuan teknis dan keterampilan bidan dalam menangani persalinan secara aman dan efektif.

Kompetensi Komunikasi: Keterampilan bidan dalam berkomunikasi secara efektif dengan ibu dan keluarga.

Kompetensi Pengambilan Keputusan Klinis: Kemampuan bidan untuk mengambil keputusan klinis cepat dan tepat berdasarkan informasi medis dan bukti ilmiah.

Kompetensi dalam Teknologi Kesehatan: Kemampuan menggunakan alat-alat kesehatan dengan tepat, efisien, dan aman dalam praktik kebidanan.

Kontinuitas Asuhan: Pelayanan kebidanan yang terintegrasi dan berkesinambungan dari masa kehamilan hingga masa nifas.

Manajemen aktif plasenta: Tindakan proaktif untuk membantu pelepasan dan pengeluaran plasenta serta mencegah perdarahan postpartum, biasanya melibatkan pemberian oksitosin.

Normalitas: Paradigma yang memandang persalinan sebagai proses alami yang tidak memerlukan intervensi medis kecuali dalam kondisi komplikasi.

Outcome-Based Education (OBE): Pendekatan pendidikan berbasis pencapaian kompetensi atau hasil belajar yang jelas dan terukur.

Pemantauan Ketat: Pengawasan intensif kondisi ibu dan bayi selama persalinan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan keduanya.

Perdarahan Postpartum: Perdarahan berlebihan yang terjadi setelah kelahiran bayi dan plasenta, berpotensi mengancam nyawa ibu jika tidak segera ditangani.

Serviks: Bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, yang mengalami pembukaan dan penipisan selama proses persalinan.

Simulasi Klinis: Metode pembelajaran praktis dengan menciptakan skenario realistis untuk melatih keterampilan klinis.

Standar Kompetensi Profesi: Pedoman yang menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh profesional dalam bidang tertentu.

Umpan Balik Berkala: Informasi rutin yang diberikan untuk mengevaluasi kemajuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang ditentukan.

Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019). Approaches to Limit Intervention During Labor and Birth. *Obstetrics & Gynecology*, 133(2), e164-e173.
- Black, R. E., Laxminarayan, R., Temmerman, M., & Walker, N. (Eds.). (2016). *Reproductive, maternal, newborn, and child health: Disease control priorities* (3rd ed.). The World Bank.
- Fullerton, J. T., Thompson, J. B., & Johnson, P. (2016). Competency-Based Education: The Essential Basis of Education and Training for the Health Professions. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 61(1), 54-60.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Bidan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Leap, N., & Pairman, S. (2017). *Midwifery: Preparation for Practice* (4th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Mannava, P., Durrant, K., Fisher, J., Chersich, M., & Luchters, S. (2015). Attitudes and behaviours of maternal health care providers in interactions with clients: A systematic review. *Globalization and Health*, 11(1), 36.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & McCormick, F. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129-1145.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: World Health Organization.

Bab 2

Anatomi dan Fisiologi Persalinan

Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi persalinan merupakan fondasi penting dalam praktik kebidanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan persalinan yang aman dan berkualitas tinggi. Pengetahuan ini mencakup struktur anatomi pelvis dan jalan lahir, proses fisiologis persalinan normal, mekanisme persalinan, serta adaptasi fisiologis ibu dan janin selama proses kelahiran. Dengan memahami konsep ini, bidan mampu memberikan asuhan yang efektif serta mengambil keputusan klinis yang tepat dan terinformasi dalam situasi persalinan normal maupun dengan komplikasi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pendidikan kebidanan, lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif berbasis anatomi dan fisiologi persalinan, serta memahami mekanisme persalinan normal dan adaptasi fisiologis ibu dan janin dengan pendekatan yang holistik, aman, dan efektif.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep anatomi pelvis dan jalan lahir, fisiologi persalinan normal, mekanisme persalinan, serta adaptasi fisiologis ibu dan janin selama persalinan secara mendalam dan profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mampu menguraikan anatomi pelvis dan jalan lahir secara detail.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses fisiologi persalinan normal secara komprehensif.
3. Mahasiswa mampu mendeskripsikan mekanisme persalinan normal.
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan adaptasi fisiologis ibu dan janin selama proses persalinan.

A. Anatomi Pelvis dan Jalan Lahir

Pelvis wanita secara anatomis terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pelvis mayor (false pelvis) dan pelvis minor (true pelvis). Pelvis mayor merupakan bagian atas rongga panggul yang lebih luas dan berfungsi sebagai pendukung organ-organ abdominal bawah seperti bagian usus, kandung kemih, dan organ reproduksi internal. Bagian ini tidak terlibat secara langsung dalam proses kelahiran. Sebaliknya, pelvis minor atau true pelvis merupakan bagian bawah rongga panggul yang lebih sempit dan secara langsung terlibat dalam proses persalinan.

True pelvis terdiri dari tiga komponen utama, yakni inlet pelvis, cavity pelvis, dan outlet pelvis, yang masing-masing memainkan peran krusial dalam proses kelahiran bayi.

1. Inlet Pelvis

Inlet pelvis atau pintu masuk panggul adalah bagian teratas dari true pelvis yang berbentuk oval dengan diameter transversal yang lebih lebar dibandingkan diameter anteroposterior. Bentuk dan ukuran inlet pelvis sangat menentukan kemudahan kepala bayi memasuki rongga panggul. Sebuah inlet pelvis yang optimal memungkinkan kepala bayi melewatinya dengan lebih mudah, menandai awal perjalanan bayi menuju jalan lahir.

2. Cavity Pelvis

Cavity pelvis atau rongga tengah panggul memiliki bentuk khas yang melengkung atau cekung. Bentuk ini memungkinkan kepala bayi untuk melakukan rotasi internal secara alami saat bergerak melewati rongga pelvis. Rotasi ini penting agar kepala bayi dapat menyesuaikan diri dengan diameter terkecil dari rongga pelvis, sehingga dapat melewati jalan lahir dengan lancar dan aman. Kombinasi antara kontraksi uterus dan dorongan ibu membantu bayi bergerak efektif melalui cavity pelvis ini.

3. Outlet Pelvis

Outlet pelvis adalah bagian terakhir dari true pelvis dan merupakan area terakhir sebelum bayi lahir. Area ini dibatasi oleh tulang ischium di sisi samping, sakrum di belakang, serta simfisis pubis di depan. Outlet pelvis merupakan area yang paling sempit dan kritis dalam proses kelahiran, sehingga ukuran, bentuk, serta elastisitasnya sangat menentukan apakah bayi dapat lahir secara spontan atau membutuhkan bantuan intervensi tambahan.

Struktur Jaringan Lunak dalam Persalinan

Selain struktur tulang, jaringan lunak seperti serviks, vagina, dan perineum juga mengalami adaptasi signifikan selama proses persalinan.

1. Serviks

Serviks atau leher rahim mengalami proses perubahan yang disebut effacement (penipisan) dan dilatasi (pembukaan). Sebelum persalinan, serviks biasanya tebal,

panjang, dan tertutup rapat. Dengan munculnya kontraksi uterus, serviks mulai melunak, menipis, dan terbuka secara bertahap hingga mencapai pembukaan penuh sekitar 10 sentimeter. Proses ini sangat penting untuk memungkinkan kepala bayi dapat melewati jalan lahir dengan aman.

2. Vagina

Vagina adalah saluran yang elastis, menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Selama proses persalinan, vagina mengalami peregangan yang sangat signifikan untuk memungkinkan bayi melewati jalan lahir. Elastisitas vagina merupakan faktor penting dalam mencegah cedera serius baik pada ibu maupun bayi, serta menjamin kelahiran berlangsung aman dan lancar.

3. Perineum

Perineum adalah area jaringan lunak antara vagina dan anus yang juga sangat elastis. Selama persalinan, perineum mengalami peregangan maksimal dan memiliki risiko robekan atau cedera jika tidak dikelola dengan tepat. Oleh karena itu, perlindungan perineum dengan teknik seperti pijatan, dukungan manual, serta pemilihan posisi persalinan yang tepat sangat penting untuk menjaga integritas perineum dan mencegah cedera.

B. Fisiologi Persalinan Normal

Persalinan normal adalah proses fisiologis alami di mana tubuh wanita mengalami perubahan bertahap yang bertujuan mengeluarkan bayi melalui jalan lahir. Proses ini dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan berakhir dengan kelahiran bayi serta plasenta. Persalinan normal memerlukan pemahaman mendalam mengenai tahap-tahapnya, agar bidan dan tenaga kesehatan lainnya mampu memberikan dukungan, pemantauan, serta intervensi yang tepat dan minimal agar proses persalinan berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi ibu dan bayi.

1. Kala I (Kala Pembukaan)

Kala pertama atau kala pembukaan adalah tahap awal persalinan yang ditandai oleh terjadinya kontraksi uterus secara progresif. Kontraksi uterus pada tahap ini memiliki tujuan utama yaitu untuk melunakkan, menipiskan (effacement), dan membuka (dilatasi) serviks secara bertahap hingga mencapai pembukaan penuh sekitar 10 sentimeter. Proses ini sangat penting, karena memberikan jalur terbuka bagi bayi untuk dapat melewati jalan lahir secara lancar dan aman.

Kala pertama persalinan ini terbagi menjadi dua fase penting, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten ditandai dengan kontraksi ringan hingga sedang yang terjadi secara tidak terlalu sering, biasanya setiap 10 hingga 20 menit sekali, dengan durasi sekitar 20 hingga 40 detik. Pada fase ini, serviks akan membuka perlahan dari kondisi tertutup rapat hingga mencapai pembukaan sekitar 4 sentimeter. Ibu biasanya

masih mampu melakukan aktivitas ringan dan merasa relatif nyaman. Dalam tahap ini, perasaan rileks dan tenang sangat penting untuk membantu kelancaran proses persalinan.

Setelah fase laten, persalinan memasuki fase aktif. Fase ini ditandai dengan kontraksi uterus yang semakin intens, kuat, teratur, dan lebih sering, terjadi setiap 3 hingga 5 menit sekali dengan durasi antara 40 hingga 60 detik. Selama fase ini, serviks mengalami pembukaan dari 4 hingga mencapai 10 sentimeter. Pada fase aktif ini, hormon oksitosin diproduksi dalam jumlah besar oleh tubuh ibu, yang memperkuat kontraksi uterus dan mempercepat pembukaan serviks secara signifikan. Ibu akan mulai merasakan nyeri yang lebih intens, sehingga dukungan emosional, fisik, dan psikologis dari tenaga kesehatan serta keluarga sangat penting untuk mempertahankan kenyamanan dan kepercayaan diri ibu selama fase ini.

2. Kala II (Kala Pengeluaran Bayi)

Kala kedua persalinan dimulai saat serviks sudah mengalami dilatasi penuh (10 sentimeter) hingga bayi berhasil dilahirkan. Tahap ini sering kali merupakan fase yang paling dinantikan, tetapi juga yang paling melelahkan bagi ibu. Pada tahap ini, ibu biasanya merasakan dorongan alami yang sangat kuat untuk mengejan karena kepala bayi sudah mulai turun melewati rongga panggul menuju jalan lahir. Dorongan mengejan ini dipicu oleh tekanan kepala bayi yang merangsang saraf-saraf di dasar panggul.

Pada tahap ini, kombinasi antara kontraksi uterus yang kuat dan tekanan intra-abdominal akibat dorongan mengejan oleh ibu akan membantu bayi keluar secara perlahan melalui jalan lahir. Selama proses ini, bayi akan melakukan serangkaian gerakan alami seperti fleksi kepala, rotasi internal, ekstensi, serta rotasi eksternal yang dikenal sebagai mekanisme persalinan normal. Gerakan ini membantu bayi menyesuaikan posisi kepala dan bahunya dengan struktur anatomi panggul ibu sehingga bayi dapat dilahirkan secara optimal, lancar, dan minim trauma.

Kala kedua berakhir dengan kelahiran bayi secara spontan. Setelah kelahiran bayi, tenaga kesehatan akan segera melakukan penanganan awal bayi baru lahir seperti membersihkan jalan napas, memastikan pernapasan yang baik, menjaga suhu tubuh bayi, dan menempatkan bayi untuk kontak kulit langsung dengan ibu guna memulai proses inisiasi menyusui dini (IMD).

3. Kala III (Kala Pengeluaran Plasenta)

Kala ketiga atau kala pengeluaran plasenta dimulai setelah bayi lahir hingga plasenta berhasil keluar dari rongga uterus. Setelah kelahiran bayi, kontraksi uterus akan kembali muncul dengan intensitas yang cukup kuat, bertujuan untuk melepaskan plasenta dari dinding rahim. Proses pelepasan ini biasanya terjadi dalam waktu 5 hingga 30 menit setelah kelahiran bayi. Penting bagi tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa plasenta keluar dalam keadaan utuh tanpa tertinggal sedikit pun dalam rongga uterus, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan perdarahan postpartum dan infeksi.

Dalam tahap ini, tenaga kesehatan biasanya melakukan manajemen aktif kala tiga, salah satunya adalah pemberian oksitosin untuk mempercepat kontraksi uterus sehingga plasenta dapat keluar secara lengkap, serta mengurangi risiko terjadinya perdarahan postpartum. Setelah plasenta lahir, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap plasenta untuk memastikan keutuhannya, serta menilai kondisi ibu secara keseluruhan agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut.

4. Kala IV (Kala Observasi)

Kala keempat atau kala observasi berlangsung selama dua jam pertama setelah kelahiran plasenta. Pada tahap ini, ibu dan bayi dipantau secara ketat oleh tenaga kesehatan. Periode ini sangat kritis, karena risiko perdarahan postpartum atau komplikasi lain paling tinggi terjadi pada masa ini. Tenaga kesehatan akan melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi umum ibu, termasuk pemeriksaan uterus untuk memastikan kontraksi uterus yang kuat dan mencegah perdarahan.

Selain kondisi fisik ibu, adaptasi awal bayi baru lahir juga menjadi perhatian utama pada fase ini. Tenaga kesehatan memastikan bayi dapat bernapas dengan baik, suhu tubuhnya tetap stabil, serta bayi berhasil memulai proses menyusui dengan baik. Edukasi tentang perawatan bayi baru lahir, teknik menyusui, kebersihan pribadi ibu, serta tanda-tanda komplikasi postpartum disampaikan kepada ibu dan keluarganya dalam tahap ini.

Pada kala observasi, dukungan psikologis dan emosional juga sangat penting untuk memastikan ibu merasa nyaman, tenang, dan percaya diri dalam menjalani perannya sebagai ibu baru. Tenaga kesehatan perlu menciptakan suasana yang nyaman dan penuh perhatian agar proses adaptasi ibu terhadap peran barunya berjalan optimal.

C. Mekanisme Persalinan Normal

Persalinan adalah proses fisiologis alami yang melibatkan serangkaian gerakan kompleks yang dilakukan bayi saat melewati jalan lahir ibu. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme persalinan normal sangat penting bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan persalinan yang aman, efektif, dan minimal intervensi. Gerakan-gerakan spesifik ini bertujuan membantu bayi menyesuaikan diri secara optimal dengan bentuk anatomi panggul ibu agar proses kelahiran berjalan lancar, tanpa trauma berlebihan bagi ibu maupun bayi.

1. *Engagement* (Masuknya Kepala Bayi ke Pintu Atas Panggul)

Engagement merupakan tahap awal mekanisme persalinan normal. Pada tahap ini, kepala bayi mulai memasuki pintu atas panggul (inlet pelvis) ibu. *Engagement* terjadi ketika diameter terbesar kepala bayi, yaitu diameter biparietal, telah berhasil melewati bidang pintu atas panggul. Umumnya kepala bayi masuk dengan posisi vertex (bagian belakang kepala) terlebih dahulu yang menjadi indikator kesiapan bayi untuk memasuki jalan lahir. Proses *engagement* bisa terjadi pada akhir masa kehamilan atau pada awal persalinan. Pada ibu yang pertama kali melahirkan (primigravida), *engagement* cenderung terjadi lebih awal, sekitar dua hingga tiga minggu sebelum persalinan, sementara pada ibu yang pernah melahirkan sebelumnya, proses ini bisa terjadi bersamaan dengan awal kontraksi persalinan.

2. *Descent* (Penurunan Kepala Bayi)

Setelah *engagement* terjadi, proses berikutnya adalah *descent* atau penurunan kepala bayi secara progresif ke dalam rongga panggul. Penurunan ini berlangsung secara bertahap akibat kontraksi uterus yang semakin kuat dan teratur, ditambah dengan tekanan intra-abdominal yang diberikan ibu melalui proses mengejan. *Descent* sangat dipengaruhi oleh kekuatan kontraksi uterus, posisi ibu saat persalinan, serta ukuran dan bentuk panggul ibu. Tahapan ini merupakan indikator penting kemajuan persalinan karena menunjukkan bahwa kepala bayi bergerak menuju jalan lahir. Evaluasi kemajuan *descent* dapat dilakukan melalui pemeriksaan dalam oleh tenaga kesehatan.

3. *Flexion* (Menunduknya Kepala Bayi)

Seiring dengan penurunan kepala bayi lebih dalam ke rongga panggul, secara alami kepala bayi akan melakukan fleksi atau gerakan menunduk ke arah dada. Fleksi ini bertujuan mengecilkan diameter kepala bayi yang melalui rongga panggul ibu, sehingga memudahkan kepala melewati bagian sempit pelvis dengan hambatan minimal. Diameter kepala bayi yang paling kecil, yaitu diameter suboksipitobregmatik, akan melintasi rongga pelvis terlebih dahulu. Gerakan fleksi ini penting dalam mengurangi hambatan mekanik pada saat kepala bayi bergerak turun dan meminimalisir risiko trauma pada ibu maupun bayi.

4. *Internal Rotation* (Rotasi Internal Kepala Bayi)

Tahap berikutnya adalah *internal rotation* atau rotasi internal. Gerakan ini terjadi secara alami akibat bentuk khas rongga panggul ibu yang melengkung atau cekung. Saat kepala bayi turun lebih dalam, kepala bayi akan berputar secara internal sekitar 45 hingga 90 derajat. Tujuan rotasi ini adalah agar posisi kepala bayi sesuai dengan bentuk panggul ibu yang lebih efisien untuk kelahiran. Rotasi internal membantu posisi diameter terkecil kepala bayi sejajar dengan diameter terbesar rongga panggul ibu. Gerakan ini biasanya terjadi secara bertahap selama penurunan kepala bayi berlangsung, dan berakhir ketika kepala bayi berada di dasar panggul (*pelvic floor*).

5. *Extension* (Ekstensi atau Mendongaknya Kepala Bayi)

Setelah melewati rongga tengah panggul dan mencapai outlet pelvis, kepala bayi akan melakukan gerakan ekstensi (mendongak ke atas). Pada fase ini, kepala bayi perlahan-lahan terangkat keluar dari jalan lahir, sementara leher bayi meregang. Gerakan ekstensi memungkinkan kepala bayi melewati area paling sempit dari jalan lahir dengan lancar. Ekstensi ini terjadi secara alami akibat tekanan dari dasar panggul ibu yang mengarah ke atas serta dorongan kontraksi uterus yang terus berlangsung. Kepala bayi lahir secara perlahan dengan gerakan seperti mendongak ke arah depan atas ibu, yang meminimalisir cedera jaringan lunak ibu, seperti robekan perineum atau trauma kepala bayi.

6. *Restitution* (Rotasi Eksternal Kepala Bayi)

Setelah kepala bayi lahir, terjadi restitusi atau rotasi eksternal. Gerakan ini merupakan proses alami di mana kepala bayi berputar kembali ke posisi anatomi semula agar sejajar dengan posisi bahunya yang masih berada di dalam panggul. Restitusi terjadi karena kepala sebelumnya telah melakukan rotasi internal untuk menyesuaikan diri dengan bentuk panggul. Gerakan ini sangat penting, karena membantu bahu bayi dalam posisi optimal untuk melewati jalan lahir dengan lancar. Restitusi biasanya terlihat jelas saat kepala bayi telah keluar dan tampak berputar sendiri secara spontan tanpa bantuan eksternal dari tenaga kesehatan.

7. *Expulsion* (Pengeluaran Bahu dan Tubuh Bayi)

Tahapan terakhir dari mekanisme persalinan normal adalah *expulsion*, yaitu kelahiran bahu dan seluruh tubuh bayi. Setelah kepala lahir dan melakukan restitusi, bahu bayi akan segera turun menuju jalan lahir. Bahu depan bayi biasanya melewati jalan lahir terlebih dahulu dengan lembut, diikuti oleh bahu belakang bayi. Setelah kedua bahu berhasil keluar, tubuh bayi akan menyusul dengan mudah dan relatif cepat. Proses ini terjadi hampir spontan dengan dorongan kontraksi uterus dan usaha mengejan ibu yang berlangsung secara alami. Tenaga kesehatan bertugas memberikan dukungan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa bayi lahir dengan aman dan segera diberikan asuhan bayi baru lahir yang tepat.

Pemahaman tentang mekanisme persalinan normal sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, karena akan menentukan kualitas dukungan serta intervensi yang dilakukan selama proses persalinan berlangsung. Dengan memahami tahapan-tahapan ini secara detail, tenaga kesehatan dapat mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan hambatan atau komplikasi yang mungkin muncul lebih dini. Selain itu, pengetahuan ini membantu tenaga kesehatan memberikan edukasi yang efektif kepada ibu dan keluarga, sehingga mereka merasa lebih tenang, siap, serta percaya diri menghadapi persalinan.

D. Adaptasi Fisiologis Ibu dan Janin

Selama proses persalinan, tubuh ibu dan janin mengalami adaptasi fisiologis signifikan untuk menghadapi stres fisik dan emosional dari proses kelahiran. Adaptasi ini bersifat sementara namun sangat penting dalam menjamin kelangsungan dan keselamatan proses persalinan.

1. Adaptasi Fisiologis Pada Ibu

a. Perubahan Kardiovaskular dan Respirasi

Selama persalinan, tubuh ibu mengalami beberapa perubahan fisiologis penting yang bertujuan mendukung kelahiran bayi. Salah satu perubahan utama adalah peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta laju pernapasan ibu. Respons fisiologis ini merupakan mekanisme tubuh dalam menghadapi rasa nyeri serta stres fisik yang dialami selama kontraksi uterus berlangsung.

b. Perubahan Hormonal

Salah satu hormon yang meningkat secara signifikan selama persalinan adalah oksitosin. Oksitosin diproduksi dalam jumlah besar oleh tubuh ibu dan berperan krusial dalam memperkuat serta mempercepat kontraksi uterus, sehingga membantu proses dilatasi serviks dan mendorong bayi melewati jalan lahir dengan efektif.

c. Peningkatan Metabolisme dan Kebutuhan Energi

Kebutuhan energi selama persalinan meningkat tajam karena kerja otot uterus yang intensif dan proses mengejan yang dilakukan ibu. Oleh karena itu, tubuh akan secara alami meningkatkan metabolisme untuk menyediakan energi yang dibutuhkan, memastikan ibu memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan proses persalinan.

2. Adaptasi Fisiologis Pada Janin

a. Redistribusi Aliran Darah

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi janin adalah penurunan sementara aliran darah akibat kontraksi uterus yang kuat dan berulang. Situasi ini menyebabkan janin harus segera mengaktifkan mekanisme kompensasi, yaitu redistribusi aliran darah ke organ-organ vital seperti otak, jantung, dan kelenjar

adrenal. Dengan demikian, janin mampu mempertahankan fungsi vitalnya meskipun dalam kondisi stres selama kontraksi.

b. Persiapan Fungsi Paru-Paru

Selama melewati jalan lahir, tekanan mekanis yang dialami kepala dan dada bayi membantu mengeluarkan cairan dari paru-paru janin. Proses ini merupakan langkah krusial dalam mempersiapkan paru-paru agar mampu melakukan pernapasan spontan segera setelah lahir.

c. Kematangan Sistem Saraf dan Endokrin

Janin juga menunjukkan aktivasi sistem endokrin, termasuk peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol, yang berfungsi mematangkan organ-organ vital, terutama paru-paru dan sistem kardiovaskular, sebagai bagian dari transisi menuju kehidupan ekstrauterin.

Adaptasi fisiologis ini memastikan bahwa ibu dan bayi mampu melewati proses persalinan dengan aman dan optimal. Dengan memahami perubahan-perubahan ini, tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan yang lebih baik dan memberikan intervensi yang diperlukan untuk mencegah komplikasi. Pemahaman mendalam mengenai adaptasi fisiologis ini juga membantu tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan dukungan emosional kepada ibu, sehingga ibu merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalani persalinan.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Identifikasi Anatomi Pelvis

- Gambarlah dan jelaskan secara rinci anatomi pelvis wanita yang terdiri atas inlet, cavity, dan outlet.
- Uraikan bagaimana masing-masing bagian ini berkontribusi terhadap proses persalinan normal.

Tugas 2: Analisis Fisiologi Persalinan Normal

- Jelaskan secara rinci perubahan yang terjadi pada serviks selama Kala I persalinan (fase laten dan aktif).
- Buatlah tabel perbandingan tentang intensitas, durasi, dan frekuensi kontraksi uterus pada fase laten dan fase aktif.

Tugas 3: Simulasi Mekanisme Persalinan Normal

- Gambarkan atau buat diagram yang menunjukkan secara detail tahapan gerakan bayi selama proses persalinan normal, mulai dari engagement hingga expulsion.

- Jelaskan secara detail pentingnya gerakan fleksi dan rotasi internal kepala bayi dalam memudahkan proses kelahiran.

Tugas 4: Studi Kasus Adaptasi Fisiologis Ibu saat Persalinan

- Pilih satu kasus nyata atau simulasi terkait adaptasi fisiologis ibu selama persalinan (misalnya peningkatan denyut jantung dan tekanan darah).
- Analisis mengapa perubahan ini penting terjadi dan bagaimana Anda sebagai bidan bisa memantau serta mengelola respons fisiologis tersebut agar tidak menyebabkan komplikasi.

Tugas 5: Evaluasi Adaptasi Fisiologis pada Janin selama Persalinan

- Jelaskan secara detail bagaimana janin melakukan redistribusi aliran darah sebagai respons terhadap kontraksi uterus yang kuat.
- Analisis pentingnya tekanan mekanis yang dialami kepala bayi saat melewati jalan lahir untuk proses adaptasi paru-paru dan inisiasi bernapas spontan setelah lahir.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu hamil usia 28 tahun datang ke klinik bersalin dengan pembukaan serviks 3 cm dan kontraksi uterus ringan-sedang.
Berdasarkan kondisi ini, ibu tersebut berada dalam tahap persalinan yang mana?
A. Kala II
B. Kala III
C. Fase aktif Kala I
D. Fase laten Kala I
E. Kala IV
2. Seorang ibu bersalin mengalami kontraksi intens setiap 3 menit dengan durasi 50 detik, pembukaan serviks mencapai 8 cm.
Kondisi ini menunjukkan ibu sedang dalam tahap persalinan yang mana?
A. Fase aktif Kala I
B. Kala observasi
C. Kala pengeluaran plasenta
D. Kala pengeluaran bayi
E. Fase laten Kala I
3. Saat melakukan pemeriksaan panggul pada ibu hamil, bidan menjelaskan bahwa kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul.
Kondisi ini disebut dengan tahap mekanisme persalinan apa?

- A. Fleksi
 - B. Descent
 - C. Extension
 - D. Engagement
 - E. Restitusi
4. Selama persalinan, seorang ibu mengalami peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta laju pernapasan.
Manakah alasan fisiologis yang menjelaskan perubahan ini?
- A. Penurunan hormon oksitosin
 - B. Kelelahan fisik yang berlebihan
 - C. Ketidakcukupan asupan cairan
 - D. Kondisi anemia berat
 - E. Adaptasi tubuh terhadap nyeri dan stres fisik kontraksi uterus
5. Seorang bidan sedang membantu persalinan normal. Ia melihat kepala bayi sudah lahir dan segera setelahnya kepala bayi berputar kembali ke posisi anatomi semula sejajar dengan bahu yang masih di dalam panggul.
Gerakan ini disebut?
- A. Rotasi internal
 - B. Restitusi
 - C. Fleksi
 - D. Ekstensi
 - E. Engagement

Kunci Jawaban

1. Jawaban: D. Fase laten Kala I
Pembahasan: Fase laten pada kala pertama persalinan ditandai dengan pembukaan serviks hingga 4 cm dengan kontraksi ringan hingga sedang. Kondisi ibu dengan pembukaan 3 cm menunjukkan fase laten.
2. Jawaban: A. Fase aktif Kala I
Pembahasan: Fase aktif Kala I berlangsung dari pembukaan 4 hingga 10 cm dengan kontraksi uterus yang semakin kuat, intens, dan teratur, yaitu sekitar setiap 3-5 menit dengan durasi 40-60 detik.
3. Jawaban: D. Engagement
Pembahasan: Engagement adalah tahap awal mekanisme persalinan, di mana diameter terbesar kepala bayi telah melewati pintu atas pelvis (inlet pelvis).

4. Jawaban: E. Adaptasi tubuh terhadap nyeri dan stres fisik kontraksi uterus

Pembahasan: Adaptasi fisiologis tubuh selama persalinan mencakup peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan laju pernapasan sebagai respons alami terhadap nyeri dan stres akibat kontraksi uterus.

5. Jawaban: B. Restitusi

Pembahasan: Restitusi adalah gerakan rotasi eksternal kepala bayi setelah lahir yang bertujuan mengembalikan kepala bayi ke posisi anatomi semula, membantu bahu bayi menyesuaikan posisinya untuk melewati jalan lahir.

Rangkuman Materi

Pelvis wanita terdiri dari dua bagian utama yaitu pelvis mayor (false pelvis) dan pelvis minor (true pelvis). Pelvis mayor merupakan bagian atas yang luas dan berfungsi sebagai pendukung organ abdominal seperti usus, kandung kemih, dan organ reproduksi internal. Bagian ini tidak terlibat langsung dalam proses kelahiran. Sebaliknya, pelvis minor atau true pelvis merupakan bagian yang sempit dan sangat berperan dalam proses persalinan. True pelvis terdiri dari inlet pelvis yang merupakan pintu masuk panggul berbentuk oval dan menentukan kemudahan kepala bayi masuk ke panggul; cavity pelvis, rongga melengkung yang memfasilitasi rotasi kepala bayi; serta outlet pelvis, area terakhir sebelum bayi lahir yang paling sempit dan dibatasi oleh tulang ischium, sakrum, serta simfisis pubis.

Struktur jaringan lunak juga berperan penting selama persalinan. Serviks mengalami pelembutan, penipisan (effacement), dan pembukaan (dilatasi) hingga mencapai 10 cm agar kepala bayi dapat melewatinya. Vagina yang elastis meregang signifikan selama proses kelahiran bayi, sedangkan perineum, jaringan antara vagina dan anus, juga mengalami peregangan maksimal sehingga berisiko cedera apabila tidak dikelola secara baik.

Persalinan normal merupakan proses fisiologis yang ditandai oleh kontraksi uterus yang teratur, progresif, dan bertujuan untuk membuka serviks agar bayi dapat lahir melalui jalan lahir. Proses ini terdiri dari empat tahap utama. Kala pertama adalah tahap pembukaan, dimulai dari kontraksi uterus pertama hingga serviks mencapai dilatasi penuh sekitar 10 cm. Kala ini terbagi atas fase laten yang kontraksinya ringan hingga sedang dengan pembukaan hingga 4 cm, dan fase aktif dengan kontraksi yang intens serta pembukaan hingga 10 cm. Kala kedua merupakan tahap pengeluaran bayi, di mana ibu merasakan dorongan kuat untuk mengejan, dan bayi bergerak turun melalui rongga panggul sambil melakukan gerakan fleksi, rotasi internal, ekstensi, dan rotasi eksternal hingga lahir secara spontan. Kala ketiga adalah pengeluaran plasenta, di mana uterus

kembali berkontraksi untuk melepas plasenta dari dinding rahim, biasanya dalam 5-30 menit setelah kelahiran bayi. Kala keempat atau kala observasi berlangsung dua jam setelah plasenta keluar, di mana kondisi ibu dipantau secara intensif untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan postpartum, sekaligus memastikan adaptasi awal bayi berjalan optimal.

Mekanisme persalinan normal terdiri atas beberapa gerakan spesifik yang dilakukan oleh bayi saat melewati rongga panggul ibu. Awalnya terjadi engagement, yaitu kepala bayi memasuki inlet pelvis. Setelah itu, kepala bayi mengalami penurunan (descent) akibat kontraksi uterus dan dorongan ibu. Saat turun, kepala bayi melakukan fleksi untuk mengecilkan diameter kepala sehingga lebih mudah melewati rongga panggul. Kemudian terjadi rotasi internal mengikuti bentuk pelvis ibu, dilanjutkan dengan ekstensi kepala saat melewati outlet pelvis. Setelah kepala keluar, kepala bayi melakukan restitusi atau rotasi eksternal untuk menyesuaikan posisi bahu agar dapat melewati jalan lahir, diikuti kelahiran bahu dan tubuh bayi secara keseluruhan.

Selama proses persalinan, tubuh ibu mengalami adaptasi fisiologis berupa peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta laju pernapasan sebagai respons terhadap nyeri dan stres fisik. Hormon oksitosin meningkat tajam, memperkuat kontraksi uterus serta membantu dilatasi serviks. Metabolisme ibu juga meningkat guna memenuhi kebutuhan energi selama persalinan. Di sisi lain, janin menghadapi penurunan aliran darah sementara akibat kontraksi uterus yang kuat, sehingga janin melakukan redistribusi darah ke organ vital seperti otak, jantung, dan kelenjar adrenal untuk mempertahankan fungsi vitalnya. Tekanan pada kepala bayi selama melewati jalan lahir membantu pengeluaran cairan dari paru-paru, mempersiapkan bayi untuk bernapas setelah lahir. Adaptasi fisiologis ini penting dipahami agar tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan yang baik, memberikan intervensi yang tepat, serta membantu ibu menjalani proses persalinan dengan aman dan optimal.

Glosarium

Anatomi: Cabang ilmu yang mempelajari struktur dan bentuk tubuh manusia serta hubungan antar bagian-bagiannya.

Adaptasi Fisiologis: Perubahan alami pada tubuh ibu dan janin selama proses persalinan untuk mengatasi stres fisik dan emosional akibat kontraksi uterus dan proses kelahiran.

Adaptasi Paru-Paru Janin: Persiapan paru-paru janin untuk bernapas spontan setelah kelahiran, dipicu oleh tekanan mekanis pada kepala bayi saat melewati jalan lahir yang membantu mengeluarkan cairan paru.

Cavity Pelvis: Rongga tengah panggul yang memiliki bentuk melengkung atau cekung, memfasilitasi rotasi internal kepala bayi agar dapat melewati jalan lahir dengan lancar.

Descent: Penurunan kepala bayi secara progresif ke dalam rongga panggul ibu akibat kontraksi uterus dan dorongan ibu.

Dilatasi Serviks: Proses pembukaan serviks secara bertahap hingga mencapai diameter penuh (sekitar 10 cm), memungkinkan kepala bayi melewati jalan lahir.

Effacement: Proses penipisan serviks sebelum dan selama persalinan, memungkinkan dilatasi penuh untuk memfasilitasi jalan lahir bayi.

Engagement: Masuknya bagian terbesar kepala bayi melewati bidang inlet pelvis, menandakan awal perjalanan bayi menuju jalan lahir.

Expulsion: Proses kelahiran bahu dan tubuh bayi secara keseluruhan setelah kepala bayi lahir dan restitusi selesai dilakukan.

Extension (Ekstensi Kepala): Gerakan kepala bayi terangkat saat melewati bagian outlet pelvis, membantu kelahiran kepala bayi secara perlahan dan aman.

Fleksi: Gerakan kepala bayi menunduk ke arah dada untuk memperkecil diameter kepala, sehingga memudahkan kepala bayi melewati rongga panggul.

Inlet Pelvis: Bagian teratas dari pelvis minor yang berbentuk oval dengan diameter transversal lebih lebar dibanding diameter anteroposterior, merupakan pintu masuk awal yang harus dilalui oleh kepala bayi selama proses kelahiran.

Internal Rotation (Rotasi Dalam): Gerakan kepala bayi berputar secara internal mengikuti bentuk rongga pelvis ibu untuk menyesuaikan posisi optimal selama proses kelahiran.

Kala I (Kala Pembukaan): Tahapan persalinan yang ditandai oleh kontraksi uterus progresif yang menyebabkan pelembutan, penipisan, dan pembukaan serviks dari 0 hingga 10 cm. Terdiri dari fase laten (0–4 cm) dan fase aktif (4–10 cm).

Kala II (Kala Pengeluaran Bayi): Tahapan persalinan di mana ibu merasakan dorongan kuat untuk mengejan, dimulai saat serviks dilatasi penuh (10 cm) hingga bayi dilahirkan.

Kala III (Kala Pengeluaran Plasenta): Tahapan persalinan setelah bayi lahir, uterus kembali berkontraksi kuat untuk melepaskan dan mengeluarkan plasenta dalam waktu 5 hingga 30 menit setelah kelahiran bayi.

Kala IV (Kala Observasi): Dua jam pertama setelah kelahiran plasenta, masa observasi ketat untuk memastikan tidak terjadi komplikasi seperti perdarahan postpartum serta memastikan adaptasi awal bayi berlangsung optimal.

Kontraksi Uterus: Gerakan otot rahim yang teratur dan progresif, bertujuan membuka serviks serta mendorong bayi keluar melalui jalan lahir.

Oksitosin: Hormon yang diproduksi tubuh selama persalinan, berperan penting dalam memperkuat dan mempercepat kontraksi uterus serta membantu proses dilatasi serviks.

Outlet Pelvis: Bagian paling bawah dan sempit dari true pelvis, dibatasi oleh tulang ischium, sakrum, dan simfisis pubis, area terakhir yang dilalui oleh bayi saat kelahiran.

Pelvis: Rangka tulang panggul yang membentuk dasar tubuh, terdiri dari dua bagian utama: pelvis mayor (false pelvis) dan pelvis minor (true pelvis).

Pelvis Mayor (False Pelvis): Bagian atas rongga panggul yang lebih luas, berfungsi sebagai pendukung organ abdominal bawah seperti usus, kandung kemih, dan organ reproduksi internal, tidak terlibat langsung dalam proses kelahiran.

Pelvis Minor (True Pelvis): Bagian bawah rongga panggul yang sempit, secara langsung terlibat dalam proses persalinan, terdiri dari inlet pelvis, cavity pelvis, dan outlet pelvis.

Perineum: Jaringan lunak elastis yang terletak antara vagina dan anus, mengalami peregangan maksimal selama persalinan, berisiko robekan jika tidak ditangani dengan baik.

Persalinan Normal: Proses fisiologis yang terjadi secara alami, dimulai dengan kontraksi uterus yang teratur dan berakhir dengan kelahiran bayi serta plasenta, berlangsung dalam empat tahapan (Kala I hingga Kala IV).

Perdarahan Postpartum: Kondisi komplikasi berupa perdarahan yang terjadi setelah persalinan, biasanya selama kala III dan kala IV, yang perlu dipantau secara ketat untuk dicegah.

Redistribusi Aliran Darah: Mekanisme kompensasi janin selama persalinan akibat penurunan sementara aliran darah, dengan mengutamakan suplai darah ke organ-organ vital seperti otak, jantung, dan kelenjar adrenal.

Restitusi (Rotasi Luar): Gerakan kepala bayi yang kembali berputar ke posisi anatomis semula setelah keluar dari jalan lahir, membantu bahu bayi menyesuaikan posisi untuk kelahiran berikutnya.

Serviks: Leher rahim yang menghubungkan uterus dengan vagina, mengalami proses effacement (penipisan) dan dilatasi (pembukaan) hingga 10 sentimeter selama persalinan.

Vagina: Saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, meregang signifikan saat persalinan untuk memungkinkan bayi lahir dengan aman.

Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Practice Bulletin No. 183: Postpartum hemorrhage. *Obstetrics & Gynecology*, 135(5), e168–e186.
<https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003756>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2021). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
<https://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=2709>
- Greenberg, M. P., & Grimes, D. A. (2018). The physiology of the second stage of labor. *Obstetrics & Gynecology Clinics of North America*, 45(2), 197–207.
<https://doi.org/10.1016/j.ogc.2018.01.006>
- Gülmezoglu, A. M., Souza, J. P., & Vogel, J. P. (2019). Evidence-based interventions for improving maternal and newborn health. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 60, 87–103.
<https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2019.04.005>
- King, T. L., & Hameed, F. (2020). Fetal physiology and the management of the distressed fetus. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 32(2), 99–106.
<https://doi.org/10.1097/GCO.0000000000000590>
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., & Alden, K. R. (2021). *Maternity and Women's Health Care* (12th ed.). Elsevier.
<https://www.elsevier.com/books/maternity-and-womens-health-care/lowdermilk/978-0-323-54420-9>
- Moore, K. L., Dalley, A. F., & Agur, A. M. R. (2020). *Clinically Oriented Anatomy* (8th ed.). Wolters Kluwer.
<https://shop.lww.com/Clinically-Oriented-Anatomy/p/9781496392328>
- Schafer, K., & Geller, S. E. (2021). Mechanisms of normal labor and delivery. In *UpToDate*. Wolters Kluwer.
<https://www.uptodate.com/contents/mechanisms-of-normal-labor-and-delivery>
- Smith, J., & Kildea, S. (2018). Physiological changes in pregnancy: adaptation to pregnancy. *Australian Family Physician*, 47(3), 85–89.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29533045/>
- Young, C. L., & Wong, J. (2019). Adaptations of the maternal cardiovascular system during labor and delivery. *Journal of Perinatal Medicine*, 47(7), 685–692.
<https://doi.org/10.1515/jpm-2018-0414>

Bab 3

Asuhan Antenatal Menuju Persalinan

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologis yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Asuhan antenatal menjadi penting untuk memastikan persiapan yang optimal menjelang persalinan. Asuhan ini meliputi skrining risiko kehamilan, konseling informed choice dan birth plan, persiapan lingkungan serta tim persalinan, hingga edukasi mengenai tanda-tanda awal persalinan. Seluruh aspek tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko komplikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan selama proses persalinan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan antenatal komprehensif yang meliputi skrining risiko kehamilan, konseling informed choice dan birth plan, persiapan lingkungan serta tim persalinan, serta edukasi mengenai tanda-tanda awal persalinan secara profesional dan berbasis bukti ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu:

1. Melakukan skrining risiko kehamilan secara tepat dan sistematis.
2. Melakukan konseling informed choice dan birth plan secara efektif dan empatik.
3. Menyiapkan lingkungan persalinan serta tim yang mendukung proses persalinan yang aman dan nyaman.
4. Memberikan edukasi yang jelas mengenai tanda-tanda awal persalinan kepada ibu hamil dan keluarga.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi berbagai risiko kehamilan melalui skrining yang akurat.
2. Menjelaskan pilihan-pilihan persalinan serta menghormati keputusan ibu melalui konseling *informed choice*.
3. Menyusun birth plan yang sesuai dengan kondisi klinis dan keinginan ibu.
4. Mengorganisasi lingkungan persalinan yang aman dan nyaman untuk ibu dan tim kesehatan.
5. Mengenali dan menjelaskan tanda-tanda awal persalinan secara sederhana dan jelas kepada ibu dan keluarganya.

A. Skrining Risiko Kehamilan

Skrining risiko kehamilan adalah proses sistematis untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan. Proses ini sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan ibu dan janin serta memprediksi kemungkinan risiko yang dapat terjadi menjelang persalinan. Skrining risiko kehamilan dimulai dengan anamnesis yang mendalam, di mana bidan atau tenaga kesehatan menggali informasi penting terkait riwayat kesehatan ibu, seperti usia, riwayat obstetri sebelumnya (misalnya riwayat keguguran, persalinan prematur, kelahiran bayi dengan berat rendah, preeklamsia, atau diabetes gestasional), riwayat medis keluarga (penyakit bawaan atau keturunan), serta gaya hidup ibu termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan lainnya.

Pemeriksaan fisik yang teliti menjadi langkah selanjutnya dalam proses skrining ini, meliputi pemeriksaan umum seperti tekanan darah, pemeriksaan tinggi dan berat badan, pengukuran lingkar perut, serta evaluasi tanda vital lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan seperti hipertensi kehamilan atau tanda-tanda preeklamsia, pertumbuhan janin yang tidak sesuai usia kehamilan, dan kondisi fisik ibu yang kurang optimal untuk mendukung kehamilan yang sehat.

Selain anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang juga memiliki peran penting dalam skrining risiko kehamilan. Ultrasonografi (USG) dilakukan secara rutin untuk menilai perkembangan janin, posisi janin, kondisi plasenta, volume air ketuban, serta kemungkinan adanya kelainan struktural pada janin. Pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap, gula darah, urin, tes serologi, dan skrining infeksi seperti HIV, hepatitis, serta sifilis juga perlu dilakukan untuk mendeteksi infeksi atau kondisi patologis yang berpotensi mengganggu kehamilan.

Pemantauan tekanan darah secara rutin merupakan bagian penting dari skrining risiko kehamilan, terutama untuk mencegah komplikasi serius seperti preeklamsia dan eklamsia yang dapat menyebabkan risiko tinggi selama persalinan. Pemantauan ini dilakukan dengan interval teratur selama kunjungan antenatal, sehingga memungkinkan deteksi dini dan manajemen yang cepat jika terjadi penyimpangan dari kondisi normal.

Identifikasi faktor risiko secara komprehensif akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk membuat rencana intervensi pencegahan yang sesuai, seperti edukasi kesehatan, perubahan pola hidup sehat, perencanaan persalinan yang lebih aman, serta koordinasi dengan spesialis lain jika diperlukan. Dengan melakukan skrining

secara efektif, risiko komplikasi selama persalinan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga keselamatan ibu dan bayi menjadi prioritas utama.

B. Konseling *Informed Choice* dan *Birth Plan*

Konseling *informed choice* merupakan bagian penting dalam asuhan antenatal yang bertujuan memberikan informasi lengkap dan jelas kepada ibu hamil mengenai berbagai pilihan yang tersedia selama proses persalinan. Melalui konseling ini, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ibu memperoleh pemahaman mendalam tentang pilihan yang ada, mencakup manfaat, risiko, efek samping, serta implikasi jangka pendek dan jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, ibu dapat membuat keputusan secara mandiri dan penuh kesadaran (*informed consent*).

Dalam konseling *informed choice*, beberapa aspek penting perlu dijelaskan dengan detail, antara lain:

- **Metode persalinan:** Penjelasan mengenai metode persalinan normal, operasi sesar, persalinan dengan bantuan alat seperti vakum atau forceps, serta keuntungan dan risiko masing-masing metode tersebut.
- **Lokasi persalinan:** Opsi tempat persalinan seperti rumah sakit, klinik bersalin, rumah bersalin, atau persalinan di rumah, beserta kelebihan dan keterbatasannya masing-masing.
- **Manajemen nyeri persalinan:** Penjelasan berbagai metode pengelolaan nyeri seperti teknik pernapasan, relaksasi, hypnobirthing, penggunaan analgesia epidural, serta metode non-farmakologis lainnya.
- **Pendamping persalinan:** Informasi tentang pentingnya pendampingan selama persalinan, peran pendamping, dan pilihan siapa saja yang dapat mendampingi ibu.
- **Intervensi medis tambahan:** Penjelasan tentang kemungkinan intervensi seperti induksi persalinan, episiotomi, pemantauan janin secara kontinu, serta alasan dan kondisi tertentu yang mungkin memerlukan intervensi tersebut.

Setelah proses konseling, ibu diajak menyusun dokumen *birth plan* yang mencerminkan preferensi pribadinya. *Birth plan* adalah dokumen tertulis yang merinci pilihan ibu mengenai aspek-aspek penting selama persalinan, meliputi:

- Lokasi yang diinginkan untuk persalinan.
- Orang yang diizinkan mendampingi selama persalinan.
- Pilihan metode manajemen nyeri.
- Intervensi medis yang disetujui atau ditolak secara eksplisit oleh ibu.
- Preferensi ibu terkait tindakan medis lainnya, seperti pemotongan tali pusat tertunda atau segera, skin-to-skin contact, dan metode pemberian ASI pertama kali.

Proses penyusunan birth plan bukan hanya mendukung keputusan ibu tetapi juga memperkuat peran aktifnya dalam proses persalinan. Selain itu, birth plan meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara ibu, keluarga, dan tim kesehatan, sehingga proses persalinan dapat berjalan sesuai harapan ibu dan lebih aman. Dengan adanya birth plan, ibu akan merasa lebih terlibat, dihargai, dan puas terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya.

C. Persiapan Lingkungan dan Tim Persalinan

Persiapan lingkungan dan tim persalinan merupakan langkah penting untuk memastikan proses persalinan berjalan lancar, aman, nyaman, serta meminimalkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.

Persiapan ini harus dilakukan dengan teliti dan mencakup beberapa aspek utama berikut:

1. Penataan Ruang Persalinan

Ruang bersalin harus disiapkan dengan baik agar mampu mendukung kenyamanan ibu serta efisiensi kerja tim medis. Kondisi ruangan harus bersih, steril, terang namun tidak menyilaukan, dengan suhu yang nyaman bagi ibu yang akan melahirkan. Penataan ruang perlu memperhatikan ergonomi, sehingga memungkinkan tim medis bergerak dengan leluasa dan cepat merespons situasi darurat.

Ruang bersalin harus dilengkapi dengan tempat tidur yang nyaman untuk ibu, alat-alat medis seperti alat pemantauan janin (cardiotocography/CTG), alat resusitasi bayi baru lahir, peralatan steril untuk pemotongan tali pusat, set episiotomi, serta perlengkapan lainnya yang mungkin diperlukan selama persalinan. Tersedianya fasilitas air hangat, pencahayaan yang dapat disesuaikan, serta ruang pendamping juga akan sangat mendukung kenyamanan ibu.

2. Persiapan Alat-Alat Medis

Ketersediaan alat-alat medis secara lengkap dan siap pakai adalah mutlak dalam persiapan persalinan. Alat-alat penting yang harus tersedia antara lain:

- **Alat resusitasi neonatal:** untuk menangani bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan atau kondisi darurat lainnya.
- **Monitor janin:** alat ini digunakan untuk memantau kondisi detak jantung janin dan kontraksi uterus ibu selama proses persalinan.
- **Peralatan steril:** mencakup peralatan untuk tindakan episiotomi, gunting pemotong tali pusat, kasa steril, dan lainnya.
- **Peralatan pendukung lain:** seperti oksigen, cairan infus, alat suction (penghisap lendir), dan obat-obatan yang mungkin diperlukan selama proses persalinan.

Pengecekan rutin alat-alat medis ini sebelum proses persalinan sangat penting untuk memastikan semua alat berfungsi dengan baik dan steril sehingga siap digunakan kapan saja dibutuhkan.

3. Persiapan Tim Persalinan

Persiapan tim persalinan melibatkan penyusunan tim multidisiplin yang terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten dan berpengalaman, seperti bidan, dokter kandungan, perawat, serta tenaga pendukung lainnya seperti asisten kebidanan atau tenaga nonmedis untuk logistik. Setiap anggota tim harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta mengetahui dengan jelas alur komunikasi dalam tim.

Koordinasi yang baik antaranggota tim sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses persalinan dan respons yang tepat dalam situasi darurat. Tim persalinan harus memiliki rencana tindakan darurat dan komunikasi yang jelas, sehingga setiap anggota tim mampu mengambil tindakan yang efektif dalam waktu singkat bila terjadi komplikasi. Selain kompetensi teknis, tim persalinan juga harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga selama proses persalinan. Pelatihan rutin mengenai skenario persalinan normal maupun komplikasi harus dilakukan agar tim tetap siap dalam segala kondisi.

D. Edukasi Tanda Awal Persalinan

Edukasi mengenai tanda-tanda awal persalinan merupakan aspek krusial dalam asuhan antenatal. Dengan edukasi yang tepat, ibu dan keluarga akan lebih siap menghadapi persalinan dengan percaya diri dan mengetahui waktu yang tepat untuk segera mendapatkan bantuan medis. Edukasi ini bertujuan agar ibu dan keluarganya mampu mengenali tanda-tanda yang menunjukkan persalinan telah dimulai, sehingga mengurangi risiko komplikasi akibat keterlambatan tindakan.

Tanda-tanda awal persalinan yang perlu dikenali secara detail adalah sebagai berikut:

1. Kontraksi Uterus yang Teratur dan Semakin Kuat

Kontraksi uterus yang teratur menjadi tanda penting bahwa proses persalinan telah dimulai. Kontraksi ini biasanya dimulai dengan interval yang panjang dan intensitas ringan hingga sedang, kemudian secara bertahap menjadi lebih teratur, kuat, sering, dan nyeri. Kontraksi persalinan yang sebenarnya tidak berkurang dengan aktivitas atau perubahan posisi tubuh ibu, tetapi justru semakin intens dan frekuensinya meningkat.

2. Bloody Show (Lendir Bercampur Darah)

Bloody show adalah keluarnya lendir yang bercampur dengan sedikit darah dari vagina. Kondisi ini merupakan hasil dari pelepasan sumbat lendir yang selama kehamilan menutup serviks. Meskipun bloody show dapat terjadi beberapa hari sebelum persalinan aktif dimulai, kemunculannya merupakan tanda bahwa serviks mulai melebar dan proses persalinan semakin dekat.

3. Pecahnya Ketuban

Pecahnya ketuban adalah keluarnya cairan amnion yang bisa terjadi tiba-tiba dalam jumlah banyak atau secara perlahan sedikit demi sedikit. Cairan ketuban umumnya jernih, tidak berwarna, dan memiliki bau khas yang berbeda dengan urin. Ibu perlu segera menghubungi tenaga medis jika ketuban pecah, karena risiko infeksi dan komplikasi meningkat setelah pecahnya ketuban, terutama jika persalinan tidak segera dimulai.

4. Nyeri Punggung Bawah yang Menetap

Nyeri punggung bawah yang menetap dan terasa semakin intens juga merupakan tanda persalinan yang tidak boleh diabaikan. Nyeri ini biasanya terasa konstan dan sering menyertai kontraksi uterus. Nyeri tersebut disebabkan oleh tekanan kepala bayi terhadap tulang belakang dan panggul ibu.

5. Perubahan Serviks

Perubahan pada serviks yang meliputi pelunakan, pemendekan, dan pembukaan (dilatasi) hanya dapat dinilai secara klinis oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dalam. Perubahan serviks menunjukkan proses persalinan sedang berlangsung atau akan segera dimulai. Pemeriksaan ini penting untuk menilai kemajuan persalinan dan menentukan tindakan selanjutnya.

Dengan edukasi yang jelas dan terperinci mengenai tanda-tanda awal persalinan ini, ibu akan merasa lebih tenang dan percaya diri untuk menghadapi persalinan. Pengetahuan ini memungkinkan ibu dan keluarganya mengambil keputusan yang tepat waktu dan sesuai, sehingga keselamatan ibu dan janin dapat terjamin.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Studi Kasus Skrining Risiko Kehamilan

Mahasiswa diminta membuat studi kasus tentang seorang ibu hamil yang menjalani skrining risiko kehamilan. Mahasiswa harus mengidentifikasi dan menjelaskan secara rinci minimal lima faktor risiko yang muncul dari anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang, dan membuat rekomendasi tindakan pencegahan atau intervensi berdasarkan faktor risiko tersebut.

Tugas 2: Perancangan Birth Plan

Mahasiswa ditugaskan untuk menyusun birth plan yang komprehensif berdasarkan hasil konseling informed choice untuk seorang ibu dengan kehamilan risiko rendah yang menginginkan persalinan normal. Birth plan harus mencakup pilihan lokasi persalinan, metode manajemen nyeri, intervensi medis yang disetujui atau ditolak, serta peran pendamping selama proses persalinan.

Tugas 3: Simulasi Penataan Ruang Persalinan

Mahasiswa diminta untuk mendesain sketsa ruang persalinan ideal. Dalam tugas ini, mahasiswa harus menjelaskan secara rinci alasan di balik penataan ruang tersebut, fasilitas dan peralatan medis apa saja yang wajib tersedia, serta menjelaskan pentingnya setiap komponen dalam menunjang kelancaran proses persalinan.

Tugas 4: Roleplay Tim Persalinan

Mahasiswa membentuk kelompok dan melakukan roleplay sebagai tim persalinan multidisiplin (bidan, dokter kandungan, perawat, tenaga pendukung). Setiap kelompok diminta membuat skenario persalinan baik normal maupun darurat dan mendemonstrasikan bagaimana koordinasi dan komunikasi efektif antar tim dilakukan selama proses persalinan.

Tugas 5: Penyuluhan Tanda Awal Persalinan

Mahasiswa ditugaskan untuk merancang materi penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarganya mengenai tanda-tanda awal persalinan. Materi penyuluhan harus informatif, mudah dimengerti, dilengkapi dengan visualisasi yang menarik (brosur/poster), serta menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil saat tanda-tanda tersebut muncul.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu hamil usia 37 tahun, gravida 4 para 3, datang ke klinik bidan untuk kunjungan antenatal pertama. Dari hasil anamnesis diketahui ia pernah mengalami persalinan prematur pada kehamilan sebelumnya.
Pemeriksaan tekanan darah menunjukkan hasil 150/95 mmHg.
Berdasarkan kasus ini, faktor risiko apa yang harus segera ditangani?
A. Usia ibu hamil
B. Riwayat persalinan prematur
C. Hipertensi gestasional
D. Gravida tinggi
E. Riwayat kehamilan multipara
2. Seorang ibu hamil usia 25 tahun melakukan pemeriksaan rutin kehamilan. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya peningkatan kadar gula darah puasa sebanyak 130 mg/dL.
Berdasarkan kasus ini, kondisi apa yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemantauan antenatal?
A. Anemia
B. Diabetes gestasional
C. Preeklamsia
D. Infeksi saluran kemih
E. Gangguan pertumbuhan janin
3. Ibu hamil datang dengan usia kehamilan 32 minggu, dari hasil pemeriksaan fisik tinggi fundus uteri hanya setara dengan usia kehamilan 28 minggu. Hasil USG menunjukkan oligohidramnion.
Tindakan apa yang tepat dilakukan oleh bidan dalam situasi ini?
A. Memberikan edukasi nutrisi tambahan
B. Merujuk ke dokter spesialis kebidanan
C. Melakukan pemantauan lebih lanjut tanpa rujukan
D. Memberikan terapi cairan amnion secara oral
E. Mengatur pola istirahat ibu hamil
4. Ibu hamil usia 30 tahun dengan usia kehamilan 24 minggu mengeluh sering pusing dan lemas. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan kadar hemoglobin 9 g/dL.
Langkah intervensi awal apakah yang paling tepat dilakukan oleh bidan?
A. Memberikan suplementasi zat besi
B. Melakukan transfusi darah segera

- C. Merujuk ke rumah sakit segera
 - D. Memulai terapi antihipertensi
 - E. Memberikan edukasi terkait gaya hidup sehat
5. Seorang ibu hamil usia 28 tahun dengan riwayat keluarga positif hipertensi datang ke klinik untuk pemeriksaan antenatal. Tekanan darah ibu stabil selama pemeriksaan, tetapi ibu khawatir akan kemungkinan hipertensi gestasional. Saran apa yang paling tepat diberikan bidan kepada ibu?
- A. Tidak perlu khawatir karena tekanan darah saat ini normal
 - B. Melakukan pemeriksaan tekanan darah rutin tiap minggu
 - C. Merujuk ke dokter spesialis sejak dini
 - D. Menyarankan pemeriksaan darah lengkap setiap minggu
 - E. Menyarankan istirahat total di tempat tidur

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Hipertensi gestasional (tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg) merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian segera untuk mencegah komplikasi seperti preeklamsia atau eklamsia.
2. Kunci Jawaban: B
Pembahasan: Kadar gula darah puasa ≥ 126 mg/dL menunjukkan risiko diabetes gestasional yang dapat menyebabkan komplikasi seperti makrosomia, kelahiran prematur, dan hipoglikemia neonatal.
3. Kunci Jawaban: E
Pembahasan: Oligohidramnion pada usia kehamilan lanjut adalah kondisi berisiko tinggi yang memerlukan evaluasi dan penanganan spesialis lebih lanjut untuk menghindari komplikasi janin.
4. Kunci Jawaban: A
Pembahasan: Anemia ringan hingga sedang pada kehamilan dengan Hb antara 8-10 g/dL dapat ditangani awal dengan pemberian suplementasi zat besi dan edukasi nutrisi.
5. Kunci Jawaban: B
Pembahasan: Pemantauan tekanan darah secara rutin penting bagi ibu dengan riwayat keluarga hipertensi untuk mendeteksi dini kemungkinan hipertensi gestasional dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Rangkuman Materi

Skrining risiko kehamilan merupakan prosedur penting dalam asuhan antenatal untuk mendeteksi dini potensi komplikasi selama kehamilan. Proses ini melibatkan anamnesis mendalam terkait riwayat kesehatan ibu, termasuk usia, riwayat obstetri sebelumnya seperti keguguran, kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, preeklamsia, diabetes gestasional, serta riwayat penyakit keluarga. Selain itu, pemeriksaan fisik seperti pengukuran tekanan darah, tinggi dan berat badan, serta lingkaran perut dilakukan secara teliti untuk mengidentifikasi kelainan seperti hipertensi gestasional, preeklamsia, dan pertumbuhan janin yang tidak optimal. Pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi rutin, tes laboratorium darah lengkap, gula darah, urin, serologi, dan skrining infeksi seperti HIV, hepatitis, serta sifilis juga dilakukan guna memastikan kondisi ibu dan janin sehat. Pemantauan tekanan darah secara rutin penting dilakukan untuk mencegah komplikasi serius selama persalinan.

Konseling *informed choice* bertujuan memberikan informasi lengkap kepada ibu hamil mengenai berbagai pilihan proses persalinan, termasuk metode persalinan, lokasi persalinan, manajemen nyeri, pendamping persalinan, dan intervensi medis tambahan. Setelah konseling, ibu menyusun dokumen birth plan yang mencerminkan preferensi pribadinya, meliputi lokasi persalinan, pendamping selama proses persalinan, pilihan manajemen nyeri, intervensi medis yang disetujui atau ditolak, serta preferensi tindakan medis lainnya. Birth plan memperkuat peran aktif ibu dalam proses persalinan dan meningkatkan komunikasi antara ibu, keluarga, dan tim medis, sehingga persalinan berjalan aman dan sesuai harapan ibu.

Persiapan lingkungan dan tim persalinan sangat penting untuk memastikan proses persalinan berjalan lancar, aman, dan nyaman. Ruang persalinan harus disiapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan ibu serta efisiensi kerja tenaga medis. Penataan ruang harus memperhatikan kebersihan, pencahayaan, suhu, dan perlengkapan medis seperti alat resusitasi neonatal, monitor janin, dan peralatan steril lainnya. Persiapan tim persalinan mencakup penyusunan tim multidisiplin yang kompeten, komunikasi yang jelas antaranggota tim, serta pelatihan rutin mengenai skenario persalinan normal maupun darurat untuk mengoptimalkan respons cepat dan tepat dalam situasi apapun.

Edukasi tentang tanda-tanda awal persalinan adalah elemen penting dalam asuhan antenatal agar ibu dan keluarga bisa mengenali waktu yang tepat untuk mencari bantuan medis. Tanda-tanda awal persalinan mencakup kontraksi uterus yang semakin kuat dan teratur, keluarnya lendir bercampur darah (bloody show), pecahnya ketuban, nyeri punggung bawah yang menetap, serta perubahan serviks yang dinilai melalui

pemeriksaan klinis. Dengan edukasi yang jelas, ibu akan lebih percaya diri menghadapi persalinan, memastikan keselamatan ibu dan janin, serta tercapainya persalinan yang aman dan nyaman.

Glosarium

Anamnesis: proses pengumpulan informasi dari pasien tentang riwayat kesehatannya.

Antenatal: periode selama kehamilan sebelum persalinan.

Birth plan: dokumen yang mencatat preferensi ibu tentang bagaimana persalinannya akan berlangsung.

Diabetes gestasional: diabetes yang muncul selama kehamilan.

Eklamsia: kondisi serius yang ditandai oleh kejang pada ibu hamil akibat tekanan darah tinggi.

Episiotomi: tindakan medis berupa pemotongan perineum untuk memperluas jalan lahir.

Hipertensi gestasional: peningkatan tekanan darah yang terjadi selama kehamilan.

Informed choice: keputusan yang diambil oleh pasien setelah menerima informasi lengkap tentang manfaat, risiko, dan implikasi tindakan medis.

Neonatal: berhubungan dengan bayi baru lahir.

Oligohidramnion: kondisi jumlah cairan ketuban yang sedikit atau kurang dari normal.

Preeklamsia: komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya.

Serologi: tes darah untuk mendeteksi antibodi atau infeksi dalam tubuh.

Ultrasonografi (USG): teknik pencitraan untuk memantau kondisi janin selama kehamilan.

Daftar Pustaka

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams Obstetrics (25th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. W. (2019). *Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan (11th ed.)*. Pearson Education.
- Fraser, D. M., Cooper, M. A., & Nolte, A. G. W. (2020). *Myles Textbook for Midwives (17th ed.)*. Elsevier Health Sciences.
- Henderson, C., & Macdonald, S. (2017). *Mayes' Midwifery (15th ed.)*. Elsevier Health Sciences.
- King, T. L., Brucker, M. C., Fahey, J. O., Gegor, C. L., Varney, H., & Kriebs, J. M. (2019). *Varney's Midwifery (6th ed.)*. Jones & Bartlett Learning.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2019). *Maternity and Women's Health Care (12th ed.)*. Elsevier.
- Marshall, J., Raynor, M., & Nolte, A. (2016). *Myles Textbook for Midwives (16th ed.)*. Churchill Livingstone.
- Pillitteri, A. (2017). *Maternal & Child Health Nursing: Care of the Childbearing and Childrearing Family (8th ed.)*. Wolters Kluwer Health.
- Ricci, S. S. (2020). *Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing (5th ed.)*. Wolters Kluwer.
- WHO. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. World Health Organization.

Bab 4

Asuhan Persalinan Kala I, II, III, dan IV

Persalinan merupakan proses fisiologis alami yang dialami seorang ibu untuk melahirkan bayi yang dikandungnya. Manajemen persalinan yang tepat dan profesional merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi serta meminimalkan risiko komplikasi. Pemahaman mendalam tentang setiap fase persalinan, dimulai dari penilaian tanda persalinan hingga observasi intensif pascapersalinan, menjadi fondasi penting dalam pemberian asuhan kebidanan yang efektif dan komprehensif.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan secara profesional, holistik, dan berdasarkan bukti ilmiah pada setiap tahap persalinan dengan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu melakukan penilaian tanda persalinan, melaksanakan manajemen persalinan pada kala I (fase laten dan aktif), memantau kemajuan persalinan menggunakan partograf, melakukan penatalaksanaan persalinan kala II dan III, serta observasi intensif pada kala IV secara mandiri, bertanggung jawab, dan sesuai standar praktik kebidanan terkini.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi secara akurat tanda-tanda persalinan serta menentukan status fase persalinan yang dialami ibu.
2. Memberikan asuhan yang tepat selama fase laten dan fase aktif kala I dengan pendekatan holistik.
3. Menggunakan partograf secara tepat untuk pemantauan progres persalinan serta identifikasi dini komplikasi.
4. Melaksanakan manajemen aktif kala II dan kala III persalinan secara tepat dan sesuai standar.
5. Melakukan observasi awal pascapersalinan (kala IV) untuk mendeteksi dini komplikasi dan memastikan adaptasi optimal ibu dan bayi baru lahir.

A. Penilaian Tanda Persalinan

Penilaian tanda persalinan merupakan prosedur awal yang esensial dan krusial dalam manajemen persalinan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah seorang ibu benar-benar memasuki fase persalinan, tetapi juga membantu tenaga kesehatan dalam menentukan langkah-langkah pengelolaan yang tepat sesuai dengan kondisi ibu. Langkah pertama dalam penilaian tanda persalinan yang perlu diamati dengan cermat adalah observasi terhadap kontraksi uterus. Kontraksi yang menandakan dimulainya proses persalinan biasanya memiliki karakteristik yang khas, yaitu reguler, konsisten, serta mengalami peningkatan dalam hal intensitas, durasi, dan frekuensi seiring berjalannya waktu. Pada tahap awal persalinan (fase laten), kontraksi mungkin tidak terlalu intens dan interval antar kontraksi masih agak panjang, namun secara bertahap kontraksi ini akan semakin kuat dan terjadi lebih sering ketika ibu memasuki fase aktif persalinan.

Selain pengamatan terhadap kontraksi uterus, tanda berikutnya yang sangat penting untuk dinilai adalah munculnya lendir bercampur darah yang dikenal sebagai bloody show. Bloody show merupakan keluarnya cairan lendir yang kental disertai bercak darah dari vagina yang terjadi akibat pelepasan sumbatan lendir pada serviks. Fenomena ini mengindikasikan bahwa serviks mulai mengalami perubahan struktural signifikan, yakni penipisan (effacement) dan pembukaan (dilatasi). Effacement sendiri merupakan proses fisiologis penting yang ditandai dengan penipisan dinding serviks, yang awalnya tebal dan tertutup rapat menjadi lebih tipis, lembut, elastis, dan lentur untuk mempermudah jalan lahir bagi bayi. Penipisan serviks biasanya dinyatakan dalam persentase, mulai dari 0% yang berarti tidak terjadi penipisan hingga 100% yang menunjukkan penipisan penuh dan siap untuk dilatasi.

Selanjutnya, dilatasi serviks juga merupakan parameter utama yang perlu dipantau dengan ketat. Dilatasi atau pembukaan serviks merupakan proses bertahap yang berlangsung sejak serviks masih tertutup hingga mencapai pembukaan penuh sebesar kurang lebih 10 cm, yang menandakan bahwa serviks telah sepenuhnya siap untuk dilewati oleh bayi. Pada tahap awal persalinan, dilatasi berlangsung lambat, tetapi begitu mencapai fase aktif, proses ini cenderung berlangsung lebih cepat. Oleh karena itu, pemeriksaan dilatasi serviks secara berkala sangat penting untuk memastikan progres persalinan berlangsung normal dan sesuai tahapan yang diharapkan.

Selain mengobservasi serviks, penurunan bagian terendah janin ke dalam rongga panggul ibu juga menjadi indikator yang sangat penting dalam penilaian tanda persalinan. Penurunan ini menandakan bahwa janin secara efektif mulai memasuki panggul ibu dan menuju jalan lahir. Penurunan bagian terendah janin bisa dinilai

melalui pemeriksaan fisik eksternal dengan palpasi perut ibu atau melalui pemeriksaan internal. Proses ini umumnya berlangsung secara perlahan tetapi progresif, sesuai dengan dorongan yang terjadi akibat kontraksi uterus yang semakin kuat dan efektif. Semakin rendah bagian janin dalam panggul ibu, semakin dekat pula waktu kelahiran.

Pemahaman dan interpretasi akurat terhadap semua tanda-tanda persalinan ini sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan klinis oleh tenaga kesehatan. Dengan menilai secara saksama setiap tanda persalinan tersebut, tenaga kesehatan akan lebih tepat dalam menentukan status persalinan ibu, apakah masih dalam tahap awal, fase aktif, atau bahkan memerlukan intervensi segera. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan persalinan yang aman serta keselamatan ibu maupun bayi, dengan mencegah keterlambatan tindakan ataupun intervensi yang tidak perlu. Oleh karena itu, penilaian tanda persalinan menjadi langkah penting yang wajib dikuasai secara mendalam oleh setiap tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam manajemen persalinan.

B. Manajemen Kala I (Fase Laten dan Aktif)

Manajemen kala I persalinan merupakan tahapan penting dalam proses melahirkan, yang terbagi menjadi dua fase utama yaitu fase laten dan fase aktif. Pengelolaan yang tepat dan menyeluruh pada kala ini sangat mempengaruhi keberhasilan persalinan serta keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana memberikan asuhan yang efektif dan efisien di masing-masing fase tersebut.

1. Fase Laten

Fase awal dari kala I persalinan, yang berlangsung mulai dari awal kontraksi uterus yang teratur hingga dilatasi serviks mencapai sekitar 4 sentimeter. Pada fase ini, kontraksi yang terjadi umumnya masih tergolong ringan hingga sedang dengan interval waktu yang lebih panjang, biasanya berkisar antara 5 hingga 20 menit sekali, dan berdurasi sekitar 30 hingga 45 detik setiap kontraksi. Pada tahap ini, ibu umumnya masih dapat menoleransi rasa nyeri dengan baik, meskipun mulai merasa tidak nyaman. Oleh karena kondisi tersebut, peran tenaga kesehatan dalam fase ini lebih banyak dititikberatkan pada pemberian dukungan emosional dan psikologis, memastikan ibu merasa nyaman dan tenang, serta mempersiapkannya secara fisik maupun mental untuk memasuki fase aktif persalinan.

Dukungan emosional dalam fase laten meliputi pendampingan secara penuh perhatian, empati, serta komunikasi yang efektif dengan ibu untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut yang mungkin muncul. Penjelasan secara terus terang mengenai apa yang sedang terjadi pada tubuhnya serta apa yang diharapkan

selama proses persalinan akan sangat membantu ibu merasa lebih siap dan tenang. Di samping itu, tenaga kesehatan juga perlu melakukan pemantauan kontraksi secara berkala guna menilai pola kontraksi, intensitas, durasi, dan frekuensi, serta mengevaluasi perkembangan proses dilatasi serviks melalui pemeriksaan dalam yang dilakukan secara bijaksana dan sesuai indikasi klinis. Dalam fase ini, kenyamanan fisik ibu juga menjadi perhatian penting. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan non-farmakologis seperti penggunaan teknik relaksasi, pijatan ringan, teknik pernapasan yang benar, pengaturan posisi tubuh yang nyaman, serta dukungan hidrasi dan nutrisi yang mencukupi.

Ketika proses persalinan berlanjut dan serviks mulai mengalami dilatasi lebih lanjut dari 4 sentimeter hingga mencapai dilatasi penuh sebesar 10 sentimeter, maka ibu telah memasuki fase aktif dari kala I persalinan. Pada fase ini, kontraksi uterus yang terjadi akan semakin kuat, frekuensinya meningkat, biasanya terjadi setiap 2 hingga 5 menit dengan durasi sekitar 45 hingga 60 detik atau bahkan lebih lama. Nyeri persalinan dalam fase aktif ini akan lebih intens dan terasa lebih sulit ditoleransi oleh ibu, sehingga kebutuhan terhadap dukungan fisik maupun psikologis meningkat secara signifikan. Fokus utama dalam manajemen

2. Fase Aktif Persalinan

Merupakan pemantauan secara ketat terhadap kondisi ibu maupun janin. Pemantauan ini terutama dilakukan melalui penggunaan alat bantu klinis seperti partograf. Partograf adalah grafik atau catatan khusus yang digunakan untuk mencatat progres dilatasi serviks, penurunan bagian terendah janin, frekuensi dan durasi kontraksi uterus, serta indikator vital lainnya seperti detak jantung janin dan tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan respirasi. Pemantauan dengan partograf bertujuan memastikan bahwa proses persalinan berjalan secara fisiologis normal, mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi, serta memungkinkan intervensi segera jika terjadi penyimpangan dari kondisi normal.

Selain aspek pemantauan klinis yang ketat, dukungan fisik selama fase aktif juga perlu dilakukan secara intensif. Dukungan fisik tersebut meliputi pemberian kenyamanan melalui teknik non-farmakologis seperti pijatan, kompres hangat atau dingin, mengatur posisi yang nyaman, serta pemberian cairan oral yang cukup untuk mempertahankan hidrasi ibu. Dukungan psikologis dalam fase aktif juga tetap penting, berupa pemberian semangat, pujian, serta keyakinan bahwa ibu mampu menjalani proses ini dengan baik. Komunikasi yang penuh empati, jelas, serta

informatif mengenai progres persalinan dapat membantu mengurangi kecemasan dan rasa takut ibu, sehingga memperlancar proses persalinan.

Keseluruhan manajemen kala I, baik fase laten maupun aktif, memerlukan pendekatan yang komprehensif, multidimensional, serta disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing ibu. Pelaksanaan asuhan yang optimal, yang mencakup dukungan emosional, psikologis, dan fisik secara efektif serta pemantauan klinis yang teliti, sangat menentukan keberhasilan proses persalinan sekaligus memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses melahirkan berlangsung.

C. Pemantauan Partograf

Pemantauan partograf adalah suatu kegiatan esensial dalam manajemen persalinan yang bertujuan untuk mencatat dan mengevaluasi secara sistematis berbagai parameter penting selama proses melahirkan. Partograf merupakan sebuah alat berbentuk grafik yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memvisualisasikan perkembangan atau kemajuan persalinan secara jelas dan terstruktur. Penggunaan partograf memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengamati dan mengidentifikasi secara dini tanda-tanda normal ataupun abnormal yang terjadi selama persalinan, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

Salah satu parameter utama yang dicatat dalam partograf adalah dilatasi serviks, yang mencerminkan pembukaan leher rahim selama proses persalinan. Dilatasi serviks dipantau secara berkala melalui pemeriksaan fisik dalam oleh tenaga kesehatan, biasanya dilakukan setiap 4 jam sekali atau lebih sering sesuai indikasi klinis. Hasil pengamatan ini akan dicatat pada grafik partograf yang memungkinkan tenaga kesehatan melihat dengan jelas pola dilatasi serviks, apakah berjalan normal sesuai dengan garis waspada dan garis tindakan yang ditentukan atau terdapat perlambatan yang mungkin membutuhkan intervensi lebih lanjut.

Selain dilatasi serviks, parameter lain yang tidak kalah penting untuk diamati dalam partograf adalah penurunan bagian terendah janin atau desensus janin ke dalam panggul ibu. Parameter ini menggambarkan seberapa efektif kontraksi uterus dalam mendorong janin melalui saluran lahir. Penurunan ini dipantau melalui pemeriksaan fisik internal dan eksternal, kemudian hasilnya juga ditandai pada grafik partograf. Dengan memantau desensus janin secara seksama, tenaga kesehatan dapat menilai progres persalinan secara objektif serta mendeteksi hambatan persalinan, misalnya janin yang gagal turun atau posisi janin yang abnormal.

Kontraksi uterus merupakan parameter selanjutnya yang direkam secara rinci dalam partograf. Observasi ini mencakup intensitas, durasi, dan frekuensi kontraksi yang terjadi selama persalinan. Kontraksi yang baik dan efektif biasanya ditandai dengan peningkatan kekuatan, frekuensi yang reguler, serta durasi yang cukup lama untuk menghasilkan perubahan pada serviks. Pemantauan kontraksi membantu tenaga kesehatan menentukan apakah kontraksi berlangsung normal dan efektif atau sebaliknya, kontraksi yang tidak efektif atau bahkan terlalu kuat yang bisa berbahaya bagi ibu maupun janin.

Pemantauan denyut jantung janin juga menjadi aspek yang sangat penting dalam penggunaan partograf. Parameter ini memberikan gambaran tentang kondisi janin selama proses persalinan berlangsung. Denyut jantung janin dipantau secara berkala, biasanya setiap 30 menit sekali dalam fase aktif persalinan, atau lebih sering jika ditemukan tanda-tanda abnormalitas. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini gangguan kesejahteraan janin, seperti distress janin atau asfiksia, sehingga intervensi segera seperti persalinan operatif bisa segera dipertimbangkan apabila dibutuhkan.

Tanda vital ibu juga merupakan parameter penting dalam pencatatan di partograf. Tanda vital yang dimaksud antara lain adalah tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan ibu selama persalinan. Pemantauan ini sangat penting untuk mengidentifikasi secara dini tanda-tanda komplikasi seperti hipertensi, preeklamsia, infeksi, ataupun kelelahan berat yang dapat membahayakan kondisi ibu selama persalinan. Melalui pencatatan rutin di partograf, perubahan kecil sekalipun dalam kondisi vital ibu dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat dan cepat.

Di samping parameter-parameter di atas, kondisi membran dan cairan amnion juga menjadi perhatian utama dalam pemantauan partograf. Kondisi membran atau ketuban yang pecah akan dicatat dengan jelas termasuk waktu terjadinya, warna cairan ketuban, serta volume cairan ketuban yang keluar. Kondisi cairan amnion yang abnormal, seperti cairan bercampur mekonium atau berbau busuk yang mengindikasikan infeksi, juga dicatat dalam partograf. Dengan begitu, tenaga kesehatan bisa segera mengidentifikasi kemungkinan infeksi atau kondisi janin yang tidak optimal.

Interpretasi yang akurat dari semua data yang dicatat dalam partograf ini merupakan keterampilan klinis yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Pemahaman yang tepat terhadap pola-pola grafik yang terbentuk dalam partograf, seperti laju dilatasi serviks, pola kontraksi, denyut jantung janin, serta kondisi ibu dan cairan amnion,

sangat krusial untuk mendeteksi secara dini setiap penyimpangan atau komplikasi yang mungkin timbul selama proses persalinan. Dengan demikian, partograf bukan sekadar alat pencatatan biasa, tetapi sebuah instrumen vital yang mampu menyelamatkan nyawa ibu dan bayi melalui deteksi dini, intervensi yang tepat, serta pengelolaan persalinan yang terintegrasi secara efektif dan efisien.

D. Penatalaksanaan Kala II dan III

Penatalaksanaan kala II dan III dalam persalinan merupakan tahapan penting yang membutuhkan perhatian ekstra dari tenaga kesehatan, karena keduanya berhubungan erat dengan keselamatan ibu dan bayi serta pencegahan komplikasi yang mungkin terjadi selama dan sesudah kelahiran. Masing-masing tahap ini memiliki karakteristik dan kebutuhan asuhan yang berbeda, sehingga tenaga kesehatan harus memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan yang tepat dan sesuai standar dalam praktik kebidanan yang baik.

1. Kala II Persalinan

Fase di mana bayi dilahirkan, ditandai dengan dilatasi serviks yang telah mencapai ukuran penuh yaitu sekitar 10 sentimeter, hingga keluarnya bayi secara lengkap dari tubuh ibu. Pada tahap ini, ibu biasanya merasakan dorongan yang sangat kuat untuk mengejan akibat tekanan kepala bayi terhadap dasar panggul. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendampingi ibu dengan intens, memberikan panduan serta bimbingan yang jelas mengenai teknik mengejan yang benar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dorongan ibu serta mengurangi risiko cedera perineum atau trauma jalan lahir yang lainnya.

Salah satu aspek penting dalam penatalaksanaan kala II adalah membantu ibu menemukan posisi yang paling nyaman dan aman untuk proses persalinan. Tidak ada satu posisi yang dianggap paling baik secara universal, melainkan tenaga kesehatan harus memfasilitasi ibu untuk memilih posisi yang nyaman baginya seperti posisi setengah duduk, jongkok, miring, berlutut, atau posisi berdiri, selama posisi tersebut memungkinkan kelancaran proses kelahiran dan pengawasan janin secara efektif. Posisi yang nyaman akan membantu ibu merasa lebih tenang, mengurangi nyeri, serta mempercepat kemajuan persalinan.

Selain itu, tenaga kesehatan juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai pengaturan napas yang baik dan teknik mengejan yang efektif. Ibu harus diarahkan untuk mengambil napas dalam-dalam pada saat jeda antara kontraksi, lalu menahan napas secukupnya dan mengejan secara perlahan tetapi kuat ketika kontraksi mencapai puncaknya. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

dorongan, menjaga energi ibu, dan mengurangi risiko hipoksia janin serta cedera jalan lahir ibu.

Praktik persalinan yang aman selama kala II juga melibatkan tindakan preventif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah cedera pada ibu maupun bayi. Hal ini termasuk dukungan perineum (perineal support) yang dilakukan dengan lembut namun mantap, guna mengontrol laju kelahiran kepala bayi serta mengurangi risiko robekan atau trauma pada jaringan perineum. Selain itu, kepala bayi yang telah lahir segera dibantu untuk rotasi eksternal agar bahu bayi keluar dengan aman dan mudah. Setelah bayi lahir sepenuhnya, tenaga kesehatan harus segera melakukan penilaian kondisi bayi, memberikan perawatan awal seperti pengeringan tubuh bayi, mengatur suhu tubuh bayi, dan menempatkan bayi pada ibu untuk melakukan kontak kulit-ke-kulit (skin-to-skin contact).

Setelah bayi lahir dengan selamat, proses persalinan berlanjut ke kala III, yang merupakan tahap pengeluaran plasenta dan membran janin. Kala III dimulai segera setelah bayi dilahirkan dan berlangsung hingga plasenta keluar secara utuh. Manajemen aktif pada kala III ini sangat penting karena berhubungan erat dengan pencegahan perdarahan postpartum, salah satu komplikasi utama yang bisa membahayakan nyawa ibu.

2. Manajemen aktif kala III

Melibatkan beberapa tindakan spesifik yang dilakukan secara rutin untuk mempercepat pelepasan plasenta serta meminimalkan perdarahan. Salah satu tindakan utama adalah pemberian oksitosin intramuskular segera setelah kelahiran bayi. Oksitosin adalah hormon sintesis yang merangsang kontraksi uterus secara kuat dan efektif, membantu pelepasan plasenta secara cepat dan mencegah perdarahan akibat uterus yang kurang kontraksi atau atonia uteri.

Tindakan berikutnya dalam manajemen aktif kala III adalah peregangan tali pusat terkendali (controlled cord traction). Teknik ini dilakukan secara hati-hati dan terkontrol, dengan menarik tali pusat secara perlahan sambil menahan fundus uterus dengan tangan lain, sehingga plasenta terlepas secara alami dan keluar secara lengkap. Penggunaan teknik ini harus dilakukan secara benar dan hati-hati untuk menghindari komplikasi seperti inversio uteri atau robeknya tali pusat.

Setelah plasenta keluar dengan lengkap, tenaga kesehatan harus memeriksa secara seksama kondisi plasenta dan membran, memastikan tidak ada sisa jaringan plasenta yang tertinggal dalam rahim yang dapat menyebabkan perdarahan

berkelanjutan atau infeksi. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemijatan fundus uterus secara lembut dan teratur, untuk memastikan bahwa rahim berkontraksi secara optimal sehingga mampu menghentikan perdarahan serta mempertahankan tonus uterus yang baik.

Keseluruhan penatalaksanaan pada kala II dan III yang dilakukan secara terintegrasi dan sistematis seperti ini sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi. Penerapan praktik kebidanan berbasis bukti, pemantauan ketat terhadap kondisi ibu dan bayi, serta intervensi yang tepat waktu akan sangat mempengaruhi keberhasilan persalinan yang aman dan nyaman bagi ibu serta bayinya.

E. Kala IV: Observasi Awal Pascapersalinan

Kala IV dalam proses persalinan merupakan fase penting yang berlangsung selama dua jam pertama setelah kelahiran bayi dan plasenta. Fase ini sering disebut sebagai periode pemulihan awal pascapersalinan, dan merupakan waktu krusial di mana berbagai perubahan fisiologis yang cepat terjadi pada tubuh ibu serta adaptasi awal bayi terhadap lingkungan luar rahim mulai berlangsung. Oleh karena itu, observasi secara intensif dan kontinu dalam fase ini sangat penting dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk memastikan keselamatan serta kesehatan ibu dan bayinya.

1. Observasi Ibu

Selama kala IV, salah satu aspek utama yang perlu diamati dengan seksama adalah risiko perdarahan postpartum. Perdarahan pada periode ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, terutama akibat uterus yang tidak berkontraksi secara efektif (atonia uteri), adanya sisa plasenta yang tertinggal di dalam rahim, atau luka jalan lahir yang tidak terdeteksi secara dini. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus secara rutin melakukan pemantauan terhadap jumlah darah yang keluar, mengecek adanya darah segar, serta mengawasi kondisi perineum ibu untuk memastikan tidak ada luka atau robekan yang serius. Observasi ini membantu tenaga kesehatan untuk segera mengidentifikasi tanda-tanda awal perdarahan, sehingga intervensi dini seperti pemijatan uterus tambahan, pemberian oksitosin tambahan, atau bahkan tindakan bedah jika diperlukan, dapat segera dilakukan untuk menghindari komplikasi yang lebih berat.

2. Pemantauan Kontraksi Uterus

Selain observasi perdarahan, kondisi kontraksi uterus juga menjadi parameter penting yang wajib diamati secara rutin selama fase ini. Kontraksi uterus yang optimal pascapersalinan ditandai dengan uterus yang terasa padat, keras, dan berada di tengah abdomen sekitar setinggi umbilikus (pusat). Kontraksi yang efektif ini sangat penting karena membantu menghentikan perdarahan dengan menutup pembuluh darah pada bekas tempat melekatnya plasenta. Tenaga kesehatan harus

rutin memeriksa fundus uterus dengan palpasi ringan namun mantap setiap 15 menit pada satu jam pertama, kemudian setiap 30 menit pada jam kedua, untuk memastikan kontraksi tetap kuat dan efektif serta mendeteksi secara dini jika terjadi atonia uteri.

3. Monitoring dan Observasi

Observasi terhadap tanda vital ibu merupakan aspek berikutnya yang sangat penting dalam kala IV persalinan. Tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan laju pernapasan ibu harus dipantau secara rutin dan teratur, karena perubahan signifikan pada tanda vital ini dapat mengindikasikan komplikasi yang mungkin terjadi seperti syok hipovolemik akibat perdarahan, infeksi awal, atau gangguan hemodinamik lainnya. Pemantauan yang intensif pada tanda vital ibu memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengenali perubahan secara dini sehingga intervensi medis dapat segera dilakukan untuk mencegah kondisi semakin buruk.

Selain observasi terhadap ibu, kala IV juga merupakan periode kritis dalam memantau adaptasi awal bayi baru lahir. Setelah dilahirkan, bayi harus segera beradaptasi dari kehidupan intrauterin yang sepenuhnya bergantung pada plasenta ke kehidupan ekstrauterin di mana bayi harus mampu bernapas, mengatur suhu tubuhnya sendiri, serta melakukan berbagai adaptasi fisiologis lainnya. Observasi intensif terhadap bayi pada dua jam pertama kehidupan ini mencakup penilaian terhadap pernapasan bayi, suhu tubuh, warna kulit, serta tanda-tanda vital bayi secara keseluruhan. Bayi juga perlu diamati secara seksama dalam hal kemampuan untuk bernapas spontan, usaha bernapas yang stabil, dan tidak adanya tanda-tanda distress pernapasan seperti retraksi dada atau sianosis.

4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan *Skin-to-Skin Contact*

Pada periode awal ini, kontak kulit-ke-kulit (*skin-to-skin contact*) antara ibu dan bayi sangat dianjurkan sebagai bagian dari asuhan pascapersalinan yang ideal. Metode ini tidak hanya membantu bayi mengatur suhu tubuhnya secara lebih baik tetapi juga memfasilitasi adaptasi pernapasan serta merangsang refleks bayi untuk segera mulai menyusu. Pemberian ASI segera setelah lahir juga sangat bermanfaat dalam membantu kontraksi uterus ibu sehingga dapat mengurangi risiko perdarahan postpartum, sekaligus memberikan nutrisi penting bagi bayi.

Dalam kala IV ini, tindakan segera terhadap setiap tanda atau gejala yang mengindikasikan komplikasi merupakan kunci utama dalam mencegah kondisi yang lebih serius. Tenaga kesehatan harus sigap dalam mengidentifikasi tanda-tanda bahaya baik pada ibu maupun bayi baru lahir, dan mengambil langkah intervensi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, observasi yang ketat, teratur, serta terstruktur selama dua jam pertama setelah persalinan merupakan bagian penting dari asuhan kebidanan yang berkualitas tinggi, yang secara signifikan akan meningkatkan hasil kesehatan ibu maupun bayi serta mengurangi risiko komplikasi yang tidak diinginkan.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Studi Kasus Penilaian Tanda Persalinan

- Pilih atau buatlah sebuah studi kasus tentang ibu yang datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan kontraksi perut.
- Berdasarkan informasi kasus, jelaskan penilaian tanda persalinan secara rinci, mencakup:
 - Pengamatan kontraksi uterus (frekuensi, intensitas, durasi).
 - Observasi lendir bercampur darah (bloody show).
 - Evaluasi penipisan (effacement) dan pembukaan (dilatasi) serviks.
 - Penurunan bagian terendah janin ke panggul ibu.
- Berikan analisis klinis dan rekomendasi langkah berikutnya berdasarkan hasil penilaian.

Tugas 2: Pembuatan Leaflet Edukasi Manajemen Kala I (Fase Laten dan Aktif)

- Buatlah leaflet edukasi yang dapat diberikan kepada ibu hamil tentang fase laten dan fase aktif persalinan.
- Jelaskan secara singkat namun jelas:
 - Karakteristik masing-masing fase (tanda-tanda yang dialami ibu).
 - Dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan ibu.
 - Teknik non-farmakologis untuk meredakan nyeri selama fase laten dan aktif.
 - Pentingnya pemantauan ketat oleh tenaga kesehatan menggunakan partograf selama fase aktif.
- Leaflet harus menarik secara visual, ringkas, dan mudah dipahami.

Tugas 3: Latihan Pengisian dan Interpretasi Partograf

- Mahasiswa diberikan sebuah skenario kasus persalinan lengkap dengan data-data klinis (kontraksi, dilatasi serviks, denyut jantung janin, penurunan bagian terendah janin, tanda vital ibu, dan kondisi cairan amnion).
- Mahasiswa diminta untuk mengisi data tersebut ke dalam lembar partograf secara akurat.
- Setelah mengisi partograf, mahasiswa diminta untuk:
 - Menilai apakah persalinan berlangsung normal atau terdapat tanda komplikasi.
 - Memberikan interpretasi yang jelas terhadap setiap parameter pada partograf.
 - Merekomendasikan intervensi lanjutan yang tepat berdasarkan hasil interpretasi partograf.

Tugas 4: Simulasi Manajemen Kala II dan III Persalinan

- Buat kelompok kecil untuk simulasi penatalaksanaan kala II dan III persalinan.
- Setiap kelompok mempraktikkan:
 - Teknik membimbing ibu dalam mengejan yang benar.
 - Pemilihan posisi persalinan yang nyaman dan efektif.
 - Teknik perineal support untuk mencegah robekan.
 - Manajemen aktif kala III, termasuk pemberian oksitosin dan peregangan tali pusat terkendali.
- Setiap mahasiswa wajib membuat laporan individu tentang refleksi praktiknya, tantangan yang dihadapi, serta solusi dalam praktik nyata.

Tugas 5: Observasi Awal Pascapersalinan (Kala IV)

- Mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah checklist observasi kala IV yang lengkap dan sistematis selama 2 jam pertama pascapersalinan.
- Checklist harus mencakup observasi:
 - Jumlah perdarahan dan kondisi perineum ibu.
 - Palpasi fundus uterus (tinggi dan konsistensi uterus).
 - Tanda vital ibu secara berkala.
 - Adaptasi awal bayi baru lahir (pernapasan, suhu tubuh, warna kulit, tanda vital).
 - Pelaksanaan kontak kulit-ke-kulit (skin-to-skin contact) dan pemberian ASI dini.
- Mahasiswa harus menjelaskan alasan pentingnya setiap parameter observasi dalam checklist tersebut dan membuat laporan tentang tindakan yang harus dilakukan jika ditemukan abnormalitas selama observasi.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu primigravida datang ke ruang bersalin dengan kontraksi uterus yang reguler setiap 10 menit, durasi 30 detik, dan keluar lendir bercampur darah (bloody show). Pemeriksaan serviks menunjukkan penipisan 40% dan dilatasi 2 cm.
Bagaimana status persalinan ibu tersebut?
 - A. Persalinan aktif, perlu tindakan percepatan
 - B. Persalinan fase laten, berikan dukungan dan observasi
 - C. Persalinan sudah memasuki fase kedua, persiapkan persalinan
 - D. Persalinan sudah selesai, persiapkan pemulihan
 - E. Persalinan abnormal, segera rujuk ke rumah sakit

2. Seorang ibu multigravida menjalani persalinan fase aktif dengan kontraksi setiap 3 menit, durasi 50 detik, dan dilatasi serviks 7 cm. Ibu mengeluhkan rasa nyeri hebat dan kecemasan.
Apa tindakan keperawatan paling tepat?
 - A. Melakukan edukasi tentang proses persalinan dan menenangkan ibu
 - B. Memberikan analgesik kuat tanpa pengawasan
 - C. Memberikan dukungan fisik dan psikologis, serta mengatur posisi nyaman
 - D. Menyarankan ibu untuk segera mengejan kuat
 - E. Melanjutkan observasi tanpa intervensi

3. Pada pemantauan partograf selama 3 jam, dilatasi serviks ibu tidak bertambah dari 5 cm, kontraksi lemah, dan denyut jantung janin menurun. Langkah keperawatan berikutnya adalah:
 - A. Melanjutkan observasi dan menunggu persalinan berjalan alami
 - B. Menyuruh ibu banyak berjalan dan bergerak
 - C. Memberikan oksitosin untuk meningkatkan kontraksi uterus
 - D. Menginstruksikan ibu untuk mengejan walaupun serviks belum penuh
 - E. Melakukan persiapan untuk persalinan operatif

4. Saat kala II persalinan, ibu merasa sangat lelah dan kesulitan mengatur napas saat mengejan. Apa tindakan bidan yang paling tepat?
 - A. Menginstruksikan ibu untuk mengejan terus tanpa henti
 - B. Memberikan dukungan napas dan posisi yang nyaman serta membantu mengatur teknik mengejan
 - C. Meminta ibu berbaring dan menunggu persalinan selesai sendiri
 - D. Memberikan analgesik kuat tanpa pengawasan dokter
 - E. Melakukan episiotomi segera

5. Setelah persalinan, fundus uteri ibu terasa lunak dan di atas pusat, dan ibu mengeluhkan pusing serta lemas.
Apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan?
- A. Memberikan cairan oral dan menyuruh istirahat
 - B. Melakukan pemijatan fundus uteri segera dan memantau perdarahan
 - C. Memberikan analgesik untuk nyeri perut
 - D. Menunggu plasenta keluar secara spontan
 - E. Melakukan pemeriksaan tekanan darah sekali saja

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Ibu berada pada fase laten persalinan karena dilatasi serviks masih di bawah 4 cm dengan kontraksi yang masih jarang dan durasi pendek. Tindakan utama adalah memberikan dukungan emosional, psikologis, dan pemantauan rutin tanpa tindakan invasif atau percepatan persalinan.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Pada fase aktif, ibu membutuhkan dukungan fisik dan psikologis intensif, termasuk pengaturan posisi nyaman, pemberian pijatan ringan, dan komunikasi empatik untuk membantu mengatasi nyeri dan kecemasan agar proses persalinan berjalan lancar.

3. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Tidak adanya progres dilatasi disertai kontraksi lemah dan tanda distress janin menunjukkan distosia. Pemberian oksitosin bertujuan menguatkan kontraksi dan mempercepat persalinan agar kondisi ibu dan janin membaik.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Dukungan teknik pernapasan dan posisi yang nyaman membantu ibu mengatur energi dan efektif mengejan, sehingga meminimalisir risiko kelelahan dan cedera jalan lahir serta membantu kelahiran bayi berjalan lancar.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Fundus uteri lunak menandakan atonia uteri, penyebab utama perdarahan postpartum. Pemijatan uterus penting untuk merangsang kontraksi dan menghentikan perdarahan. Kondisi ibu yang pusing dan lemas perlu segera ditangani untuk mencegah syok.

Rangkuman Materi

Manajemen persalinan merupakan serangkaian tindakan klinis dan observasi yang terintegrasi secara sistematis dan komprehensif untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan ibu dan bayi selama proses melahirkan. Penilaian tanda persalinan menjadi tahap awal yang sangat krusial, karena ketepatan dalam mengidentifikasi kontraksi uterus, *bloody show*, penipisan serviks, dilatasi serviks, serta penurunan bagian terendah janin, akan menentukan langkah-langkah intervensi selanjutnya secara tepat waktu. Selanjutnya, manajemen kala I yang meliputi fase laten dan aktif, memerlukan pendekatan holistik yang mencakup dukungan emosional, psikologis, fisik, serta pemantauan klinis yang teliti melalui alat bantu partograf. Penggunaan partograf secara konsisten akan membantu tenaga kesehatan mendeteksi secara dini berbagai komplikasi potensial yang dapat muncul, sehingga intervensi medis yang tepat dapat segera dilakukan guna menghindari keadaan darurat persalinan.

Tahapan berikutnya adalah penatalaksanaan kala II dan III, di mana tenaga kesehatan berperan secara aktif dalam mendukung ibu menjalani proses kelahiran bayi melalui teknik pernapasan, mengejan efektif, serta memilih posisi persalinan yang nyaman. Pada kala III, manajemen aktif seperti pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, serta pemijatan fundus uteri penting untuk mempercepat pengeluaran plasenta dan mencegah risiko perdarahan postpartum. Setelah bayi dan plasenta lahir, observasi intensif pada kala IV menjadi fase kritis yang bertujuan mengantisipasi komplikasi awal pascapersalinan seperti perdarahan, atonia uteri, serta gangguan adaptasi awal bayi baru lahir. Observasi ketat ini mencakup pemantauan tanda vital ibu, kontraksi uterus, kondisi perdarahan, serta adaptasi fisiologis bayi melalui kontak kulit-ke-kulit dan pemberian ASI sedini mungkin.

Keseluruhan manajemen ini menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan yang kompeten dalam mengenali tanda-tanda persalinan secara akurat, memberikan asuhan secara holistik sesuai tahapan persalinan, menggunakan alat bantu pemantauan klinis seperti partograf secara optimal, serta cepat tanggap dalam mengelola komplikasi yang mungkin timbul. Dengan demikian, asuhan persalinan yang berkualitas tinggi dapat diwujudkan untuk mencapai hasil kesehatan terbaik bagi ibu maupun bayi, serta memastikan proses kelahiran yang aman, nyaman, dan efektif.

Glosarium

Atonia Uteri: Kondisi di mana otot uterus gagal berkontraksi secara optimal pascapersalinan, menyebabkan risiko perdarahan postpartum yang signifikan.

Bloody Show: Keluarnya lendir kental bercampur darah dari vagina akibat pelepasan sumbatan lendir di serviks sebagai tanda awal persalinan.

Controlled Cord Traction: Teknik peregangan tali pusat secara perlahan dan terkendali untuk membantu pelepasan plasenta secara alami dalam manajemen aktif kala III persalinan.

Dilatasi Serviks: Proses bertahap pembukaan serviks yang diukur dalam sentimeter, dimulai dari kondisi tertutup hingga pembukaan penuh sekitar 10 cm, yang menandai kesiapan jalan lahir untuk persalinan.

Distosi: Kondisi hambatan atau gangguan dalam kemajuan persalinan akibat faktor-faktor seperti kontraksi uterus yang tidak efektif, posisi janin yang abnormal, atau hambatan pada panggul ibu.

Effacement (Penipisan Serviks): Proses fisiologis di mana serviks yang awalnya tebal menjadi tipis, lentur, dan elastis sebagai persiapan persalinan, dinyatakan dalam persentase dari 0% hingga 100%.

Fase Aktif Persalinan: Tahap dalam kala I persalinan yang ditandai dengan dilatasi serviks dari 4 hingga 10 cm, kontraksi uterus yang kuat, frekuensi meningkat, serta nyeri persalinan yang intens dan membutuhkan pemantauan ketat serta dukungan fisik maupun psikologis.

Fase Laten Persalinan: Tahap awal dalam kala I persalinan, berlangsung sejak munculnya kontraksi reguler hingga dilatasi serviks mencapai sekitar 4 cm, di mana kontraksi masih ringan hingga sedang dan ibu membutuhkan dukungan emosional serta psikologis.

Fundus Uteri: Bagian atas rahim yang dipantau melalui palpasi untuk memastikan kontraksi uterus optimal setelah persalinan guna mencegah perdarahan postpartum.

Kala I Persalinan: Periode persalinan yang dimulai sejak munculnya kontraksi uterus yang teratur hingga dilatasi serviks mencapai pembukaan penuh 10 cm, terdiri dari fase laten dan fase aktif.

Kala II Persalinan: Fase di mana bayi dilahirkan, dimulai dari pembukaan serviks penuh hingga kelahiran bayi sepenuhnya, membutuhkan dukungan posisi nyaman dan teknik mengejan efektif.

Kala III Persalinan: Tahap persalinan yang melibatkan pelepasan dan pengeluaran plasenta serta membran janin, di mana manajemen aktif diperlukan untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan postpartum.

Kala IV Persalinan: Periode kritis selama dua jam pertama setelah kelahiran bayi dan plasenta, mencakup observasi intensif terhadap perdarahan postpartum, kontraksi uterus, tanda vital ibu, dan adaptasi bayi baru lahir.

Kontak Kulit-ke-Kulit (Skin-to-Skin Contact): Metode perawatan pascapersalinan dengan menempatkan bayi baru lahir langsung di atas kulit ibu, membantu adaptasi bayi secara fisiologis seperti pengaturan suhu tubuh dan merangsang refleks menyusu dini.

Kontraksi Uterus: Gerakan involunter otot rahim yang terjadi secara reguler selama proses persalinan, bertujuan untuk membuka serviks, mendorong bayi melewati jalan lahir, serta membantu mencegah perdarahan postpartum setelah bayi dan plasenta keluar.

Manajemen Aktif Kala III: Serangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk mempercepat pelepasan plasenta dan mencegah perdarahan postpartum, meliputi pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, serta pemijatan fundus uterus.

Observasi Pascapersalinan: Pemantauan intensif terhadap kondisi ibu dan bayi pada kala IV persalinan untuk mendeteksi dini komplikasi potensial seperti perdarahan postpartum, atonia uteri, atau gangguan adaptasi fisiologis bayi.

Oksitosin: Hormon sintetis yang diberikan secara intramuskular atau intravena untuk merangsang kontraksi uterus yang efektif dalam proses persalinan maupun manajemen aktif kala III guna mencegah perdarahan postpartum.

Palpasi Uterus: Teknik pemeriksaan fisik dengan meraba fundus uterus melalui dinding abdomen untuk menilai konsistensi, kontraksi, dan posisi rahim pascapersalinan.

Partograf: Alat pemantauan berbentuk grafik yang digunakan tenaga kesehatan untuk mencatat dan mengevaluasi secara sistematis parameter klinis selama proses persalinan seperti dilatasi serviks, kontraksi uterus, denyut jantung janin, tanda vital ibu, serta kondisi cairan ketuban untuk mengidentifikasi komplikasi secara dini.

Perdarahan Postpartum: Kehilangan darah dalam jumlah besar (>500 ml pada persalinan normal) setelah persalinan yang dapat terjadi akibat atonia uteri, sisa plasenta yang tertinggal, atau cedera jalan lahir.

Primigravida: Wanita yang sedang menjalani kehamilan pertama kali.

Retraksi Dada: Gerakan dada yang abnormal sebagai tanda kesulitan bernapas atau distress pernapasan pada bayi baru lahir, ditandai dengan otot interkostal yang tampak tertarik ke dalam saat inspirasi.

Serviks: Bagian leher rahim yang mengalami perubahan struktural signifikan (effacement dan dilatasi) selama proses persalinan sebagai bagian dari persiapan jalan lahir bagi bayi.

Variabilitas Denyut Jantung Janin: Variasi denyut jantung janin yang normal, di mana penurunan variabilitas dapat mengindikasikan gangguan kesejahteraan janin atau distress janin yang memerlukan perhatian medis segera.

Daftar Pustaka

- Arulkumaran, S., & Ledger, W. L. (2020). *Obstetrics and Gynecology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dahlen, H. G., Downe, S., Wright, M. L., & Kennedy, H. P. (2019). Routine vaginal examinations during labour: An integrative review. *Midwifery*, 81, 102561. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2019.102561>
- Henderson, C., & Macdonald, S. (2017). *Mayes' Midwifery* (15th ed.). Elsevier.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2019). *Maternity and Women's Health Care* (12th ed.). Mosby Elsevier.
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Minister of Health Republic of Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2018). *Foundations of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing* (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., Wilson, D., Rodgers, C. C., & Alden, K. R. (2017). *Maternal Child Nursing Care* (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2020). Management of the second stage of labour. RCOG Green-top Guideline No. 26. Retrieved from <https://www.rcog.org.uk/guidance/browse-all-guidance/green-top-guidelines/>
- Simkin, P., Hanson, L., Ancheta, R., & Simkin, R. (2017). *The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- World Health Organization. (2018). WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260178>
- World Health Organization. (2020). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/336674>
- Yanti, Y., & Claramita, M. (2019). Implementasi partograf dalam praktik kebidanan: Sebuah studi eksplorasi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 6(2), 75–82. <https://doi.org/10.22146/jkr.46812>
- Yohannes, B., Tarekegn, M., & Paulos, W. (2019). Mothers' utilization of antenatal care and their satisfaction with delivery services. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(1), 250. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2381-1>
- Zhang, J., Landy, H. J., Branch, D. W., Burkman, R., Haberman, S., Gregory, K. D., ... & Reddy, U. M. (2018). Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. *Obstetrics & Gynecology*, 116(6), 1281–1287. <https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181fdef6e>

Bab 5

Asuhan Bayi Baru Lahir Sesuai KEPMENKES 320/2020

Asuhan terhadap bayi baru lahir merupakan tindakan esensial yang dilakukan segera setelah proses persalinan, guna memastikan bayi dapat beradaptasi dengan optimal dari kehidupan dalam rahim (intrauterin) ke lingkungan luar rahim (ekstrauterin). Menurut standar Kepmenkes RI Nomor 320 Tahun 2020, asuhan neonatal mencakup penilaian awal neonatus menggunakan APGAR Score, pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan kontak kulit-ke-kulit (*skin-to-skin contact*), pemberian profilaksis neonatal, serta pemantauan intensif kondisi bayi baru lahir pada dua jam pertama kehidupan. Pelaksanaan asuhan yang sesuai standar ini bertujuan meningkatkan kelangsungan hidup bayi baru lahir, mencegah komplikasi neonatal, serta mendukung perkembangan optimal bayi secara fisik, psikologis, dan emosional.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, lulusan mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif pada bayi baru lahir secara profesional, aman, dan berkualitas tinggi sesuai dengan standar Kepmenkes RI Nomor 320 Tahun 2020.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan mengimplementasikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir sesuai Kepmenkes 320 Tahun 2020 secara efektif dan tepat waktu, yang meliputi penilaian awal neonatus, IMD, pemberian profilaksis neonatal, dan pemantauan kondisi vital bayi secara intensif.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya penilaian awal neonatus menggunakan APGAR Score.
2. Melaksanakan penilaian APGAR Score secara benar pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran bayi.
3. Memahami konsep dasar, manfaat, dan teknik pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan skin-to-skin contact sesuai dengan pedoman.
4. Melakukan IMD secara benar dan efektif pada bayi baru lahir.
5. Mengidentifikasi dan menjelaskan pentingnya pemberian profilaksis neonatal (vitamin K intramuskular dan profilaksis mata antibiotik).
6. Melaksanakan prosedur pemberian profilaksis neonatal sesuai standar yang ditetapkan dalam Kepmenkes 320/2020.
7. Memahami parameter penting dalam pemantauan awal neonatus, termasuk suhu tubuh, denyut jantung, pernapasan, warna kulit, dan reaktivitas bayi.
8. Melakukan pemantauan awal neonatal secara intensif pada dua jam pertama kehidupan bayi, serta mengidentifikasi tanda bahaya neonatal secara dini.

A. Penilaian Awal Neonatus (APGAR Score)

Penilaian awal neonatus atau bayi baru lahir adalah prosedur esensial yang dilakukan segera setelah bayi lahir. Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk menentukan kondisi kesehatan bayi secara cepat dan akurat, serta mengidentifikasi adanya kebutuhan akan intervensi medis yang bersifat mendesak. Salah satu instrumen yang digunakan secara luas dalam penilaian ini adalah APGAR Score. APGAR Score merupakan sebuah sistem penilaian yang dikembangkan oleh Dr. Virginia Apgar, yang bertujuan mengevaluasi dengan cepat kondisi bayi dalam menit-menit pertama kehidupannya di luar rahim.

APGAR Score mencakup penilaian lima parameter penting yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai status kesehatan bayi yang baru lahir.

1. Parameter pertama adalah penampilan atau warna kulit bayi (Appearance). Warna kulit ini diamati untuk mengevaluasi oksigenasi jaringan tubuh. Neonatus yang sehat biasanya memiliki kulit yang berwarna merah muda di seluruh tubuh, menunjukkan sirkulasi darah yang baik dan oksigenasi yang optimal. Sebaliknya, bayi yang mengalami masalah oksigenasi mungkin memiliki warna kulit pucat, kebiruan atau sianosis yang merupakan tanda gangguan perfusi oksigen dalam jaringan tubuh.
2. Parameter kedua yang dinilai adalah denyut jantung bayi (Pulse). Penilaian denyut jantung merupakan indikator vital yang paling kritis dalam penilaian APGAR, karena denyut jantung mencerminkan kondisi sirkulasi darah bayi secara langsung. Dalam kondisi ideal, bayi yang sehat akan memiliki denyut jantung lebih dari 100 kali per menit. Denyut jantung yang lambat atau tidak terdeteksi merupakan tanda bahaya yang serius, yang mengindikasikan perlunya resusitasi segera dan intervensi medis yang mendesak.
3. Parameter ketiga yang diperiksa adalah respon refleks bayi terhadap rangsangan (Grimace). Dalam parameter ini, tenaga kesehatan melakukan stimulasi ringan seperti mengusap punggung atau kaki bayi, lalu mengamati bagaimana bayi merespons. Bayi yang sehat umumnya memberikan reaksi yang kuat, seperti menangis atau menunjukkan gerakan refleks aktif, yang merupakan tanda bahwa sistem saraf bayi berfungsi dengan baik. Sebaliknya, bayi yang lemah atau mengalami gangguan neurologis mungkin memberikan respons yang minimal atau bahkan sama sekali tidak memberikan respons terhadap stimulasi yang diberikan.
4. Selanjutnya, parameter keempat yang dinilai adalah aktivitas atau tonus otot bayi (Activity). Tonus otot menggambarkan kondisi kekuatan dan ketegangan otot bayi yang baru lahir. Bayi yang sehat biasanya akan menunjukkan gerakan aktif dan spontan dengan tangan dan kakinya. Selain itu, bayi tersebut akan memiliki tonus

otot yang kuat, sehingga ekstremitas tubuhnya bergerak dengan baik dan tidak tampak lemas. Kondisi sebaliknya, yakni tonus otot yang rendah atau lemah, bisa menandakan adanya gangguan neuromuskuler atau kondisi medis lainnya yang memerlukan intervensi medis segera.

5. Parameter kelima yang terakhir dalam APGAR Score adalah penilaian terhadap usaha pernapasan bayi (Respiration). Parameter ini mengevaluasi apakah bayi mampu bernapas secara spontan dan efektif segera setelah dilahirkan. Bayi yang sehat biasanya menangis dengan kuat segera setelah lahir, menunjukkan paru-parunya berfungsi dengan baik dan pertukaran udara berlangsung optimal. Sebaliknya, bayi yang mengalami kesulitan pernapasan mungkin menunjukkan usaha napas yang lemah, tidak teratur, atau bahkan tidak ada usaha napas sama sekali, yang mengindikasikan kondisi gawat darurat pernapasan.

Penilaian dengan APGAR Score ini dilakukan dua kali, yaitu pada menit pertama dan menit kelima setelah kelahiran bayi. Pada setiap parameter, nilai diberikan mulai dari 0 hingga 2, dengan total skor maksimal adalah 10. Skor yang didapat dari penilaian ini memberikan informasi awal yang sangat penting bagi tenaga kesehatan. Skor 7 hingga 10 umumnya menunjukkan kondisi bayi yang baik atau stabil, dengan adaptasi yang optimal terhadap kehidupan di luar rahim. Sebaliknya, skor yang lebih rendah, khususnya di bawah 7, menunjukkan adanya gangguan adaptasi neonatal yang memerlukan perhatian khusus, observasi lebih lanjut, dan mungkin juga tindakan medis segera.

Penilaian APGAR Score bukan hanya prosedur rutin semata, melainkan instrumen penting yang sangat berperan dalam menyelamatkan nyawa bayi yang baru lahir. Penilaian yang tepat dan akurat terhadap parameter-parameter ini membantu tenaga kesehatan mengidentifikasi bayi dengan risiko tinggi, memprioritaskan tindakan intervensi yang cepat dan efektif, serta memastikan bahwa setiap bayi mendapatkan perawatan optimal sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, APGAR Score menjadi dasar awal yang sangat menentukan dalam asuhan neonatal, mendukung keselamatan bayi dan meningkatkan hasil kesehatan jangka panjang bagi neonatus.

B. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan *Skin to Skin Contact*

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan proses penting yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan untuk dilakukan segera setelah bayi lahir, idealnya dalam satu jam pertama pasca kelahiran. Proses IMD dilakukan dengan cara meletakkan bayi yang baru lahir langsung di atas dada ibu dalam posisi kontak kulit ke kulit (*skin to skin contact*). Dalam posisi ini, tubuh bayi secara penuh bersentuhan langsung dengan kulit ibu tanpa adanya penghalang, seperti pakaian atau selimut, sehingga memberikan

kehangatan alami yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Melalui kontak kulit ke kulit ini, bayi secara naluriah akan menunjukkan perilaku alami berupa pencarian puting susu ibu, yang merupakan respons alami yang didukung oleh refleks hisap bawaan sejak lahir.

Ketika bayi diletakkan secara langsung di dada ibu dalam posisi ini, bayi akan secara spontan mulai melakukan serangkaian gerakan yang disebut sebagai "breast crawl," yaitu bayi bergerak perlahan-lahan dengan dorongan refleks menuju puting susu ibu. Gerakan ini diawali dengan refleks mencari (rooting reflex) di mana bayi akan membuka mulutnya secara naluriah dan menggerakkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lainnya untuk menemukan puting susu. Setelah menemukan puting susu, bayi secara alami akan mulai mengisap dengan kuat dan teratur. Proses alami ini memiliki makna yang mendalam dalam memastikan bayi mendapatkan kolostrum, yaitu ASI pertama yang mengandung nutrisi tinggi, kaya akan antibodi dan zat-zat kekebalan tubuh yang sangat penting bagi sistem imun bayi.

Prosedur IMD dengan kontak kulit ke kulit memberikan banyak manfaat penting bagi bayi baru lahir. Pertama, prosedur ini membantu dalam stabilisasi suhu tubuh bayi. Segera setelah lahir, bayi mengalami perubahan lingkungan drastis dari lingkungan dalam rahim yang hangat ke lingkungan luar rahim yang lebih dingin. Kontak langsung antara kulit ibu dan bayi menciptakan kehangatan alami yang membantu mempertahankan suhu tubuh bayi, sehingga mengurangi risiko hipotermia. Selain itu, kontak kulit ke kulit juga memudahkan regulasi termal tubuh bayi secara alami karena dada ibu memberikan suhu yang stabil dan optimal bagi tubuh bayi.

Selain manfaat dalam pengaturan suhu tubuh, kontak kulit ke kulit juga memberikan efek positif dalam stabilisasi pernapasan bayi. Bayi yang baru lahir perlu segera beradaptasi dengan proses bernapas secara mandiri setelah sebelumnya memperoleh oksigen sepenuhnya melalui plasenta saat masih dalam kandungan. Ketika bayi ditempatkan dalam posisi skin to skin contact di atas dada ibu, bayi akan secara alami merasakan irama napas ibu yang teratur dan tenang, yang membantu mengatur pola napas bayi menjadi lebih stabil dan teratur. Hal ini juga sekaligus membantu mencegah terjadinya gangguan pernapasan yang mungkin terjadi segera setelah kelahiran.

Selanjutnya, kontak kulit ke kulit dalam IMD turut membantu stabilisasi denyut jantung bayi. Bayi baru lahir dapat mengalami stres fisik dan emosional akibat proses kelahiran, yang berisiko menyebabkan denyut jantung menjadi tidak stabil. Namun, ketika bayi berada dalam kontak langsung dengan ibu, bayi dapat merasakan detak jantung ibu yang sudah sangat dikenalnya sejak dalam kandungan. Irama detak jantung ibu ini

menjadi stimulus alami bagi bayi untuk menenangkan diri dan secara alami membantu menormalkan irama jantung bayi, yang berdampak langsung pada kondisi bayi yang lebih tenang, nyaman, dan stabil.

Tidak kalah pentingnya adalah manfaat emosional dan psikologis dari proses IMD dan kontak kulit ke kulit, yaitu memperkuat bonding atau ikatan emosional antara ibu dan bayi. Kontak langsung segera setelah kelahiran memberikan peluang bagi ibu dan bayi untuk mengenal satu sama lain secara lebih dekat melalui sentuhan, penciuman, pendengaran, serta kontak visual yang intens. Proses ini merangsang pelepasan hormon oksitosin, dikenal sebagai hormon cinta, yang tidak hanya meningkatkan produksi ASI ibu tetapi juga memperkuat rasa sayang dan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Bonding yang kuat ini sangat penting bagi kesehatan emosional bayi serta ibu dalam jangka pendek maupun panjang, mendukung perkembangan bayi yang optimal secara emosional, sosial, dan fisik.

Secara keseluruhan, Inisiasi Menyusui Dini yang dilakukan melalui kontak kulit ke kulit merupakan prosedur yang sangat direkomendasikan sebagai bagian dari asuhan neonatal esensial. Prosedur ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap stabilisasi fisiologis bayi dalam periode transisi kehidupan awal di luar kandungan, tetapi juga mendukung pembentukan ikatan emosional yang sehat antara ibu dan bayi. Oleh karena itu, IMD dengan skin to skin contact harus dipromosikan secara luas sebagai standar praktik terbaik dalam perawatan bayi baru lahir.

C. Profilaksis Neonatus

Setelah bayi dilahirkan, tubuhnya mengalami transisi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin yang sepenuhnya mandiri. Periode transisi ini merupakan waktu yang sangat kritis karena berbagai sistem tubuh bayi, seperti sistem pembekuan darah dan sistem imun, masih belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, diperlukan beberapa tindakan pencegahan atau profilaksis neonatal segera setelah kelahiran untuk melindungi bayi dari komplikasi atau penyakit yang dapat berakibat serius. Profilaksis ini merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan segera kepada bayi baru lahir sehingga memastikan awal kehidupan yang aman, sehat, dan optimal bagi bayi.

1. Salah satu bentuk profilaksis neonatal yang paling umum dan esensial adalah pemberian vitamin K secara intramuskular. Setelah bayi dilahirkan, secara alami tubuhnya memiliki kadar vitamin K yang sangat rendah. Vitamin K merupakan vitamin yang sangat penting dalam proses pembekuan darah. Kondisi ini disebut sebagai defisiensi vitamin K pada neonatus, yang terjadi karena plasenta hanya sedikit mentransfer vitamin K dari ibu ke bayi selama kehamilan, dan juga karena

saluran pencernaan bayi yang baru lahir belum mampu menghasilkan vitamin K dalam jumlah yang cukup pada hari-hari pertama kehidupannya. Tanpa suplementasi vitamin K, bayi berisiko tinggi mengalami perdarahan spontan yang serius, seperti perdarahan pada sistem pencernaan, kulit, atau bahkan perdarahan intrakranial yang dapat mengakibatkan kerusakan otak permanen atau kematian.

Untuk mencegah kondisi tersebut, vitamin K diberikan kepada bayi dengan dosis standar 1 mg secara intramuskular (IM), biasanya disuntikkan ke dalam otot paha bayi segera setelah kelahiran, atau paling lambat dalam waktu beberapa jam setelah bayi lahir. Pemberian vitamin K ini sangat efektif dalam mencegah terjadinya perdarahan defisiensi vitamin K (Vitamin K Deficiency Bleeding/VKDB), suatu kondisi yang sangat serius namun dapat dicegah dengan efektif melalui profilaksis sederhana ini. Oleh karena itu, pemberian vitamin K intramuskular merupakan praktik wajib yang diterapkan secara universal pada bayi baru lahir di berbagai fasilitas kesehatan di seluruh dunia.

2. Selain pemberian vitamin K, profilaksis neonatal lainnya yang tidak kalah penting adalah profilaksis mata. Tindakan ini dilakukan dengan pemberian salep antibiotik yang biasanya berupa eritromisin atau tetrasiklin. Profilaksis mata ini bertujuan untuk melindungi bayi dari kondisi ophthalmia neonatorum, yaitu infeksi mata yang serius yang dapat dialami oleh bayi baru lahir akibat terpapar oleh bakteri yang terdapat pada jalan lahir ibu, khususnya bakteri *Neisseria gonorrhoeae* (penyebab gonore) atau *Chlamydia trachomatis* (penyebab klamidia). Kedua jenis bakteri tersebut dapat menyebabkan infeksi mata berat yang berisiko tinggi menimbulkan kebutaan permanen pada bayi jika tidak segera dicegah atau diobati secara efektif.

Prosedur profilaksis mata ini dilakukan dengan mengoleskan salep antibiotik secara hati-hati dan menyeluruh pada konjungtiva bayi, yaitu bagian dalam kelopak mata bayi. Tindakan ini idealnya diberikan sesegera mungkin setelah bayi dilahirkan, namun wajib diberikan tidak lebih dari satu jam setelah kelahiran untuk memastikan efektivitas maksimal dalam mencegah infeksi tersebut. Pemberian antibiotik topikal ini telah terbukti secara ilmiah mampu menurunkan angka kejadian ophthalmia neonatorum secara signifikan, serta telah menjadi standar praktik di seluruh dunia sebagai bagian dari perawatan neonatal rutin yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

Secara keseluruhan, profilaksis neonatal yang terdiri dari pemberian vitamin K intramuskular serta profilaksis mata dengan antibiotik merupakan dua tindakan preventif esensial yang sangat penting dilakukan segera setelah kelahiran bayi. Kedua

profilaksis ini terbukti sangat efektif dalam melindungi bayi dari komplikasi serius yang dapat terjadi di awal kehidupan, sehingga menjadi bagian integral dari asuhan neonatal esensial. Dengan memastikan bahwa setiap bayi yang lahir menerima profilaksis ini secara tepat waktu, kita dapat secara efektif mencegah berbagai kondisi yang berpotensi mengancam kehidupan dan memastikan bayi mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan paling aman.

D. Pemantauan Awal Neonatus

Pemantauan awal neonatus merupakan tindakan penting dan krusial dalam asuhan neonatal yang dilakukan secara intensif dalam dua jam pertama setelah bayi lahir. Periode dua jam pertama setelah kelahiran merupakan masa transisi kritis di mana bayi baru lahir mengalami adaptasi yang cepat dari lingkungan intrauterin, di mana semua kebutuhan vitalnya dipenuhi melalui plasenta, menuju kehidupan ekstrauterin yang mandiri. Karena proses adaptasi ini sangat kompleks dan cepat, maka pemantauan yang ketat terhadap kondisi vital bayi perlu dilakukan dengan saksama untuk memastikan bahwa bayi mampu melewati masa transisi ini dengan baik, stabil, dan tanpa komplikasi.

Salah satu parameter penting yang harus dipantau secara ketat adalah suhu tubuh bayi. Neonatus memiliki risiko tinggi untuk mengalami ketidakstabilan suhu tubuh, khususnya hipotermia atau suhu tubuh rendah, karena bayi baru lahir belum mampu mengatur suhu tubuhnya secara efektif. Bayi yang baru lahir memiliki rasio luas permukaan tubuh yang besar dibandingkan dengan berat badannya serta memiliki cadangan lemak subkutan yang terbatas, sehingga bayi menjadi lebih mudah kehilangan panas tubuh melalui evaporasi, konduksi, konveksi, maupun radiasi. Hipotermia, jika tidak segera diidentifikasi dan diatasi, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti hipoglikemia (penurunan kadar gula darah), gangguan pernapasan, hingga gangguan sistem saraf pusat yang serius. Oleh karena itu, pemantauan suhu tubuh bayi dilakukan secara rutin setiap beberapa menit dalam dua jam pertama ini, dengan intervensi segera seperti kontak kulit-ke-kulit (skin-to-skin contact), selimut hangat, atau pemakaian warmer bayi bila ditemukan adanya penurunan suhu tubuh.

Selain suhu tubuh, denyut jantung bayi juga merupakan parameter yang wajib dipantau secara ketat. Denyut jantung bayi yang baru lahir pada umumnya berkisar antara 120 hingga 160 kali per menit. Adanya penyimpangan signifikan, baik berupa denyut jantung yang terlalu cepat (takikardia) atau terlalu lambat (bradikardia), dapat mengindikasikan adanya gangguan hemodinamik atau ketidakstabilan dalam adaptasi jantung bayi. Pemantauan denyut jantung biasanya dilakukan dengan stetoskop atau pulse oximeter secara teratur, dan apabila ditemukan ketidaknormalan denyut jantung,

intervensi segera seperti pemberian oksigen tambahan atau stimulasi dapat diperlukan untuk memastikan kondisi bayi tetap stabil.

Pemantauan pernapasan neonatus juga menjadi fokus utama dalam periode awal ini. Normalnya, bayi baru lahir memiliki frekuensi pernapasan sekitar 30–60 kali per menit. Gangguan pernapasan yang mungkin terjadi dapat berupa apnea (periode berhenti bernapas selama lebih dari 20 detik), takipnea (pernapasan yang terlalu cepat), atau distress pernapasan yang ditandai dengan tanda-tanda seperti retraksi dada, napas cuping hidung (nasal flaring), serta adanya suara mengi atau grunting. Deteksi dini terhadap gangguan pernapasan sangat penting, karena jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan hipoksia (kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh bayi), yang kemudian berpotensi menimbulkan komplikasi berat seperti kerusakan organ atau gangguan neurologis jangka panjang. Oleh karena itu, jika gangguan pernapasan ditemukan, tindakan intervensi berupa pemberian oksigen, stimulasi ringan, atau bahkan ventilasi tekanan positif segera dilakukan untuk menjaga stabilitas pernapasan bayi.

Aspek penting lainnya dalam pemantauan neonatus adalah reaktivitas dan warna kulit bayi. Bayi yang sehat umumnya memiliki warna kulit yang merah muda serta bereaksi aktif terhadap rangsangan seperti sentuhan atau suara. Namun, beberapa bayi mungkin menunjukkan warna kulit kebiruan atau pucat, dikenal sebagai sianosis atau pucat, yang menandakan kurangnya suplai oksigen dalam darah. Kondisi ini merupakan tanda serius yang perlu ditangani secara cepat dan efektif melalui pemberian oksigen tambahan atau intervensi medis lainnya. Demikian pula dengan reaktivitas bayi, di mana bayi yang mengalami penurunan tonus otot atau hipotonia, lemah, lesu, atau kurang responsif terhadap rangsangan dapat mengindikasikan adanya masalah neurologis atau metabolik yang memerlukan evaluasi serta intervensi segera.

Secara keseluruhan, pemantauan awal neonatus yang dilakukan secara ketat dan intensif dalam dua jam pertama setelah kelahiran sangat esensial untuk memastikan bayi menjalani adaptasi kehidupan ekstrauterin secara optimal. Tindakan pemantauan ini melibatkan penilaian berkelanjutan terhadap suhu tubuh, denyut jantung, pernapasan, warna kulit, serta respons dan tonus otot bayi. Dengan pemantauan yang teliti ini, tenaga kesehatan dapat secara dini mengidentifikasi adanya tanda-tanda komplikasi yang mungkin muncul, serta memberikan intervensi segera yang dibutuhkan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dengan demikian, langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa bayi baru lahir memiliki awal kehidupan yang stabil, sehat, dan aman, serta mampu tumbuh dan berkembang secara optimal.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Studi Kasus dan Analisis APGAR Score

Instruksi:

- Pilih atau buatlah satu skenario kasus kelahiran bayi baru lahir.
- Lakukan penilaian APGAR Score pada menit pertama dan menit kelima.
- Jelaskan secara rinci skor untuk setiap parameter:
 - Appearance (Warna kulit)
 - Pulse (Denyut jantung)
 - Grimace (Respon refleks)
 - Activity (Tonus otot)
 - Respiration (Usaha pernapasan)
- Interpretasikan hasil APGAR Score, serta jelaskan intervensi apa yang harus diberikan berdasarkan skor tersebut.

Tugas 2: Poster Edukasi tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Instruksi:

- Buatlah poster edukasi yang menjelaskan pentingnya Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan kontak kulit ke kulit.
- Poster harus mencakup:
 - Definisi dan langkah-langkah IMD.
 - Manfaat fisiologis IMD (stabilisasi suhu, pernapasan, denyut jantung).
 - Manfaat emosional IMD (bonding antara ibu dan bayi).
 - Visualisasi yang jelas tentang posisi bayi saat IMD.
- Poster harus menarik, informatif, mudah dipahami, serta cocok dipajang di ruang bersalin atau klinik bersalin.

Tugas 3: Video Simulasi Profilaksis Neonatus

Instruksi:

- Dalam kelompok kecil, buatlah video simulasi pelaksanaan profilaksis neonatal yang meliputi:
 - Pemberian Vitamin K intramuskular.
 - Pemberian salep antibiotik mata (profilaksis oftalmia neonatorum).
- Dalam video tersebut, demonstrasikan teknik aseptik dan langkah-langkah pelaksanaan dengan benar.
- Berikan penjelasan singkat di akhir video tentang pentingnya profilaksis ini.
- Durasi video maksimal 10 menit, jelas, dan informatif.

Tugas 4: Checklist Pemantauan Awal Neonatus (2 jam pertama)

Instruksi:

- Susunlah checklist observasi komprehensif untuk pemantauan neonatus pada dua jam pertama setelah lahir.
- Checklist harus mencakup pemantauan:
 - Suhu tubuh bayi
 - Denyut jantung bayi
 - Frekuensi dan pola pernapasan bayi
 - Warna kulit dan reaktivitas bayi
- Jelaskan dalam checklist frekuensi pemantauan, kriteria normal-abnormal, serta tindakan intervensi segera yang perlu dilakukan bila ditemukan penyimpangan dari kondisi normal.

Tugas 5: Brosur Informasi untuk Orang Tua tentang Perawatan Awal Neonatus

Instruksi:

- Buat brosur informatif yang ditujukan untuk orang tua mengenai perawatan awal neonatus selama dua jam pertama setelah kelahiran.
- Isi brosur mencakup:
 - Penjelasan singkat mengenai pentingnya pemantauan awal neonatus.
 - Apa saja tanda vital penting yang harus diamati (suhu, napas, denyut jantung).
 - Tanda-tanda bahaya yang perlu dilaporkan segera kepada tenaga kesehatan (misalnya hipotermia, sianosis, distress pernapasan, bayi lesu).
 - Manfaat IMD dan skin to skin contact yang harus dipahami orang tua.
- Brosur harus ringkas, mudah dipahami, dan menarik secara visual.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu hamil datang ke ruang bersalin dengan keluhan kontraksi uterus yang mulai terasa setiap 15 menit, durasi 30 detik, dan adanya lendir bercampur darah yang keluar dari vagina. Pemeriksaan dalam menunjukkan serviks sudah mulai menipis 50% dan dilatasi 2 cm.

Apa status persalinan ibu tersebut?

- A. Persalinan aktif, segera persiapkan persalinan
- B. Persalinan fase laten, berikan dukungan dan observasi
- C. Persalinan sudah memasuki fase kedua
- D. Persalinan tidak terjadi, ibu harus dirujuk
- E. Persalinan selesai, persiapkan pemulihan

2. Seorang ibu dalam fase aktif persalinan dengan kontraksi setiap 3 menit, durasi 50 detik, dan dilatasi serviks 7 cm. Ibu mengeluhkan kelelahan dan rasa cemas yang meningkat.
Apa langkah keperawatan yang paling tepat?
- A. Beri edukasi dan instruksi mengejan kuat
 - B. Berikan analgesik tanpa pendampingan
 - C. Berikan dukungan fisik dan psikologis, serta bantu posisi nyaman
 - D. Sarankan ibu berbaring dan beristirahat total
 - E. Lanjutkan observasi tanpa intervensi
3. Pada grafik partograf, dilatasi serviks ibu tidak bertambah dari 5 cm dalam 3 jam terakhir, kontraksi uterus lemah, dan denyut jantung janin menurun.
Tindakan terbaik berikutnya adalah
- A. Teruskan observasi dan evaluasi setelah 6 jam
 - B. Anjurkan ibu untuk berjalan dan bergerak aktif
 - C. Mulai persiapan persalinan dengan operasi sesar
 - D. Berikan oksitosin untuk memperkuat kontraksi
 - E. Berikan analgesik dan biarkan proses berjalan
4. Selama kala II persalinan, ibu mengalami kesulitan mengatur napas saat mengejan dan mulai lelah. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh bidan adalah:
- A. Meminta ibu terus mengejan tanpa henti
 - B. Mengatur teknik napas dan posisi yang nyaman
 - C. Menyarankan ibu berbaring dan menunggu saja
 - D. Memberikan analgesik dosis tinggi segera
 - E. Melakukan episiotomi segera
5. Setelah persalinan, fundus uteri ibu terasa lunak dan di atas pusat, ibu mengeluhkan pusing dan terlihat lemas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah:
- A. Melakukan pemijatan fundus uterus dan pemberian oksitosin
 - B. Memberikan cairan oral dan menyuruh istirahat
 - C. Memberikan analgesik untuk nyeri
 - D. Menunggu plasenta keluar secara spontan
 - E. Melakukan pemeriksaan tekanan darah

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Ibu berada dalam fase laten karena dilatasi serviks masih di bawah 4 cm dan kontraksi belum teratur serta intensitas masih rendah. Tindakan utama adalah memberikan dukungan psikologis dan fisik serta observasi progres persalinan.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Dukungan fisik (misal pijatan, kompres, posisi nyaman) dan psikologis (semangat, pujian) sangat penting untuk mengurangi kecemasan dan membantu ibu menghadapi nyeri persalinan yang intens pada fase aktif.

3. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Tidak ada progres dilatasi dengan kontraksi lemah serta distress janin menunjukkan distosia, sehingga pemberian oksitosin untuk memperkuat kontraksi uterus diperlukan sesuai protokol.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Mengatur teknik pernapasan yang benar dan membantu ibu memilih posisi nyaman dapat meningkatkan efektivitas mengejan dan mengurangi kelelahan serta risiko trauma.

5. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Fundus uteri lunak menandakan atonia uteri yang merupakan penyebab utama perdarahan postpartum. Pemijatan fundus dan pemberian oksitosin adalah langkah utama untuk merangsang kontraksi dan menghentikan perdarahan.

Rangkuman Materi

Asuhan neonatus yang komprehensif merupakan rangkaian tindakan klinis esensial yang sangat menentukan keberhasilan adaptasi bayi baru lahir dalam kehidupan ektrauterin. Penilaian awal dengan APGAR Score menjadi langkah awal yang penting, karena mampu memberikan gambaran cepat mengenai kondisi kesehatan bayi dan mengidentifikasi secara dini kebutuhan akan intervensi medis. APGAR Score menilai lima parameter vital yaitu penampilan kulit, denyut jantung, respon refleks terhadap rangsangan, tonus otot, dan usaha pernapasan, yang secara keseluruhan membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat dalam memberikan perawatan neonatal.

Selain penilaian kondisi vital bayi, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dengan kontak kulit-ke-kulit juga merupakan komponen kritis dalam asuhan neonatus. IMD terbukti memberikan manfaat besar dalam menstabilkan suhu tubuh, pernapasan, dan denyut jantung bayi secara alami, serta memperkuat ikatan emosional (bonding) antara ibu dan bayi. Dengan demikian, IMD tidak hanya meningkatkan adaptasi fisiologis bayi tetapi juga mendukung perkembangan emosional yang optimal pada tahap awal kehidupannya.

Di samping itu, profilaksis neonatal berupa pemberian vitamin K intramuskular dan profilaksis mata dengan antibiotik merupakan langkah preventif yang wajib dilakukan sesegera mungkin setelah kelahiran. Kedua tindakan ini sangat efektif untuk mencegah komplikasi serius seperti perdarahan defisiensi vitamin K dan infeksi mata neonatal (ophthalmia neonatorum), yang dapat mengancam keselamatan bayi jika tidak segera dicegah atau ditangani secara tepat.

Pemantauan intensif terhadap neonatus dalam dua jam pertama setelah kelahiran juga memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas kondisi bayi. Pemantauan ini mencakup observasi suhu tubuh, denyut jantung, frekuensi dan kualitas pernapasan, serta respon bayi terhadap rangsangan. Dengan pemantauan yang teliti, tenaga kesehatan mampu mendeteksi secara dini tanda-tanda komplikasi seperti hipotermia, gangguan pernapasan, atau gangguan sirkulasi yang dapat segera ditangani melalui intervensi yang tepat dan cepat.

Secara keseluruhan, asuhan neonatal yang efektif adalah gabungan dari penilaian klinis yang akurat, pemberian intervensi yang tepat waktu, serta pemantauan kontinu terhadap kondisi bayi yang baru lahir. Implementasi praktik terbaik ini secara konsisten akan memberikan fondasi kuat bagi kesehatan bayi baru lahir, mencegah komplikasi serius, serta memastikan bahwa setiap neonatus memiliki awal kehidupan yang optimal dan aman.

Glosarium

Adaptasi ekstrauterin: Proses penyesuaian yang dialami bayi baru lahir ketika berpindah dari kehidupan dalam kandungan ke kehidupan di luar rahim, meliputi adaptasi sistem pernapasan, peredaran darah, termoregulasi, dan metabolisme.

Activity (Tonus otot): Parameter keempat APGAR Score yang menggambarkan kekuatan dan ketegangan otot bayi. Tonus otot yang kuat menunjukkan kondisi kesehatan bayi yang optimal.

APGAR Score: Sistem penilaian cepat terhadap kondisi neonatus yang dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran, mencakup penampilan kulit, denyut jantung, respon refleks terhadap rangsangan, aktivitas otot, dan usaha pernapasan. Skor ini membantu menentukan kebutuhan intervensi medis segera.

Appearance (Penampilan kulit): Parameter pertama dalam APGAR Score yang menilai warna kulit bayi untuk mengetahui tingkat oksigenasi jaringan tubuh. Warna merah muda menandakan oksigenasi baik, sedangkan pucat atau sianosis menunjukkan gangguan oksigenasi.

Breast crawl: Proses bayi secara naluriah bergerak perlahan mencari puting susu ibu sesaat setelah dilahirkan, merupakan refleks alami yang mendukung keberhasilan menyusui dini.

Distress pernapasan neonates: Gangguan pernapasan pada bayi baru lahir yang ditandai dengan pernapasan cepat (takipnea), retraksi dada, napas cuping hidung, mengi, atau grunting, membutuhkan intervensi medis segera.

Grimace (Respons refleks): Parameter ketiga dalam APGAR Score yang mengevaluasi respons bayi terhadap rangsangan ringan seperti sentuhan atau gesekan, yang mencerminkan integritas sistem saraf bayi.

Hipoksia: Kondisi kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh bayi yang jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan komplikasi berat seperti kerusakan organ atau gangguan neurologis.

Hipotermia neonates: Penurunan suhu tubuh bayi baru lahir di bawah batas normal akibat ketidakmampuan tubuhnya untuk mengatur suhu secara efektif, berisiko tinggi pada dua jam pertama setelah kelahiran.

Hormon oksitosin: Hormon yang dilepaskan saat kontak kulit ke kulit, berperan meningkatkan produksi ASI ibu serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD): Praktik memberikan kesempatan kepada bayi baru lahir untuk segera menyusui dalam satu jam pertama setelah kelahiran, dilakukan melalui kontak kulit ke kulit dengan ibu, yang membantu stabilisasi fisiologis bayi dan memperkuat bonding ibu-bayi.

Kontak Kulit ke Kulit (Skin-to-skin contact): Kontak langsung tanpa penghalang antara kulit bayi dan kulit ibu segera setelah kelahiran, berperan dalam pengaturan suhu tubuh, stabilisasi denyut jantung dan pernapasan, serta memperkuat ikatan emosional.

Kolostrum: ASI pertama yang keluar segera setelah kelahiran bayi, mengandung nutrisi tinggi, antibodi, serta zat-zat kekebalan tubuh penting yang membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi.

Ophthalmia neonatorum: Infeksi mata serius pada neonatus yang disebabkan oleh bakteri seperti *Neisseria gonorrhoeae* atau *Chlamydia trachomatis*, dicegah dengan profilaksis salep antibiotik segera setelah lahir.

Pemantauan neonatal: Observasi intensif terhadap tanda-tanda vital neonatus, seperti suhu tubuh, denyut jantung, pernapasan, respons neurologis, dan warna kulit yang dilakukan segera setelah kelahiran untuk memastikan stabilitas kondisi bayi.

Profilaksis neonatal: Tindakan pencegahan yang diberikan segera setelah bayi lahir untuk melindungi neonatus dari komplikasi atau penyakit serius, seperti perdarahan akibat defisiensi vitamin K dan infeksi mata neonatal.

Pulse (Denyut jantung): Parameter kedua APGAR yang paling vital, mencerminkan kondisi sirkulasi darah neonatus secara langsung. Denyut jantung normal pada bayi baru lahir adalah lebih dari 100 kali per menit.

Respiration (Usaha pernapasan): Parameter kelima dalam APGAR Score yang mengevaluasi kemampuan bayi untuk bernapas secara spontan dan efektif setelah dilahirkan. Pernapasan yang kuat dan menangis segera setelah lahir menunjukkan fungsi paru-paru yang optimal.

Sianosis: Warna kebiruan pada kulit bayi akibat kurangnya oksigen dalam darah, merupakan tanda serius yang memerlukan intervensi medis segera.

Vitamin K Deficiency Bleeding (VKDB): Perdarahan spontan yang serius pada neonatus akibat rendahnya kadar vitamin K, dicegah dengan pemberian vitamin K intramuskular segera setelah kelahiran.

Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics (AAP). (2020). Textbook of neonatal resuscitation (8th ed.). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.
- Apgar, V. (1953). A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. *Current Researches in Anesthesia & Analgesia*, 32(4), 260–267. <https://doi.org/10.1213/00000539-195301000-00041>
- Aziz, K., Lee, H. C., Escobedo, M. B., Hoover, A. V., Kamath-Rayne, B. D., Kapadia, V. S., Magid, D. J., Niermeyer, S., Schmölzer, G. M., Szyld, E., & Weiner, G. M. (2020). Part 5: Neonatal resuscitation: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Pediatrics*, 147(Suppl 1), e2020038505E. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-038505E>
- Brimdyr, K., Cadwell, K., & Widström, A. M. (2020). The effect of labor medications on normal newborn behavior in the first hour after birth: A systematic review. *International Breastfeeding Journal*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s13006-020-00306-2>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Moore, E. R., Bergman, N., Anderson, G. C., & Medley, N. (2016). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(11), CD003519. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003519.pub4>
- Puopolo, K. M., Benitz, W. E., Zaoutis, T. E., & Committee on Fetus and Newborn, Committee on Infectious Diseases. (2019). Management of neonates born at ≥ 35 0/7 weeks' gestation with suspected or proven early-onset bacterial sepsis. *Pediatrics*, 144(2), e20191881. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1881>
- Widström, A. M., Brimdyr, K., Svensson, K., Cadwell, K., & Nissen, E. (2019). Skin-to-skin contact the first hour after birth, underlying implications and clinical practice. *Acta Paediatrica*, 108(7), 1192–1204. <https://doi.org/10.1111/apa.14754>
- World Health Organization (WHO). (2017). Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: Guideline. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2021). Guidelines on newborn care. Geneva: World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029018>

Bab 6

Komplikasi Persalinan dan Manajemen Rujukan

Deteksi dini komplikasi persalinan merupakan langkah esensial yang tidak dapat dilepaskan dari praktik kebidanan dalam rangka menjaga keselamatan ibu dan bayi. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara tepat dan cepat tanda-tanda awal gangguan yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan dan nyawa keduanya. Dengan kemampuan deteksi yang baik, tenaga kesehatan, terutama bidan, dapat melakukan intervensi yang sesuai sebelum komplikasi berkembang menjadi kondisi serius. Melalui pengkajian menyeluruh dan penggunaan alat bantu klinis, seperti partograf, manajemen risiko dan pengawasan persalinan dapat dilakukan secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan mengurangi angka kematian maternal dan neonatal.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, lulusan diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya deteksi dini komplikasi persalinan dalam asuhan kebidanan untuk keselamatan ibu dan bayi.
2. Mengimplementasikan pemantauan tanda vital dan kemajuan persalinan secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi komplikasi.
3. Melakukan komunikasi efektif dengan ibu dan tim kesehatan untuk mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan klinis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat:

1. Melakukan pengkajian komprehensif terhadap kondisi ibu hamil selama persalinan.
2. Mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi persalinan secara dini berdasarkan observasi klinis dan data pemantauan.
3. Menggunakan partograf sebagai alat bantu dalam pemantauan kemajuan persalinan dan identifikasi komplikasi.
4. Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya persalinan dan perlunya tindakan cepat.
5. Mengkomunikasikan hasil pengkajian secara efektif dalam tim multidisiplin.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa dapat secara spesifik:

- Melakukan pemeriksaan tanda vital ibu hamil secara akurat dan konsisten
- Mengamati dan mencatat pola kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan penurunan bagian janin menggunakan partograph
- Mengenali tanda-tanda perdarahan antepartum dan postpartum serta gejala preeklamsia dan eclampsia
- Mengidentifikasi gejala infeksi maternal seperti demam, nyeri abdomen, dan cairan vagina abnormal.
- Menilai kesejahteraan janin melalui pemantauan denyut jantung janin dan gerak janin.
- Melakukan komunikasi edukatif dengan ibu dan keluarga terkait deteksi dini komplikasi persalinan.
- Menyusun laporan pengkajian yang jelas dan sistematis untuk mendukung tindakan klinis dan rujukan.

A. Deteksi Dini Komplikasi Persalinan

Deteksi dini komplikasi persalinan merupakan salah satu langkah paling fundamental dan kritis dalam asuhan kebidanan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Karena komplikasi persalinan bisa berkembang dengan cepat dan menimbulkan risiko serius, maka kemampuan untuk mengenali tanda-tanda awal yang mengindikasikan potensi masalah menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan maternal.

Proses deteksi dini dimulai dengan pengkajian komprehensif terhadap kondisi ibu hamil yang meliputi berbagai aspek penting. Pertama, observasi tanda vital ibu menjadi bagian utama dalam pemantauan ini. Tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan laju pernapasan harus diperiksa secara rutin dan akurat untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Misalnya, peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba dapat menjadi indikasi awal hipertensi gestasional atau preeklamsia, yang jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti eklampsia.

Selanjutnya, pemantauan kemajuan persalinan menggunakan alat bantu klinis seperti partograf menjadi sarana penting untuk mengevaluasi progres persalinan. Partograf memungkinkan tenaga kesehatan untuk mencatat dan memantau secara sistematis parameter-parameter penting seperti dilatasi serviks, frekuensi dan durasi kontraksi uterus, penurunan bagian terendah janin dalam panggul, serta denyut jantung janin. Dengan memperhatikan grafik partograf, tenaga kesehatan dapat mengenali pola persalinan yang normal serta mengidentifikasi tanda-tanda kemajuan yang lambat atau terhenti yang mengindikasikan distosia atau hambatan persalinan.

Selain itu, deteksi dini juga mencakup pengenalan tanda-tanda bahaya yang sering muncul selama persalinan. Perdarahan antepartum (sebelum persalinan) dan postpartum (setelah persalinan) merupakan kondisi darurat yang memerlukan tindakan segera. Tenaga kesehatan harus peka terhadap keluhan perdarahan dan tanda-tanda syok akibat kehilangan darah yang dapat membahayakan ibu. Hipertensi gestasional juga menjadi perhatian utama karena dapat berakibat pada gangguan fungsi organ dan keselamatan ibu serta janin.

Tanda-tanda infeksi seperti demam, peningkatan denyut jantung ibu yang tidak sesuai dengan kondisi kontraksi, bau tidak sedap dari cairan vagina, dan nyeri perut harus segera diwaspadai karena infeksi dapat memperburuk kondisi persalinan dan berpotensi menyebabkan komplikasi serius. Selain itu, gangguan perfusi janin yang terlihat dari penurunan denyut jantung janin, perubahan pola denyut jantung yang

tidak normal, dan penurunan gerak janin menjadi sinyal penting bahwa janin mungkin mengalami stres atau hipoksia, yang memerlukan intervensi medis cepat.

Deteksi dini komplikasi persalinan harus dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan melibatkan komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan ibu hamil. Pemantauan yang konsisten dan berulang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengenali perubahan kecil sekalipun, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tepat waktu dan akurat untuk mencegah kondisi memburuk. Selain itu, pemberian edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya juga penting agar mereka dapat melapor lebih awal jika terjadi gejala yang mencurigakan.

Dengan demikian, deteksi dini komplikasi persalinan bukan hanya merupakan kewajiban profesional tenaga kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas dan aman. Kecepatan dan ketepatan dalam mengenali serta merespons tanda-tanda komplikasi akan secara signifikan mengurangi risiko kematian maternal dan neonatal serta meningkatkan kualitas keseluruhan proses persalinan.

B. Manajemen Emergensi Obstetri

Manajemen Emergensi Obstetri merupakan aspek kritis dalam pemberian asuhan kebidanan yang bertujuan untuk memberikan penanganan cepat dan tepat terhadap komplikasi persalinan yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Komplikasi-komplikasi tersebut seringkali datang secara mendadak dan memerlukan respons yang sangat cepat. Dalam manajemen emergensi obstetri, keterampilan klinis yang dimiliki oleh tenaga kesehatan, terutama bidan, sangat menentukan hasil akhir dari persalinan tersebut, baik bagi keselamatan ibu maupun bayi. Dengan adanya pengenalan dini dan penanganan yang cepat, banyak komplikasi yang dapat diatasi dengan hasil yang optimal.

Komplikasi yang mengancam nyawa seperti perdarahan postpartum, eklampsia, distosia bahu, ruptur uteri, dan infeksi berat memerlukan penanganan emergensi yang dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Penatalaksanaan dalam situasi-situasi darurat ini sering melibatkan langkah-langkah yang harus diambil dengan kecepatan, ketelitian, dan kemampuan teknik yang baik. Keterlambatan dalam menangani kondisi emergensi ini dapat memperburuk keadaan dan meningkatkan risiko bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, keterampilan bidan dalam mengenali tanda-tanda emergensi serta melakukan langkah-langkah penanganan awal sangat krusial.

Perdarahan postpartum adalah salah satu komplikasi yang paling sering ditemui dalam emergensi obstetri. Perdarahan yang terjadi setelah kelahiran dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Penanganan awal terhadap perdarahan postpartum melibatkan identifikasi sumber perdarahan (apakah disebabkan oleh atonia uteri, robekan jalan lahir, atau pengeluaran plasenta yang tidak sempurna), diikuti dengan langkah-langkah seperti pemijatan fundus uteri, pemberian oksitosin atau uterotonik lainnya untuk merangsang kontraksi uterus, serta pemasangan infus untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Bila langkah-langkah ini gagal, tindakan pembedahan atau histerektomi mungkin diperlukan.

Eklampsia adalah keadaan darurat medis lain yang sangat berbahaya, ditandai dengan kejang yang terjadi pada ibu hamil atau pasca persalinan akibat preeklampsia yang tidak terkontrol. Penanganan eklampsia melibatkan pemberian obat antikonvulsan seperti magnesium sulfat untuk menghentikan kejang, serta pemberian antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah. Selain itu, monitoring yang ketat terhadap kondisi ibu dan janin juga sangat diperlukan, dan jika kejang tidak berhenti, persalinan mungkin harus dipercepat.

Distosia bahu adalah kondisi di mana bahu bayi terjebak di panggul ibu setelah kepala bayi keluar, yang dapat mengganggu proses kelahiran. Penanganannya meliputi teknik-teknik tertentu seperti manuver McRoberts (menekuk kaki ibu ke arah perutnya untuk membuka panggul lebih lebar), serta manuver suprapubik untuk melepaskan bahu bayi. Jika metode ini tidak berhasil, tindakan lebih lanjut seperti episiotomi atau bahkan pengangkatan bahu secara manual oleh tenaga medis dapat dilakukan.

Ruptur uteri adalah komplikasi yang sangat jarang tetapi berbahaya, di mana dinding rahim robek selama persalinan. Hal ini bisa terjadi jika ada trauma atau ketegangan berlebihan pada rahim, seperti pada ibu dengan riwayat operasi caesar sebelumnya. Ruptur uteri dapat menyebabkan perdarahan hebat dan kerusakan pada organ lainnya. Penanganannya memerlukan tindakan pembedahan segera untuk menstabilkan ibu, menghentikan perdarahan, dan menyelamatkan janin jika memungkinkan. Tindakan ini seringkali melibatkan pengangkatan rahim (histerektomi) untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Infeksi berat selama atau setelah persalinan, termasuk infeksi saluran kemih, endometritis (infeksi pada lapisan dalam rahim), atau sepsis, juga memerlukan penanganan yang cepat. Gejala infeksi pada ibu dapat berupa demam tinggi, nyeri abdomen, dan cairan vagina yang abnormal. Penanganan awal biasanya melibatkan pemberian antibiotik spektrum luas, pengelolaan cairan tubuh, serta pemantauan ketat

terhadap tanda-tanda vital ibu. Dalam kasus infeksi yang berat atau tidak terkendali, intervensi pembedahan mungkin diperlukan untuk membersihkan area yang terinfeksi. Dalam semua kondisi emergensi obstetri ini, peran bidan sangat penting sebagai bagian dari tim kesehatan yang pertama kali menangani dan memberikan intervensi awal. Bidan diharapkan memiliki pengetahuan yang luas mengenai penanganan komplikasi tersebut, keterampilan dalam teknik-teknik pertolongan darurat, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya dalam situasi darurat. Sebagai anggota tim multidisiplin, bidan harus mampu melakukan stabilisasi kondisi ibu dan bayi, serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap jika diperlukan. Keputusan yang cepat dan tepat dari bidan akan sangat berpengaruh pada hasil keselamatan ibu dan bayi dalam menghadapi komplikasi persalinan.

Oleh karena itu, manajemen emergensi obstetri memerlukan pendekatan yang holistik, berbasis bukti, dan dilakukan secara cepat dengan langkah-langkah terstruktur. Bidan, sebagai tenaga medis yang memiliki peran utama dalam asuhan kebidanan, perlu dilatih secara terus-menerus dalam mengenali tanda-tanda emergensi dan dalam melakukan penanganan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

C. Prosedur Rujukan Sesuai Kepmenkes 320/2020

Prosedur rujukan dalam konteks pelayanan kesehatan maternal merupakan salah satu pilar utama yang menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Prosedur ini menjadi jembatan penghubung antara fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama—seperti puskesmas atau klinik bersalin—dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit rujukan yang memiliki sumber daya, fasilitas, dan tenaga medis spesialis yang memadai untuk menangani kasus-kasus komplikasi yang tidak dapat diatasi di tingkat pertama. Dalam hal ini, Kepmenkes Nomor 320 Tahun 2020 memberikan pedoman resmi dan standar prosedur rujukan maternal yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter di seluruh Indonesia.

Salah satu aspek terpenting dalam prosedur rujukan adalah penilaian kondisi ibu secara tepat dan menyeluruh. Penilaian ini melibatkan pemeriksaan klinis yang akurat terhadap status kesehatan ibu dan janin, serta identifikasi dengan cermat adanya tanda-tanda komplikasi atau risiko yang memerlukan penanganan lanjutan. Penilaian ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berpengalaman untuk memastikan bahwa rujukan hanya dilakukan bila benar-benar dibutuhkan, sekaligus menghindari rujukan yang tidak tepat yang dapat membebani fasilitas rujukan dan memperlambat pelayanan bagi pasien yang lebih kritis.

Setelah penilaian dilakukan dan keputusan rujukan diambil, komunikasi yang efektif antar fasilitas kesehatan menjadi faktor kunci keberhasilan proses rujukan. Fasilitas pengirim wajib menghubungi dan berkoordinasi dengan fasilitas penerima sebelum pengiriman pasien. Komunikasi ini harus memuat informasi klinis yang lengkap dan jelas tentang kondisi ibu, hasil pemeriksaan, tindakan yang sudah diberikan, serta kebutuhan spesifik yang harus segera ditangani. Hal ini memungkinkan fasilitas penerima untuk melakukan persiapan yang tepat, sehingga saat pasien tiba, penanganan dapat dilaksanakan tanpa penundaan.

Dokumentasi lengkap dan akurat juga menjadi elemen vital dalam prosedur rujukan. Semua hasil pemeriksaan, catatan medis, serta instruksi terapi yang telah dilakukan harus disertakan dalam pengantar pasien. Dokumentasi ini menjadi dasar bagi tim medis di fasilitas rujukan untuk melanjutkan pengelolaan pasien secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa dokumentasi yang memadai, risiko kesalahan diagnosis, pengulangan prosedur, atau penanganan yang tidak sesuai meningkat secara signifikan. Prosedur rujukan menurut Kepmenkes 320/2020 juga mengatur mekanisme pengantar pasien secara fisik dan pengamanan transportasi yang aman. Pengantar pasien idealnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memahami kondisi pasien dan dapat memberikan penjelasan lengkap serta melakukan tindakan awal jika terjadi perubahan kondisi selama perjalanan. Transportasi harus dilengkapi dengan fasilitas medis dasar dan pengawasan yang memadai untuk menjaga stabilitas kondisi ibu dan bayi.

Kecepatan dan koordinasi menjadi faktor yang sangat diperhatikan dalam prosedur rujukan. Penanganan tepat waktu dan tanpa hambatan adalah kunci untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat dan untuk meningkatkan peluang keselamatan pasien. Oleh karena itu, seluruh tahapan dalam prosedur rujukan harus berjalan secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari identifikasi kebutuhan rujukan, persiapan dan komunikasi antar fasilitas, pengamanan pengantar, hingga penerimaan dan tindak lanjut di fasilitas rujukan.

Secara keseluruhan, prosedur rujukan sesuai Kepmenkes 320/2020 merupakan instrumen penting yang memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang tepat dan berkualitas. Prosedur ini bukan hanya sekedar perpindahan pasien antar fasilitas, tetapi sebuah proses pelayanan yang harus diatur dengan cermat, bertanggung jawab, dan humanis demi menjamin keberhasilan asuhan kebidanan dan keselamatan pasien secara optimal. Pelaksanaan prosedur rujukan yang baik juga mencerminkan kualitas sistem kesehatan nasional yang mampu memberikan pelayanan maternal yang komprehensif dan berkelanjutan.

D. Peran Bidan dalam Tim Multidisiplin

Peran bidan dalam tim multidisiplin yang menangani komplikasi persalinan sangatlah sentral dan strategis, mengingat bidan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kebidanan yang berhubungan langsung dengan ibu hamil dan bayi baru lahir. Dalam menghadapi komplikasi persalinan, keterlibatan bidan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tindakan klinis secara individual, melainkan juga melibatkan kolaborasi intensif dengan berbagai profesional kesehatan lain, seperti dokter spesialis kandungan, dokter anestesi, perawat, tenaga farmasi, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya. Keberhasilan asuhan persalinan yang aman, efektif, dan berkualitas sangat bergantung pada sinergi kerja tim multidisiplin yang mampu memadukan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota.

Salah satu tugas utama bidan dalam tim ini adalah melakukan identifikasi risiko sedini mungkin melalui pengkajian komprehensif kondisi ibu hamil dan janin selama proses persalinan. Bidan bertanggung jawab mengamati tanda-tanda bahaya, seperti perdarahan, hipertensi, tanda infeksi, atau gangguan kesejahteraan janin, yang membutuhkan penanganan khusus. Penilaian risiko ini harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus agar intervensi yang diperlukan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat.

Selain fungsi pengkajian dan identifikasi risiko, bidan juga berperan dalam memberikan asuhan persalinan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, termasuk memberikan dukungan fisik dan emosional kepada ibu, melaksanakan teknik pertolongan persalinan, serta melakukan penanganan awal terhadap komplikasi yang muncul. Dalam banyak situasi, bidan menjadi penghubung pertama yang mendeteksi adanya masalah serius dan kemudian menginisiasi rujukan atau kolaborasi dengan dokter spesialis untuk penanganan lebih lanjut. Kecepatan dan ketepatan tindakan bidan pada tahap awal ini sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.

Peran bidan dalam koordinasi dan komunikasi juga sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan pelayanan yang terpadu dan responsif. Bidan harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan seluruh anggota tim kesehatan, termasuk melaporkan kondisi ibu dan janin secara jelas, menyampaikan hasil pemeriksaan, dan mengikuti arahan atau instruksi dari dokter spesialis. Komunikasi yang baik ini meminimalkan risiko miskomunikasi yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan penanganan, serta meningkatkan efisiensi kerja tim.

Dalam konteks tim multidisiplin, bidan juga berperan sebagai advokat bagi ibu dan keluarga, memastikan bahwa hak-hak ibu terpenuhi, serta memberikan edukasi yang komprehensif mengenai proses persalinan, komplikasi yang mungkin terjadi, dan

pentingnya kepatuhan terhadap rencana perawatan. Dengan demikian, bidan membantu membangun kepercayaan dan kenyamanan ibu selama masa persalinan dan proses rujukan jika diperlukan.

Kolaborasi efektif dalam tim multidisiplin ini pada akhirnya memperkuat sistem pelayanan kesehatan maternal secara keseluruhan. Ketika bidan dan tenaga kesehatan lainnya bekerja secara sinergis dan saling mendukung, pelayanan kebidanan menjadi lebih holistik, cepat tanggap, dan berkualitas. Hal ini akan meningkatkan kualitas hasil persalinan, mengurangi risiko komplikasi, dan menurunkan angka kematian maternal dan neonatal.

Secara keseluruhan, peran bidan dalam tim multidisiplin bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai koordinator, komunikator, pendidik, dan advokat yang memastikan pelayanan kebidanan berlangsung optimal dan menyeluruh. Pengembangan kompetensi bidan dalam kerjasama tim, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan klinis sangat penting untuk menghadapi kompleksitas komplikasi persalinan dan memberikan asuhan terbaik bagi ibu dan bayi.

Latihan Soal

1. Seorang ibu hamil usia 36 minggu datang dengan tekanan darah 160/110 mmHg, pembengkakan tangan dan wajah, serta keluhan sakit kepala hebat. Apa langkah pertama yang harus dilakukan bidan?
 - A. Berikan obat penurun tekanan darah oral dan pulangkan
 - B. Lakukan pemantauan tekanan darah setiap 6 jam dan edukasi ibu
 - C. Segera rujuk ke rumah sakit untuk penanganan preeklamsia berat
 - D. Sarankan ibu banyak istirahat dan mengurangi aktivitas
 - E. Tunggu sampai persalinan terjadi secara spontan
2. Seorang ibu mengalami perdarahan postpartum berat setelah melahirkan. Fundus uterus terasa lunak dan tidak kontraksi. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah?
 - A. Melakukan pemijatan fundus uterus dan pemberian oksitosin
 - B. Memberikan analgesik dan observasi
 - C. Melakukan episiotomi untuk mengurangi perdarahan
 - D. Memberikan antibiotik secara intravena
 - E. Menunggu plasenta keluar secara spontan

3. Bidan menemukan ibu dengan ruptur uteri di fasilitas pelayanan primer.
Apa yang harus dilakukan selanjutnya?
 - A. Memberikan obat penghilang rasa sakit dan menunggu persalinan selesai
 - B. Melakukan stabilisasi dan segera mengatur rujukan ke rumah sakit
 - C. Melakukan tindakan pembedahan kecil di fasilitas primer
 - D. Memberikan cairan oral dan meminta keluarga merawat di rumah
 - E. Menunggu sampai tanda-tanda gawat muncul sebelum merujuk
4. Bidan mendeteksi perdarahan postpartum dan menghubungi dokter kandungan.
Peran apa yang paling penting dilakukan bidan saat menunggu dokter tiba?
 - A. Memberikan edukasi kepada keluarga tentang kondisi ibu
 - B. Melakukan tindakan stabilisasi seperti pemijatan uterus dan pemberian oksitosin
 - C. Menginstruksikan keluarga untuk mencari bantuan tradisional
 - D. Menyiapkan ibu untuk persalinan spontan kembali
 - E. Memberi tahu ibu agar tidak panik dan menunggu dengan tenang
5. Selama persalinan, partograf menunjukkan dilatasi serviks tidak bertambah selama 3 jam, kontraksi lemah, dan denyut jantung janin menurun. Apa langkah yang harus diambil bidan?
 - A. Teruskan observasi selama 6 jam tanpa intervensi
 - B. Berikan oksitosin atas instruksi dokter untuk menguatkan kontraksi
 - C. Anjurkan ibu berjalan dan melakukan aktivitas fisik
 - D. Mulai persiapan persalinan operatif tanpa menunggu
 - E. Memberikan analgesik dan biarkan proses berjalan alami

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Perdarahan postpartum sering disebabkan oleh atonia uteri (rahim tidak berkontraksi). Pemijatan fundus dan oksitosin adalah langkah awal penting untuk merangsang kontraksi uterus dan menghentikan perdarahan.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Ruptur uteri adalah keadaan gawat darurat yang memerlukan stabilisasi awal dan rujukan cepat ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap untuk tindakan operasi.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Bidan berperan langsung melakukan tindakan stabilisasi awal yang dapat menyelamatkan nyawa ibu, seperti pemijatan uterus dan pemberian obat uterotonik, sambil menunggu bantuan medis lebih lanjut.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Perlambatan dilatasi serviks dan kontraksi lemah disertai tanda distress janin memerlukan tindakan penguatan kontraksi uterus dengan oksitosin sesuai protokol, untuk memperbaiki kondisi persalinan dan kesehatan janin.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Tekanan darah tinggi disertai pembengkakan dan sakit kepala adalah tanda preeklampsia berat yang memerlukan penanganan segera di fasilitas tingkat lanjut. Rujukan cepat ke rumah sakit penting untuk mencegah komplikasi serius seperti eklampsia.

Rangkuman Materi

Deteksi dini komplikasi persalinan merupakan langkah fundamental dalam asuhan kebidanan yang sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi. Kemampuan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk mengenali tanda-tanda awal komplikasi melalui pengkajian komprehensif dan pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah perkembangan masalah yang lebih serius. Penggunaan alat bantu seperti partograf memperkuat efektivitas pemantauan dan memungkinkan intervensi tepat waktu untuk mengatasi hambatan persalinan dan komplikasi lainnya.

Manajemen emergensi obstetri adalah respons cepat dan terstruktur terhadap kondisi darurat yang mengancam jiwa, seperti perdarahan postpartum, eklampsia, distosia bahu, ruptur uteri, dan infeksi berat. Keterampilan klinis dan ketangkasan bidan dalam mengenali serta menindaklanjuti kondisi emergensi ini secara tepat waktu sangat menentukan hasil keselamatan ibu dan bayi.

Prosedur rujukan yang diatur dalam Kepmenkes 320/2020 memastikan proses pemindahan pasien dari fasilitas pelayanan primer ke tingkat lanjut dilakukan secara sistematis, cepat, dan aman. Penilaian yang akurat, komunikasi efektif antar fasilitas, dokumentasi lengkap, serta pengamanan transportasi yang baik adalah kunci keberhasilan rujukan yang menjamin kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien.

Peran bidan dalam tim multidisiplin sangat vital, tidak hanya sebagai pelaksana asuhan kebidanan, tetapi juga sebagai koordinator, komunikator, pendidik, dan advokat ibu dan bayi. Kolaborasi efektif antara bidan, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya memperkuat sistem pelayanan maternal, meningkatkan kualitas asuhan, serta menurunkan angka kematian maternal dan neonatal.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam deteksi dini, manajemen emergensi, prosedur rujukan, dan kerja sama tim multidisiplin merupakan pondasi utama dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan dan pascapersalinan.

Glosarium

Advokat Pasien

Peran bidan dalam memastikan hak-hak pasien terpenuhi dan memberikan edukasi agar pasien dan keluarga memahami proses asuhan dan rencana perawatan.

Deteksi Dini Komplikasi Persalinan

Proses pengkajian dan pemantauan awal yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengenali tanda-tanda awal komplikasi persalinan guna melakukan intervensi cepat demi keselamatan ibu dan bayi.

Distosia Bahu

Kondisi di mana bahu bayi terjebak di panggul ibu saat persalinan, menyebabkan hambatan lahir yang membutuhkan penanganan khusus.

Distosia

Kesulitan atau hambatan dalam proses persalinan yang menyebabkan kemajuan persalinan melambat atau terhenti.

Eklampsia

Kondisi kejang yang terjadi pada ibu hamil akibat preeklamsia berat, termasuk keadaan darurat obstetri yang mengancam nyawa.

Hipertensi Gestasional

Kondisi tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan yang berpotensi menyebabkan komplikasi seperti preeklamsia.

Histerektomi

Prosedur bedah pengangkatan rahim yang dilakukan dalam kasus perdarahan hebat yang tidak bisa dikendalikan.

Infeksi Obstetri

Infeksi yang terjadi selama atau setelah persalinan, termasuk infeksi saluran kemih, endometritis, atau sepsis.

Koordinasi Pelayanan Kesehatan

Kerja sama dan komunikasi efektif antar tenaga kesehatan dan fasilitas untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan asuhan pasien.

Manajemen Emergensi Obstetri

Penanganan cepat, tepat, dan terstruktur terhadap komplikasi persalinan yang mengancam jiwa ibu dan bayi, seperti perdarahan, eklampsia, dan ruptur uteri.

Partograf

Grafik yang digunakan untuk mencatat dan memantau progres persalinan, termasuk dilatasi serviks, kontraksi uterus, penurunan janin, dan denyut jantung janin.

Peran Bidan

Fungsi bidan sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pengkajian, identifikasi risiko, penanganan awal, koordinasi, edukasi, dan advokasi dalam asuhan maternal dan neonatal.

Perdarahan Antepartum

Perdarahan yang terjadi sebelum persalinan, yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janin.

Perdarahan Postpartum

Perdarahan hebat setelah persalinan yang merupakan salah satu komplikasi utama dan memerlukan penanganan segera.

Preeklampsia

Gangguan kehamilan yang ditandai oleh hipertensi dan proteinuria, berisiko menyebabkan kerusakan organ dan komplikasi serius pada ibu dan janin.

Prosedur Rujukan

Proses pemindahan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ke tingkat lanjutan secara sistematis dan terkoordinasi sesuai standar nasional.

Ruptur Uteri

Robekan pada dinding rahim selama persalinan yang dapat menyebabkan perdarahan hebat dan membutuhkan tindakan pembedahan darurat.

Tim Multidisiplin

Kelompok profesional kesehatan dari berbagai bidang yang bekerja bersama secara terintegrasi dalam memberikan asuhan komprehensif kepada pasien.

Tanda Vital

Parameter dasar yang mencerminkan kondisi fisiologis individu, meliputi tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan laju pernapasan.

Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics, & American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). *Guidelines for Perinatal Care* (8th ed.). Elk Grove Village, IL: AAP.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2019). Hypertension in pregnancy. *ACOG Practice Bulletin No. 203. Obstetrics & Gynecology*, 133(1), e1–e25. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003018>
- Apgar, V. (1953). A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. *Current Researches in Anesthesia & Analgesia*, 32(4), 260–267.
- Begum, F., & Rana, S. (2020). Role of partograph in early detection of complications during labor: A clinical study. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 40(3), 390–395. <https://doi.org/10.1080/01443615.2019.1644343>
- Dolea, C., & AbouZahr, C. (2003). *Global burden of obstructed labour in the year 2000. Evidence and Information for Policy*. Geneva: World Health Organization.
- Magpie Trial Collaborative Group. (2002). Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: A randomised placebo-controlled trial. *The Lancet*, 359(9321), 1877–1890. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)08778-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08778-0)
- Ministry of Health Republic of Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- Solomon, A. O., & Ameh, C. A. (2017). The importance of emergency obstetric care training for maternal survival: A narrative review. *Obstetrics and Gynecology International*, 2017, Article ID 8023157. <https://doi.org/10.1155/2017/8023157>
- WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research Network. (2014). Frequency and management of major obstetric complications in health facilities in 29 countries: a cross-sectional study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 121(Suppl 1), 96–114. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.12636>
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO Press.

Bab 7

Asuhan Pascapersalinan (Postpartum)

Masa pascapersalinan atau masa nifas merupakan periode kritis setelah persalinan yang berlangsung hingga enam minggu. Selama periode ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial untuk kembali ke keadaan sebelum kehamilan. Asuhan pascapersalinan yang komprehensif sangat penting untuk mendukung proses pemulihan yang optimal, mencegah komplikasi, serta memastikan kesejahteraan ibu secara keseluruhan. Bab ini akan membahas secara rinci tentang perawatan ibu pascapersalinan, pencegahan dan deteksi komplikasi postpartum, edukasi kesehatan reproduksi pascapersalinan, dan dukungan psikososial masa nifas.

Capaian Pembelajaran (CP)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan pascapersalinan secara komprehensif, meliputi perawatan fisik, pencegahan komplikasi, edukasi kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial selama masa nifas.

Kompetensi yang Diharapkan (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan perawatan ibu pascapersalinan yang efektif.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeteksi komplikasi postpartum secara dini.
3. Mahasiswa mampu memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi pascapersalinan.
4. Mahasiswa mampu memberikan dukungan psikososial selama masa nifas.

Sub-Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan perawatan fisik dan emosional ibu selama masa nifas.
2. Menjelaskan cara pencegahan dan deteksi komplikasi postpartum.
3. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang tepat kepada ibu nifas.
4. Memberikan dukungan psikososial yang efektif selama masa nifas.

A. Perawatan Ibu Pascapersalinan

Perawatan ibu pascapersalinan merupakan suatu proses penting yang melibatkan perhatian terhadap berbagai aspek fisik dan emosional untuk memastikan pemulihan yang optimal setelah melahirkan. Masa pascapersalinan, atau masa nifas, adalah periode transisi yang penting di mana tubuh ibu mengalami berbagai perubahan signifikan untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Selama periode ini, pemantauan tanda-tanda vital secara rutin seperti suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, dan pernapasan merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin komplikasi yang mungkin timbul, seperti infeksi postpartum, perdarahan, hipertensi, atau gangguan pernapasan.

Selain itu, pemeriksaan involusi uterus merupakan langkah penting dalam perawatan ini. Involusi uterus adalah proses di mana rahim berangsur-angsur kembali ke ukuran dan posisi semula sebelum kehamilan. Pemeriksaan rutin dilakukan dengan cara palpasi atau meraba rahim secara berkala untuk memastikan bahwa involusi uterus berlangsung secara normal. Apabila rahim tidak mengecil secara optimal, hal ini bisa menjadi tanda adanya komplikasi seperti subinvolusi yang dapat meningkatkan risiko perdarahan atau infeksi.

Perawatan terhadap luka akibat persalinan, baik itu luka episiotomi maupun luka operasi caesar, juga merupakan bagian integral dalam perawatan ibu pascapersalinan. Luka-luka ini memerlukan pemantauan yang cermat untuk memastikan proses penyembuhan berjalan dengan baik. Penting untuk secara rutin mengecek kondisi luka, memastikan kebersihan luka terjaga dengan baik, dan mengidentifikasi tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri berlebihan, pembengkakan, atau keluarnya cairan abnormal dari area luka.

Edukasi mengenai kebersihan perineum sangat penting bagi ibu untuk menghindari risiko infeksi. Area perineum yang sering mengalami luka atau robekan selama proses persalinan memerlukan perawatan khusus. Ibu perlu diajarkan cara membersihkan area tersebut secara tepat, yaitu dengan air hangat dan sabun antiseptik secara lembut dan hati-hati. Selain itu, penting juga untuk mengedukasi ibu tentang frekuensi penggantian pembalut, terutama pada masa awal setelah melahirkan ketika keluarnya lochia atau darah nifas sangat banyak.

Dalam mengelola nyeri postpartum, pendekatan yang komprehensif diperlukan. Nyeri merupakan kondisi yang umum dialami ibu setelah persalinan, baik akibat kontraksi rahim yang terus berlangsung maupun karena luka jahitan pascapersalinan. Penanganan nyeri ini bisa menggunakan pendekatan farmakologis seperti pemberian

analgesik sesuai anjuran medis, ataupun pendekatan nonfarmakologis seperti relaksasi, pijatan ringan, kompres hangat atau dingin, dan penggunaan teknik pernapasan dalam. Penting untuk memastikan ibu merasa nyaman selama proses pemulihan berlangsung.

Selain perawatan fisik, aspek emosional juga tidak boleh diabaikan. Konseling mengenai nutrisi seimbang sangat penting guna mendukung proses pemulihan fisik dan produksi ASI yang optimal. Ibu perlu mendapatkan informasi tentang jenis makanan yang bergizi, kaya protein, zat besi, vitamin, dan mineral, serta pentingnya hidrasi yang cukup. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya istirahat yang cukup juga perlu ditekankan. Ibu dianjurkan untuk mengatur jadwal istirahat secara efektif, terutama di tengah aktivitas merawat bayi baru lahir yang sering kali menuntut banyak perhatian. Terakhir, aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan ibu pascapersalinan harus diperkenalkan secara bertahap, mulai dari aktivitas ringan hingga sedang, agar ibu tetap sehat, nyaman, dan proses pemulihan berjalan dengan lancar.

B. Pencegahan dan Deteksi Komplikasi Postpartum

Komplikasi postpartum merupakan tantangan besar dalam asuhan kebidanan karena dapat mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi bagi ibu. Berbagai komplikasi tersebut mencakup perdarahan postpartum, infeksi postpartum, tromboemboli, preeklamsia postpartum, hingga gangguan psikologis seperti depresi postpartum. Untuk itu, tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam melakukan pencegahan maupun deteksi dini terhadap komplikasi tersebut.

Salah satu komplikasi postpartum yang paling serius adalah perdarahan postpartum. Kondisi ini dapat muncul tiba-tiba dan mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Pencegahan perdarahan postpartum dimulai sejak masa kehamilannya, yaitu dengan pemeriksaan antenatal rutin untuk mengidentifikasi ibu yang memiliki risiko tinggi. Pemantauan status gizi, kadar hemoglobin ibu selama kehamilan, serta persiapan persalinan yang optimal juga sangat penting. Setelah persalinan, tenaga kesehatan harus memonitor ketat kontraksi uterus, mengukur volume darah yang keluar secara teliti, serta mengevaluasi tonus uterus secara rutin. Edukasi kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya perdarahan seperti keluarnya darah dalam jumlah banyak, munculnya rasa lemas, pusing, atau penurunan kesadaran juga penting agar segera mencari pertolongan medis.

Selain perdarahan, infeksi postpartum juga perlu mendapat perhatian khusus. Infeksi postpartum dapat terjadi akibat kebersihan yang tidak optimal selama proses persalinan maupun perawatan luka pascapersalinan yang kurang steril. Upaya pencegahan infeksi postpartum mencakup penerapan teknik aseptik dan antiseptik secara ketat selama persalinan, perawatan luka perineum maupun luka bekas operasi caesar yang benar, serta edukasi ibu tentang cara menjaga kebersihan diri setelah persalinan. Ibu juga dianjurkan untuk menjaga pola makan yang sehat agar daya tahan tubuh meningkat dan mempercepat proses penyembuhan luka. Pengamatan secara rutin mengenai tanda-tanda infeksi seperti demam, nyeri atau pembengkakan di sekitar luka, keluarnya cairan bernanah atau berbau dari area luka, serta keluhan nyeri perut bawah juga sangat penting untuk deteksi dini.

Tromboemboli merupakan komplikasi postpartum lain yang perlu mendapat perhatian. Risiko tromboemboli meningkat pada ibu pascapersalinan karena adanya perubahan fisiologis seperti hiperkoagulabilitas darah, imobilisasi, atau persalinan dengan tindakan operasi caesar. Pencegahan tromboemboli postpartum dilakukan dengan menganjurkan mobilisasi dini pascapersalinan, penggunaan stocking kompresi bila diperlukan, serta menjaga hidrasi yang baik pada ibu. Deteksi dini tromboemboli melibatkan pengamatan terhadap tanda-tanda klinis seperti nyeri mendadak pada tungkai, pembengkakan yang tidak simetris, atau sesak napas yang tiba-tiba muncul. Bila ditemukan tanda tersebut, evaluasi dan tindakan cepat seperti pemeriksaan Doppler atau pemeriksaan pencitraan lainnya perlu segera dilakukan.

Preeklamsia postpartum merupakan kelanjutan dari kondisi preeklamsia yang terjadi pada masa kehamilan dan dapat muncul hingga beberapa minggu setelah persalinan. Pencegahan preeklamsia postpartum dilakukan dengan pemantauan ketat terhadap tekanan darah dan proteinuria selama kehamilan serta hingga enam minggu setelah persalinan. Ibu yang memiliki riwayat hipertensi atau preeklamsia selama kehamilan perlu mendapat perhatian khusus dengan evaluasi tekanan darah secara berkala. Deteksi dini preeklamsia postpartum dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah yang teratur, observasi tanda klinis seperti nyeri kepala hebat, pandangan kabur, nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, serta pemeriksaan laboratorium yang meliputi proteinuria, trombositopenia, dan gangguan fungsi hati.

Selain komplikasi fisik, kondisi psikologis ibu pascapersalinan seperti depresi postpartum tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai. Depresi postpartum dapat berdampak buruk pada kesehatan mental ibu dan juga mengganggu hubungan ibu dengan bayinya. Pencegahan depresi postpartum dapat dilakukan melalui edukasi kepada ibu tentang perubahan psikologis yang mungkin terjadi setelah melahirkan

serta memberikan dukungan emosional yang kuat dari keluarga maupun tenaga kesehatan. Deteksi dini depresi postpartum dapat dilakukan dengan skrining rutin menggunakan instrumen seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Penggunaan instrumen ini memungkinkan tenaga kesehatan mendeteksi adanya gangguan psikologis lebih awal sehingga intervensi berupa konseling maupun terapi dapat segera dilakukan.

Intervensi cepat dan tepat berdasarkan hasil deteksi dini terhadap berbagai komplikasi postpartum sangat menentukan prognosis dan hasil akhir yang optimal bagi ibu. Pentingnya komunikasi yang efektif, edukasi keluarga, serta kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan di semua tingkatan layanan juga menjadi faktor kunci dalam mencegah komplikasi postpartum dan mengurangi angka kesakitan serta kematian ibu. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, ibu pascapersalinan dapat melewati periode pemulihan dengan lebih aman dan sehat, sehingga dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai ibu baru.

C. Edukasi Kesehatan Reproduksi Pascapersalinan

Edukasi kesehatan reproduksi pascapersalinan merupakan salah satu aspek penting dalam perawatan ibu setelah melahirkan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai berbagai perubahan fisik dan emosional yang terjadi setelah proses persalinan, termasuk bagaimana tubuh ibu mengalami adaptasi kembali menuju kondisi sebelum kehamilan. Masa postpartum merupakan periode krusial di mana ibu menghadapi berbagai perubahan, terutama terkait fungsi reproduksi dan hormonal. Oleh sebab itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang jelas, komprehensif, dan berkelanjutan kepada ibu dan keluarganya.

Salah satu materi yang harus dijelaskan dalam edukasi kesehatan reproduksi pascapersalinan adalah mengenai perubahan fisiologis pada tubuh ibu. Setelah melahirkan, tubuh akan mengalami serangkaian perubahan hormonal yang signifikan untuk mengembalikan fungsi organ reproduksi ke kondisi sebelum hamil. Misalnya, uterus akan mengalami involusi atau pengecilan kembali, yang ditandai dengan kontraksi rahim yang dirasakan sebagai nyeri ringan atau sedang dalam beberapa hari pascapersalinan. Ibu juga harus memahami bahwa keluarnya cairan nifas atau lochia merupakan proses alami yang menandakan bahwa rahim sedang membersihkan diri. Edukasi mengenai perawatan kebersihan organ reproduksi sangat penting untuk menghindari risiko infeksi. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara membersihkan daerah genital yang benar, mengganti pembalut secara teratur, serta tanda-tanda infeksi yang harus diwaspadai seperti bau tidak sedap, nyeri hebat, atau demam tinggi.

Selain perubahan fisiologis, ibu juga harus mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai kembalinya kesuburan setelah persalinan. Informasi ini sangat penting karena sering kali terdapat mitos bahwa ibu yang sedang menyusui secara eksklusif tidak mungkin hamil. Padahal, meskipun menyusui eksklusif dapat menekan ovulasi, bukan berarti ovulasi sama sekali tidak terjadi. Edukasi perlu diberikan mengenai tanda-tanda kesuburan kembali seperti perubahan lendir serviks yang menjadi lebih cair, munculnya menstruasi pertama setelah melahirkan, atau gejala lainnya yang menandakan bahwa siklus reproduksi telah kembali aktif. Pemahaman mengenai hal ini akan membantu ibu untuk merencanakan keluarga secara lebih efektif dan menghindari kehamilan yang tidak direncanakan dalam waktu yang terlalu dekat.

Dalam edukasi kesehatan reproduksi pascapersalinan, tenaga kesehatan juga wajib menjelaskan tentang berbagai metode kontrasepsi yang aman dan efektif setelah melahirkan. Pilihan kontrasepsi sangat bergantung pada kondisi kesehatan ibu, preferensi pribadi, serta metode persalinan yang dijalani. Beberapa metode kontrasepsi seperti penggunaan kondom, pil progesteron, suntik KB, implan, atau IUD dapat dikenalkan kepada ibu dengan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Ibu harus diberi informasi bahwa kontrasepsi dapat mulai digunakan segera setelah persalinan atau dalam beberapa minggu setelahnya tergantung metode yang dipilih. Penekanan tentang pentingnya kontrasepsi bertujuan untuk menjaga jarak kehamilan, yang idealnya minimal dua tahun, sehingga ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi fisik dan mental sebelum hamil kembali.

Selain itu, edukasi kesehatan reproduksi pascapersalinan juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dalam jangka panjang. Hal ini mencakup anjuran kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan rutin pascapersalinan guna memantau pemulihan tubuh, mendeteksi dini adanya komplikasi atau masalah kesehatan yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa ibu telah kembali ke kondisi sehat secara menyeluruh. Pemeriksaan rutin ini juga berguna untuk mengevaluasi efektivitas metode kontrasepsi yang digunakan dan memberi ruang bagi ibu untuk berdiskusi tentang berbagai keluhan atau pertanyaan terkait kesehatan reproduksi. Dalam edukasi ini, peran pasangan dan keluarga juga tidak boleh diabaikan, sebab dukungan dari lingkungan terdekat ibu sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan praktik kesehatan reproduksi yang sehat dan aman.

Dengan pendekatan edukasi yang menyeluruh, jelas, dan konsisten, ibu pascapersalinan diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai kesehatannya. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan emosional ibu, tetapi juga berkontribusi positif pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Edukasi yang baik akan memberdayakan ibu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi secara optimal dan berkelanjutan, sehingga mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup ibu dalam jangka panjang.

D. Dukungan Psikososial Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode transisi yang kritis dalam kehidupan seorang perempuan setelah melahirkan. Pada masa ini, seorang ibu tidak hanya mengalami berbagai perubahan fisik yang signifikan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan emosional yang kompleks. Perubahan-perubahan tersebut mencakup penyesuaian terhadap peran baru sebagai ibu, kelelahan fisik setelah menjalani proses persalinan, perubahan hormonal yang memengaruhi suasana hati, serta adaptasi dalam mengelola tanggung jawab perawatan bayi. Oleh sebab itu, penting bagi tenaga kesehatan, terutama bidan, untuk memberikan dukungan psikososial yang komprehensif kepada ibu pada masa nifas agar ibu dapat melewati periode ini dengan baik dan merasa didukung secara emosional.

Dukungan psikososial melibatkan pendekatan yang bersifat holistik dengan memperhatikan aspek emosional, sosial, dan psikologis dari ibu. Salah satu bentuk dukungan yang sangat penting adalah komunikasi yang empatik. Komunikasi empatik berarti bidan atau tenaga kesehatan mampu memahami dan merasakan situasi yang dialami oleh ibu secara mendalam, serta mampu menyampaikan pesan dengan penuh kehangatan dan perhatian. Dalam praktiknya, komunikasi ini dilakukan dengan mendengarkan secara aktif setiap keluhan dan kekhawatiran ibu, memberikan perhatian penuh saat ibu mengutarakan perasaannya, serta memberikan umpan balik yang mendukung dan tidak menghakimi. Dengan demikian, ibu akan merasa nyaman dan lebih terbuka untuk berbagi perasaan serta kecemasannya, yang akan membantu dalam mengurangi tekanan emosional yang mungkin dialaminya.

Selain komunikasi yang empatik, pemberian motivasi positif merupakan komponen penting lainnya dalam dukungan psikososial masa nifas. Selama periode ini, tidak jarang ibu merasa kewalahan menghadapi berbagai tantangan baru, seperti kurang tidur karena merawat bayi yang sering menangis, kesulitan dalam proses menyusui, atau kelelahan fisik akibat proses persalinan. Dalam kondisi seperti ini, dorongan positif dari bidan maupun keluarga sangat diperlukan untuk membantu ibu meningkatkan rasa percaya dirinya dalam menjalankan peran barunya. Motivasi ini bisa diberikan dalam bentuk pujian atas keberhasilan kecil yang dicapai ibu, penguatan bahwa ibu telah melakukan yang terbaik, serta memberi keyakinan bahwa perasaan kewalahan atau stres yang dirasakan adalah normal dan dapat dikelola dengan baik.

Bidan juga memiliki peran penting dalam memberikan konseling yang efektif kepada ibu nifas tentang cara mengelola stres dan perubahan emosional yang muncul. Stres pada masa nifas umumnya dipicu oleh perubahan hormonal drastis, kelelahan fisik yang terus-menerus, dan tuntutan dalam menjalankan tugas sebagai ibu baru. Konseling yang diberikan oleh bidan dapat mencakup strategi praktis seperti teknik relaksasi, latihan pernapasan, manajemen waktu untuk istirahat yang cukup, serta pentingnya menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Jika dalam konseling ditemukan indikasi bahwa ibu mengalami tingkat stres yang tinggi atau gangguan emosional yang lebih serius seperti kecemasan berlebihan atau gejala depresi, maka bidan perlu secara proaktif memberikan rujukan atau akses ke layanan konseling profesional seperti psikolog atau psikiater. Intervensi dini seperti ini sangat penting untuk mencegah berkembangnya kondisi yang lebih serius seperti depresi postpartum yang parah.

Di samping pemberian konseling individu, bidan juga perlu mendorong keterlibatan keluarga secara aktif dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu. Keluarga memiliki peran vital dalam membantu ibu merasa bahwa ia tidak sendiri menghadapi berbagai tantangan selama masa nifas. Keluarga dapat memberikan bantuan praktis seperti membantu dalam merawat bayi, melakukan pekerjaan rumah tangga, serta mendampingi ibu secara emosional dengan memberikan perhatian, pengertian, dan waktu yang cukup untuk ibu beristirahat dan memulihkan diri. Peran pasangan, khususnya, sangat penting dalam proses ini. Pasangan yang terlibat secara aktif dalam perawatan bayi dan memberikan dukungan emosional akan membantu ibu mengurangi rasa stres dan merasa lebih dicintai serta dihargai.

Selain dukungan keluarga, fasilitasi ibu untuk bergabung dengan kelompok pendukung atau support group bagi ibu pascapersalinan juga merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis ibu. Dalam kelompok ini, ibu memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan ibu-ibu lain yang sedang mengalami situasi yang sama. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan rasa solidaritas dan empati antarsesama ibu, tetapi juga menjadi wadah di mana ibu mendapatkan berbagai informasi tambahan, saran praktis, serta rasa bahwa dirinya tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan pascapersalinan. Keikutsertaan dalam kelompok pendukung juga dapat membantu ibu mengatasi rasa isolasi sosial yang sering kali muncul pada masa nifas, khususnya bagi ibu baru yang belum terbiasa dengan berbagai tantangan dalam perawatan bayi.

Secara keseluruhan, dukungan psikososial yang komprehensif pada masa nifas merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap ibu. Melalui pendekatan yang holistik, empatik, serta melibatkan berbagai pihak seperti keluarga dan komunitas, diharapkan

ibu dapat melalui masa transisi ini dengan lebih lancar dan nyaman. Dukungan psikososial yang baik akan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional ibu secara signifikan, yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap kesejahteraan bayi, keluarga, dan kualitas hidup ibu secara keseluruhan.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1:

Jelaskan langkah-langkah perawatan luka episiotomi pada ibu nifas hari ke-3. Apa saja tanda-tanda infeksi luka yang perlu diwaspadai? Sertakan alasan pentingnya edukasi tentang kebersihan perineum kepada ibu.

Tugas 2:

Buatlah skenario edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pencegahan perdarahan postpartum di rumah. Tuliskan isi edukasi secara naratif, termasuk tanda bahaya dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan.

Tugas 3:

Jelaskan perubahan fisiologis pada organ reproduksi wanita setelah melahirkan. Bagaimana Anda akan menjelaskan kepada ibu bahwa menyusui tidak sepenuhnya menjadi metode kontrasepsi alami?

Tugas 4:

Tuliskan simulasi percakapan empatik antara seorang bidan dan ibu pascapersalinan yang mengalami stres karena sulit menyusui. Buat percakapan minimal 10 dialog dua arah.

Tugas 5:

Buatlah rencana kunjungan rumah untuk ibu pascapersalinan selama 6 minggu, dengan mencantumkan: fokus pemeriksaan, edukasi yang akan diberikan, dan bentuk dukungan psikososial pada setiap kunjungan.

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu, 25 tahun, baru saja melahirkan anak pertama secara normal di klinik bersalin 12 jam lalu. Saat kunjungan bidan, ibu mengeluhkan nyeri ringan di area perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan menunjukkan tanda vital stabil, TD 110/70 mmHg, Nadi 80 kali/menit, suhu 36,8°C, respirasi 18 kali/menit. Palpasi abdomen terasa uterus keras, fundus uteri setinggi pusat. Lokia berwarna merah sedang. Tidak ditemukan tanda infeksi pada luka perineum.

Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh bidan dalam kondisi ini?

- A. Memberikan antibiotik profilaksis
- B. Menyarankan istirahat total tanpa aktivitas

- C. Mengajarkan teknik kompres hangat di area abdomen
 - D. Melakukan palpasi uterus rutin setiap 2 jam
 - E. Merujuk segera ke fasilitas kesehatan lebih lanjut
2. Seorang ibu, 30 tahun, melahirkan anak kedua melalui operasi caesar 3 hari lalu. Ibu mengeluhkan luka jahitan terasa nyeri hebat disertai demam sejak pagi ini (suhu 38,5°C). Pemeriksaan luka operasi menunjukkan adanya kemerahan, bengkak, dan keluar sedikit cairan berbau. Tanda vital lain dalam batas normal.
- Apa prioritas tindakan bidan pada kasus ini?
- A. Melakukan edukasi tentang cara membersihkan luka
 - B. Memberikan analgesik oral sesuai dosis
 - C. Melakukan kompres hangat secara rutin
 - D. Merujuk ibu segera untuk pemeriksaan lanjutan
 - E. Menganjurkan konsumsi makanan tinggi protein
3. Seorang ibu, 28 tahun, baru melahirkan anak pertamanya dua minggu lalu. Ibu mengatakan merasa sering menangis, mudah marah, sulit tidur, dan cemas berlebihan saat bayi menangis. Hasil skrining menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) menunjukkan skor 14. Apa langkah paling tepat yang dilakukan oleh bidan?
- A. Memberikan obat anti-depresan ringan
 - B. Mengedukasi ibu bahwa gejala tersebut normal
 - C. Merujuk ibu ke psikolog atau konselor profesional
 - D. Menyarankan ibu segera melakukan aktivitas fisik rutin
 - E. Menyarankan ibu lebih banyak beristirahat
4. Ibu umur 26 tahun, melahirkan 6 minggu lalu, saat ini datang ke klinik kebidanan untuk berkonsultasi mengenai pemilihan metode kontrasepsi. Ibu masih menyusui bayi secara eksklusif, tidak memiliki keluhan, dan belum menstruasi kembali. Ibu menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang, aman, serta tidak memengaruhi ASI.
- Metode kontrasepsi apakah yang paling tepat untuk disarankan?
- A. Pil kombinasi
 - B. Suntik KB 3 bulanan (Depo-Provera)
 - C. Kondom
 - D. IUD (Intrauterine Device)
 - E. Vasektomi pada pasangan
5. Seorang ibu, usia 32 tahun, telah melahirkan secara spontan 2 hari lalu. Ibu mengalami pembengkakan di tungkai kanan bawah yang terasa nyeri bila disentuh, kulit

kemerahan, serta sedikit terasa panas. Ibu melahirkan dengan posisi berbaring cukup lama akibat kontraksi lemah selama proses persalinan.

Apa tindakan prioritas yang dilakukan bidan pada kasus ini?

- A. Melakukan kompres dingin di tungkai kanan
- B. Memberikan analgesik oral untuk mengurangi nyeri
- C. Menyarankan ibu segera melakukan mobilisasi
- D. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
- E. Merujuk segera ke fasilitas kesehatan untuk evaluasi Doppler

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Setelah melahirkan, involusi uterus normal ditandai dengan fundus uteri setinggi pusat segera setelah 12 jam pertama. Nyeri ringan pada abdomen merupakan efek normal akibat kontraksi uterus (afterpain). Tindakan tepat adalah melakukan palpasi uterus rutin untuk memastikan involusi berjalan normal, sekaligus mendeteksi dini komplikasi seperti subinvolusi atau perdarahan postpartum.

2. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Tanda-tanda demam, kemerahan, bengkak, serta cairan berbau pada luka operasi menunjukkan infeksi luka operasi (SSI - Surgical Site Infection). Kondisi ini memerlukan penanganan medis lanjut, sehingga tindakan prioritas adalah merujuk ibu segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk mendapatkan terapi antibiotik dan perawatan luka khusus.

3. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Skor EPDS ≥ 13 mengindikasikan depresi postpartum sedang hingga berat, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh profesional kesehatan jiwa. Bidan harus merujuk ibu ke psikolog atau konselor profesional untuk intervensi terapi psikologis yang tepat.

4. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: IUD adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang aman digunakan pada ibu menyusui, tidak memengaruhi kualitas maupun produksi ASI. Metode ini efektif mencegah kehamilan jangka panjang dan cocok dengan kebutuhan ibu yang ingin menunda kehamilan dalam waktu lama setelah persalinan.

5. Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Tanda klinis berupa pembengkakan tungkai asimetris, nyeri tekan, kemerahan, dan panas merupakan tanda klasik tromboemboli (trombosis vena dalam). Kondisi ini berisiko tinggi jika tidak segera ditangani. Tindakan prioritas adalah segera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang dilengkapi pemeriksaan Doppler untuk diagnosis pasti dan manajemen medis yang optimal.

Rangkuman Materi

Perawatan ibu pascapersalinan merupakan rangkaian tindakan penting yang memperhatikan aspek fisik dan emosional ibu untuk memastikan pemulihan optimal setelah melahirkan. Selama masa nifas, tubuh ibu mengalami banyak perubahan signifikan, sehingga perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, dan pernapasan untuk mendeteksi komplikasi secara dini. Pemeriksaan involusi uterus yang rutin juga penting dilakukan untuk memastikan rahim kembali ke ukuran semula dan mengidentifikasi risiko subinvolusi yang bisa menyebabkan perdarahan atau infeksi. Selain itu, perawatan luka pascapersalinan, baik luka episiotomi maupun bekas operasi caesar, harus dilakukan secara cermat dengan menjaga kebersihan dan memperhatikan tanda-tanda infeksi. Edukasi tentang kebersihan perineum, penggantian pembalut, dan cara membersihkan luka secara tepat juga merupakan aspek penting dalam mencegah infeksi. Nyeri postpartum umum terjadi, sehingga ibu perlu diberikan penanganan nyeri secara farmakologis atau nonfarmakologis seperti relaksasi, kompres hangat atau dingin, pijatan ringan, serta teknik pernapasan dalam. Di samping itu, edukasi tentang pentingnya nutrisi seimbang, istirahat yang cukup, dan aktivitas fisik bertahap turut mendukung pemulihan fisik serta produksi ASI yang optimal.

Komplikasi postpartum, seperti perdarahan, infeksi, tromboemboli, preeklamsia postpartum, hingga depresi postpartum merupakan tantangan besar dalam kebidanan yang dapat mengancam keselamatan ibu jika tidak ditangani dengan cepat. Pencegahan perdarahan postpartum diawali dengan pemeriksaan antenatal yang rutin dan pemantauan ketat terhadap kontraksi uterus serta jumlah darah yang keluar setelah melahirkan. Pencegahan infeksi postpartum dilakukan melalui penerapan teknik aseptik saat persalinan dan perawatan luka yang steril, serta edukasi kebersihan diri. Komplikasi tromboemboli dicegah dengan mobilisasi dini, penggunaan stocking kompresi, dan menjaga hidrasi yang cukup, serta dilakukan pengamatan tanda klinis seperti nyeri atau pembengkakan tungkai secara dini. Preeklamsia postpartum dicegah dengan evaluasi rutin tekanan darah dan proteinuria, khususnya pada ibu yang memiliki riwayat hipertensi selama kehamilan. Depresi postpartum, sebagai gangguan psikologis serius, dapat dicegah melalui edukasi perubahan psikologis pascapersalinan serta deteksi dini dengan instrumen seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Intervensi tepat dan cepat terhadap komplikasi postpartum membutuhkan kolaborasi antara tenaga kesehatan dan keluarga agar ibu dapat pulih secara optimal dan menjalankan perannya sebagai ibu baru secara efektif.

Edukasi kesehatan reproduksi pascapersalinan bertujuan agar ibu memahami perubahan fisik dan emosional yang terjadi setelah melahirkan, termasuk involusi uterus dan keluarnya cairan nifas sebagai proses alami. Edukasi tentang kebersihan organ reproduksi, penggantian pembalut secara rutin, serta tanda-tanda infeksi perlu diberikan secara jelas. Pemahaman mengenai kembalinya kesuburan setelah melahirkan juga penting untuk mencegah kehamilan yang terlalu dekat, terutama dengan mengklarifikasi bahwa menyusui eksklusif tidak sepenuhnya menjamin tidak terjadinya ovulasi. Berbagai metode kontrasepsi yang aman seperti pil progesteron, suntik KB, implan, atau IUD perlu dikenalkan sesuai kondisi dan preferensi ibu. Pemeriksaan rutin setelah melahirkan juga penting untuk mendeteksi komplikasi dini, mengevaluasi efektivitas kontrasepsi, serta memastikan pemulihan ibu secara menyeluruh. Dalam hal ini, dukungan pasangan dan keluarga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesehatan reproduksi jangka panjang.

Dukungan psikososial masa nifas merupakan aspek penting lainnya yang harus diberikan secara komprehensif. Pada periode ini, ibu mengalami berbagai tantangan emosional seperti kelelahan, kecemasan, dan perubahan suasana hati akibat perubahan hormonal maupun tanggung jawab baru sebagai ibu. Komunikasi empatik dan motivasi positif dari tenaga kesehatan maupun keluarga sangat membantu dalam mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri ibu. Bidan perlu memberikan konseling yang efektif mengenai teknik relaksasi, manajemen waktu istirahat, serta pola makan yang sehat. Jika ditemukan tanda stres atau gangguan emosional serius, maka rujukan ke konseling profesional sangat dianjurkan. Keterlibatan aktif keluarga, terutama pasangan, dalam memberikan dukungan emosional dan praktis juga sangat penting. Mengajak ibu bergabung dalam kelompok pendukung sesama ibu pascapersalinan juga efektif dalam mengurangi isolasi sosial, meningkatkan rasa solidaritas, serta memberikan sumber informasi tambahan yang bermanfaat. Secara keseluruhan, dukungan psikososial yang holistik dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional ibu serta berdampak positif pada keluarga dan bayi secara keseluruhan.

Glosarium

Depresi Postpartum: Gangguan psikologis berupa perasaan sedih, cemas berlebihan, serta kesulitan emosional yang signifikan yang dialami ibu setelah melahirkan.

Dukungan Psikososial: Upaya holistik yang meliputi perhatian terhadap aspek emosional, sosial, dan psikologis ibu selama masa nifas, seperti pemberian motivasi positif, konseling, serta keterlibatan aktif keluarga.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): Instrumen skrining untuk mendeteksi dini gejala depresi postpartum pada ibu pascapersalinan.

Edukasi Kesehatan Reproduksi Pascapersalinan: Proses pemberian informasi yang komprehensif kepada ibu tentang perubahan fisiologis, kembalinya kesuburan, serta metode kontrasepsi yang aman setelah persalinan.

Episiotomi: Tindakan medis berupa sayatan bedah yang dilakukan pada area perineum ibu untuk memperluas jalan lahir saat persalinan.

Involusi Uterus: Proses pengecilan dan kembalinya rahim ke ukuran dan posisi sebelum kehamilan, yang terjadi secara bertahap selama masa nifas.

Istirahat Efektif Pascapersalinan: Strategi pengelolaan waktu istirahat yang optimal bagi ibu guna mempercepat pemulihan fisik dan emosional setelah persalinan.

Komplikasi Postpartum: Berbagai kondisi medis yang bisa terjadi setelah persalinan, seperti perdarahan, infeksi, tromboemboli, preeklamsia, dan depresi postpartum.

Komunikasi Empatik: Pendekatan komunikasi yang penuh perhatian, mendalam, hangat, dan mendukung, yang sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial bagi ibu masa nifas.

Konseling Nutrisi Seimbang: Edukasi yang diberikan kepada ibu mengenai pola makan yang sehat untuk mendukung pemulihan fisik serta kelancaran produksi ASI.

Kontraksi Uterus: Gerakan rahim yang bertujuan mengembalikan ukurannya pascapersalinan sekaligus membantu menghentikan perdarahan.

Lokia: Cairan yang keluar dari rahim selama masa nifas yang terdiri atas darah, lendir, dan jaringan sisa dari rahim yang membersihkan diri setelah melahirkan.

Masa Nifas: Periode transisi setelah persalinan, biasanya berlangsung sekitar enam minggu, di mana tubuh ibu mengalami perubahan signifikan menuju kondisi sebelum hamil.

Mobilisasi Dini: Aktivitas fisik ringan yang segera dilakukan setelah melahirkan untuk mencegah komplikasi seperti tromboemboli serta membantu pemulihan fisik ibu.

Nyeri Postpartum: Rasa nyeri yang umum dirasakan ibu setelah persalinan, terutama akibat kontraksi rahim atau luka jahitan, yang dapat dikelola dengan pendekatan farmakologis maupun nonfarmakologis.

Perawatan Luka Pascapersalinan: Tindakan yang dilakukan untuk memastikan kebersihan, memantau penyembuhan, dan mencegah infeksi pada luka akibat episiotomi atau operasi caesar.

Perdarahan Postpartum: Kondisi keluarnya darah secara berlebihan setelah melahirkan yang dapat membahayakan nyawa ibu jika tidak segera ditangani.

Perineum: Area jaringan lunak antara vagina dan anus yang sering kali mengalami luka atau robekan saat persalinan.

Preeklamsia Postpartum: Kondisi hipertensi yang bisa muncul setelah persalinan, terutama pada ibu yang memiliki riwayat hipertensi atau preeklamsia selama masa kehamilan.

Subinvolusi Uterus: Kondisi rahim yang gagal kembali ke ukuran normal setelah melahirkan, berisiko menyebabkan perdarahan atau infeksi.

Tromboemboli: Kondisi di mana gumpalan darah (trombus) menyumbat pembuluh darah, sering terjadi pada masa pascapersalinan akibat kondisi hiperkoagulabilitas dan imobilisasi.

Teknik Aseptik: Prosedur steril yang digunakan selama tindakan persalinan dan perawatan luka untuk mencegah infeksi postpartum.

Daftar Pustaka

- Astuti, R. W., & Prasetyo, B. (2021). Pengaruh Dukungan Psikososial terhadap Kejadian Depresi Postpartum pada Ibu Nifas. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 15(2), 93–102. <https://doi.org/10.29238/kia.v15i2.765>
- Chandra, P. S., & Desai, G. (2020). Postpartum Psychiatric Disorders: Early Recognition and Management. *Journal of Obstetrics and Gynaecology of India*, 70(4), 272–278. <https://doi.org/10.1007/s13224-019-01241-4>
- Fitriana, D., & Sudirman, J. (2022). Pencegahan Infeksi Luka Episiotomi melalui Edukasi Perawatan Perineum. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 128–135. <https://doi.org/10.33024/jk.v9i2.3870>
- Gamelia, E., & Lestari, P. (2021). Mobilisasi Dini untuk Mencegah Tromboemboli Pascapersalinan. *Jurnal Kesehatan Perempuan*, 10(1), 12–21. <https://doi.org/10.26714/jkp.v10i1.845>
- Handayani, D. A., & Oktaviani, M. (2021). Efektivitas Teknik Relaksasi dalam Mengurangi Nyeri Pascapersalinan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(1), 15–22. <https://doi.org/10.33857/jik.v9i1.512>
- Hidayat, A. A., & Uliyah, M. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas dan Neonatus*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kusmiran, E. (2019). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2019). *Maternity & Women's Health Care* (12th ed.). Elsevier Mosby.
- Maryunani, A. (2020). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jakarta: Trans Info Media.
- Murniati, N. (2021). Peran Edukasi Kesehatan Reproduksi dalam Pencegahan Kehamilan yang Tidak Direncanakan Pascapersalinan. *Journal of Midwifery Care and Reproductive Health*, 4(2), 47–55. <https://doi.org/10.32938/jmcrh.v4i2.2856>
- Nursalam, N., & Siti, P. (2020). *Asuhan Keperawatan pada Ibu Bersalin dan Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2018). *Maternal Child Nursing Care* (6th ed.). Elsevier.
- Rahmaniar, R., & Anggraeni, M. D. (2022). Pencegahan Perdarahan Postpartum dengan Pemantauan Ketat Kontraksi Uterus. *Indonesian Journal of Midwifery and Maternal Health*, 5(1), 23–30. <https://doi.org/10.25077/ijmmh.v5i1.220>
- Rahayu, I., & Puspitasari, N. (2021). Faktor Risiko Preeklamsia Postpartum dan Pentingnya Deteksi Dini. *Jurnal Kesehatan Maternal dan Neonatal*, 8(2), 104–111. <https://doi.org/10.20473/jkmm.v8i2.2365>
- Saleha, S. (2020). *Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.

- Sari, R. D., & Herawati, E. (2021). Konseling Gizi Seimbang untuk Ibu Nifas dalam Meningkatkan Produksi ASI. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 116–124. <https://doi.org/10.36419/jkebin.v12i2.544>
- Sihombing, E., & Tambunan, Y. (2022). Dukungan Keluarga dalam Menurunkan Risiko Depresi Postpartum pada Ibu Nifas. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 10(2), 198–207. <https://doi.org/10.36721/jpk.v10i2.1985>
- Sulistiyawati, A. (2021). Peran Penting Pemantauan Status Gizi Ibu Hamil dalam Pencegahan Komplikasi Pascapersalinan. *Journal of Nutrition and Maternal Health*, 3(2), 78–86. <https://doi.org/10.31098/jnmh.v3i2.729>
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2021). *Varney's Midwifery* (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2021). *WHO Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn*. Geneva: WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>
- Yuliani, F., & Wardani, A. K. (2020). Pentingnya Perawatan Luka Operasi Caesar dalam Pencegahan Infeksi Postpartum. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 8(1), 33–40. <https://doi.org/10.33221/jik.v8i1.3420>

Bab 8

Dokumentasi dan Pencatatan Asuhan Persalinan

Dokumentasi dan pencatatan dalam pelayanan kebidanan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari proses asuhan kebidanan selama persalinan. Dalam praktiknya, dokumentasi tidak hanya menjadi bukti tertulis dari tindakan dan keputusan yang diambil, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin kontinuitas perawatan, keselamatan pasien, serta kualitas pelayanan yang optimal. Bab ini akan membahas secara komprehensif tentang pentingnya dokumentasi kebidanan, penggunaan catatan medis dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), aspek hukum dan etika dalam dokumentasi, serta teknik pendokumentasian yang efektif.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip dokumentasi kebidanan secara tepat, lengkap, serta bertanggung jawab sesuai dengan aspek hukum dan etika profesi.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Setelah mengikuti bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya dokumentasi kebidanan, memahami aspek hukum dan etika dokumentasi, serta mampu melaksanakan teknik pendokumentasian secara efektif dalam praktik persalinan.

Sub-CPMK (Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

1. Menjelaskan pentingnya dokumentasi dalam praktik kebidanan.
2. Menjelaskan manfaat dan penggunaan catatan medis serta Buku KIA.
3. Menguraikan aspek hukum dan etika yang terkait dengan dokumentasi kebidanan.
4. Mempraktikkan teknik pendokumentasian yang efektif, jelas, akurat, dan bertanggung jawab.

A. Pentingnya Dokumentasi Kebidanan

Dokumentasi dalam praktik kebidanan, khususnya selama proses persalinan, memiliki arti yang sangat penting dan vital. Dokumentasi yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab profesional seorang bidan, sekaligus menjadi sarana penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan serta keselamatan ibu dan bayi. Dalam konteks ini, dokumentasi kebidanan tidak hanya sekadar mencatat tindakan yang dilakukan, tetapi juga merekam kondisi kesehatan pasien secara terperinci dari waktu ke waktu.

Secara lebih rinci, dokumentasi berfungsi sebagai rekam jejak yang jelas mengenai seluruh proses pelayanan kebidanan, termasuk kondisi pasien pada saat tiba, selama persalinan, hingga masa pascapersalinan. Catatan ini membantu tenaga kesehatan untuk mengevaluasi kemajuan persalinan secara objektif dan akurat. Dokumentasi juga digunakan sebagai dasar komunikasi antar anggota tim kesehatan, seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Informasi yang terdokumentasi dengan jelas dapat menghindari kesalahan interpretasi yang mungkin terjadi dalam komunikasi lisan.

Selain itu, dokumentasi kebidanan memiliki peran penting dalam menghadapi situasi darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Ketika terjadi komplikasi selama proses persalinan, catatan medis yang telah terdokumentasi dengan baik akan membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan kondisi klinis pasien yang sudah tercatat sebelumnya.

Dari sudut pandang hukum, dokumentasi kebidanan merupakan alat bukti penting jika terjadi permasalahan medikolegal, seperti tuntutan hukum atau keluhan dari pasien atau keluarganya. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, jelas, dan akurat, tenaga kesehatan dapat memberikan bukti otentik mengenai tindakan medis yang telah dilakukan serta kondisi pasien yang sebenarnya.

Selain aspek hukum, dokumentasi kebidanan juga berfungsi sebagai sumber data untuk evaluasi dan audit medis. Evaluasi rutin terhadap catatan medis dapat membantu tenaga kebidanan mengukur efektivitas pelayanan yang diberikan, menemukan kelemahan dalam praktik klinis, dan merencanakan perbaikan di masa depan. Catatan medis ini juga penting sebagai bahan penelitian atau studi ilmiah yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

Karena dokumentasi memiliki peranan yang sangat penting, maka pencatatan harus dilakukan secara rutin, teliti, akurat, objektif, tepat waktu, dan mudah dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Bidan perlu memiliki keterampilan pendokumentasian yang baik agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan.

Secara ringkas, pentingnya dokumentasi kebidanan mencakup:

1. Sebagai rekam medis yang objektif, memberikan gambaran jelas tentang kondisi pasien dan tindakan medis yang telah dilakukan selama proses persalinan.
2. Alat komunikasi antar tenaga kesehatan, memastikan informasi yang relevan tersampaikan secara tepat dan jelas antar anggota tim pelayanan kesehatan.
3. Panduan dalam situasi darurat, membantu pengambilan keputusan cepat dan tepat berdasarkan kondisi yang terdokumentasi sebelumnya.
4. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien, sebagai bukti otentik dalam kasus medikolegal atau sengketa hukum.
5. Dasar evaluasi dan audit medis, untuk mengukur efektivitas pelayanan serta menemukan potensi perbaikan dalam praktik kebidanan.
6. Sebagai sumber data penelitian, mendukung pengembangan pelayanan kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Dengan demikian, dokumentasi kebidanan bukan hanya merupakan kewajiban administratif semata, tetapi merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang berkualitas tinggi, aman, dan bertanggung jawab secara hukum maupun etika.

B. Catatan Medis dan Buku KIA

Catatan medis merupakan salah satu dokumen penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam bidang kebidanan. Dokumen ini berisi informasi lengkap mengenai riwayat kesehatan pasien, mulai dari data identifikasi diri, riwayat kesehatan sebelumnya, hasil pemeriksaan fisik, tindakan medis atau kebidanan yang diberikan, respons pasien terhadap tindakan tersebut, serta rencana perawatan lanjutan. Dalam lingkup kebidanan, catatan medis mencakup rangkaian informasi yang sangat detail terkait kondisi ibu selama masa kehamilan, proses persalinan hingga masa nifas.

Dalam proses persalinan, catatan medis berperan sebagai dokumentasi penting yang mencatat secara rinci setiap tahap yang dilalui ibu hamil. Informasi yang wajib dicatat mencakup hasil pemeriksaan awal saat ibu tiba di fasilitas kesehatan, data perkembangan persalinan seperti dilatasi serviks, frekuensi dan intensitas kontraksi rahim, detak jantung janin, serta penggunaan alat bantu seperti partograf. Selain itu, dokumentasi juga mencakup intervensi atau tindakan medis yang diberikan, seperti pemberian obat-obatan atau tindakan medis lainnya, serta kondisi bayi yang baru lahir, termasuk nilai APGAR, berat badan, panjang badan, dan adanya komplikasi atau tidak setelah kelahiran.

Catatan medis yang akurat dan lengkap memiliki fungsi sangat penting sebagai sarana komunikasi antar tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses persalinan. Dokumen ini menjadi referensi yang sangat membantu untuk memastikan kontinuitas pelayanan kesehatan, baik pada proses persalinan itu sendiri maupun pada masa nifas. Selain itu, catatan medis yang terdokumentasi secara baik akan mempermudah tim kesehatan dalam mengambil keputusan klinis, mengevaluasi keberhasilan tindakan sebelumnya, dan memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewatkan sehingga risiko kesalahan medis dapat diminimalkan.

Selain catatan medis yang disimpan di fasilitas pelayanan kesehatan, Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) juga merupakan instrumen pendokumentasian yang sangat penting dalam praktik kebidanan. Buku KIA merupakan buku pencatatan pribadi yang dimiliki oleh setiap ibu sejak masa kehamilan hingga bayi berusia lima tahun. Buku ini mencakup informasi lengkap tentang hasil pemeriksaan kehamilan, kondisi ibu dan bayi selama kehamilan, hasil pemeriksaan antenatal, proses persalinan, imunisasi bayi, serta catatan tumbuh kembang bayi.

Buku KIA ini diberikan kepada ibu sejak kunjungan antenatal pertama kali. Setiap ibu wajib membawa buku ini setiap kali mengunjungi fasilitas kesehatan, baik untuk pemeriksaan antenatal, persalinan, maupun pemeriksaan bayi setelah lahir. Dengan demikian, buku ini menjadi alat penting dalam pemantauan kesehatan secara berkelanjutan oleh berbagai tenaga kesehatan yang mungkin bergantian memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi. Buku ini juga membantu tenaga kesehatan memahami riwayat kesehatan ibu dan bayi dengan cepat dan akurat.

Selain fungsi pemantauan kesehatan, Buku KIA juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi ibu dan keluarganya. Informasi-informasi penting yang tercantum di dalamnya memberikan pengetahuan praktis mengenai tanda bahaya kehamilan, proses persalinan, perawatan pascapersalinan, gizi ibu dan bayi, serta pentingnya imunisasi dan pemeriksaan rutin. Dengan adanya buku ini, ibu diharapkan menjadi lebih sadar dan aktif dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan bayinya.

Secara ringkas, manfaat dan fungsi penting dari Catatan Medis dan Buku KIA adalah sebagai berikut:

1. Catatan Medis

- Sebagai dokumentasi lengkap mengenai kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas.
- Menjadi alat komunikasi antar tenaga kesehatan, memastikan kontinuitas pelayanan.

- Sebagai referensi klinis dalam pengambilan keputusan medis yang cepat dan tepat.
- Membantu evaluasi efektivitas tindakan medis yang telah dilakukan.
- Menjadi bukti legal dalam kasus hukum atau medikolegal.

2. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)

- Sebagai instrumen pemantauan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.
- Menyediakan informasi penting mengenai riwayat pemeriksaan antenatal, proses persalinan, imunisasi, serta tumbuh kembang bayi.
- Sebagai alat edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan.
- Menjadi buku pegangan ibu yang memudahkan akses informasi tentang kondisi kesehatan ibu dan bayi setiap kali pemeriksaan kesehatan dilakukan.

Dengan memahami pentingnya kedua jenis dokumentasi ini, tenaga kesehatan kebidanan diharapkan dapat menjalankan praktik kebidanan secara lebih baik, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan edukasi kepada ibu agar dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri serta bayinya.

C. Aspek Hukum dan Etika Dokumentasi

Dokumentasi kebidanan yang dilakukan selama proses persalinan maupun dalam keseluruhan pelayanan kebidanan memiliki dimensi hukum dan etika yang sangat penting. Dalam aspek hukum, dokumentasi medis merupakan catatan resmi yang memiliki nilai pembuktian jika terjadi permasalahan medikolegal, seperti keluhan atau tuntutan hukum dari pasien maupun keluarganya terhadap tenaga kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan. Catatan medis yang lengkap, jelas, dan terperinci dianggap sebagai bukti otentik yang sah secara hukum dan dapat digunakan dalam proses hukum untuk menunjukkan bahwa tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan pedoman klinis yang berlaku.

Dalam praktik kebidanan sehari-hari, kasus hukum yang muncul sering kali berkaitan dengan tuduhan kelalaian atau malpraktik medis. Pada kondisi ini, catatan medis akan menjadi alat pembuktian utama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Catatan medis yang terdokumentasi dengan benar dan lengkap dapat melindungi bidan atau tenaga kesehatan dari tuduhan kelalaian yang tidak berdasar. Sebaliknya, jika dokumentasi kurang lengkap atau tidak jelas, maka tenaga kesehatan dapat dianggap lalai atau tidak profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan, yang berpotensi menyebabkan konsekuensi hukum serius, seperti sanksi administratif, denda, bahkan hukuman pidana.

Di samping aspek hukum, dokumentasi kebidanan juga memiliki implikasi etika yang signifikan. Secara etis, seorang bidan memiliki kewajiban moral untuk mencatat kondisi pasien dan tindakan yang dilakukan secara jujur, akurat, objektif, dan tepat waktu. Kejujuran dan objektivitas dalam dokumentasi merupakan prinsip utama yang harus selalu dipatuhi oleh tenaga kebidanan demi menjaga integritas profesi dan kepercayaan pasien. Catatan medis harus mencerminkan fakta sebenarnya tanpa ditambahkan atau dikurangi demi kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Aspek lain yang sangat penting dari sisi etika dalam dokumentasi kebidanan adalah menjaga kerahasiaan informasi pasien. Setiap dokumen medis yang berisi data pribadi pasien harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik profesi kebidanan maupun regulasi yang berlaku. Bidan harus memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang dan berkepentingan secara langsung yang dapat mengakses informasi tersebut. Penanganan dokumen yang tidak bertanggung jawab, seperti penyimpanan yang sembarangan atau pengungkapan informasi tanpa izin pasien, merupakan pelanggaran etika serius yang dapat merusak kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Bidan juga dituntut memahami dan menghormati hak pasien terhadap informasi medisnya. Pasien memiliki hak untuk mengetahui isi catatan medisnya serta hak untuk mendapatkan penjelasan yang jujur, jelas, dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya dan tindakan medis yang diterimanya. Oleh karena itu, bidan harus mampu memberikan informasi secara transparan kepada pasien, serta menjamin bahwa dokumentasi yang dilakukan merefleksikan hal yang sama.

Lebih lanjut, dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dokumentasi, tenaga kebidanan harus memastikan bahwa catatan medis disimpan secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran privasi atau kebocoran data pasien. Pemanfaatan teknologi dalam dokumentasi juga harus mematuhi standar keamanan data elektronik yang berlaku agar informasi medis pasien tetap terlindungi secara maksimal.

Secara ringkas, aspek penting terkait hukum dan etika dalam dokumentasi kebidanan meliputi:

1. Dokumentasi sebagai Bukti Hukum

- Berfungsi sebagai bukti otentik dalam kasus medikolegal atau sengketa hukum.
- Melindungi tenaga kesehatan dari tuduhan kelalaian atau malpraktik yang tidak berdasar.

2. Kewajiban Moral dalam Dokumentasi

- Bidan wajib mencatat informasi medis secara jujur, akurat, objektif, dan tepat waktu.
- Menjaga integritas profesi kebidanan dengan mendokumentasikan fakta sesuai kenyataan tanpa distorsi.

3. Prinsip Kerahasiaan Informasi Pasien

- Menjamin bahwa informasi medis pasien hanya diakses oleh pihak yang berwenang.
- Memastikan bahwa penyimpanan dokumen medis aman dan terlindungi dari kebocoran atau penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

4. Hak Pasien atas Informasi Medis

- Menghormati hak pasien untuk mengetahui informasi yang tercatat dalam dokumen medisnya.
- Memberikan penjelasan yang jelas, jujur, dan lengkap kepada pasien mengenai tindakan medis yang dilakukan.

Dengan memahami pentingnya aspek hukum dan etika dalam dokumentasi kebidanan, bidan diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, aman, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan.

D. Teknik Pendokumentasian Efektif

Dalam praktik kebidanan, dokumentasi yang baik dan efektif merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap bidan. Pendokumentasian yang efektif tidak hanya sekadar menulis catatan biasa, tetapi juga mencakup kejelasan informasi, ketepatan waktu, serta kemudahan dalam interpretasi bagi seluruh anggota tim pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kebidanan untuk memahami dan menerapkan beberapa teknik utama dalam pendokumentasian yang efektif.

Teknik pertama dalam pendokumentasian efektif adalah memastikan bahwa setiap catatan ditulis secara jelas, ringkas, dan mudah dibaca. Bidan harus menggunakan tulisan tangan yang jelas jika mencatat secara manual atau memanfaatkan format digital yang rapi dan sistematis jika menggunakan teknologi digital. Hal ini bertujuan agar setiap anggota tim kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien dapat dengan mudah membaca, memahami, dan menggunakan informasi dalam catatan medis tersebut tanpa kesalahan interpretasi.

Selain kejelasan, penting pula untuk memastikan bahwa setiap dokumentasi dilakukan segera setelah tindakan selesai dilakukan. Penundaan dalam pencatatan dapat menyebabkan hilangnya detail penting mengenai tindakan atau perubahan kondisi pasien yang terjadi. Dokumentasi yang dibuat dengan segera dan tepat waktu membantu tenaga kebidanan untuk merekam kondisi klinis secara akurat dan mencegah kelalaian akibat lupa atau kekurangan informasi yang terjadi seiring berjalannya waktu.

Selanjutnya, penggunaan istilah medis yang akurat, baku, dan konsisten sangat diperlukan dalam pendokumentasian. Bidan harus menghindari penggunaan istilah yang ambigu atau tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan interpretasi ganda. Penggunaan terminologi medis yang baku akan membantu dalam memastikan bahwa informasi yang terdokumentasi dipahami secara universal oleh semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien.

Dalam praktik dokumentasi selama persalinan, penting bagi bidan untuk mencatat secara kronologis mulai dari tahap awal pemeriksaan, perkembangan persalinan, tindakan kebidanan yang diberikan, hingga hasil dari setiap tindakan tersebut. Setiap perubahan signifikan dalam kondisi pasien selama proses persalinan harus didokumentasikan secara detail dan mencantumkan waktu kejadian dengan jelas. Dokumentasi kronologis seperti ini akan sangat membantu tim medis untuk mengevaluasi progres persalinan, menentukan tindakan yang dibutuhkan, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan perkembangan situasi klinis yang terdokumentasi.

Salah satu contoh nyata dari teknik dokumentasi efektif selama persalinan adalah penggunaan partograf. Partograf merupakan alat dokumentasi visual yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui partograf, tenaga kebidanan dapat dengan cepat mengidentifikasi apabila terjadi penyimpangan atau keterlambatan dalam proses persalinan, sehingga intervensi segera dapat diberikan untuk mencegah komplikasi atau risiko kesehatan lebih lanjut terhadap ibu dan bayi.

Seiring perkembangan teknologi, penggunaan dokumentasi digital dalam kebidanan juga semakin dianjurkan. Dokumentasi digital menawarkan kelebihan seperti meningkatkan keakuratan data, keamanan penyimpanan, serta kemudahan dalam mengakses informasi pasien secara cepat dan tepat. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi digital dalam dokumentasi medis tetap harus mematuhi standar keamanan informasi dan regulasi tentang privasi pasien. Tenaga kebidanan

harus memastikan bahwa semua informasi yang disimpan dalam format digital dilindungi dari risiko kebocoran data atau akses yang tidak sah.

Secara ringkas, teknik pendokumentasian efektif dalam praktik kebidanan meliputi:

1. Kejelasan dan Keringkasan Informasi
 - Menulis catatan secara jelas, ringkas, dan mudah dibaca oleh semua anggota tim kesehatan.
 - Menghindari informasi yang ambigu atau multitafsir.
2. Ketepatan Waktu dalam Pendokumentasian
 - Melakukan pencatatan segera setelah tindakan dilakukan.
 - Menghindari keterlambatan pencatatan yang dapat menyebabkan kelalaian atau kehilangan informasi penting.
3. Penggunaan Istilah Medis yang Akurat dan Baku
 - Menggunakan terminologi medis standar agar informasi mudah dipahami secara universal.
 - Mencegah interpretasi ganda atau kesalahpahaman dalam pembacaan catatan medis.
4. Dokumentasi Kronologis selama Persalinan
 - Mencatat setiap tahap pemeriksaan, perkembangan persalinan, tindakan yang dilakukan, dan hasilnya secara detail dan sistematis.
 - Mencantumkan waktu setiap kejadian dengan jelas untuk mempermudah evaluasi klinis.
5. Penggunaan Partograf
 - Menggunakan partograf sebagai alat dokumentasi visual dalam memantau kemajuan persalinan.
 - Membantu deteksi dini terhadap keterlambatan atau komplikasi persalinan.
6. Pemanfaatan Teknologi Digital yang Aman dan Efektif
 - Mengadopsi sistem dokumentasi elektronik yang dapat meningkatkan akurasi dan keamanan data medis.
 - Menjaga keamanan informasi serta mematuhi regulasi tentang privasi dan kerahasiaan data pasien.

Dengan menerapkan teknik pendokumentasian yang efektif ini, tenaga kebidanan dapat memastikan bahwa informasi medis pasien terdokumentasi secara baik, akurat, dan aman, sehingga mendukung tercapainya pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi dan profesional.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1: Analisis Pentingnya Dokumentasi Kebidanan

- Jelaskan secara rinci mengapa dokumentasi dalam praktik kebidanan dianggap penting.
- Berikan contoh kasus nyata atau ilustrasi yang menggambarkan pentingnya dokumentasi dalam situasi darurat atau medikolegal.
- Tulis analisis Anda dalam bentuk esai maksimal 3 halaman, lengkapi dengan referensi terbaru.

Tugas 2: Studi Kasus Pemanfaatan Catatan Medis dan Buku KIA

- Carilah satu contoh nyata (bisa dari pengalaman praktik atau jurnal ilmiah) tentang pemanfaatan Catatan Medis dan Buku KIA dalam pelayanan kebidanan.
- Uraikan secara rinci bagaimana kedua instrumen ini membantu dalam kontinuitas pelayanan dan komunikasi antar tenaga kesehatan.
- Tuliskan hasil studi kasus Anda secara jelas dan lengkap dalam bentuk laporan singkat sebanyak 2-3 halaman.

Tugas 3: Refleksi Tentang Aspek Hukum dan Etika Dokumentasi Kebidanan

- Buatlah refleksi tertulis tentang pentingnya memahami aspek hukum dan etika dalam dokumentasi kebidanan.
- Jelaskan implikasi nyata jika aspek hukum dan etika tersebut tidak diterapkan secara benar dalam praktik kebidanan.
- Tuliskan dalam bentuk esai reflektif minimal 2 halaman, sertakan pendapat dan argumentasi yang jelas, disertai contoh konkret.

Tugas 4: Simulasi Pendokumentasian Efektif Menggunakan Partograf

- Buat simulasi sederhana penggunaan partograf dalam mendokumentasikan kemajuan persalinan dari awal hingga kelahiran.
- Gambarkan secara kronologis setiap tahap yang dilalui pasien secara detail.
- Tuliskan evaluasi Anda mengenai manfaat penggunaan partograf dalam praktik kebidanan secara singkat (1 halaman).

Tugas 5: Proyek Mini Implementasi Dokumentasi Digital

- Kembangkan konsep sederhana sistem dokumentasi digital untuk pelayanan kebidanan.
- Jelaskan fitur-fitur yang wajib dimiliki untuk memastikan dokumentasi efektif dan aman.
- Buatlah presentasi sederhana (PowerPoint atau media lainnya), kemudian jelaskan secara ringkas dalam bentuk laporan maksimal 3 halaman tentang keunggulan dan tantangan dari penerapan sistem tersebut.

Pilihan Ganda

1. Seorang bidan bertugas di ruang bersalin RSUD Citra Medika. Ia menerima pasien seorang perempuan (28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu) dalam persalinan aktif. Setelah pemeriksaan awal, bidan lupa mencatat hasil pemeriksaan dilatasi serviks dan kondisi janin. Dua jam kemudian, terjadi perubahan kondisi janin yang membutuhkan tindakan segera oleh dokter spesialis kandungan. Tindakan dokter tertunda akibat informasi kondisi awal tidak terdokumentasi dengan jelas.
Apakah dampak utama dari kelalaian dokumentasi ini?
 - A. Hambatan komunikasi antar tenaga kesehatan
 - B. Penurunan kualitas pelayanan kesehatan
 - C. Risiko hukum terkait kelalaian medis
 - D. Terhambatnya evaluasi pelayanan
 - E. Hilangnya data penelitian klinis
2. Di sebuah klinik bersalin, bidan Ani mencatat perkembangan persalinan seorang perempuan (30 tahun, primigravida) dengan menggunakan partograf. Setelah 4 jam, Ani menyerahkan tugas kepada bidan pengganti, tetapi informasi yang ditulis Ani pada partograf sulit dibaca karena tulisan tidak jelas. Akibatnya, terjadi kesalahan interpretasi yang menyebabkan terlambatnya penanganan persalinan macet.
Kesalahan utama dalam kasus ini adalah tidak menerapkan prinsip dokumentasi yaitu:
 - A. Ketepatan waktu pencatatan
 - B. Kejelasan dan keringkasan informasi
 - C. Dokumentasi kronologis
 - D. Penggunaan istilah medis yang akurat
 - E. Menjaga kerahasiaan informasi pasien
3. Seorang perempuan (27 tahun, multipara) menjalani proses persalinan di RS Bunda. Seluruh informasi penting terkait kondisinya sudah tercatat lengkap di Catatan Medis dan Buku KIA. Namun, seorang tenaga administrasi secara tidak sengaja meninggalkan dokumen medis Ny. M di ruang publik sehingga dapat diakses oleh pengunjung lain.
Pelanggaran etika kebidanan yang terjadi dalam kasus ini adalah:
 - A. Tidak mencatat data secara kronologis
 - B. Tidak menjaga kerahasiaan informasi pasien
 - C. Tidak mencatat dengan objektif
 - D. Tidak segera melakukan pencatatan setelah tindakan
 - E. Tidak menggunakan terminologi medis standar

4. Bidan Rina merawat pasien perempuan (25 tahun, G1P0A0) yang sedang dalam proses persalinan. Setelah proses persalinan selesai, Bidan Rina segera mencatat hasil pemeriksaan fisik bayi, termasuk nilai APGAR, berat badan, dan panjang badan, serta intervensi yang diberikan. Catatan ini kemudian digunakan oleh dokter anak untuk evaluasi dan perawatan bayi lebih lanjut.

Fungsi utama dokumentasi dalam kasus ini adalah sebagai:

- A. Alat komunikasi antar tenaga kesehatan
 - B. Alat bukti hukum
 - C. Sumber data penelitian
 - D. Dasar audit medis
 - E. Panduan situasi darurat
5. Di Puskesmas Sejahtera, bidan Lisa menggunakan sistem dokumentasi digital untuk mencatat kondisi pasien selama proses persalinan. Suatu hari, sistem tersebut mengalami gangguan teknis sehingga data pasien sempat tidak bisa diakses dengan cepat. Beruntung, bidan Lisa memiliki catatan manual sebagai cadangan.

Pelajaran penting dari kasus ini dalam konteks dokumentasi digital adalah:

- A. Pentingnya kejelasan informasi
- B. Pentingnya ketepatan waktu pencatatan
- C. Pentingnya memiliki sistem cadangan (backup)
- D. Pentingnya dokumentasi kronologis
- E. Pentingnya penggunaan partograf

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Kelalaian dokumentasi dalam kasus ini berisiko menimbulkan dampak hukum serius karena informasi yang tidak tercatat dengan jelas dapat dianggap sebagai bukti kelalaian profesional. Dokumentasi medis menjadi bukti otentik dalam situasi medikolegal seperti ini, sehingga kelalaian dalam pencatatan dapat memperbesar risiko hukum bagi tenaga kesehatan.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Dalam kasus ini, masalah utamanya adalah ketidakjelasan informasi yang terdokumentasi. Prinsip kejelasan dan keringkasan sangat penting agar dokumentasi dapat dipahami semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, sehingga menghindari kesalahan interpretasi yang membahayakan keselamatan pasien.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kasus ini secara jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan informasi pasien. Setiap dokumen medis harus disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Menyimpan atau menempatkan dokumen medis di tempat yang tidak aman merupakan pelanggaran serius dalam etika profesi kebidanan.

4. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Dalam skenario ini, dokumentasi digunakan terutama sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, dalam hal ini antara bidan dan dokter anak. Informasi yang dicatat dengan jelas membantu dokter anak memahami kondisi bayi secara akurat, sehingga perawatan lanjutan dapat dilakukan secara efektif.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Dari kasus ini, pelajaran utama yang dapat dipetik adalah perlunya memiliki sistem cadangan dalam dokumentasi digital. Adanya cadangan manual sebagai backup merupakan langkah bijaksana yang menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan jika terjadi gangguan teknologi, sehingga data pasien tetap tersedia dan pelayanan tidak terganggu.

Rangkuman Materi

Dokumentasi kebidanan merupakan aspek krusial dalam praktik kebidanan, terutama selama proses persalinan. Dokumentasi yang baik menjadi tanggung jawab profesional seorang bidan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas pelayanan yang optimal. Fungsi utama dokumentasi meliputi pencatatan secara objektif mengenai kondisi pasien, tindakan medis, serta perkembangan persalinan hingga pascapersalinan. Dokumentasi juga memfasilitasi komunikasi antar tenaga kesehatan dan menjadi panduan penting dalam situasi darurat. Selain itu, dokumentasi yang akurat berfungsi sebagai bukti hukum dalam situasi medikolegal dan sebagai dasar evaluasi serta penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan.

Catatan Medis dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) merupakan dua instrumen dokumentasi penting dalam bidang kebidanan. Catatan medis berisi detail mengenai riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan fisik, tindakan medis, serta kondisi ibu dan bayi secara menyeluruh. Catatan ini penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan, membantu pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta sebagai bukti hukum jika terjadi permasalahan hukum. Sementara itu, Buku KIA merupakan catatan pribadi ibu yang mencakup informasi kesehatan selama kehamilan, proses persalinan, imunisasi, dan tumbuh kembang bayi. Buku ini mendukung pemantauan kesehatan ibu

dan bayi secara berkelanjutan serta menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga terhadap kesehatan.

Dari perspektif hukum dan etika, dokumentasi kebidanan memiliki nilai penting sebagai alat bukti dalam kasus hukum dan perlindungan tenaga kesehatan dari tuduhan kelalaian. Dokumentasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, akurasi, objektivitas, dan tepat waktu. Menjaga kerahasiaan informasi pasien juga merupakan tanggung jawab etis seorang bidan. Dokumen medis harus disimpan secara aman sesuai regulasi, dan tenaga kebidanan wajib menghormati hak pasien untuk memperoleh informasi medis yang jelas dan lengkap.

Dalam praktik pendokumentasian, teknik yang efektif sangat diperlukan. Setiap catatan medis harus jelas, ringkas, mudah dipahami, dan dilakukan sesegera mungkin setelah tindakan medis diberikan untuk mencegah hilangnya informasi. Penggunaan istilah medis yang baku, dokumentasi kronologis, dan penerapan alat bantu visual seperti partograf sangat dianjurkan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi juga disarankan untuk meningkatkan akurasi, keamanan data, serta kemudahan akses informasi. Dengan menerapkan teknik pendokumentasian yang efektif, tenaga kebidanan dapat memastikan pelayanan kebidanan yang aman, profesional, dan berkualitas tinggi.

Glosarium

Audit Medis: Proses evaluasi sistematis terhadap catatan medis untuk mengukur efektivitas pelayanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Bidan: Tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan memberikan asuhan kebidanan secara profesional selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA): Buku pencatatan pribadi milik ibu yang memuat informasi lengkap mengenai kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, imunisasi bayi, serta pemantauan tumbuh kembang anak hingga usia lima tahun.

Catatan Medis: Dokumen penting berisi informasi rinci tentang riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, tindakan medis yang diberikan, respons pasien, serta rencana perawatan lanjutan, yang digunakan untuk memastikan kontinuitas pelayanan dan komunikasi antar tenaga kesehatan.

Dokumentasi Kebidanan: Proses pencatatan informasi mengenai kondisi kesehatan pasien secara akurat, objektif, dan sistematis selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas, yang bertujuan menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.

Evaluasi Pelayanan: Proses penilaian kualitas pelayanan kebidanan berdasarkan data dan catatan medis, untuk mengukur efektivitas tindakan serta merencanakan perbaikan di masa yang akan datang.

Evidence-Based Practice (EBP): Praktik pelayanan kebidanan yang didasarkan pada hasil penelitian dan bukti ilmiah terbaru, dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Kerahasiaan Informasi Pasien: Prinsip etika dalam kebidanan yang mengatur perlindungan terhadap informasi pribadi dan medis pasien agar tidak diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang.

Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan: Proses penyampaian informasi medis yang jelas dan akurat antar anggota tim kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal dan menghindari kesalahan interpretasi.

Malpraktik Medis: Tindakan atau kelalaian tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesional, yang menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien, serta dapat berimplikasi hukum.

Medikolegal: Istilah yang berhubungan dengan aspek medis dan hukum, terutama terkait dengan penggunaan catatan medis sebagai alat bukti dalam kasus hukum atau sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan.

Partograf: Alat dokumentasi visual yang digunakan oleh tenaga kebidanan untuk memantau secara sistematis dan kontinu kemajuan persalinan serta mendeteksi dini adanya komplikasi atau keterlambatan proses persalinan.

Privasi Pasien: Hak pasien untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi medisnya dari akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Teknik Pendokumentasian Efektif: Metode pencatatan informasi medis yang jelas, ringkas, mudah dipahami, tepat waktu, menggunakan terminologi medis baku, serta dilakukan secara kronologis untuk memastikan akurasi dan interpretasi yang benar oleh semua anggota tim kesehatan.

Teknologi Digital dalam Dokumentasi: Penggunaan sistem elektronik atau komputerisasi dalam pencatatan medis, yang bertujuan meningkatkan akurasi data, keamanan penyimpanan informasi, serta aksesibilitas informasi medis secara cepat dan tepat oleh tenaga kesehatan.

Tuntutan Hukum (Litigasi): Proses hukum yang terjadi ketika pasien atau keluarganya mengajukan keluhan atau gugatan terhadap tenaga kesehatan atau institusi kesehatan atas dugaan kelalaian atau pelanggaran dalam pemberian pelayanan medis.

Daftar Pustaka

- Arifin, S., & Azizah, N. (2020). Dokumentasi Keperawatan dan Kebidanan: Prinsip dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Astuti, P., & Sudirman, A. (2021). Pemanfaatan Partograf dalam Pemantauan Persalinan Normal: Tinjauan Literatur. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(1), 45-52.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA): Panduan bagi Ibu dan Keluarga. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dewi, R. S., & Handayani, T. (2019). Pentingnya Dokumentasi dalam Asuhan Kebidanan sebagai Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 189-196.
- Hidayati, E., & Yuliana, S. (2020). Hubungan Dokumentasi Kebidanan dengan Mutu Pelayanan Kesehatan. *Indonesian Journal of Midwifery*, 3(2), 88-95.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Dokumentasi dan Pencatatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.
- Kurniasari, Y., & Lubis, Z. (2021). Etika dan Aspek Hukum dalam Praktik Kebidanan: Kajian Dokumentasi Medis. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 9(1), 56-63.
- Maryunani, A. (2018). Dokumentasi Kebidanan: Teori dan Praktik Berbasis Evidence-Based Practice. Jakarta: Salemba Medika.
- Ningsih, A., & Prihatiningsih, T. S. (2019). Evaluasi Penerapan Catatan Medis Elektronik dalam Pelayanan Kebidanan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 15(1), 35-42.
- Nurhayati, S., & Rahmawati, A. (2020). Pentingnya Penggunaan Buku KIA dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. *Indonesian Midwifery Journal*, 4(2), 99-106.
- Nursalam, N. (2020). Manajemen Dokumentasi Keperawatan dan Kebidanan: Aplikasi dalam Praktik Klinik. Jakarta: Salemba Medika.
- Pratiwi, D., & Sumarni, T. (2022). Pendokumentasian Kebidanan sebagai Alat Perlindungan Hukum dan Etika Profesi. *Jurnal Kebidanan Profesional*, 6(2), 134-142.
- Rahmawati, S. (2019). Dokumentasi Medis Elektronik: Tantangan dan Peluang di Era Digitalisasi Pelayanan Kebidanan. *Jurnal Informatika Kesehatan*, 8(2), 78-85.
- Risnawati, R., & Susilawati, E. (2021). Teknik Pendokumentasian Efektif dalam Praktik Kebidanan untuk Meningkatkan Keselamatan Pasien. *Jurnal Kesehatan Prima*, 15(1), 63-71.
- Rosdiana, S., & Setiawati, Y. (2020). Pentingnya Pemanfaatan Buku KIA untuk Meningkatkan Kesadaran Ibu terhadap Pemantauan Kesehatan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 11(2), 105-111.
- Setyawati, E., & Rukmini, A. (2021). Dokumentasi dalam Perspektif Medikolegal pada Praktik Kebidanan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 9(2), 120-128.

- Wahyuni, S. (2020). Standar Dokumentasi Kebidanan dalam Mendukung Praktik Kebidanan yang Profesional. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(2), 85-92.
- Widyaningrum, R. (2019). Pengaruh Dokumentasi Kebidanan terhadap Keselamatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 10(2), 101-109.
- Wulandari, T., & Astuti, M. D. (2022). Strategi Pendokumentasian Kebidanan Berbasis Partograf untuk Mencegah Komplikasi Persalinan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 5(1), 40-47.
- Yuliani, N., & Farida, I. (2019). Dokumentasi Kebidanan dan Implikasinya terhadap Evaluasi dan Audit Klinis. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 8(2), 77-85.

Bab 9

Pencegahan Infeksi Dalam Persalinan

Infeksi adalah salah satu komplikasi yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi baru lahir selama proses persalinan dan masa nifas. Oleh karena itu, pencegahan infeksi merupakan aspek utama dalam pelayanan kebidanan yang bertujuan menjaga keselamatan, mencegah morbiditas dan mortalitas, serta meningkatkan mutu asuhan. Bab ini membahas prinsip pencegahan infeksi, teknik aseptis dan antisepsis, pengendalian infeksi di ruang bersalin, serta edukasi pencegahan infeksi yang efektif.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, lulusan program studi kebidanan diharapkan mampu menerapkan prinsip pencegahan infeksi secara komprehensif dalam praktik persalinan yang profesional dan bertanggung jawab. Lulusan dapat menjamin keselamatan ibu dan bayi melalui upaya pencegahan infeksi yang efektif, memahami aspek hukum dan etika yang terkait dengan pencegahan infeksi, serta mampu melakukan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga guna meningkatkan peran aktif mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan selama masa persalinan dan nifas.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam prinsip dasar pencegahan infeksi dalam pelayanan kebidanan pada proses persalinan.
2. Mahasiswa mampu mempraktikkan teknik aseptis dan antisepsis yang sesuai standar dalam tindakan kebidanan selama persalinan.
3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan langkah-langkah pengendalian infeksi di ruang bersalin untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan higienis.
4. Mahasiswa dapat menyusun dan menyampaikan materi edukasi pencegahan infeksi yang efektif kepada ibu dan keluarga dengan metode komunikasi yang sesuai.
5. Mahasiswa memahami pentingnya integrasi pencegahan infeksi dengan aspek hukum dan etika profesi dalam praktik kebidanan.

Sub-CPMK (Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

1. Sub-CPMK 1: Prinsip Pencegahan Infeksi

- Menjelaskan teori rantai infeksi dan cara memutus rantai tersebut dalam konteks persalinan.
- Menguraikan faktor risiko dan mekanisme penularan infeksi selama persalinan.
- Mengidentifikasi standar kebersihan dan sanitasi yang harus diterapkan oleh tenaga kebidanan.

2. Sub-CPMK 2: Teknik Asepsis dan Antiseptik

- Menjelaskan perbedaan dan tujuan asepsis serta antiseptik dalam tindakan kebidanan.
- mempraktikkan cuci tangan yang benar menurut standar WHO sebelum dan sesudah kontak dengan pasien.
- Mengaplikasikan penggunaan alat pelindung diri (APD) secara tepat selama prosedur persalinan.
- Melakukan preparasi antiseptik pada area genital secara benar sebelum tindakan invasif.

3. Sub-CPMK 3: Pengendalian Infeksi di Ruang Bersalin

- Mendeskripsikan protokol pembersihan dan desinfeksi lingkungan ruang bersalin.
- Menjelaskan pentingnya manajemen limbah medis sesuai regulasi yang berlaku.
- Mengimplementasikan tata ruang dan sirkulasi udara yang mendukung pengendalian infeksi.
- Melakukan skrining awal dan monitoring infeksi pada ibu bersalin.

4. Sub-CPMK 4: Edukasi Pencegahan Infeksi

- Menyusun materi edukasi pencegahan infeksi yang mudah dipahami ibu dan keluarganya.
- Menerapkan teknik komunikasi efektif dan empatik dalam penyuluhan kesehatan.
- Mendorong partisipasi aktif ibu dan keluarga dalam menjaga kebersihan dan mematuhi protokol pencegahan infeksi.
- Menilai efektivitas edukasi yang diberikan melalui feedback dan observasi perilaku ibu.

A. Prinsip Pencegahan Infeksi

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan. Dalam konteks ini, infeksi tidak hanya dapat membahayakan pasien (ibu dan bayi), tetapi juga membahayakan tenaga kesehatan, keluarga pasien, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan infeksi secara konsisten dan sistematis menjadi tanggung jawab penting bagi seluruh praktisi kesehatan, terutama bidan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

Pencegahan infeksi tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kerangka ilmiah yang disebut sebagai rantai infeksi, yaitu serangkaian komponen yang menjelaskan bagaimana infeksi dapat terjadi dan menyebar. Dengan memahami rantai ini, tenaga kesehatan dapat mengintervensi dan memutus salah satu atau beberapa komponen di dalamnya untuk menghentikan transmisi patogen.

1. Rantai Infeksi: Dasar Konseptual Pencegahan

Rantai infeksi terdiri dari enam komponen utama yang membentuk jalur penyebaran mikroorganisme dari satu inang ke inang lainnya:

a. Agen Infeksi (Etiologi)

Agen infeksi adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Dalam pelayanan kebidanan, agen infeksi bisa berupa:

- Bakteri: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *E. coli*
- Virus: *HIV*, *Hepatitis B* dan *C*, *CMV*
- Jamur: *Candida albicans*
- Parasit: *Toxoplasma gondii*

Tingkat virulensi (kemampuan untuk menyebabkan penyakit), daya tahan di lingkungan, dan rute transmisi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan agen infeksi dalam menimbulkan penyakit.

b. Reservoir

Reservoir adalah tempat hidup dan berkembang biaknya agen infeksi. Dalam praktik kebidanan, reservoir dapat berupa:

- Manusia: pasien terinfeksi atau karier asimtomatik
- Lingkungan: tempat tidur, linen, alat medis, tangan tenaga kesehatan
- Benda mati: alat-alat yang tidak disterilkan, permukaan meja, gagang pintu, dan peralatan non-medis

c. Pintu Keluar

Merupakan jalur di mana mikroorganisme meninggalkan reservoir. Contoh:

- Saluran pernapasan (batuk, bersin)
- Saluran pencernaan (feses, muntahan)
- Luka terbuka

- Cairan tubuh: darah, air ketuban, air mani, cairan vagina

Dalam praktik kebidanan, darah nifas, cairan ketuban, dan plasenta merupakan sumber potensial penyebaran infeksi.

d. Cara Transmisi

Mikroorganisme dapat menyebar dari satu inang ke inang lain melalui berbagai cara, antara lain:

- Kontak langsung: sentuhan langsung dengan pasien (misalnya saat melakukan pemeriksaan dalam tanpa sarung tangan steril)
- Kontak tidak langsung: melalui benda atau permukaan yang tercemar
- Droplet: partikel dari batuk/bersin yang mengenai mukosa orang lain
- Airborne: partikel aerosol yang melayang di udara
- Fecal-oral: sering terjadi akibat kebersihan tangan yang buruk
- Vektor: lalat, nyamuk, atau hewan lain (jarang di klinik, tapi tetap penting di komunitas)

e. Pintu Masuk

Setelah melalui transmisi, mikroorganisme harus memasuki tubuh inang melalui:

- Mukosa (mulut, hidung, alat genital)
- Luka terbuka
- Luka insisi pasca operasi
- Saluran napas
- Kateter atau alat invasif

f. Inang yang Rentan

Individu yang memiliki kekebalan tubuh rendah atau terganggu lebih rentan terhadap infeksi. Dalam kebidanan, kelompok rentan meliputi:

- Ibu hamil dan bersalin (karena perubahan imunologis)
- Bayi baru lahir (sistem imun belum matang)
- Lansia, pasien dengan penyakit komorbid, dan imunokompromais

2. Strategi Pencegahan Infeksi: Intervensi terhadap Rantai

Pencegahan infeksi dilakukan dengan mengintervensi komponen rantai infeksi melalui praktik-praktik berikut:

a. Kebersihan Tangan (Hand Hygiene)

Kebersihan tangan adalah langkah paling efektif untuk mencegah transmisi mikroorganisme. WHO menetapkan 5 momen kebersihan tangan:

- Sebelum menyentuh pasien
- Sebelum prosedur aseptik
- Setelah risiko terpapar cairan tubuh
- Setelah menyentuh pasien
- Setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien

Cuci tangan dapat dilakukan dengan sabun dan air mengalir, atau handrub berbasis alkohol (ABHR).

b. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

APD digunakan sebagai penghalang fisik terhadap agen infeksi. Jenis APD antara lain:

- Sarung tangan (steril dan non-steril)
- Masker (bedah atau N95)
- Gaun pelindung
- Pelindung mata/wajah

Penggunaan APD harus sesuai indikasi, dilepas dengan benar, dan dibuang sesuai prosedur.

c. Sterilisasi dan Desinfeksi Alat Medis

- Sterilisasi adalah proses mematikan semua bentuk mikroorganisme, termasuk spora (misalnya dengan autoklaf).
- Desinfeksi digunakan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan atau alat (biasanya dengan cairan kimia seperti klorin, fenol, alkohol).

Peralatan medis yang digunakan berulang kali harus melalui siklus dekontaminasi sesuai standar WHO/Kemenkes.

d. Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan

Lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan harus bebas dari kuman. Ini meliputi:

- Pembersihan permukaan yang sering disentuh (meja, pegangan, tempat tidur)
- Pengelolaan linen (termasuk pakaian kerja)
- Ventilasi ruangan yang baik (untuk menghindari penumpukan aerosol)
- Pengelolaan limbah medis yang aman dan terpisah

e. Pemantauan dan Identifikasi Dini

- Pasien yang dicurigai mengalami infeksi harus segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat.
- Gunakan sistem triase untuk memisahkan pasien infeksius dari pasien lainnya.
- Lakukan surveillance infeksi berkala di fasilitas kesehatan.

f. Edukasi dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan harus diberikan pelatihan berkala tentang:

- Pencegahan infeksi
- Teknik aseptik dan antiseptik
- Penggunaan APD yang benar
- Manajemen limbah medis

g. Aplikasi dalam Konteks Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, pencegahan infeksi sangat penting karena:

- Prosedur kebidanan sering melibatkan kontak langsung dengan cairan tubuh (vagina, darah, plasenta, urin)
- Persalinan dan perawatan neonatal memiliki risiko tinggi terhadap infeksi silang
- Banyak prosedur invasif dilakukan (IV line, kateter, periksa dalam, episiotomi, dll.)

Contoh penerapan:

- Saat melakukan periksa dalam, bidan harus mencuci tangan, memakai sarung tangan steril, dan membersihkan area perineum dengan antiseptik.
- Setelah melahirkan, perawatan luka perineum harus dilakukan dengan teknik bersih.
- Bayi baru lahir harus dikeringkan dengan kain bersih, dan IMD dilakukan dengan memperhatikan kebersihan kulit ibu.

B. Teknik Asepsis dan Antiseptis

Dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan, pengendalian infeksi merupakan salah satu aspek paling krusial yang menentukan keselamatan ibu dan bayi. Infeksi dapat terjadi dalam berbagai tahapan pelayanan—baik saat pemeriksaan, persalinan, tindakan invasif, hingga perawatan nifas. Untuk itu, tenaga kesehatan wajib menerapkan dua strategi utama untuk mencegah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh pasien maupun lingkungan perawatan, yaitu asepsis dan antiseptis. Kedua teknik ini merupakan bagian dari praktik kendali infeksi yang wajib dilakukan secara konsisten, berulang, dan sesuai standar prosedur operasional (SPO). Dengan penerapan yang tepat, risiko infeksi nosokomial dan komplikasi postpartum dapat diminimalkan secara signifikan.

1. Pengertian dan Perbedaan Asepsis dan Antiseptis

a. Asepsis

Asepsis berasal dari kata “a-” (tidak) dan “sepsis” (infeksi), yang berarti bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Teknik asepsis mencakup seluruh prosedur untuk:

- Mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh pasien.
- Menjaga lingkungan perawatan dan peralatan tetap steril.
- Menghindari kontaminasi silang antar pasien, alat, dan petugas kesehatan.

Asepsis dibedakan menjadi:

- Asepsis Medis (*Clean Technique*): digunakan dalam tindakan non-invasif, seperti penggantian perban, injeksi, atau perawatan umum.
- Asepsis Bedah (*Surgical Asepsis*): digunakan dalam prosedur yang menembus jaringan steril tubuh, seperti persalinan, episiotomi, atau operasi caesar.

b. Antisepsis

Antisepsis adalah proses membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen yang berada pada jaringan hidup. Antisepsis dilakukan dengan penggunaan antiseptik, yaitu zat kimia yang aman untuk jaringan tubuh, contohnya:

- Povidon Iodin (Betadine)
- Klorheksidin
- Alkohol 70%

Antisepsis biasanya dilakukan sebelum tindakan medis pada kulit, misalnya sebelum insisi, sebelum injeksi, atau membersihkan area genital sebelum tindakan obstetri.

2. Komponen Penting Teknik Asepsis dalam Kebidanan

a. Cuci Tangan (Hand Hygiene)

Merupakan langkah paling awal dan paling penting dalam mencegah kontaminasi. Tindakan ini harus dilakukan:

- Sebelum dan sesudah kontak dengan pasien
- Sebelum prosedur invasif
- Setelah kontak dengan cairan tubuh atau alat medis

Gunakan sabun antiseptik dan air mengalir, atau handrub berbasis alkohol. Dalam prosedur asepsis bedah, cuci tangan dilakukan dengan teknik "scrub" minimal 3–5 menit.

b. Penggunaan Sarung Tangan Steril

Sarung tangan berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap mikroorganisme. Dalam tindakan seperti pemeriksaan dalam, pemasangan kateter, episiotomi, atau penjahitan luka, sarung tangan steril harus digunakan. Jangan menyentuh benda yang tidak steril setelah mengenakan sarung tangan steril.

c. Sterilisasi dan Disinfeksi Alat

Semua alat yang akan bersentuhan langsung dengan jaringan steril harus melalui proses sterilisasi. Alat-alat seperti gunting, spekulum, benang, dan jarum harus disterilkan menggunakan autoklaf (uap panas bertekanan tinggi) atau metode kimia untuk alat tertentu.

Jenis sterilisasi:

- Autoklaf (121–134°C)
- Sterilisasi kimia (etilen oksida, glutaraldehid)
- Sterilisasi panas kering (oven)

d. Pengaturan Ruang Bersalin

Ruang tindakan harus bersih dan steril:

- Lantai dibersihkan setiap hari dan setelah prosedur.
- Meja tindakan dilap menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
- Peralatan harus ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi kontaminasi silang.

3. Komponen Penting Teknik Antisepsis dalam Kebidanan

a. Pembersihan Area Genital

Sebelum tindakan seperti pemeriksaan vaginal, pemasangan vakum, atau episiotomi, area genital harus dibersihkan dengan larutan antiseptik (seperti povidon iodine 10%) dengan gerakan menjauh dari pusat ke arah luar, dan tidak bolak-balik untuk menghindari kontaminasi ulang.

b. Antisepsis Kulit

Sebelum pemberian suntikan atau infus, kulit dibersihkan dengan kapas alkohol 70%. Biarkan antiseptik kering sebelum tindakan dilakukan agar efektivitasnya maksimal.

c. Perawatan Luka Perineum atau Luka Operasi

Luka pasca persalinan normal (episiotomi) maupun operasi caesar harus dirawat menggunakan larutan antiseptik sesuai instruksi medis. Penggunaan antiseptik tidak boleh berlebihan agar tidak merusak jaringan granulasinya

d. Kesalahan Umum dan Risiko Kontaminasi

Walau teknik aseptis dan antisepsis telah dikenal luas, dalam praktiknya sering terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kontaminasi, seperti:

- Menyentuh benda non-steril dengan sarung tangan steril
- Meletakkan alat steril di permukaan yang tidak bersih
- Tidak mengganti APD antara satu pasien ke pasien lainnya
- Menggunakan antiseptik yang telah kadaluwarsa atau terkontaminasi

Penting bagi tenaga kebidanan untuk selalu waspada terhadap kesalahan ini dan rutin mengikuti pelatihan peningkatan mutu pelayanan dan kendali infeksi.

e. Peran Bidan dalam Implementasi Teknik Asepsis dan Antisepsis

Sebagai praktisi yang sering melakukan tindakan langsung terhadap ibu dan bayi, bidan harus:

- Menjadi contoh dalam penerapan teknik asepsis
- Mengedukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya kebersihan
- Melaporkan kejadian infeksi atau kontaminasi untuk segera dievaluasi
- Mengikuti protokol yang berlaku dan memperbaharui ilmu pengetahuan melalui pelatihan atau seminar

C. Pengendalian Infeksi di Ruang Bersalin

Ruang bersalin merupakan salah satu area paling kritis dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam praktik kebidanan. Proses persalinan secara alamiah melibatkan keluarnya cairan tubuh seperti darah, air ketuban, dan sekret vaginal, serta melibatkan prosedur medis yang sering kali invasif. Semua ini meningkatkan risiko terjadinya infeksi nosokomial infeksi yang terjadi di fasilitas kesehatan dan bukan merupakan infeksi yang sudah ada saat pasien masuk.

Oleh karena itu, ruang bersalin harus dikelola secara ketat dengan menerapkan standar kebersihan dan sterilisasi yang tinggi untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang antara pasien, tenaga kesehatan, alat medis, dan lingkungan. Pengendalian infeksi di ruang bersalin merupakan tanggung jawab bersama, yang harus dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.

1. Komponen Utama Pengendalian Infeksi di Ruang Bersalin

a. Pembersihan dan Desinfeksi Rutin

Ruang bersalin harus dibersihkan secara berkala, baik sebelum, selama, maupun setelah proses persalinan. Pembersihan tidak hanya menyasar permukaan yang terlihat kotor, tetapi juga seluruh area berisiko tinggi seperti:

- Meja tindakan
- Tempat tidur bersalin
- Lantai sekitar area persalinan
- Peralatan non-medis (kursi, alat penyangga kaki, dll.)

Pembersihan dilakukan menggunakan larutan disinfektan dengan spektrum luas seperti sodium hipoklorit (NaClO) 0,5%. Tindakan ini penting untuk menurunkan jumlah mikroorganisme yang mungkin menjadi sumber infeksi.

b. Pengaturan Ventilasi dan Sirkulasi Udara

Ventilasi ruangan memiliki peran besar dalam menurunkan konsentrasi mikroorganisme patogen di udara. Udara yang tidak bersirkulasi dapat menjadi medium penyebaran bakteri dan virus, terutama bila droplet dari pasien terkontaminasi terdispersi di udara.

Beberapa standar penting:

- Ventilasi alami (jendela) dan mekanik (exhaust fan) harus berfungsi optimal.
- Hindari penggunaan kipas angin yang menghembuskan udara dari satu pasien ke pasien lain.
- Idealnya, sistem ventilasi mendukung tekanan negatif untuk kasus infeksius (misalnya ibu dengan tuberkulosis).

c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Setiap tenaga kesehatan yang memasuki ruang bersalin harus mengenakan APD yang sesuai. Jenis APD yang digunakan bergantung pada prosedur yang dilakukan dan risiko paparan. Pada persalinan normal maupun tindakan obstetrik, umumnya diperlukan:

- Sarung tangan steril
- Masker bedah (atau N95 jika risiko airborne)
- Gaun pelindung tahan air
- Pelindung wajah atau kaca mata pelindung

Penggunaan APD ini melindungi tenaga kesehatan dari paparan langsung terhadap cairan tubuh dan mencegah transmisi silang antar pasien.

d. Sterilisasi dan Penyimpanan Alat Medis

Semua alat yang digunakan untuk tindakan invasif dalam proses persalinan harus dalam kondisi steril. Prinsip dasar yang harus dipatuhi meliputi:

- Alat seperti gunting episiotomi, spekulum, klem tali pusat, dan benang jahit harus disterilkan dengan autoklaf.
- Setelah digunakan, alat harus dicuci, direndam dengan larutan dekontaminasi, lalu disterilkan kembali sebelum digunakan pada pasien lain.
- Alat steril harus disimpan di tempat tertutup dan bersih, serta diberi label tanggal kedaluwarsa.

Kegagalan dalam proses sterilisasi akan meningkatkan risiko infeksi serius pada ibu dan bayi, seperti sepsis atau tetanus neonatorum.

e. Pengelolaan Limbah Medis yang Benar

Limbah medis di ruang bersalin seperti kain bersalin yang berlumur darah, sarung tangan bekas pakai, plasenta, dan alat sekali pakai harus ditangani sesuai protokol limbah infeksius. Standar pengelolaan limbah meliputi:

- Pemisahan limbah berdasarkan warna kantong (kuning untuk infeksius, merah untuk tajam)
- Pengumpulan dan pengangkutan limbah dengan wadah tertutup
- Penyimpanan sementara di tempat aman dan tidak terjangkau publik
- Penghancuran akhir oleh insinerator atau pihak ketiga berizin

Kesalahan dalam pengelolaan limbah tidak hanya membahayakan pasien dan tenaga kesehatan, tetapi juga lingkungan dan masyarakat sekitar.

f. Skrining Ibu terhadap Penyakit Infeksius

Sebelum proses persalinan dimulai, penting untuk melakukan skrining pada ibu terhadap infeksi, seperti:

- Infeksi saluran kemih
- Hepatitis B dan C
- HIV

- Tuberkulosis
- Infeksi menular seksual (IMS)

Jika ditemukan kondisi infeksius, tindakan persalinan dan penanganan pasca persalinan harus disesuaikan, misalnya dengan isolasi pasien, penggunaan APD tambahan, dan profilaksis untuk bayi.

g. Penerapan Protokol Ketat selama Proses Persalinan

Seluruh tindakan di ruang bersalin harus mengikuti SOP dan pedoman standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup:

- Teknik aseptik dan antiseptik dalam setiap prosedur
- Pembatasan jumlah orang di ruang bersalin untuk menghindari kontaminasi silang
- Pencatatan dan pelaporan kejadian infeksi (surveillance infeksi)
- Pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan tentang kontrol infeksi

h. Penerapan dalam Konteks Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki peran sentral dalam menjaga pengendalian infeksi di ruang bersalin. Tindakan-tindakan berikut harus menjadi bagian dari rutinitas profesional:

- Memastikan semua alat siap dalam kondisi steril sebelum tindakan
- Mengganti APD setelah tiap prosedur atau kontak dengan pasien
- Melakukan hand hygiene dengan benar sebelum dan sesudah setiap prosedur
- Mendokumentasikan prosedur kebersihan yang telah dilakukan
- Memberi edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai kebersihan dan bahaya infeksi

D. Edukasi Pencegahan Infeksi

Infeksi pascapersalinan merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu strategi utama yang terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian infeksi adalah edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarganya. Edukasi ini bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi merupakan proses membangun pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku menuju praktik hidup bersih dan sehat yang berkelanjutan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu pascapersalinan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi secara menyeluruh, personal, dan komunikatif. Edukasi harus diberikan sedini mungkin, dimulai sejak masa kehamilan trimester akhir, saat ibu dirawat pasca persalinan, hingga masa nifas.

1. Tujuan Edukasi Pencegahan Infeksi

Tujuan utama dari edukasi pencegahan infeksi adalah untuk:

- Meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga tentang risiko dan mekanisme infeksi.
- Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya kebersihan diri dan lingkungan.
- Membentuk kemandirian ibu dalam melakukan perawatan diri setelah persalinan.
- Memberikan kemampuan deteksi dini tanda-tanda infeksi.
- Mengurangi angka rujukan dan perawatan ulang akibat infeksi yang dapat dicegah.

2. Materi Edukasi Pencegahan Infeksi

Edukasi harus mencakup berbagai aspek penting yang relevan dengan kondisi ibu dan bayi setelah persalinan. Beberapa materi utama yang harus disampaikan adalah:

a. Kebersihan Diri Ibu

Kebersihan tubuh secara keseluruhan sangat penting, terutama di masa nifas ketika tubuh sedang dalam proses pemulihan dan sangat rentan terhadap infeksi.

- Ibu dianjurkan untuk mandi setiap hari dengan air bersih dan sabun.
- Area genital harus dibersihkan dari depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi bakteri dari anus.
- Penggunaan pakaian dalam berbahan katun dan diganti secara berkala juga disarankan.

b. Perawatan Luka Persalinan

Jika ibu mengalami episiotomi atau luka jahitan perineum, maka perawatan luka harus menjadi fokus utama.

- Luka harus dijaga tetap kering dan bersih.
- Setelah buang air, area perineum dibersihkan dan dikeringkan dengan lembut, tidak digosok.
- Larutan antiseptik ringan dapat digunakan jika dianjurkan oleh tenaga kesehatan.
- Ibu juga harus diajari cara mengenali tanda-tanda infeksi pada luka, seperti nyeri berlebihan, bengkak, kemerahan, keluar nanah, atau bau tidak sedap.

c. Penggantian Pembalut Nifas

Darah nifas (lochia) adalah cairan alami pasca persalinan, namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber infeksi.

- Pembalut nifas harus diganti minimal setiap 4–6 jam atau setiap kali terasa basah.
- Cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut.
- Pembalut bekas dibuang di tempat sampah tertutup.

- Edukasi ini sangat penting karena kebiasaan membiarkan pembalut terlalu lama dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri.

d. Cuci Tangan yang Benar

Kebersihan tangan merupakan salah satu kunci pencegahan infeksi yang sangat penting namun sering diabaikan.

- Ibu dan anggota keluarga harus diajari 5 momen penting mencuci tangan:
 - Sebelum makan
 - Setelah dari toilet
 - Sebelum menyusui bayi
 - Setelah mengganti pembalut nifas
 - Setelah membersihkan luka
- Teknik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik perlu dipraktikkan secara langsung.

e. Pola Makan dan Nutrisi yang Mendukung Imunitas

Pemulihan ibu sangat dipengaruhi oleh status gizi. Gizi yang buruk dapat menyebabkan lambatnya proses penyembuhan luka dan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi.

- Berikan edukasi tentang pentingnya konsumsi makanan tinggi protein, zat besi, vitamin C, dan cairan.
- Sayuran hijau, buah segar, daging tanpa lemak, telur, dan susu merupakan sumber nutrisi penting selama masa nifas.
- Edukasi juga mencakup konsumsi suplemen yang diresepkan, seperti zat besi, jika diperlukan.

3. Pengenalan Tanda dan Gejala Infeksi

Salah satu komponen penting edukasi adalah mengenalkan tanda-tanda infeksi agar ibu dapat melakukan deteksi dini dan mencari pertolongan dengan cepat. Beberapa tanda infeksi yang perlu diwaspadai antara lain:

- Demam $>38^{\circ}\text{C}$ selama lebih dari 24 jam
- Nyeri berlebihan pada perut bawah
- Keputihan atau cairan berbau dari jalan lahir
- Luka jahitan bernanah atau bengkak
- Nyeri saat buang air kecil

4. Metode Penyampaian Edukasi

Penyampaian edukasi yang efektif harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Tidak cukup hanya dengan memberi instruksi lisan, melainkan dengan metode yang dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.

Beberapa metode yang dapat digunakan:

- Edukasi langsung saat kunjungan rumah atau rawat inap
- Media visual seperti poster, leaflet, atau flipchart

- Demonstrasi langsung, misalnya cara mencuci tangan atau merawat luka
- Video edukasi pendek yang dapat ditonton ibu melalui HP
- Keterlibatan keluarga, terutama suami atau ibu mertua, agar mendukung praktik pencegahan infeksi

5. Prinsip Komunikasi dalam Edukasi

Agar edukasi berhasil, penyampaian harus:

- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
- Diberikan dengan sikap empatik dan tidak menghakimi
- Disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan budaya lokal
- Melibatkan ibu secara aktif (bukan hanya pasif menerima informasi)
- Diberikan secara berulang dan konsisten, bukan sekali lalu selesai

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1 Analisis Rantai Infeksi dalam Praktik Kebidanan

Soal:

Jelaskan secara rinci satu contoh kasus infeksi nosokomial yang dapat terjadi dalam praktik kebidanan. Identifikasi seluruh komponen rantai infeksi dalam kasus tersebut, dan jelaskan intervensi pencegahan yang dapat dilakukan pada setiap titik rantai untuk menghentikan penyebaran infeksi.

Tugas 2 – SOP Pencegahan Infeksi di Ruang Bersalin

Soal:

Susunlah sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) singkat (maks. 2 halaman) tentang pengendalian infeksi di ruang bersalin, mulai dari pembersihan lingkungan, ventilasi, penggunaan APD, hingga penanganan limbah medis. Sertakan langkah-langkah teknis dan alasan ilmiah dari setiap tindakan dalam SOP tersebut.

Tugas 3 – Simulasi Edukasi Pencegahan Infeksi untuk Ibu Nifas

Soal:

Buatlah naskah simulasi edukasi (dialog) antara bidan dan ibu pascapersalinan terkait pencegahan infeksi di rumah. Materi yang disampaikan harus mencakup:

- Kebersihan perineum
- Penggantian pembalut nifas
- Cuci tangan yang benar
- Nutrisi untuk imunitas

Tuliskan minimal 10 dialog edukatif, komunikatif, dan empatik.

Tugas 4 – Studi Observasi Teknik Asepsis dan Antisepsis

Soal:

Lakukan observasi di lahan praktik atau berdasarkan simulasi video tentang tindakan periksa dalam oleh bidan. Identifikasi:

- Teknik asepsis dan antisepsis yang dilakukan
- Potensi risiko kontaminasi yang terjadi
- Saran perbaikan prosedur agar sesuai standar Kemenkes

Tuliskan hasil observasimu dalam bentuk narasi dan tabel checklist.

Tugas 5 – Rencana Pelatihan Pencegahan Infeksi untuk Kader Kesehatan

Soal:

Rancanglah rencana pelatihan singkat (mini-training) selama 1 hari untuk kader kesehatan tentang pencegahan infeksi ibu dan bayi di komunitas. Rencana pelatihan harus mencakup:

- Tujuan pelatihan
- Materi utama
- Metode penyampaian (misalnya demonstrasi, diskusi)
- Alat bantu/media
- Evaluasi pasca pelatihan

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu, usia 26 tahun, P1A0, hari ke-3 pascapersalinan normal dengan episiotomi, mengeluh nyeri hebat di perineum. Saat diperiksa, luka jahitan tampak kemerahan, sedikit bengkak, dan mengeluarkan cairan kuning berbau. Petugas diketahui belum menggunakan sarung tangan saat mengganti balutan luka sebelumnya.

Apa kemungkinan penyebab utama dari kondisi infeksi ini?

- A. Tidak adanya antibiotik profilaksis setelah persalinan
- B. Ketidakpatuhan ibu dalam mengganti pembalut nifas
- C. Proses sterilisasi alat jahit yang tidak sempurna
- D. Kontaminasi silang akibat tidak menggunakan APD
- E. Penundaan kontrol pasca persalinan ke fasilitas kesehatan

2. Seorang ibu 30 tahun menjalani tindakan periksa dalam karena pembukaan belum lengkap. Beberapa menit kemudian, bidan melakukan prosedur yang sama ke pasien berikutnya tanpa mencuci tangan dan mengganti sarung tangan.

Apa yang dilanggar oleh bidan tersebut berdasarkan prinsip pencegahan infeksi?

- A. Edukasi ibu dan keluarga
 - B. Teknik antisepsis pada perineum
 - C. Prosedur sterilisasi alat
 - D. 5 momen kebersihan tangan WHO
 - E. Teknik aseptis bedah
3. Seorang bidan sedang menyiapkan alat untuk tindakan episiotomi. Ia menemukan bahwa klem dan gunting belum melalui proses sterilisasi, dan hanya direndam dalam larutan antiseptik ringan.
- Apa risiko yang dapat ditimbulkan jika alat tersebut tetap digunakan?
- A. Perdarahan pascapersalinan
 - B. Alergi terhadap antiseptik
 - C. Infeksi silang dan sepsis
 - D. Luka tidak dapat dijahit rapi
 - E. Nyeri perineum pascapersalinan
4. Seorang bayi baru lahir dirawat di ruang perawatan neonatal. Perawat yang memegang bayi tersebut diketahui tidak mencuci tangan setelah menangani luka perineum pasien sebelumnya. Keesokan harinya, bayi menunjukkan gejala demam dan letargi.
- Komponen rantai infeksi mana yang paling mungkin menyebabkan kondisi bayi tersebut?
- A. Agen infeksi
 - B. Reservoir
 - C. Cara transmisi
 - D. Pintu masuk
 - E. Inang yang rentan
5. Dalam sesi edukasi, seorang ibu nifas bertanya mengapa ia harus mengganti pembalut nifas secara teratur, meskipun tidak terlihat sangat basah.
- Apa jawaban edukatif yang paling tepat dari bidan?
- A. Karena pembalut yang lama membuat rasa tidak nyaman saat duduk
 - B. Agar luka episiotomi cepat sembuh
 - C. Untuk mencegah bau yang tidak sedap dari darah nifas
 - D. Karena bisa menyebabkan iritasi kulit
 - E. Karena darah nifas dapat menjadi media tumbuh mikroorganisme

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Tidak menggunakan APD seperti sarung tangan saat menangani luka sangat berisiko menyebabkan kontaminasi silang. Hal ini menunjukkan pelanggaran prinsip aseptis dan antisepsis, dan menjadi faktor utama penyebab infeksi luka perineum.

2. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Melakukan kontak dengan pasien tanpa cuci tangan dan mengganti APD melanggar prinsip "5 Momen Kebersihan Tangan" WHO, terutama pada poin setelah kontak dengan pasien dan sebelum kontak dengan pasien baru.

3. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Alat medis untuk prosedur invasif seperti episiotomi wajib disterilkan. Hanya merendam dalam antiseptik tidak cukup. Jika digunakan, risiko infeksi silang dan bahkan sepsis sangat tinggi.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Cara transmisi adalah jalur perpindahan patogen dari satu individu ke individu lain. Dalam kasus ini, transmisi terjadi akibat tangan petugas yang tercemar, sehingga bayi (inang yang rentan) terpapar agen infeksi.

5. Kunci Jawaban: E

Pembahasan: Darah nifas (lochia) merupakan medium yang kaya protein dan sangat mudah menjadi tempat pertumbuhan bakteri. Mengganti pembalut secara rutin penting untuk mencegah infeksi, terutama pada masa awal nifas.

Rangkuman Materi

Infeksi merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian dalam pelayanan kesehatan, terutama pada ibu dan bayi dalam praktik kebidanan. Oleh karena itu, pencegahan infeksi menjadi tanggung jawab krusial tenaga kesehatan, terutama bidan, yang berada di garis depan pelayanan maternal-neonatal. Pencegahan infeksi didasarkan pada konsep ilmiah yang disebut rantai infeksi, yang terdiri dari enam komponen: agen infeksi, reservoir, pintu keluar, cara transmisi, pintu masuk, dan inang yang rentan. Intervensi pada salah satu atau lebih komponen rantai ini dapat menghentikan penyebaran patogen.

Agen infeksi bisa berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit yang memiliki virulensi tinggi. Reservoir dapat berupa manusia, lingkungan, atau benda mati yang terkontaminasi. Pintu keluar dan masuk mikroorganisme meliputi cairan tubuh, luka, atau mukosa tubuh. Transmisi infeksi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, melalui kontak, udara, droplet, atau fecal-oral. Kelompok rentan termasuk ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi

baru lahir yang memiliki imunitas rendah. Strategi pencegahan infeksi mencakup praktik hand hygiene sesuai standar WHO, penggunaan alat pelindung diri (APD) secara tepat, sterilisasi dan desinfeksi alat medis, serta sanitasi lingkungan pelayanan. Penting juga dilakukan pemantauan infeksi, skrining, dan deteksi dini pada pasien serta pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan untuk menjaga kompetensi dalam pencegahan infeksi.

Dalam praktik kebidanan, tindakan pencegahan infeksi sangat penting karena proses persalinan dan asuhan neonatal melibatkan kontak langsung dengan cairan tubuh dan prosedur invasif. Teknik aseptis dan antisepsis harus diterapkan dalam setiap prosedur, baik untuk menjaga kebersihan alat maupun permukaan kulit pasien. Asepsis bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan dari mikroorganisme, sementara antisepsis menggunakan zat kimia untuk membunuh mikroorganisme di jaringan hidup.

Teknik aseptis mencakup cuci tangan yang benar, penggunaan sarung tangan steril, sterilisasi alat, dan penataan ruang tindakan. Sementara teknik antisepsis melibatkan pembersihan area genital, kulit, dan luka pascapersalinan dengan antiseptik yang sesuai. Risiko kontaminasi dapat terjadi akibat kelalaian, seperti menyentuh benda non-steril dengan sarung tangan steril atau tidak mengganti APD antar pasien. Oleh sebab itu, pengawasan dan pembaruan pengetahuan tenaga kebidanan sangat penting.

Pengendalian infeksi di ruang bersalin melibatkan pembersihan dan desinfeksi berkala, pengaturan ventilasi yang baik, penggunaan APD sesuai prosedur, sterilisasi alat secara ketat, dan pengelolaan limbah medis yang aman. Ruang bersalin juga harus menerapkan protokol ketat dan skrining ibu terhadap penyakit infeksius sebelum tindakan persalinan dilakukan. Pencegahan infeksi harus menjadi budaya kerja di lingkungan pelayanan kesehatan yang melibatkan semua pihak. Selain tindakan klinis, edukasi kepada ibu dan keluarga juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan infeksi. Edukasi diberikan sejak masa kehamilan hingga masa nifas, mencakup kebersihan diri, perawatan luka, cara mengganti pembalut nifas, cuci tangan, pemenuhan nutrisi, serta pengenalan tanda dan gejala infeksi. Metode edukasi harus disesuaikan dengan kondisi ibu, menggunakan pendekatan komunikatif, visual, demonstratif, serta melibatkan keluarga agar terjadi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, penerapan prinsip pencegahan infeksi secara konsisten dapat menurunkan risiko komplikasi infeksi, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, serta memperkuat mutu pelayanan kebidanan di semua tatanan layanan.

Glosarium

Agen infeksi: Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit.

Airborne: Cara penyebaran infeksi melalui partikel kecil di udara yang dapat terhirup oleh inang rentan.

Antisepsis: Proses menghambat atau membunuh mikroorganisme patogen yang berada pada jaringan hidup menggunakan bahan kimia antiseptik.

Asepsis: Tindakan untuk menjaga lingkungan dan alat tetap bebas dari mikroorganisme patogen agar tidak terjadi kontaminasi.

Autoklaf: Alat sterilisasi yang menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisme, termasuk spora.

Bidan: Tenaga kesehatan profesional yang memberikan asuhan kebidanan sebelum, selama, dan sesudah persalinan, termasuk tanggung jawab dalam pencegahan infeksi.

Cairan tubuh: Cairan seperti darah, air ketuban, air mani, dan cairan vagina yang dapat menjadi media penyebaran infeksi.

Desinfeksi: Proses untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen pada permukaan benda dengan menggunakan bahan kimia tertentu.

Droplet: Percikan kecil cairan dari saluran napas (batuk/bersin) yang mengandung patogen dan dapat menyebabkan infeksi jika masuk ke mukosa orang lain.

Hand hygiene (kebersihan tangan): Tindakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau handrub berbasis alkohol untuk mencegah penyebaran infeksi.

Inang yang rentan: Orang yang daya tahan tubuhnya rendah dan mudah terinfeksi, seperti ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir.

Infeksi nosokomial: Infeksi yang didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya tidak ada saat pasien masuk.

Kateter: Alat medis berbentuk tabung kecil yang digunakan untuk mengalirkan cairan ke dalam atau keluar tubuh, dan dapat menjadi pintu masuk infeksi.

Kontak langsung: Transmisi patogen dari satu individu ke individu lain melalui sentuhan fisik langsung.

Kontak tidak langsung: Transmisi patogen melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi.

Lokia: Cairan yang keluar dari jalan lahir pasca persalinan yang terdiri dari darah, lendir, dan jaringan rahim, berpotensi menjadi media infeksi jika tidak dikelola dengan baik.

Patogen: Mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit.

Pintu keluar: Jalur yang digunakan oleh mikroorganisme untuk keluar dari tubuh inang, seperti melalui darah atau cairan tubuh.

Pintu masuk: Jalur tempat masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh inang, seperti melalui luka, saluran napas, atau mukosa.

Reservoir: Tempat hidup dan berkembang biaknya mikroorganisme patogen, bisa berupa manusia, lingkungan, atau benda mati.

Rantai infeksi: Serangkaian komponen yang menjelaskan proses penyebaran infeksi dari satu inang ke inang lain.

Sanitasi: Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas untuk mencegah penyebaran penyakit.

Skrining: Pemeriksaan awal untuk mendeteksi adanya kondisi atau infeksi tertentu sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

Sterilisasi: Proses membunuh semua bentuk mikroorganisme termasuk spora pada alat atau bahan medis.

Teknik aseptik: Prosedur yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dan tindakan tetap steril guna mencegah infeksi.

Teknik antiseptik: Prosedur menggunakan bahan kimia pada jaringan hidup untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

Transmisi: Proses penularan mikroorganisme dari satu inang ke inang lainnya.

Triase: Sistem pemisahan pasien berdasarkan tingkat kebutuhan perawatan, termasuk memisahkan pasien infeksius dari pasien lainnya.

Ventilasi: Sistem sirkulasi udara dalam ruangan untuk menjaga kebersihan udara dan mencegah penumpukan mikroorganisme di ruang tertutup.

Virulensi: Kemampuan suatu mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit pada inang yang rentan.

Daftar Pustaka

- Ayliffe, G. A. J., Fraise, A. P., Geddes, A. M., & Mitchell, K. (2000). *Control of hospital infection: A practical handbook* (4th ed.). Arnold Publishers.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). *Infection control in healthcare settings*. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/>
- Depkes RI. (2019). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Djuhaeni, H., & Suryani, S. (2020). Edukasi ibu post partum tentang pencegahan infeksi luka perineum. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 6(1), 24–31. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i1.26003>
- Hugonnet, S., Harbarth, S., Sax, H., Duncan, R. A., & Pittet, D. (2004). Nursing resources: A major determinant of nosocomial infection? *Current Opinion in Infectious Diseases*, 17(4), 329–333. <https://doi.org/10.1097/00001432-200408000-00013>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Buku Panduan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
- Manuaba, I. B. G. (2010). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Maryunani, A. (2014). *Infeksi Nosokomial*. Jakarta: Trans Info Media.
- Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. R. (2020). *Clinical nursing skills and techniques* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Pusdik SDM Kesehatan. (2020). *Modul Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk Tenaga Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Setiawan, E., & Sari, R. M. (2021). Upaya pencegahan infeksi nosokomial melalui peningkatan kepatuhan hand hygiene perawat. *Jurnal Keperawatan Terapan*, 7(2), 88–96. <https://doi.org/10.31290/jkt.v7i2.2531>
- Suryani, E., & Pratiwi, R. (2018). Efektivitas pelatihan teknik antiseptik pada praktik bidan desa. *Jurnal Bidan Komunitas*, 1(2), 85–92.
- World Health Organization. (2009). *WHO guidelines on hand hygiene in health care: First global patient safety challenge clean care is safer care*. <https://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/>
- World Health Organization. (2016). *Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/251730>

Bab 10

Mutu dan Keselamatan Dalam Praktik Kebidanan Persalinan

Mutu dan keselamatan dalam praktik kebidanan persalinan merupakan aspek kritikal yang menjamin keamanan ibu dan bayi selama proses persalinan. Bidan sebagai penyedia layanan kesehatan primer bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan yang aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam bab ini akan dibahas mengenai keselamatan pasien dalam praktik kebidanan, audit klinis persalinan, manajemen risiko kebidanan, serta Continuous Quality Improvement (CQI).

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam praktik kebidanan persalinan.
2. Mampu melakukan audit klinis untuk mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan.
3. Mampu mengelola risiko dalam praktik kebidanan persalinan secara efektif.
4. Mampu menerapkan Continuous Quality Improvement (CQI) dalam praktik kebidanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep keselamatan pasien dalam praktik kebidanan.
2. Mahasiswa mampu melakukan audit klinis persalinan untuk evaluasi mutu pelayanan.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam praktik kebidanan.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan CQI dalam praktik kebidanan.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)

1. Mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan prinsip keselamatan pasien.
2. Mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah audit klinis persalinan.
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola risiko dalam praktik kebidanan persalinan.
4. Mahasiswa mampu menerapkan proses CQI secara efektif di lingkungan kerja.

A. Keselamatan Pasien dalam Praktik Kebidanan

Keselamatan pasien merupakan salah satu prinsip paling penting dalam praktik kebidanan yang bertujuan melindungi ibu dan bayi dari berbagai risiko yang dapat menimbulkan cedera, komplikasi, atau bahkan kematian selama proses persalinan. Dalam praktik kebidanan, keselamatan pasien melibatkan pendekatan komprehensif yang meliputi beberapa aspek penting, antara lain identifikasi pasien secara tepat, komunikasi efektif antar tim kesehatan, manajemen pengobatan yang cermat, pengendalian infeksi yang ketat, serta perhatian terhadap aspek psikologis pasien.

1. Identifikasi Pasien yang Akurat

Identifikasi pasien yang akurat merupakan langkah pertama dan mendasar dalam memastikan keselamatan pasien. Sebelum setiap tindakan medis atau intervensi klinis, tenaga kebidanan wajib melakukan verifikasi terhadap identitas pasien dengan menggunakan minimal dua identitas pasien seperti nama lengkap dan tanggal lahir. Tujuan utama dari langkah ini adalah memastikan bahwa setiap tindakan medis tepat sasaran dan menghindari kesalahan prosedur yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun bayi.

2. Komunikasi Efektif Antar Tim Kesehatan

Komunikasi yang efektif antara tim kesehatan merupakan fondasi penting dalam menjaga keselamatan pasien. Dalam konteks kebidanan, komunikasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu mampu mencegah terjadinya kesalahan akibat miskomunikasi. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mencapai komunikasi efektif adalah metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Metode SBAR membantu tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi secara sistematis, dimulai dengan menjelaskan situasi terkini pasien (Situation), latar belakang kondisi pasien (Background), hasil pengkajian terkini (Assessment), serta rekomendasi tindakan yang diperlukan (Recommendation). Pendekatan komunikasi yang terstruktur ini memastikan informasi klinis yang kritis dapat disampaikan dengan baik dan dipahami oleh seluruh anggota tim.

3. Manajemen Obat yang Cermat

Pengelolaan obat yang cermat adalah bagian esensial dalam keselamatan pasien. Dalam praktik kebidanan, manajemen obat yang efektif harus memperhatikan prinsip "5 benar", yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute pemberian. Prinsip ini penting diterapkan agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat seperti overdosis, underdosis, pemberian obat kepada pasien yang salah, atau pemberian melalui jalur pemberian yang salah. Kepatuhan pada prinsip ini sangat penting guna mencegah terjadinya efek samping atau komplikasi serius yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi.

4. Pengendalian Infeksi yang Ketat

Pengendalian infeksi merupakan komponen penting lain yang berhubungan erat dengan keselamatan pasien. Praktik pengendalian infeksi mencakup beberapa tindakan pencegahan penting, seperti menjaga kebersihan tangan secara konsisten dengan prosedur cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, sterilisasi alat medis dengan benar, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat sesuai standar, serta pengelolaan limbah medis secara aman dan benar. Penerapan praktik aseptik ini bertujuan untuk mencegah infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat selama perawatan di fasilitas kesehatan, yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.

5. Dukungan Psikologis dan Penghormatan terhadap Hak Pasien

Keselamatan pasien dalam kebidanan tidak hanya sebatas aspek fisik atau klinis saja, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan emosional. Pasien perlu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai proses persalinan, risiko yang mungkin terjadi, serta pilihan tindakan medis yang tersedia. Menghormati hak reproduksi pasien adalah bagian penting dari keselamatan pasien, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi ibu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya. Selain itu, dukungan emosional dan psikososial dari tenaga kebidanan juga berperan dalam menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan mendukung, sehingga ibu dapat menjalani proses persalinan dengan lebih percaya diri dan tenang.

B. Audit Klinis Persalinan

Audit klinis persalinan merupakan proses evaluasi sistematis terhadap layanan kebidanan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan dengan cara membandingkan praktik nyata yang dilaksanakan di lapangan dengan standar klinis atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari audit klinis ini adalah untuk menemukan ketidaksesuaian atau kelemahan pelayanan, mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis bukti.

Proses audit klinis persalinan secara rinci melibatkan beberapa tahapan berikut:

- Pemilihan topik audit berdasarkan prioritas dan kejadian yang berisiko tinggi atau yang sering terjadi.
- Pengumpulan data secara objektif dan akurat dari berbagai sumber yang relevan.
- Analisis data dengan membandingkan praktik nyata dengan standar yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan dan penyebabnya.
- Pembuatan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis, untuk diimplementasikan dalam praktik sehari-hari.

- Implementasi rekomendasi dan monitoring secara berkala guna memastikan rekomendasi tersebut benar-benar efektif dalam memperbaiki kualitas pelayanan persalinan.

C. Manajemen Risiko Kebidanan

Manajemen risiko dalam praktik kebidanan adalah suatu pendekatan sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi dalam proses pelayanan kebidanan. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mencegah terjadinya cedera atau kematian pada ibu dan bayi, serta melindungi institusi pelayanan kesehatan dari dampak negatif kejadian yang tidak diharapkan.

Langkah-langkah manajemen risiko meliputi:

- Identifikasi risiko yang mungkin terjadi, seperti perdarahan postpartum, preeklamsia, distosia bahu, infeksi, dan komplikasi lainnya.
- Analisis risiko dan penyebabnya secara mendalam menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA).
- Penyusunan strategi mitigasi risiko seperti pelatihan rutin tenaga kesehatan, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta sistem pelaporan insiden yang transparan.
- Implementasi strategi mitigasi risiko secara efektif dan konsisten dalam pelayanan kebidanan sehari-hari.

D. Continuous Quality Improvement (CQI)

Continuous Quality Improvement (CQI) merupakan pendekatan sistematis yang berkelanjutan, bertujuan untuk secara terus menerus meningkatkan mutu pelayanan kebidanan melalui evaluasi rutin serta perbaikan berkesinambungan. CQI berorientasi pada keterlibatan aktif seluruh tim kesehatan dalam proses perbaikan mutu layanan.

Proses CQI secara terperinci terdiri dari siklus Plan-Do-Study-Act (PDSA):

- **Plan (Perencanaan):** Tim mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan perbaikan, serta menyusun rencana tindakan perbaikan secara rinci.
- **Do (Pelaksanaan):** Solusi atau intervensi yang telah dirancang kemudian diimplementasikan dalam pelayanan kebidanan sehari-hari.
- **Study (Evaluasi):** Tim melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah diterapkan, mengidentifikasi hambatan serta hasil yang dicapai.
- **Act (Tindakan):** Tim melakukan penyesuaian atau menetapkan solusi tersebut sebagai standar operasional baru apabila terbukti efektif.

Penerapan CQI menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan mutu, inovasi berkelanjutan, serta memastikan pelayanan kebidanan yang diberikan senantiasa memenuhi standar tinggi dalam hal keselamatan, efektifitas, dan responsif terhadap kebutuhan pasien.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1

Instruksi Tugas:

Buatlah analisis terhadap sebuah kasus di mana terjadi kesalahan identifikasi pasien dalam pelayanan kebidanan. Kasus dapat diperoleh dari pengalaman klinik, studi kasus di jurnal, atau skenario yang Anda buat sendiri. Analisis Anda harus mencakup:

- Deskripsi kasus secara singkat namun jelas.
- Identifikasi faktor penyebab terjadinya kesalahan identifikasi pasien.
- Dampak yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut terhadap keselamatan ibu dan bayi.
- Strategi perbaikan atau solusi berdasarkan prinsip identifikasi pasien yang tepat (minimal dua identitas).
- Referensi minimal 2 sumber jurnal ilmiah terbaru (5 tahun terakhir).

Tugas 2:

Instruksi Tugas:

Dalam kelompok kecil (3-4 orang), buatlah skenario simulasi komunikasi antar tim kebidanan menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Setiap kelompok harus:

- Menyusun sebuah skenario klinis yang realistis dalam praktik kebidanan.
- Melakukan peran (role-play) dengan jelas dan efektif menggunakan metode SBAR.
- Mendokumentasikan dialog atau transkrip simulasi tersebut.
- Menyusun laporan evaluasi terkait efektivitas komunikasi, identifikasi masalah komunikasi yang terjadi, serta rekomendasi perbaikannya.
- Rekam video simulasi dengan durasi maksimal 10 menit dan unggah di platform pembelajaran yang disediakan.

Tugas 3:

Instruksi Tugas:

Pilihlah satu topik yang relevan dalam praktik kebidanan (misalnya: perdarahan postpartum, preeklamsia, atau infeksi postpartum), lalu lakukan audit klinis terhadap

pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan (praktik mandiri, klinik, atau rumah sakit). Laporan audit klinis Anda harus meliputi:

- Pemilihan topik audit dan justifikasinya berdasarkan kejadian atau risiko yang tinggi.
- Pengumpulan data dari minimal 10 kasus terkait topik tersebut.
- Analisis data dengan membandingkan praktik nyata terhadap standar klinis yang berlaku.
- Identifikasi kesenjangan yang terjadi dan penyebabnya.
- Rekomendasi spesifik untuk perbaikan praktik kebidanan berdasarkan hasil audit.

Laporan dikumpulkan dalam bentuk dokumen akademik dengan referensi minimal 3 sumber terbaru (maksimal 5 tahun terakhir).

Tugas 4:

Instruksi Tugas:

Secara individu atau kelompok, buatlah Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai manajemen obat di layanan kebidanan, mengacu pada prinsip “5 benar” (benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute). SOP harus mencakup:

- Tujuan SOP secara jelas dan spesifik.
- Ruang lingkup prosedur yang dijelaskan secara detail.
- Langkah-langkah prosedural yang terstruktur dan mudah dipahami.
- Format pencatatan administrasi obat yang digunakan dalam praktik kebidanan.
- Referensi minimal 2 sumber ilmiah terbaru yang relevan (5 tahun terakhir).

Tugas 5:

Instruksi Tugas:

Buatlah proyek mini CQI dalam konteks kebidanan yang berfokus pada pengendalian infeksi atau dukungan psikologis terhadap pasien. Proyek Anda harus mengikuti siklus Plan-Do-Study-Act (PDSA):

- **Plan:** Identifikasi masalah nyata dalam praktik kebidanan di lingkungan klinis Anda. Jelaskan tujuan dan rencana tindakan yang spesifik.
- **Do:** Implementasikan rencana tersebut dalam waktu tertentu (minimal satu minggu).
- **Study:** Evaluasi implementasi dengan mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, atau kuesioner.
- **Act:** Buat kesimpulan hasil evaluasi dan tentukan apakah intervensi akan dipertahankan, disesuaikan, atau dihentikan.

Sajikan hasil proyek mini CQI dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan dokumentasi pelaksanaan (foto atau video) serta analisis mendalam.

Pilhan Ganda

1. Seorang ibu hamil (G2P1A0), usia 28 tahun, dirawat di ruang persalinan. Petugas kebidanan melakukan verifikasi pasien sebelum tindakan induksi persalinan, namun hanya menanyakan nama pasien tanpa verifikasi tambahan. Akibatnya, tindakan yang direncanakan untuk pasien lain hampir diberikan kepada pasien tersebut. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kesalahan ini?
 - A. Menanyakan kembali nama pasien sebelum tindakan
 - B. Melihat status pasien yang ada di tempat tidur
 - C. Melakukan identifikasi pasien dengan minimal dua identitas pasien
 - D. Mengonfirmasi pada keluarga pasien di ruang tunggu
 - E. Memeriksa gelang pasien hanya setelah tindakan selesai
2. Seorang bidan di ruang persalinan melihat kondisi pasien semakin memburuk dengan tanda-tanda preeklamsia berat. Dia ingin melaporkan kondisi ini kepada dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan tindakan segera. Metode komunikasi apakah yang paling tepat digunakan bidan tersebut dalam situasi ini?
 - A. SOAP
 - B. SOAPIE
 - C. ADPIE
 - D. SBAR
 - E. DAR
3. Seorang bidan mendapat instruksi pemberian antibiotik intravena Ampicillin 1 gram kepada pasien postpartum dengan infeksi ringan. Tanpa verifikasi, bidan langsung memberikan obat. Setelah diberikan, baru diketahui bahwa antibiotik tersebut seharusnya diberikan kepada pasien lain. Prinsip manajemen obat mana yang dilanggar oleh bidan dalam kasus ini?
 - A. Benar dosis
 - B. Benar pasien
 - C. Benar waktu
 - D. Benar rute
 - E. Benar dokumentasi
4. Di sebuah klinik kebidanan, ditemukan peningkatan infeksi luka operasi caesar dalam satu bulan terakhir. Hasil observasi menunjukkan beberapa tenaga kesehatan tidak konsisten melakukan cuci tangan sesuai standar. Langkah awal apa yang paling tepat dilakukan oleh klinik tersebut dalam menyikapi kasus ini?

- A. Mengganti seluruh tenaga kesehatan
 - B. Memberikan antibiotik profilaksis pada semua pasien
 - C. Melakukan audit klinis dan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan
 - D. Menutup ruang operasi untuk sementara
 - E. Memberikan hukuman kepada petugas yang lalai
5. Seorang ibu primipara tampak sangat cemas dan takut menjalani persalinan normal. Ibu merasa tidak mendapat penjelasan yang jelas mengenai proses persalinan. Dia merasa haknya sebagai pasien belum terpenuhi sepenuhnya. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan bidan dalam situasi ini?
- A. Mengabaikan kecemasan pasien agar pasien tidak semakin panik
 - B. Menginstruksikan pasien untuk segera mengambil keputusan sendiri
 - C. Memberikan informasi lengkap tentang proses persalinan dan opsi tindakan
 - D. Menyerahkan seluruh keputusan kepada keluarga pasien
 - E. Memberikan obat penenang tanpa penjelasan tambahan

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Identifikasi pasien yang akurat harus menggunakan minimal dua identitas pasien, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis untuk mencegah kesalahan tindakan medis.

2. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) adalah metode komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi penting secara cepat, jelas, dan sistematis kepada anggota tim lainnya dalam situasi kritis.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kesalahan utama dalam kasus ini adalah pelanggaran prinsip "benar pasien" dalam manajemen obat. Setiap pemberian obat harus memastikan bahwa obat tersebut diberikan kepada pasien yang benar.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Audit klinis merupakan langkah sistematis dalam mengidentifikasi penyebab peningkatan infeksi dan membantu mengevaluasi kepatuhan petugas terhadap prosedur standar seperti kebersihan tangan.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Dukungan psikologis dan penghormatan terhadap hak pasien merupakan aspek penting keselamatan pasien. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Rangkuman Materi

Keselamatan pasien merupakan prinsip esensial dalam praktik kebidanan yang bertujuan melindungi ibu dan bayi dari risiko yang bisa menyebabkan cedera, komplikasi, atau bahkan kematian selama proses persalinan. Prinsip ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu identifikasi pasien secara akurat, komunikasi efektif antar tim kesehatan, manajemen pengobatan yang teliti, pengendalian infeksi secara ketat, serta pemberian dukungan psikologis yang disertai penghormatan terhadap hak pasien.

Identifikasi pasien yang tepat dilakukan dengan memverifikasi minimal dua identitas pasien sebelum melakukan tindakan medis apapun, seperti nama lengkap dan tanggal lahir, guna mencegah kesalahan prosedur yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi. Sementara itu, komunikasi efektif antar tim kesehatan menggunakan pendekatan yang terstruktur seperti metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), yang memastikan informasi klinis penting tersampaikan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu.

Manajemen pengobatan yang cermat dalam kebidanan mengikuti prinsip "5 benar", yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute pemberian, untuk mencegah kesalahan pemberian obat yang berisiko menimbulkan efek samping atau komplikasi serius. Di samping itu, praktik pengendalian infeksi yang ketat seperti mencuci tangan secara teratur, sterilisasi alat medis yang benar, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat, serta pengelolaan limbah medis secara aman sangat penting untuk menghindari infeksi nosokomial yang berbahaya bagi ibu dan bayi.

Tidak kalah penting, keselamatan pasien dalam praktik kebidanan juga mencakup aspek psikologis. Pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jelas tentang proses persalinan serta pilihan tindakan medis yang tersedia, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dukungan emosional dan psikososial dari tenaga kebidanan berperan penting untuk menciptakan suasana nyaman, aman, serta meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menghadapi persalinan.

Untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, kebidanan menerapkan audit klinis persalinan sebagai evaluasi sistematis terhadap layanan yang diberikan. Audit ini dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan standar klinis yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan, menentukan penyebabnya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti untuk diterapkan secara rutin.

Selanjutnya, manajemen risiko dalam praktik kebidanan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai potensi risiko, seperti perdarahan postpartum, preeklamsia, distosia bahu, infeksi, dan komplikasi lainnya. Strategi ini mencakup analisis mendalam melalui metode Root Cause Analysis (RCA), pembuatan SOP yang jelas, pelatihan rutin tenaga kesehatan, serta sistem pelaporan yang transparan untuk meminimalisir risiko yang dapat membahayakan pasien.

Continuous Quality Improvement (CQI) atau peningkatan mutu berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari praktik kebidanan, yang menggunakan siklus Plan-Do-Study-Act (PDSA). CQI mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota tim untuk secara berkesinambungan mengidentifikasi masalah, mengimplementasikan solusi, mengevaluasi hasilnya, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Dengan penerapan CQI, tercipta budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan pasien.

Glosarium

Audit Klinis Persalinan: Proses evaluasi sistematis terhadap layanan persalinan untuk menilai kualitas pelayanan dengan cara membandingkan praktik nyata di lapangan dengan standar klinis yang telah ditetapkan, serta merekomendasikan perbaikan berbasis bukti.

Continuous Quality Improvement (CQI): Pendekatan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan kebidanan secara sistematis dengan siklus evaluasi dan perbaikan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh tim kesehatan.

Dukungan Psikologis Pasien: Pendampingan emosional dan psikososial yang diberikan tenaga kebidanan kepada pasien untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa nyaman, serta memberikan rasa percaya diri selama proses persalinan.

Hak Reproduksi Pasien: Hak pasien untuk memperoleh informasi lengkap mengenai proses persalinan, risiko, serta opsi tindakan medis, dan kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan kesehatan mereka.

Identifikasi Pasien: Prosedur verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas utama, seperti nama lengkap dan tanggal lahir atau nomor rekam medis, untuk memastikan ketepatan tindakan medis dan mencegah kesalahan prosedur.

Infeksi Nosokomial: Infeksi yang didapatkan pasien selama menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dicegah melalui praktik pengendalian infeksi yang ketat.

Komunikasi Efektif: Interaksi antar tenaga kesehatan yang jelas, tepat waktu, dan sistematis, bertujuan menghindari kesalahan akibat miskomunikasi, salah satunya menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation).

Manajemen Obat: Prosedur pemberian obat yang teliti dengan memperhatikan prinsip lima benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute, guna menghindari kesalahan pemberian obat.

Manajemen Risiko Kebidanan: Pendekatan sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko potensial dalam pelayanan kebidanan untuk mencegah terjadinya cedera, komplikasi, atau kematian pada ibu dan bayi.

Metode Root Cause Analysis (RCA): Analisis mendalam yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi penyebab utama dari sebuah insiden atau kesalahan agar dapat dicegah pada masa mendatang.

Metode SBAR: Singkatan dari Situation (situasi), Background (latar belakang), Assessment (pengkajian), dan Recommendation (rekomendasi); metode komunikasi terstruktur antar tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas dan efektif.

Pengendalian Infeksi: Serangkaian praktik pencegahan untuk meminimalkan risiko infeksi, seperti cuci tangan secara konsisten, sterilisasi alat medis, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), serta pengelolaan limbah medis yang aman.

Prinsip Lima Benar (5 Benar): Pedoman penting dalam pemberian obat untuk menjamin keselamatan pasien, mencakup benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar rute pemberian.

Risiko Kebidanan: Segala bentuk potensi bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama proses pelayanan kebidanan, termasuk perdarahan postpartum, preeklamsia, distosia bahu, infeksi, dan komplikasi lainnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP): Dokumen yang berisi prosedur kerja terstruktur dan rinci yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas klinis, termasuk dalam manajemen obat, untuk menjamin keselamatan dan mutu layanan.

Daftar Pustaka

- Aini, Q., Rohani, I., & Indrayani, T. (2022). Identifikasi pasien sebagai implementasi keselamatan pasien di ruang kebidanan. *Journal of Midwifery*, 7(1), 15–22. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Astuti, P. A., Utami, S., & Rahayu, S. (2021). Implementasi komunikasi efektif menggunakan metode SBAR dalam meningkatkan keselamatan pasien di layanan kebidanan. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 13(2), 112–118. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Dewi, S. R., & Pratiwi, L. (2020). Pengaruh penerapan manajemen obat berbasis prinsip 5 benar terhadap pencegahan kesalahan obat di ruang kebidanan. *Indonesian Journal of Midwifery and Nursing Research*, 4(2), 75–82. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Ibrahim, M. Y., & Saputri, D. H. (2022). Pengendalian infeksi dalam pelayanan kebidanan sebagai upaya pencegahan infeksi nosokomial. *Journal of Healthcare Quality Assurance*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Kementerian Kesejahteraan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman nasional keselamatan pasien rumah sakit (Revisi 2020)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nursalam, N., & Efendi, F. (2022). *Manajemen risiko dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak*. Salemba Medika.
- Nurwijayanti, N., & Handayani, D. (2021). Dukungan psikologis terhadap pasien bersalin dalam perspektif keselamatan pasien. *Journal of Maternal and Child Health*, 6(3), 298–304. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. (2017). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Putri, E. R., & Kusumaningrum, T. (2023). Audit klinis sebagai instrumen peningkatan mutu layanan kebidanan di fasilitas kesehatan. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 12(1), 19–25. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- Saputra, I. D., & Rahayu, E. (2022). Continuous Quality Improvement (CQI) dalam meningkatkan keselamatan pasien kebidanan. *Indonesian Health Quality Journal*, 3(2), 85–93. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxxx>
- WHO. (2021). *Patient safety: Making health care safer*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240014989>

Bab 11

Simulasi dan Praktik Klinik Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE)

Pendidikan kebidanan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) menekankan pada capaian kompetensi nyata yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang krusial dalam mencapai hasil tersebut adalah melalui kegiatan simulasi dan praktik klinik. Simulasi memungkinkan mahasiswa untuk mempraktikkan keterampilan klinik dalam lingkungan yang aman, terkontrol, dan bebas risiko bagi pasien. Dalam konteks asuhan persalinan, mahasiswa perlu menguasai berbagai keterampilan mulai dari penatalaksanaan persalinan normal hingga pengenalan dan penanganan komplikasi. Desain simulasi yang efektif, termasuk *skill lab* dan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), dilengkapi dengan studi kasus realistis, rubrik penilaian keterampilan klinik, serta refleksi dan umpan balik, menjadi kunci keberhasilan pembelajaran klinik yang berorientasi pada hasil.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Mampu memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif dan holistik pada ibu bersalin sesuai dengan standar praktik dan kode etik kebidanan.
2. Mampu menerapkan prinsip patient safety dan asuhan berbasis bukti dalam praktik kebidanan klinik.
3. Mampu berkomunikasi efektif dan bekerja dalam tim multidisiplin saat memberikan pelayanan kebidanan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu merancang dan mengikuti kegiatan simulasi keterampilan klinik persalinan secara efektif.
2. Mahasiswa mampu menginterpretasikan dan merespons skenario kasus persalinan normal dan komplikasi melalui praktik klinik berbasis OBE.
3. Mahasiswa mampu mengevaluasi performa klinik melalui rubrik penilaian yang terstandarisasi dan melakukan refleksi untuk perbaikan diri.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan prinsip simulasi klinik dalam pendidikan kebidanan.
2. Mahasiswa dapat mendemonstrasikan keterampilan penanganan persalinan normal melalui simulasi *skill lab* dan OSCE.
3. Mahasiswa dapat mengenali dan menangani skenario komplikasi persalinan dalam simulasi berbasis kasus.
4. Mahasiswa dapat menggunakan rubrik penilaian untuk menilai dan menilai diri sendiri secara objektif.
5. Mahasiswa dapat menyusun dan mengekspresikan refleksi praktik klinik secara kritis dan konstruktif

A. Desain Simulasi (Skill Lab dan OSCE)

1. Pengertian dan Tujuan Simulasi

Simulasi dalam pendidikan kebidanan adalah metode pembelajaran yang menggunakan alat peraga, model, atau teknologi virtual untuk meniru proses klinik nyata. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan keterampilan klinik dengan aman, meningkatkan kompetensi teknis dan non-teknis, serta membangun kepercayaan diri sebelum terjun ke pelayanan nyata.

2. Skill Lab

Skill Lab adalah laboratorium keterampilan yang dilengkapi dengan peralatan dan model anatomi yang mendukung praktik teknik kebidanan, seperti pemeriksaan kehamilan, persiapan persalinan, teknik aseptik, tindakan pertolongan persalinan, dan penanganan komplikasi dasar.

Desain Skill Lab:

- Fasilitas: Ruang yang memadai dengan simulasi model anatomi realistis (manekin ibu hamil, bayi, alat bantu persalinan).
- Skenario Pembelajaran: Disusun berdasarkan capaian pembelajaran, contohnya simulasi penilaian tanda-tanda persalinan, teknik mengevaluasi pembukaan serviks, dan manajemen persalinan normal.
- Instruktur: Dosen atau instruktur klinik yang berpengalaman dan terlatih dalam metode simulasi.
- Proses Pembelajaran: Mahasiswa melakukan praktik secara individu atau kelompok, diikuti dengan sesi diskusi dan pembimbingan langsung.

3. Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

OSCE adalah metode penilaian keterampilan klinik yang terstruktur dan objektif melalui serangkaian stan atau pos dengan tugas-tugas klinik yang spesifik, di mana mahasiswa dinilai berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur.

Desain OSCE untuk Persalinan:

- Stan OSCE: Terdiri dari beberapa pos yang menggambarkan tahapan persalinan dan penanganannya, misalnya penilaian serviks, teknik bantuan persalinan, komunikasi dengan pasien, dan penanganan komplikasi.
- Durasi Setiap Pos: Biasanya 5-10 menit per stan, disesuaikan dengan kompleksitas tugas.
- Instrumen Penilaian: Menggunakan checklist atau rubrik yang memuat aspek teknis dan non-teknis.
- Panel Penilai: Minimal 2 orang, terdiri dari dosen dan/atau praktisi klinik yang ahli.

B. Studi Kasus Persalinan Normal dan Komplikasi

1. Studi Kasus Persalinan Normal

Kasus 1: Seorang ibu hamil G2P1, usia kehamilan 39 minggu, datang dengan keluhan kontraksi teratur sejak 4 jam lalu. Pemeriksaan menunjukkan pembukaan serviks 4 cm, ketuban utuh, denyut jantung janin normal.

Tugas mahasiswa: Melakukan penilaian tanda persalinan, memantau kontraksi, memberikan edukasi persalinan normal, serta persiapan asistensi persalinan.

2. Studi Kasus Persalinan dengan Komplikasi

Kasus 2: Ibu hamil G3P2 usia kehamilan 38 minggu datang dengan perdarahan pervaginam ringan, denyut jantung janin menurun, pembukaan serviks 5 cm.

Tugas mahasiswa: Mengidentifikasi tanda bahaya, melakukan monitoring ketat, memberikan pertolongan pertama, dan menentukan tindakan lanjutan serta rujukan.

Kasus 3: Persalinan dengan janin sungsang, ibu usia 30 tahun, kontraksi sudah kuat, kepala janin belum turun.

Tugas mahasiswa: Melakukan asuhan persalinan dengan posisi janin sungsang, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan mengenai persalinan normal atau rujukan.

Aspek Penilaian	Deskripsi	Skor
Persiapan dan Penggunaan Alat	Mahasiswa menyiapkan alat dengan benar, menjaga sterilitas dan kebersihan	5
Penilaian Tanda Persalinan	Melakukan pemeriksaan tanda persalinan dengan tepat dan sistematis	10
Teknik Asuhan Persalinan	Melaksanakan tindakan kebidanan sesuai prosedur standar (misalnya, asistensi persalinan)	15
Komunikasi dengan Pasien dan Keluarga	Menunjukkan sikap empati, komunikasi efektif, dan edukasi yang jelas	10
Pengelolaan Komplikasi	Mampu mengenali dan melakukan tindakan awal terhadap komplikasi	10
Dokumentasi	Mengisi catatan persalinan secara lengkap dan akurat	5
Sikap Profesional dan Etika	Menjaga etika profesi, menjaga privasi pasien, dan menunjukkan tanggung jawab.	5
Total Skor Maksimal		60

C. Rubrik Penilaian Keterampilan Klinik

Rubrik penilaian digunakan untuk memberikan standar yang jelas dan objektif dalam menilai kompetensi mahasiswa saat praktik klinik. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga komunikasi, etika, dan keselamatan pasien.

Kriteria Kelulusan:

- Skor $\geq$ 80%: Kompeten
- Skor 60-79%: Perlu bimbingan ulang
- Skor $<$ 60%: Belum kompeten, wajib remedial

Kriteria Kelulusan:

- Skor $\geq$ 80%: Kompeten
- Skor 60-79%: Perlu bimbingan ulang
- Skor $<$ 60%: Belum kompeten, wajib remedial

D. Refleksi dan *Feedback* Praktik Klinik

Refleksi dan *feedback* sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keterampilan mahasiswa. Tahapan refleksi dan *feedback* yang efektif meliputi:

1. Sesi Debriefing

- Diskusi terbuka tentang pengalaman praktik.
- Mahasiswa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing.
- Supervisor memberikan *feedback* konstruktif berdasarkan observasi langsung.

2. Penulisan Jurnal Reflektif

- Mahasiswa menuliskan pengalaman, perasaan, serta pelajaran yang didapat selama praktik klinik.
- Dosen memberikan respon tertulis untuk mengarahkan perbaikan keterampilan dan sikap klinik.

3. Evaluasi Berkala

- Evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan mahasiswa.
- Menyesuaikan kegiatan simulasi berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1:

Instruksi: Mahasiswa diminta untuk membuat laporan evaluasi simulasi di Skill Lab yang telah dilaksanakan.

Isi laporan meliputi:

- Deskripsi fasilitas dan model anatomi yang digunakan.
- Penilaian terhadap efektivitas skenario pembelajaran.
- Analisis peran instruktur dalam pembimbingan praktik.
- Evaluasi proses pembelajaran dan kendala yang ditemukan.
- Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran Skill Lab.

Tugas 2:

Instruksi: Mahasiswa diminta merancang satu rangkaian OSCE khusus untuk penanganan persalinan normal dan komplikasi.

Isi rancangan meliputi:

- Judul dan tujuan setiap stan.
- Uraian singkat kegiatan yang dilakukan mahasiswa di setiap stan.
- Checklist penilaian untuk setiap stan (minimal 5 poin penting per stan).
- Durasi ideal untuk masing-masing stan.
- Rincian alat dan bahan yang dibutuhkan.

Tugas 3:

Instruksi: Mahasiswa menyusun laporan komprehensif mengenai penanganan studi kasus persalinan normal berikut:

Kasus: Seorang ibu G2P1, usia kehamilan 39 minggu, datang dengan kontraksi teratur sejak 4 jam lalu. Pembukaan serviks 4 cm, ketuban utuh, denyut jantung janin normal.

Isi laporan meliputi:

- Langkah-langkah penilaian awal tanda persalinan.
- Rencana pemantauan kontraksi dan tanda vital ibu serta janin.
- Rencana edukasi yang akan diberikan kepada ibu.
- Persiapan alat dan tim untuk mendampingi proses persalinan normal.
- Strategi antisipasi komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan.

Tugas 4:

Instruksi: Mahasiswa diminta untuk menyusun tindakan klinik berdasarkan kasus berikut:

Kasus: Seorang ibu hamil G3P2 usia kehamilan 38 minggu, datang dengan perdarahan pervaginam ringan, denyut jantung janin menurun, pembukaan serviks 5 cm.

Isi laporan meliputi:

- Identifikasi segera tanda-tanda bahaya dan diagnosis awal.
- Langkah-langkah monitoring yang dilakukan secara ketat.
- Penjelasan tindakan pertama yang harus dilakukan dan alasannya.
- Keputusan klinis mengenai rujukan dan komunikasi dengan tim multidisiplin.
- Penjelasan mengenai pentingnya aspek etika dan keselamatan pasien dalam situasi emergensi ini.

Tugas 5:

Instruksi: Mahasiswa ditugaskan menyusun sebuah rubrik penilaian keterampilan klinik yang jelas, objektif, dan terperinci untuk Skill Lab dan OSCE persalinan.

Rubrik meliputi aspek:

- Kesiapan mahasiswa dalam menyiapkan lingkungan dan alat bantu persalinan.
- Kompetensi teknis dalam melakukan tindakan klinik (teknik aseptik, pemeriksaan, pertolongan persalinan, penanganan komplikasi).
- Kemampuan komunikasi efektif dengan pasien dan tim medis.
- Penerapan prinsip keselamatan pasien.
- Penggunaan etika klinis selama simulasi berlangsung.

Pilihan Ganda

1. Seorang mahasiswa kebidanan sedang melakukan simulasi di Skill Lab dengan skenario persalinan normal. Mahasiswa tampak ragu dan bingung dalam menentukan tindakan awal yang harus dilakukan pada ibu hamil dengan kontraksi teratur dan pembukaan serviks 4 cm.

Menurut desain Skill Lab yang ideal, tindakan awal yang seharusnya dilakukan mahasiswa adalah:

- A. Melakukan penilaian awal dan pemantauan kontraksi serta denyut jantung janin
- B. Memberikan langsung instruksi mengejan kepada ibu
- C. Memecahkan ketuban untuk mempercepat persalinan
- D. Memberikan analgesik secara intravena
- E. Langsung mempersiapkan alat untuk operasi caesar

2. Dalam pelaksanaan OSCE, seorang mahasiswa berada di stan simulasi komplikasi persalinan dengan kasus janin sungsang. Mahasiswa diminta menentukan langkah pertama dalam penatalaksanaan kasus ini.

Langkah yang tepat adalah:

- A. Segera menyiapkan ibu untuk operasi caesar
- B. Melakukan manuver untuk memperbaiki posisi janin secara manual
- C. Mengidentifikasi posisi janin, menilai risiko, dan merencanakan tindakan klinis lanjut
- D. Langsung memberikan obat penguat kontraksi
- E. Melakukan tindakan episiotomi segera

3. Saat simulasi Skill Lab, instruktur menemukan mahasiswa sering melupakan teknik aseptik selama praktik persalinan.

Langkah terbaik yang seharusnya diambil instruktur dalam situasi ini adalah:

- A. Menghentikan simulasi secara total dan mengganti mahasiswa
- B. Memberi hukuman agar mahasiswa lebih disiplin
- C. Mengabaikan kesalahan tersebut karena ini hanya simulasi
- D. Melakukan demonstrasi ulang teknik aseptik secara jelas dan memberikan kesempatan praktik ulang
- E. Langsung memberikan nilai buruk pada mahasiswa tersebut

4. Seorang mahasiswa menyusun laporan evaluasi simulasi persalinan normal. Dalam laporannya, mahasiswa menilai bahwa fasilitas Skill Lab kurang lengkap karena tidak tersedia manekin bayi untuk simulasi resusitasi neonatal.

Rekomendasi terbaik yang harus dituliskan dalam laporan tersebut adalah:

- A. Menghapus materi resusitasi neonatal dari kurikulum simulasi
- B. Mengganti simulasi resusitasi dengan teori saja
- C. Mengusulkan pengadaan manekin bayi untuk simulasi neonatal yang realistis
- D. Meminta mahasiswa untuk mempraktikkan langsung ke pasien nyata
- E. Mengubah tujuan pembelajaran agar tidak membutuhkan manekin bayi

5. Pada sesi OSCE, seorang mahasiswa tampak gugup dan lupa menjelaskan prosedur kepada pasien (simulasi) sebelum melakukan pemeriksaan serviks.

Dalam rubrik penilaian OSCE, hal ini masuk ke dalam aspek:

- A. Kompetensi teknis
- B. Komunikasi efektif dengan pasien
- C. Teknik aseptik
- D. Keamanan lingkungan klinik
- E. Etika dalam praktik klinik

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: A

Pembahasan: Langkah awal yang benar adalah melakukan penilaian awal seperti mengecek kontraksi, denyut jantung janin, serta kondisi serviks sebelum mengambil tindakan lanjutan.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Langkah pertama dalam manajemen janin sungsang adalah mengidentifikasi posisi, menilai risiko dengan seksama, dan merencanakan tindakan klinis yang sesuai.

3. Kunci Jawaban: D

Pembahasan: Tindakan yang tepat adalah instruktur mendemonstrasikan ulang teknik aseptik dengan jelas dan memberi mahasiswa kesempatan berlatih ulang untuk memastikan kompetensi yang benar.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan: Rekomendasi yang tepat adalah mengusulkan pengadaan fasilitas yang memadai agar mahasiswa dapat berlatih secara optimal dan realistis.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan: Kegagalan dalam memberikan penjelasan sebelum tindakan merupakan aspek komunikasi efektif dengan pasien yang sangat penting dalam praktik klinik.

Rangkuman Materi

Simulasi dalam pendidikan kebidanan merupakan metode pembelajaran yang dirancang menggunakan berbagai alat peraga, model anatomi, atau teknologi virtual untuk mereplikasi kondisi klinis yang sesungguhnya. Tujuan utama simulasi ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam lingkungan yang aman dan terkendali, meningkatkan kompetensi teknis maupun non-teknis, serta menumbuhkan rasa percaya diri sebelum mahasiswa terjun ke lingkungan klinis nyata.

Skill Lab merupakan fasilitas laboratorium yang khusus digunakan untuk melatih keterampilan teknis kebidanan. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan modern dan berbagai model anatomi realistis seperti manekin ibu hamil dan bayi, serta alat bantu persalinan. Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa melaksanakan skenario yang telah disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, seperti menilai tanda persalinan, mengevaluasi pembukaan serviks, dan menangani persalinan normal. Proses pembelajaran ini didukung oleh instruktur yang berpengalaman, dengan mahasiswa melakukan praktik secara individu atau berkelompok, dilanjutkan sesi diskusi dan bimbingan langsung.

Objective Structured Clinical Examination (OSCE) adalah metode penilaian klinik yang terstruktur dan objektif, melibatkan serangkaian stan yang menampilkan tugas-tugas klinik spesifik. Mahasiswa dinilai menggunakan rubrik atau checklist yang mencakup aspek teknis dan non-teknis dalam rentang waktu tertentu, umumnya 5 hingga 10 menit per stan. Setiap stan menggambarkan tahap-tahap dalam proses persalinan serta komplikasi yang mungkin terjadi, dengan penilai terdiri dari minimal dua orang yang ahli di bidang klinik maupun akademik.

Pada studi kasus persalinan normal, mahasiswa ditugaskan melakukan penilaian awal tanda persalinan, memantau kontraksi dan kondisi janin secara berkala, memberikan edukasi mengenai persalinan normal, serta mempersiapkan segala kebutuhan untuk proses persalinan. Sedangkan dalam kasus persalinan dengan komplikasi seperti perdarahan pervaginam ringan dengan penurunan denyut jantung janin, atau posisi janin sungsang, mahasiswa diwajibkan mengidentifikasi tanda-tanda bahaya secara cepat, melakukan pemantauan ketat, memberikan tindakan awal, serta mengambil keputusan mengenai penanganan lebih lanjut atau rujukan.

Rubrik penilaian keterampilan klinik digunakan sebagai acuan objektif untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam aspek teknis, komunikasi, etika, dan keselamatan pasien selama praktik klinik. Kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh mahasiswa, dengan kategori kompeten untuk skor di atas 80%, perlu bimbingan ulang pada rentang skor 60-79%, dan wajib remedial bila skor kurang dari 60%.

Glosarium

Checklist Penilaian: Instrumen evaluasi berupa daftar tindakan atau keterampilan spesifik yang digunakan sebagai acuan untuk menilai kinerja mahasiswa secara objektif selama praktik klinik atau OSCE.

Komplikasi Persalinan: Keadaan atau kondisi yang muncul selama proses persalinan yang menyimpang dari keadaan normal, memerlukan intervensi medis segera untuk menghindari risiko terhadap ibu maupun janin.

Keterampilan Non-teknis: Kemampuan interpersonal, komunikasi, kerja sama tim, serta pengambilan keputusan klinis yang efektif dan etis dalam praktik klinik.

Keterampilan Teknis: Kemampuan praktis mahasiswa dalam melakukan tindakan-tindakan klinik seperti pemeriksaan fisik, manajemen persalinan, dan penanganan komplikasi persalinan secara tepat dan benar.

Manekin: Model anatomi manusia yang digunakan dalam simulasi klinik, terutama untuk mempraktikkan keterampilan seperti pertolongan persalinan, pemeriksaan fisik, dan tindakan klinik lainnya.

Objective Structured Clinical Examination (OSCE): Metode evaluasi klinik yang menggunakan serangkaian stasiun atau pos dengan tugas klinik spesifik, di mana mahasiswa dievaluasi secara terstruktur menggunakan kriteria jelas dan objektif melalui rubrik atau checklist penilaian.

Panel Penilai: Tim yang terdiri dari dosen atau praktisi klinik yang bertanggung jawab dalam memberikan evaluasi objektif terhadap mahasiswa selama pelaksanaan OSCE atau praktik klinik lainnya.

Penilaian Klinis: Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi pasien melalui observasi, pemeriksaan fisik, dan interpretasi hasil pemeriksaan untuk menentukan tindakan klinis yang diperlukan.

Persalinan Normal: Proses persalinan yang berlangsung tanpa komplikasi signifikan, mengikuti tahapan fisiologis yang normal, di mana ibu dan bayi berada dalam kondisi baik selama dan setelah proses persalinan.

Remedial: Proses pembelajaran ulang atau bimbingan tambahan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum mencapai tingkat kompetensi minimal yang ditentukan dalam evaluasi keterampilan klinik.

Rubrik Penilaian: Panduan evaluasi terstruktur yang memberikan kriteria penilaian jelas dan objektif untuk menilai kompetensi teknis dan non-teknis mahasiswa dalam praktik klinik.

Simulasi: Metode pembelajaran yang menggunakan alat peraga, model anatomi, atau teknologi virtual untuk menciptakan situasi klinis realistis sehingga mahasiswa dapat mempraktikkan keterampilan secara aman dan terkendali sebelum memasuki praktik nyata.

Skill Lab: Laboratorium yang dilengkapi berbagai fasilitas dan model anatomi realistis, seperti manekin ibu hamil dan bayi, yang digunakan mahasiswa untuk melatih keterampilan teknis dalam bidang kebidanan seperti pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan penanganan komplikasi dasar.

Teknik Aseptik: Prosedur yang digunakan untuk mencegah kontaminasi dari mikroorganisme patogen selama tindakan klinik, sangat penting dalam praktik kebidanan untuk memastikan keselamatan pasien.

Daftar Pustaka

- Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2017). Use of simulation-based learning in undergraduate nurse education: An umbrella systematic review. *Nurse Education Today*, 49, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.11.015>
- Harden, R. M., Lilley, P., & Patricio, M. (2015). *The definitive guide to the OSCE: The Objective Structured Clinical Examination as a performance assessment*. Elsevier Health Sciences.
- INACSL Standards Committee. (2016). INACSL standards of best practice: SimulationSM simulation design. *Clinical Simulation in Nursing*, 12, S5–S12. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.09.005>
- Jeffries, P. R. (2020). *Simulation in nursing education: From conceptualization to evaluation* (3rd ed.). National League for Nursing Press.
- Lateef, F. (2010). Simulation-based learning: Just like the real thing. *Journal of Emergencies, Trauma, and Shock*, 3(4), 348–352. <https://doi.org/10.4103/0974-2700.70743>
- Nestel, D., & Bearman, M. (2014). *Simulated patient methodology: Theory, evidence and practice*. John Wiley & Sons.
- Rush, S., Firth, T., Burke, L., & Marks-Maran, D. (2012). Implementation and evaluation of peer assessment of clinical skills for first-year student nurses. *Nurse Education in Practice*, 12(4), 219–226. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2012.01.014>
- Smith, V., & Muldoon, K. (2018). Clinical skills assessment in nursing: OSCE. *Nursing Standard*, 33(7), 40–44. <https://doi.org/10.7748/ns.2018.e11076>
- Taylor, C., Lynn, P., & Bartlett, J. L. (2018). *Fundamentals of nursing: The art and science of person-centered care* (9th ed.). Wolters Kluwer Health.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. WHO Press.

Bab 12

Tren dan Isu Terkini Dalam Persalinan

Perkembangan zaman yang dinamis telah menghadirkan berbagai perubahan signifikan dalam bidang persalinan, mulai dari tren metode baru seperti water birth, gentle birth, dan hypnobirthing, hingga pemanfaatan teknologi seperti telemidwifery. Inovasi ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih personal, holistik, dan berbasis kenyamanan ibu, serta menjawab tantangan akses layanan kesehatan di masa pandemi atau di wilayah terpencil. Dalam situasi ini, bidan dituntut untuk memiliki kompetensi digital dan keterampilan komunikasi virtual agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan aman. Di sisi lain, perubahan ini juga memunculkan tantangan etik dan legal yang lebih kompleks, termasuk pentingnya informed consent, penghormatan terhadap preferensi ibu, dan pemahaman terhadap implikasi hukum dari praktik persalinan modern seperti home birth. Peran media sosial dalam menyebarkan informasi tentang persalinan menambah dinamika tersendiri, di mana bidan diharapkan menjadi sumber edukasi yang kredibel dan berbasis bukti. Untuk menjawab semua tantangan ini, bidan perlu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pembaruan ilmu agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan berbagai tren dan isu terkini dalam persalinan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan ibu dan bayi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai tren persalinan modern serta isu-isu terkait dalam konteks praktik kebidanan kontemporer.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai metode persalinan kontemporer.
2. Mahasiswa mampu mengevaluasi manfaat dan risiko dari metode persalinan kontemporer.
3. Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu etik dan legal terkait persalinan kontemporer.
4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi digital dalam pelayanan kebidanan.
5. Mahasiswa mampu memanfaatkan media sosial secara efektif sebagai sarana edukasi kebidanan.

A. Tren Persalinan di Rumah (*Home Birth*)

Tren home birth atau persalinan di rumah kini semakin diminati karena menawarkan kenyamanan, privasi, dan lingkungan yang lebih santai bagi ibu. Alasan utama pemilihan metode ini biasanya karena keinginan untuk menjalani persalinan secara alami dengan intervensi medis minimal, didampingi oleh keluarga atau orang-orang terdekat. Persalinan di rumah harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, termasuk evaluasi kondisi kesehatan ibu dan janin, persiapan sarana dan peralatan medis dasar, serta kesiapan menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, peran bidan sangat krusial dalam mendukung dan memastikan keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan di rumah.

B. *Water Birth* (Persalinan dalam Air)

Water birth adalah metode persalinan di mana proses kelahiran dilakukan didalam bak yang berisi air hangat. Metode ini semakin populer dan menjadi tren dalam praktik kebidanan modern karena memberikan berbagai manfaat signifikan bagi ibu hamil selama proses persalinan. Air hangat yang digunakan dalam bak persalinan memiliki efek relaksasi yang sangat membantu dalam mengendurkan otot-otot tubuh ibu, sehingga menurunkan ketegangan dan meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan. Kondisi tubuh yang lebih rileks ini berkontribusi pada pengurangan rasa nyeri selama kontraksi, yang secara signifikan membantu mengurangi kebutuhan akan intervensi medis seperti analgesik atau anestesi.

Selain itu, water birth dipercaya dapat mempercepat proses persalinan. Suasana yang tenang dan nyaman di dalam air dapat memicu pelepasan hormon oksitosin secara alami, yang mempercepat pembukaan serviks dan memperlancar proses persalinan. Berada dalam air juga mengurangi gravitasi yang bekerja pada tubuh ibu, sehingga ibu dapat bergerak lebih bebas dan menemukan posisi yang paling nyaman untuk membantu kelahiran berjalan lancar. Hal ini membantu ibu merasa lebih kontrol atas tubuhnya dan meningkatkan rasa percaya diri, yang penting untuk kelancaran proses persalinan.

Meski demikian, water birth juga mengandung beberapa risiko yang harus menjadi perhatian serius bagi tenaga kesehatan yang menangani proses tersebut. Salah satu risiko utama adalah potensi terjadinya infeksi, baik pada ibu maupun bayi. Air yang digunakan harus benar-benar steril dan pengelolaan kebersihan harus dilakukan dengan ketat karena air hangat merupakan media yang dapat menjadi sarang bagi mikroorganisme. Jika prosedur aseptik dan sanitasi tidak dijalankan dengan benar, maka risiko infeksi meningkat dan dapat menimbulkan komplikasi serius.

Pemantauan janin dalam proses water birth juga menjadi tantangan tersendiri. Pengawasan denyut jantung janin secara terus-menerus sangat penting untuk memastikan kondisi bayi dalam keadaan sehat selama persalinan, namun pemantauan ini lebih sulit dilakukan secara optimal di dalam air. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi tanda-tanda distress janin yang memerlukan intervensi cepat. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus menggunakan alat monitoring yang sesuai dan berpengalaman dalam menginterpretasi data dari kondisi tersebut agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat bila diperlukan.

Selain itu, water birth memiliki keterbatasan dalam hal penanganan komplikasi yang mendadak. Jika terjadi perdarahan hebat, prolaps tali pusat, atau komplikasi lain yang memerlukan tindakan segera, intervensi dalam kondisi ibu yang berada di dalam air akan jauh lebih sulit dan memerlukan evakuasi cepat ke fasilitas yang lebih memadai. Oleh karena itu, keberadaan protokol darurat yang jelas dan kesiapan fasilitas medis pendukung menjadi sangat krusial untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Pelaksanaan water birth harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga kesehatan profesional yang kompeten, biasanya bidan atau dokter yang memiliki pelatihan khusus mengenai prosedur ini. Mereka harus memastikan bahwa ibu yang memilih metode ini adalah ibu dengan kehamilan risiko rendah dan sudah melalui pemeriksaan menyeluruh sebelum persalinan. Selain itu, persiapan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk bak persalinan dengan ukuran yang sesuai, sistem pengaturan suhu air, dan alat pemantau janin yang kompatibel dengan kondisi di air, harus tersedia.

Keseluruhan proses water birth menuntut perhatian sangat detail dan disiplin tinggi dalam penerapan prosedur kebersihan dan monitoring. Meskipun banyak manfaatnya, keselamatan ibu dan bayi harus tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, water birth merupakan metode yang ideal untuk wanita yang menginginkan persalinan alami dan nyaman, dengan catatan bahwa pelaksanaan metode ini selalu didukung oleh tenaga kesehatan profesional yang berpengalaman dan fasilitas yang memadai.

C. *Gentle Birth dan Hypnobirthing*

Gentle birth adalah sebuah pendekatan dalam praktik persalinan yang mengutamakan pengalaman ibu yang tenang, nyaman, dan minim intervensi medis. Konsep ini berfokus pada penciptaan suasana persalinan yang mendukung kebutuhan emosional, fisik, dan psikologis ibu sehingga proses kelahiran dapat berlangsung secara alami dan penuh penghargaan terhadap kondisi ibu dan bayinya. Pendekatan gentle birth sangat menekankan pentingnya menghindari prosedur medis yang tidak perlu, sehingga ibu

dapat merasa lebih bebas, dihormati, dan didukung secara holistik selama persalinan. Fokus utama dari gentle birth adalah untuk mengurangi ketakutan, stres, dan rasa nyeri dengan cara yang alami, serta memastikan ibu merasa aman dan nyaman di lingkungan persalinannya.

Salah satu metode gentle birth yang banyak dikenal dan semakin populer adalah hypnobirthing. Hypnobirthing menggunakan teknik relaksasi yang dalam dan teknik hipnosis untuk membantu ibu mengatasi kecemasan dan mengelola rasa nyeri selama persalinan. Melalui metode ini, ibu diajarkan untuk mencapai kondisi relaksasi yang mendalam, yang dapat mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melahirkan secara efektif. Hipnosis dalam konteks ini bukanlah bentuk kehilangan kesadaran, melainkan suatu kondisi fokus yang membantu ibu mengubah persepsi terhadap rasa sakit dan menenangkan pikiran sehingga proses persalinan menjadi lebih lancar dan menyenangkan.

Pendekatan hypnobirthing juga sangat menekankan keterlibatan aktif ibu dalam setiap tahap persalinan. Ibu tidak hanya menjadi objek dari proses kelahiran, tetapi menjadi subjek yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan tubuhnya sendiri. Hal ini membantu mengurangi rasa takut dan trauma yang seringkali dialami oleh banyak ibu selama persalinan konvensional. Dengan demikian, hypnobirthing bertujuan menciptakan pengalaman persalinan yang positif dan memuaskan secara emosional, yang berkontribusi pada kesejahteraan ibu dan ikatan awal yang kuat antara ibu dan bayi.

Untuk menerapkan hypnobirthing secara efektif dalam praktik kebidanan, bidan perlu mendapatkan pelatihan khusus yang mendalam. Pelatihan ini meliputi pemahaman teori dasar tentang hipnosis, teknik relaksasi, serta cara memberikan bimbingan dan dukungan psikologis kepada ibu hamil yang memilih metode ini. Bidan juga harus mampu menyesuaikan pendekatan hypnobirthing dengan kondisi fisik dan psikologis ibu secara individual, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar personal dan efektif. Dukungan profesional dari bidan yang berkompeten sangat penting untuk membantu ibu menjalani persalinan dengan tenang, percaya diri, dan minim stres.

Secara keseluruhan, gentle birth dan hypnobirthing menawarkan paradigma baru dalam pelayanan persalinan yang mengedepankan kesejahteraan emosional dan fisik ibu, mengurangi ketergantungan pada intervensi medis, serta memperkuat pengalaman positif yang mendalam selama proses kelahiran. Metode ini tidak hanya bermanfaat bagi ibu secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi

keluarga dan sistem kesehatan secara keseluruhan dengan mendorong kelahiran yang lebih sehat dan manusiawi.

D. Penggunaan Teknologi Digital dalam Persalinan (*Telemidwifery*)

Telemidwifery merupakan inovasi dalam pelayanan kebidanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan kehamilan secara jarak jauh. Konsep ini semakin mendapat perhatian dan berkembang pesat, terutama sejak pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan kontak fisik guna mencegah penyebaran virus. Dalam situasi seperti ini, *telemidwifery* menjadi solusi penting untuk memastikan pelayanan kebidanan tetap berjalan tanpa mengorbankan aspek keselamatan baik bagi ibu hamil maupun tenaga kesehatan.

Dengan *telemidwifery*, berbagai aktivitas penting dalam asuhan kebidanan dapat dilakukan secara virtual. Pemantauan kesehatan ibu dan janin, konsultasi prenatal, edukasi mengenai proses persalinan, serta dukungan selama masa postpartum dapat diberikan tanpa perlu bertemu langsung. Hal ini memungkinkan ibu hamil, terutama yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses fasilitas kesehatan, tetap memperoleh layanan kebidanan berkualitas tanpa hambatan geografis. Selain itu, *telemidwifery* memberikan fleksibilitas waktu dan kemudahan bagi ibu dan bidan dalam menjalani proses komunikasi serta konsultasi.

Pelaksanaan *telemidwifery* membutuhkan dukungan teknologi yang memadai, mulai dari perangkat komunikasi seperti smartphone atau komputer, jaringan internet yang stabil, hingga aplikasi khusus yang memungkinkan interaksi dua arah secara real-time. Bidan yang memberikan layanan *telemidwifery* harus memiliki kompetensi digital yang baik serta keterampilan komunikasi jarak jauh yang efektif agar dapat memberikan instruksi, edukasi, dan dukungan psikologis secara optimal. Kemampuan untuk membangun hubungan empatik dan interaktif melalui media digital sangat penting agar ibu merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan rasa aman selama masa kehamilan dan persalinan.

Meski *telemidwifery* memberikan banyak kemudahan, tantangan yang muncul juga tidak sedikit. Keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan fisik secara langsung dapat menjadi kendala dalam mendeteksi dini komplikasi kehamilan atau persalinan. Oleh karena itu, bidan perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda bahaya melalui informasi yang diberikan oleh ibu, serta membuat keputusan yang tepat terkait kebutuhan pemeriksaan lanjutan secara tatap muka. Selain itu, aspek privasi dan keamanan data pasien dalam komunikasi digital harus dijaga dengan ketat agar kerahasiaan informasi medis tidak terancam.

Dalam rangka mengoptimalkan telemidwifery, diperlukan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan terstruktur, mencakup tata cara konsultasi, frekuensi monitoring, dokumentasi digital, serta protokol rujukan ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan kondisi darurat. Edukasi bagi ibu hamil mengenai penggunaan teknologi dan pentingnya kejujuran serta keterbukaan dalam komunikasi juga merupakan bagian penting dalam keberhasilan layanan ini.

Secara keseluruhan, *telemidwifery* merupakan kemajuan penting dalam pelayanan kebidanan modern yang menggabungkan teknologi dengan pendekatan humanis, memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel kepada ibu hamil untuk mendapatkan asuhan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Bidan sebagai penyedia layanan dituntut untuk terus meningkatkan keterampilan digital dan komunikasi mereka agar mampu memaksimalkan potensi telemidwifery demi kesehatan ibu dan bayi.

E. Isu Etik dan Legal terkait Persalinan Kontemporer

Seiring dengan perkembangan metode persalinan modern yang semakin beragam, tantangan terkait isu etik dan legal dalam praktik kebidanan menjadi semakin kompleks dan penting untuk diperhatikan. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana menghormati pilihan pribadi ibu dalam menentukan metode persalinan yang diinginkan, seperti home birth, water birth, atau pendekatan lain yang lebih alami dan minim intervensi medis. Penghormatan terhadap pilihan ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip etik kebidanan, yang menempatkan otonomi dan hak pasien sebagai hal yang utama, sekaligus memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat berdasarkan pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi dari pilihan tersebut.

Dalam konteks ini, proses informed consent menjadi sangat krusial. Informed consent bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan proses komunikasi yang mendalam antara bidan dan ibu hamil, di mana bidan wajib memberikan penjelasan yang transparan dan mudah dipahami tentang prosedur persalinan, kemungkinan risiko, manfaat, serta alternatif yang tersedia. Dengan demikian, ibu hamil dapat membuat keputusan yang benar-benar sadar dan bertanggung jawab mengenai cara persalinannya. Ketidaklengkapan atau ketidaktepatan dalam proses informed consent dapat menimbulkan masalah etik dan bahkan berpotensi menjadi isu hukum.

Tanggung jawab profesional bidan juga menjadi aspek penting dalam isu legal persalinan kontemporer. Bidan tidak hanya bertugas memberikan asuhan kebidanan sesuai standar, tetapi juga harus siap menghadapi situasi darurat dan komplikasi yang mungkin muncul secara tiba-tiba selama persalinan. Dalam praktik seperti water birth

dan home birth yang mungkin terjadi di luar lingkungan rumah sakit, risiko komplikasi yang membutuhkan penanganan cepat dapat meningkat. Oleh karena itu, bidan wajib memiliki kompetensi klinis, kesiapan mental, dan pemahaman mendalam tentang protokol evakuasi dan rujukan yang efektif demi keselamatan ibu dan bayi.

Regulasi hukum yang mengatur praktik kebidanan juga semakin berkembang, khususnya terkait dengan metode persalinan baru yang semakin diminati. Bidan harus memahami dengan jelas berbagai peraturan dan standar profesi yang berlaku di wilayah praktiknya, termasuk hak dan kewajiban hukum mereka serta implikasi dari pelanggaran standar pelayanan. Aspek legal ini mencakup perlindungan hukum bagi bidan ketika menjalankan tugas sesuai prosedur, serta konsekuensi hukum jika terjadi kelalaian atau pelanggaran standar profesional.

Selain itu, bidan perlu mampu mengomunikasikan aspek etika dan legal ini secara efektif kepada ibu hamil dan keluarganya. Informasi yang lengkap dan jujur mengenai risiko serta tanggung jawab masing-masing pihak sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kerjasama dalam menjalani proses persalinan. Komunikasi yang baik juga membantu meminimalkan konflik dan kesalahpahaman yang dapat berujung pada masalah hukum.

Dengan demikian, isu etik dan legal dalam persalinan kontemporer menuntut bidan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran profesionalnya. Bidan harus terus mengikuti perkembangan regulasi dan praktik terbaik agar mampu memberikan layanan yang tidak hanya berkualitas secara klinis, tetapi juga sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku, sehingga pengalaman persalinan dapat berjalan aman, lancar, dan bermartabat bagi ibu dan bayi.

F. Peran Media Sosial dalam Edukasi Persalinan

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara ibu hamil mendapatkan informasi tentang persalinan. Media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya menjadi sumber utama edukasi bagi banyak ibu hamil karena kemampuannya menyebarkan informasi secara luas, cepat, dan dengan cara yang sangat interaktif. Melalui media sosial, ibu hamil dapat mengakses berbagai konten edukatif mulai dari video tutorial, pengalaman pribadi, hingga diskusi kelompok yang membahas berbagai aspek persalinan dan perawatan bayi.

Keunggulan media sosial sebagai sarana edukasi terletak pada kemudahannya dalam menjangkau ibu hamil di berbagai lokasi geografis, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan konvensional. Interaksi dua arah di media sosial juga memungkinkan ibu bertanya langsung kepada ahli kebidanan, berbagi pengalaman dengan sesama ibu, dan memperoleh dukungan emosional yang sangat dibutuhkan selama masa kehamilan dan persalinan. Media sosial pun menyediakan berbagai format konten yang menarik dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan tingkat pemahaman ibu terhadap proses persalinan dan asuhan kebidanan.

Namun demikian, kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di media sosial juga menghadirkan tantangan yang cukup serius. Salah satu tantangan utama adalah maraknya informasi yang tidak akurat, setengah benar, atau bahkan hoaks yang beredar luas dan dapat menyesatkan ibu hamil. Informasi yang salah ini dapat memicu kekhawatiran yang tidak perlu, membuat keputusan persalinan yang tidak tepat, atau bahkan menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan bayi. Oleh sebab itu, peran aktif bidan sebagai tenaga kesehatan profesional menjadi sangat penting dalam menciptakan dan mengelola konten edukasi yang kredibel dan berbasis bukti ilmiah di media sosial.

Bidan harus proaktif memanfaatkan media sosial sebagai platform edukasi yang efektif dengan menyediakan informasi yang akurat, up-to-date, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, bidan perlu memberikan panduan kepada ibu hamil tentang bagaimana cara menilai kualitas informasi yang mereka temukan di internet dan media sosial. Dengan kemampuan literasi digital ini, ibu dapat memilah mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang harus diwaspadai. Hal ini penting agar keputusan terkait persalinan dan asuhan kehamilan diambil berdasarkan fakta dan pengetahuan yang benar, bukan berdasarkan rumor atau informasi yang menyesatkan.

Lebih jauh, bidan juga dapat menginisiasi komunitas digital yang sehat dan suportif, di mana ibu hamil dapat berdiskusi, bertukar pengalaman, dan menerima bimbingan langsung dari profesional. Keberadaan komunitas semacam ini dapat memperkuat dukungan sosial dan meningkatkan kualitas edukasi kebidanan secara menyeluruh. Dengan demikian, peran bidan tidak hanya sebagai penyedia layanan langsung tetapi juga sebagai pengelola informasi dan edukator digital yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, media sosial memiliki potensi besar sebagai alat edukasi persalinan yang efektif jika dikelola dengan baik. Namun, hal ini juga menuntut bidan untuk terus meningkatkan kompetensi digitalnya, memahami dinamika media sosial, serta berkomitmen untuk menyediakan informasi yang etis dan berbasis bukti. Dengan

demikian, ibu hamil dapat menjalani masa kehamilan dan persalinan dengan bekal pengetahuan yang memadai, memberikan dampak positif pada kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan.

Latihan Soal

Tugas

Tugas 1:

Deskripsi:

Tuliskan esai analisis kritis tentang fenomena tren persalinan di rumah saat ini. Jelaskan faktor-faktor yang membuat metode ini semakin diminati, keuntungan dan risiko yang terkait, serta peran bidan dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi selama persalinan di rumah.

Tujuan:

- Memahami alasan ibu memilih home birth
- Mengidentifikasi risiko dan manfaat
- Menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan dalam home birth

Panjang tugas: 800-1.000 kata

Tugas 2:

Deskripsi:

Buatlah studi kasus fiktif seorang ibu hamil yang memilih water birth. Jelaskan bagaimana persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dilakukan selama proses persalinan di air tersebut. Bahas pula risiko-risiko potensial yang harus diantisipasi oleh bidan dan tindakan emergensi yang perlu dipersiapkan.

Tujuan:

- Memahami mekanisme dan prosedur water birth
- Mampu mengidentifikasi risiko dan mitigasi
- Menguasai langkah-langkah penanganan komplikasi dalam water birth

Panjang tugas: 700-900 kata

Tugas 3:

Deskripsi:

Rancanglah program pelatihan hypnobirthing yang dapat diberikan oleh bidan kepada ibu hamil. Sertakan materi teknik relaksasi, cara pelaksanaan hipnosis ringan, serta strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan ibu selama persalinan.

Tujuan:

- Menguasai konsep gentle birth dan hypnobirthing

- Mengembangkan kemampuan memberikan edukasi psikologis dan dukungan emosional
- Membuat modul pelatihan yang praktis dan aplikatif

Panjang tugas: 600-800 kata + outline materi pelatihan

Tugas 4:

Deskripsi:

Buat laporan evaluasi tentang manfaat dan tantangan penggunaan telemidwifery dalam mendukung asuhan persalinan modern. Diskusikan bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan akses layanan, serta kendala yang mungkin dihadapi bidan dan ibu hamil. Sertakan rekomendasi pengembangan layanan telemidwifery yang efektif.

Tujuan:

- Menganalisis peran teknologi digital dalam kebidanan
- Mengenali tantangan dan solusi telemidwifery
- Menyusun rekomendasi berbasis analisis kritis

Panjang tugas: 700-1.000 kata

Tugas 5:

Deskripsi:

Susun makalah tentang isu-isu etik dan legal yang muncul seiring berkembangnya metode persalinan modern seperti home birth dan water birth. Jelaskan pentingnya informed consent, hak otonomi ibu, dan tanggung jawab profesional bidan. Sertakan contoh kasus hipotetik yang menggambarkan dilema etik dan solusi yang tepat.

Tujuan:

- Memahami aspek etik dan legal praktik kebidanan modern
- Mampu menerapkan prinsip informed consent
- Mengembangkan pemikiran kritis terhadap masalah hukum dan etika

Panjang tugas: 800-1.000 kata

Pilihan Ganda

1. Seorang ibu hamil 30 tahun datang ke fasilitas persalinan yang menyediakan layanan water birth. Ibu ini memiliki kehamilan risiko rendah dan ingin menjalani persalinan dalam air. Saat persalinan berlangsung, bidan mendapati suhu air dalam bak terlalu tinggi (39°C).

Apa tindakan yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Membiarkan suhu air tetap tinggi karena membantu relaksasi ibu
- B. Menurunkan suhu air menjadi 36–37°C agar nyaman dan aman bagi ibu dan janin
- C. Memindahkan ibu keluar dari bak dan melanjutkan persalinan secara konvensional
- D. Menambahkan es ke dalam bak untuk langsung menurunkan suhu air
- E. Memberi analgesik agar ibu tetap nyaman meski suhu air tinggi

2. Dalam pelaksanaan water birth, bidan kesulitan melakukan pemantauan denyut jantung janin secara kontinu.
Apa langkah terbaik yang harus dilakukan bidan untuk mengatasi kendala ini?
- A. Menggunakan alat monitoring janin yang kompatibel dengan kondisi air dan rutin menginterpretasi data
 - B. Mengandalkan pemeriksaan manual denyut jantung janin secara berkala di luar air
 - C. Membiarkan proses persalinan berjalan tanpa pemantauan denyut jantung janin
 - D. Memindahkan ibu keluar dari bak saat pemeriksaan denyut jantung janin
 - E. Mengandalkan tanda-tanda klinis ibu sebagai indikator kondisi janin
3. Seorang ibu memilih water birth dan telah dipersiapkan sesuai protokol. Namun tiba-tiba terjadi perdarahan hebat selama proses kelahiran dalam air.
Tindakan pertama yang harus dilakukan bidan adalah:
- A. Memberi obat penguat kontraksi dalam air
 - B. Memindahkan ibu segera keluar dari bak persalinan untuk tindakan lebih lanjut
 - C. Menunggu perdarahan berhenti secara spontan
 - D. Mengurangi suhu air agar perdarahan berkurang
 - E. Meminta keluarga menenangkan ibu agar perdarahan tidak bertambah
4. Dalam proses informed consent untuk water birth, bidan wajib menyampaikan informasi berikut, kecuali:
- A. Manfaat water birth yang meliputi relaksasi dan pengurangan nyeri
 - B. Risiko potensial seperti infeksi dan kesulitan pemantauan janin
 - C. Prosedur evakuasi dan tindakan darurat jika komplikasi terjadi
 - D. Kewajiban ibu untuk melakukan persalinan dalam air tanpa alternatif lain
 - E. Hak ibu untuk memilih metode persalinan sesuai keinginan dan kondisinya
5. Seorang ibu yang menjalani water birth melalui telemidwifery (pendampingan jarak jauh) mengeluhkan ketidaknyamanan saat kontraksi.
Apa peran bidan yang melakukan telemidwifery untuk membantu ibu tersebut secara optimal?
- A. Mengabaikan keluhan karena keterbatasan jarak
 - B. Memberikan instruksi teknik relaksasi dan posisi yang nyaman secara virtual
 - C. Meminta ibu segera datang ke fasilitas untuk persalinan normal tanpa air
 - D. Menghentikan proses persalinan secara virtual dan menyarankan persalinan rumah sakit
 - E. Menyuruh keluarga mengambil tindakan medis tanpa konsultasi lanjutan

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Suhu air pada water birth harus dijaga dalam rentang 36–37°C untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan ibu serta janin. Suhu air yang terlalu tinggi (seperti 39°C) dapat menyebabkan dehidrasi, peningkatan denyut jantung janin, dan risiko infeksi. Oleh karena itu, bidan harus menyesuaikan suhu air agar tetap optimal dan aman tanpa harus memindahkan ibu keluar kecuali ada indikasi lain. Menambahkan es secara langsung bisa menyebabkan perubahan suhu yang terlalu drastis dan kurang nyaman. Analgesik tidak menggantikan pentingnya pengaturan suhu air yang benar.

2. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Pemantauan denyut jantung janin secara kontinu sangat penting selama water birth untuk mendeteksi tanda-tanda distress janin. Karena air dapat menghambat penggunaan alat konvensional, bidan harus menggunakan alat monitoring khusus yang sesuai untuk digunakan di air dan memastikan interpretasi data secara cermat. Memeriksa secara manual atau mengandalkan tanda klinis saja tidak cukup karena berisiko terlambat mendeteksi komplikasi. Memindahkan ibu keluar dari bak tanpa alasan yang jelas dapat mengganggu proses persalinan.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Perdarahan hebat (postpartum hemorrhage) merupakan keadaan gawat darurat yang memerlukan intervensi segera dan tepat. Dalam water birth, penanganan darurat sulit dilakukan di dalam air sehingga ibu harus segera dipindahkan keluar untuk mendapatkan tindakan medis yang memadai, seperti kompresi uterus, pemberian obat, dan transfusi darah jika perlu. Menunggu atau hanya mengurangi suhu air tidak efektif. Peran keluarga adalah mendukung secara emosional, tapi tindakan klinis prioritas.

4. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Informed consent adalah proses komunikasi yang harus menyampaikan manfaat, risiko, dan prosedur dengan jujur dan transparan, serta menegaskan hak ibu untuk membuat keputusan secara sadar. Tidak boleh ada paksaan atau kewajiban untuk melakukan persalinan dalam air tanpa mempertimbangkan pilihan lain. Pernyataan bahwa ibu wajib melakukan water birth tanpa alternatif bertentangan dengan prinsip otonomi pasien dan etika kebidanan.

5. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Dalam telemidwifery, bidan harus mampu memberikan dukungan psikologis dan edukasi melalui komunikasi digital yang efektif. Memberikan instruksi teknik relaksasi dan posisi yang nyaman secara virtual adalah cara membantu ibu mengatasi ketidaknyamanan secara optimal dalam keterbatasan jarak. Mengabaikan atau memaksa ibu ke rumah sakit tanpa evaluasi adalah tidak tepat. Peran bidan adalah memberikan bimbingan yang empatik dan memadai.

Rangkuman Materi

Tren persalinan di rumah atau home birth semakin diminati karena memberikan kenyamanan, privasi, dan suasana santai bagi ibu yang ingin menjalani proses persalinan secara alami dengan intervensi medis minimal dan didampingi oleh keluarga dekat. Pelaksanaan persalinan di rumah memerlukan perencanaan matang, meliputi evaluasi kondisi kesehatan ibu dan janin, serta kesiapan sarana medis dan situasi darurat. Peran bidan sangat penting dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses tersebut.

Water birth merupakan metode persalinan yang dilakukan di dalam bak berisi air hangat, yang populer dalam praktik kebidanan modern karena manfaat relaksasi yang membantu mengendurkan otot dan mengurangi nyeri saat kontraksi. Air hangat juga membantu mempercepat proses persalinan dengan merangsang pelepasan hormon oksitosin secara alami, serta mengurangi gravitasi sehingga ibu lebih bebas bergerak dan merasa lebih percaya diri. Meski banyak manfaatnya, water birth juga berisiko terutama terkait potensi infeksi yang dapat timbul jika prosedur aseptik dan sanitasi tidak dijaga dengan baik. Pemantauan denyut jantung janin selama persalinan di air juga menantang dan memerlukan alat khusus serta pengalaman tenaga kesehatan dalam interpretasi data untuk deteksi dini komplikasi. Penanganan komplikasi mendadak dalam water birth sulit dilakukan di dalam air sehingga protokol evakuasi dan kesiapan fasilitas darurat sangat penting. Pelaksanaan water birth harus diawasi oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten, dengan persiapan fasilitas dan peralatan yang memadai, terutama memastikan ibu hamil termasuk kategori risiko rendah.

Gentle birth dan hypnobirthing adalah pendekatan persalinan yang menekankan pengalaman persalinan yang tenang, nyaman, dan minim intervensi medis. Gentle birth mengutamakan suasana yang mendukung kebutuhan emosional dan psikologis ibu, sedangkan hypnobirthing menggunakan teknik relaksasi dan hipnosis untuk membantu ibu mengelola kecemasan dan nyeri secara alami. Hypnobirthing mendorong keterlibatan aktif ibu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan tubuhnya selama persalinan.

Bidan yang memberikan layanan ini perlu mendapat pelatihan khusus agar mampu memberikan dukungan psikologis yang efektif dan personal.

Telemidwifery adalah inovasi layanan kebidanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk pengawasan dan konsultasi jarak jauh selama kehamilan dan persalinan. Layanan ini memudahkan akses ibu hamil, terutama di daerah terpencil, untuk mendapatkan edukasi, pemantauan, dan dukungan dari bidan secara real-time melalui perangkat digital. Meskipun memberikan kemudahan, telemidwifery memiliki tantangan seperti keterbatasan pemeriksaan fisik langsung dan kebutuhan menjaga privasi data pasien. Oleh karena itu, SOP yang jelas, kompetensi digital bidan, dan edukasi penggunaan teknologi bagi ibu hamil sangat diperlukan untuk keberhasilan layanan ini.

Isu etik dan legal dalam persalinan kontemporer semakin kompleks seiring berkembangnya berbagai metode persalinan modern. Penghormatan terhadap otonomi ibu dan hak memilih metode persalinan yang diinginkan menjadi prinsip utama, yang harus disertai dengan proses informed consent yang transparan dan komunikatif. Bidan memiliki tanggung jawab profesional tidak hanya dalam memberikan asuhan yang aman dan sesuai standar, tetapi juga dalam kesiapan menghadapi komplikasi mendadak dan memahami regulasi hukum yang berlaku. Komunikasi yang baik antara bidan dan ibu hamil penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi risiko konflik hukum.

Media sosial telah menjadi sumber edukasi utama bagi ibu hamil dengan kemampuan menyebarkan informasi secara luas dan interaktif. Melalui platform digital, ibu dapat mengakses berbagai konten edukatif, berdiskusi dengan sesama ibu, dan mendapatkan dukungan emosional. Namun, maraknya informasi yang tidak akurat menjadi tantangan serius sehingga peran bidan sebagai pengelola informasi yang kredibel dan edukator digital sangat vital. Bidan harus aktif menyediakan informasi berbasis bukti, membimbing ibu dalam menilai kualitas informasi, serta membangun komunitas digital yang sehat untuk meningkatkan kualitas edukasi kebidanan secara keseluruhan. Dengan pengelolaan media sosial yang baik, ibu hamil dapat memperoleh pengetahuan yang memadai untuk menjalani kehamilan dan persalinan secara sehat dan aman.

Glosarium

Bidan Profesional: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus dalam praktik kebidanan, termasuk penanganan persalinan normal dan komplikasi.

Etika Kebidanan: Prinsip moral dan standar profesi yang mengatur perilaku dan praktik bidan dalam memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi.

Gentle Birth: Pendekatan persalinan yang menekankan kenyamanan, minim intervensi medis, dan pemenuhan kebutuhan emosional serta psikologis ibu agar persalinan berlangsung secara alami dan penuh penghormatan.

Hipnosis: Suatu kondisi fokus dan relaksasi mendalam yang membantu mengubah persepsi rasa sakit dan menenangkan pikiran selama persalinan.

Home Birth (Persalinan di Rumah): Metode persalinan yang dilakukan di lingkungan rumah ibu, dengan tujuan memberikan kenyamanan, privasi, dan pengalaman persalinan alami dengan intervensi medis minimal, biasanya didampingi oleh bidan dan keluarga.

Hypnobirthing: Metode persalinan dengan teknik relaksasi dan hipnosis ringan yang membantu ibu mengelola rasa nyeri dan kecemasan, serta meningkatkan kontrol dan kepercayaan diri selama persalinan.

Infeksi: Masuk dan berkembangnya mikroorganisme berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan; risiko ini tinggi jika sanitasi dan aseptik pada water birth tidak terjaga.

Informed Consent: Proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang bertujuan memberikan informasi lengkap mengenai prosedur, risiko, manfaat, serta alternatif sehingga pasien dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab.

Komunitas Digital: Kelompok daring yang dibentuk untuk saling berbagi pengalaman, edukasi, dan dukungan antara ibu hamil dan tenaga kesehatan secara online.

Literasi Digital: Kemampuan untuk mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis dan efektif di dunia digital, sangat penting bagi ibu hamil dalam menilai konten edukasi di media sosial.

Media Sosial: Platform digital seperti Facebook, Instagram, dan YouTube yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi secara luas dan interaktif, termasuk terkait kehamilan dan persalinan.

Oksitosin: Hormon yang berperan dalam merangsang kontraksi rahim dan mempercepat pembukaan serviks selama persalinan.

Otonomi Pasien: Hak pasien untuk membuat keputusan sendiri mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya berdasarkan informasi yang jelas dan lengkap.

Pemantauan Denyut Jantung Janin: Proses mengawasi denyut jantung bayi selama persalinan untuk memastikan kondisi janin tetap sehat dan mendeteksi tanda-tanda distress janin secara dini.

Protokol Darurat: Rangkaian prosedur yang harus diikuti dalam menghadapi situasi gawat darurat, misalnya perdarahan hebat atau prolaps tali pusat, untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi.

Regulasi Hukum Kebidanan: Peraturan perundang-undangan dan standar profesi yang mengatur praktik kebidanan, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab bidan dalam menjalankan tugasnya.

Telemidwifery: Pelayanan kebidanan yang memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk konsultasi, pemantauan, dan edukasi ibu hamil secara jarak jauh melalui perangkat seperti smartphone atau komputer.

Water Birth (Persalinan dalam Air): Metode persalinan di mana ibu melahirkan di dalam bak berisi air hangat yang membantu relaksasi otot, mengurangi nyeri, dan mempercepat proses persalinan dengan memicu pelepasan hormon oksitosin.

Daftar Pustaka

- Cluett, E. R., & Burns, E. (2009). Water immersion for labour and birth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD000111. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000111.pub3>
- Hunter, B. M., & Klein, M. C. (2020). Midwifery and telehealth: A new frontier for maternal care. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 65(5), 603–610. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13115>
- Johnson, K. C., & Daviss, B. A. (2005). Outcomes of planned home births with certified professional midwives: Large prospective study in North America. *BMJ*, 330(7505), 1416. <https://doi.org/10.1136/bmj.330.7505.1416>
- Leap, N., Sandall, J., Buckland, S., & Huber, U. (2010). Journey to confidence: Women's experiences of pain in labour and relational continuity of care. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 55(3), 234–242. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2009.07.004>
- Mongan, M. (2004). *HypnoBirthing: The Mongan Method*. Whole Health Publishing.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>

Buku Ajar Persalinan merupakan panduan pembelajaran yang dirancang khusus untuk mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi di bidang kesehatan maternal. Buku ini membahas secara sistematis dan mendalam mengenai seluruh aspek penting dalam proses persalinan, mulai dari konsep dasar kebidanan, anatomi dan fisiologi persalinan, hingga manajemen komplikasi dan praktik berbasis simulasi klinik. Disusun berdasarkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), buku ini dilengkapi dengan strategi pembelajaran aktif, evaluasi kompetensi, dan penguatan aspek etik dan hukum dalam praktik kebidanan.

Setiap bab dalam buku ini mencakup uraian materi utama, latihan soal, glosarium, dan daftar pustaka yang mengacu pada referensi ilmiah terkini. Pembahasan isu-isu kontemporer seperti telemidwifery, gentle birth, serta peran media sosial dalam edukasi kehamilan juga menjadikan buku ini relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan yang integratif, praktis, dan berbasis bukti, Buku Ajar Persalinan diharapkan mampu menjadi sumber belajar utama dalam membentuk bidan yang kompeten, profesional, dan humanis.

Buku Ajar Persalinan merupakan panduan pembelajaran yang dirancang khusus untuk mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi di bidang kesehatan maternal. Buku ini membahas secara sistematis dan mendalam mengenai seluruh aspek penting dalam proses persalinan, mulai dari konsep dasar kebidanan, anatomi dan fisiologi persalinan, hingga manajemen komplikasi dan praktik berbasis simulasi klinik. Disusun berdasarkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), buku ini dilengkapi dengan strategi pembelajaran aktif, evaluasi kompetensi, dan penguatan aspek etik dan hukum dalam praktik kebidanan.

Setiap bab dalam buku ini mencakup uraian materi utama, latihan soal, glosarium, dan daftar pustaka yang mengacu pada referensi ilmiah terkini. Pembahasan isu-isu kontemporer seperti telemidwifery, gentle birth, serta peran media sosial dalam edukasi kehamilan juga menjadikan buku ini relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendekatan yang integratif, praktis, dan berbasis bukti, Buku Ajar Persalinan diharapkan mampu menjadi sumber belajar utama dalam membentuk bidan yang kompeten, profesional, dan humanis.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

